



Oedema Face



Oedema Legs



Neck Examination



Breast Examination

## یونٹ: 11

## حاملہ کے لئے مفید مشورے

## (ADVICES FOR PREGNANT FEMALE)

## (حمل کا قائم ہونا)

## (PREGNANCY)

**تعارف (Introduction):** ایک شادی شدہ عورت کی زندگی کا یہ ایک خوشگوار لمحہ ہوتا ہے جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس دوران کے معمولات غذا اور جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ بہت سی لڑکیاں نادانیت کی وجہ سے فکر مند ہو جاتی ہیں۔ اس ذہنی پریشانی اور خوف کا اثر ہونے والے بچے پر بھی پڑتا ہے لہذا حمل کے درمیانی عرصے میں زیادہ سے زیادہ خوش رہنا چاہیے۔

جسم میں یوٹرس پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹیوب (Tube) کے ذریعے بیضہ دانی (Ovary) سے ملا ہوتا ہے۔ یہ تینوں اعضاء یعنی یوٹرس، ٹیوب اور بیضہ دانی مل کر ہی نئی زندگی کی ابتداء کرتے ہیں۔ ہر ماہ میں عورت کے تین سے چھ دن ماہواری کے ایام ہوتے ہیں۔ ان ایام کے ایک ہفتے بعد ایک چھوٹا سا انڈا بیضہ دانی سے نکل کر ٹیوب کی طرف آتا ہے۔ اگر اس وقت مرد کے مادہ تناسل سے ایک سپرم اس چھوٹے انڈے سے مل جائے اور اس میں داخل ہو جائے اور تب دونوں مل کر یوٹرس میں داخل ہوں تو اس عمل سے ایک نئی زندگی کی ابتداء ہوتی ہے۔ قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ یہ چھوٹا سا انڈا یوٹرس کی دیوار میں جگہ بناتا ہے اور وہاں بڑی تیزی سے بڑھتا ہے۔ پورے تین ہفتے کے بعد وہ ایک انگور کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرحلہ وار تخلیقی مراحل سے گزر کر تقریباً نو ماہ دو ہفتہ کا کل وقت بچے کی پیدائش کے لئے چاہیے ہوتا ہے۔

ماں کے یوٹرس میں سپرم پرورش پائے تو حمل قائم ہوتا ہے۔ عورت کا یوٹرس بچے کے لئے ایک چھوٹے گھر کی طرح ہوتا ہے جو کہ مضبوط مسلز سے بنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑھتا اور نشوونما پاتا ہے ویسے ویسے یوٹرس بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے یوٹرس میں پورے نو ماہ پرورش پاتا ہے۔ بچہ یوٹرس کے اندر ایک پانی کی تھیلی میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس تھیلی میں کافی جگہ ہوتی ہے اور یہ پانی بچے کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے۔ بچہ پیٹ کے اندر اپنے منہ سے خوراک نہیں کھاتا لیکن اسے خوراک پہنچائی جاتی ہے۔ ماں کے یوٹرس کے اندر بچہ پلے سینا کے ذریعے خوراک حاصل کرتا ہے۔ پلے سینا ایک طرف بچے کی ناف کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور دوسری طرف ماں کے یوٹرس کی دیوار کے ساتھ۔ جو خوراک ماں کھاتی ہے وہ اس کے معدے میں ہضم ہو کر خون میں جذب ہوتی ہے۔ خون کا دوران اس خوراک کو پلے سینا کے ذریعے بچے تک پہنچاتا ہے اور اس طرح بچہ طاقت حاصل کر کے نشوونما پاتا ہے۔

سب سے پہلی اور یقینی پہچان حمل قائم ہونے کی یہ ہے کہ ایام حیض رک جاتے ہیں۔ بریسٹ نرم اور سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ آخری علامت بعض عورتوں میں جلد اور بعض میں دیر میں پیدا ہوتی ہے۔ طبیعت خراب ہونا، پیٹ میں گرانی، سینہ میں جلن، قے، متلی اور سر میں درد وغیرہ بھی عموماً ہو جاتا ہے لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ تین یا چار مہینے بعد متلی و قے وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے لیبارٹری ٹیسٹ، ایکس رے اور الٹراساؤنڈ کی مدد سے بھی حمل کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

**حمل کے قائم ہونے کی یقینی علامات (Signs and symptoms of pregnancy):** حمل قائم ہونے کی یوں تو کئی علامات ہیں مگر حمل قائم ہونے کی یقینی علامات درج ذیل ہیں:

|    |                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | حمل قائم ہوتے ہی پیٹ میں خصوصاً مثانہ اور ریکٹم میں دباؤ کا احساس ہونا۔                                                                                                                               |
| 2  | پیٹ کا ماہواری کی رکاوٹ کے حساب سے بڑھنا اور ایام حیض کا رک جانا۔                                                                                                                                     |
| 3  | سب سے یقینی نشانی حمل قائم ہونے کی یہ ہے کہ ماں کو پیٹ میں بچہ کی موجودگی کا باقاعدہ احساس ہوتا ہے۔                                                                                                   |
| 4  | بچے کی حرکات محسوس کی جاسکتی ہیں اور بچے کے دل کی رفتار 140 فی منٹ محسوس ہوتی ہے لیکن یہ تمام نشانیاں حمل قائم ہونے کے پانچ ماہ بعد شروع ہوتی ہیں۔                                                    |
| 5  | ماں کا یوٹرس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نو ماہ میں اس کا کنارہ معدہ کی دیوار تک جا پہنچتا ہے۔ اس طرح بڑھے ہوئے یوٹرس کا پریشر اس کیساتھ والے آرگنز اور ٹشوز میں مختلف تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ |
| 6  | اکثر حاملہ کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ حمل کے پانچ یا چھ ماہ بعد پیروں اور بعض دفعہ ہاتھوں اور چہرے پر بھی درم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔                                                                       |
| 7  | دوران حمل شروع کے تین چار ماہ سینے میں جلن، قے، متلی، سر میں درد وغیرہ بھی عموماً ہو جاتا ہے۔                                                                                                         |
| 8  | حاملہ عورت کے چہرے پر کالے یا پیلے دھبے بھی پڑ سکتے ہیں جنہیں عرف عام میں چھائیاں کہتے ہیں۔                                                                                                           |
| 9  | حاملہ کی کمر میں درد بھی رہتا ہے بعض دفعہ دانتوں میں بھی درد ہوتا ہے اور بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔                                                                                         |
| 10 | بریسٹ نرم پڑ جاتے ہیں اور سائز میں بڑھ جاتے ہیں۔                                                                                                                                                      |
| 11 | پیٹ میں زندہ بچہ ہو تو چوبیس یا پچیسویں ہفتہ میں اس کے دل کی دھڑکن فلیٹو سکوپ رکھ کر سنی جاسکتی ہے۔ بچے کا دل اس حالت میں ایک منٹ میں 140 بار دھڑکتا ہے۔                                              |

|    |                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | حمل کے بارے میں سولہ یا اٹھارہ ہفتے کے شروع میں ”ایکسرے“ کرانے سے اس کا ڈھانچہ فلم میں نظر آتا ہے۔ اس عرصے سے پہلے ایکسرے مفید نہیں۔ |
| 13 | یورین فارپرگ نیسی ٹیسٹ کے ذریعے بھی حمل کی نشان دہی ہو سکتی ہے۔                                                                      |
| 14 | پیلوک الٹراساؤنڈ کے ذریعے پرگ نیسی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔                                                                        |
| 15 | ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر حاملہ کا کلینیکل معائنہ کر کے بھی پرگ نیسی کی تشخیص کر سکتی ہے۔                                                  |



## بچہ کے بارے میں پیش گوئی

### (CHILD SUSPECTION)

**تعارف (Introduction):** بچوں کے جڑواں ہونے کے بارے میں ہم یقینی نہیں بتا سکتے لیکن پھر بھی دو بچوں کے دل کی دھڑکنوں اور بہت زیادہ حرکت سے جڑواں ہونے کی پیش گوئی کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے جڑواں ہونے کے بارے میں تصدیق ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اندازے کے مطابق نوے کیسوں میں سے ایک جڑواں ہو سکتا ہے۔ اور سات ہزار ڈیوری کیسوں میں سے ایک کیس تین جڑواں بچوں کا ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی علامت یا نشانی نہیں ہے جس سے پیدا ہونے والے بچے کی جنس معلوم کی جاسکتی ہو البتہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے کی جنس کا بھی پتہ چلایا جاسکتا ہے۔



## بچہ کی پیدائش کی تاریخ

### (DATE OF DELIVERY)

**تعارف (Introduction):** بچے کی پیدائش کی صحیح تاریخ مقرر نہیں کی جاسکتی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ فلاں دن فلاں وقت بچہ پیدا ہو جائے گا۔ حمل کی مدت 280 دن ہے۔ پیدائش کی تاریخ آخری ماہواری کے پہلے دن سے شمار کی جاتی ہے اور اس میں سات دن جمع کر کے سال میں سے تین مہینے نکال دیئے جاتے ہیں مثلاً اگر حاملہ کو آخری ماہواری 22 اکتوبر 2017ء کو آئی تھی تو زچگی 29 جولائی 2018ء میں ہوگی۔ ویسے لیڈی ڈاکٹر سے معائنہ کراتے رہنا چاہیے خصوصاً آخری دنوں میں ڈاکٹر یوٹرس دیکھ کر حمل کی مدت کا اندازہ لگا کر تقریباً تاریخ پیدائش بتا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے بھی اندازہ بچے کی تاریخ پیدائش معلوم کی جاسکتی ہے۔



## حاملہ کے لئے ہدایات

### (ADVICES FOR PREGNANT FEMALE)

**تعارف (Introduction):** حمل قائم ہونا قدرت کے خلاف نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی بیماری یا کمزوری ہے بلکہ عین قدرت کی منشاء کے مطابق ہے۔ عورت کے لئے بڑی خوشی کا موقع ہے کیونکہ اس کے لئے دنیا میں یہ کام بہت بڑا اور ضروری فرض ہے لیکن اس بڑے اور ضروری فرض کے یہ معنی نہیں ہیں کہ محض حمل قائم ہو جانے کی وجہ سے وہ گھر کے کام کاج سے ہلکی محنت و مشقت سے بچوں کی دیکھ بھال یا بڑوں کی خدمت وغیرہ سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، الگ بیٹھ رہے یا ہر وقت لیٹی رہے جیسا کہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوران حمل لیٹی رہتی ہیں۔ وہ غالباً یہ خیال کرتی ہیں کہ ان کو تو اس طرح لیٹے رہنے سے آرام ملتا ہے اور ان کے ہونے والے بچے کو بھی اس طرح آرام ملے گا۔ ان کا یہ آرام اس وقت تو انہیں اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن بعد میں یہ آرام خاص طور سے وضع حمل کے وقت بہت دشواریاں اور پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے جس سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں تو وضع حمل کے وقت خاص طور سے بہت سے خطرے ہیں یعنی وضع حمل میں ذرا سی بے پروائی یا غلطی میٹرنٹی ہوم کی نرس یا دایہ سے ہو جائے تو جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو عورتیں ورزش کرتی رہتی ہیں وہ عموماً بہت آسانی سے اور مقابلاً زیادہ جلدی فارغ ہو جاتی ہیں۔ ذرا سا چلنا پھرنا یا کام کاج کرنا جو اس وقت کا بل عورتوں کو دوران حمل دو بھر معلوم ہوتا ہے۔ مستقبل میں بہت کام آتا ہے یہی وجہ ہے کہ گاؤں کی اور غریب گھروں کی لڑکیاں جلدی فارغ ہو جاتی ہیں اور امیر یا شہری لڑکیاں نہ صرف فارغ ہونے میں دیر لگاتی ہیں بلکہ بڑی وقت بھی اٹھاتی ہیں اور جو حمل کے زمانہ میں ہلکی ورزش ترک نہیں کرتیں اور غذا ہلکی، زود ہضم لیکن طاقتور کھاتی ہیں ان کو وضع حمل زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا۔



## حاملہ کے خیالات کا بچے پر اثر

### (EFFECTS OF FEMALE'S PSYCHOLOGY ON BABY)

**تعارف (Introduction):** حاملہ کے دل میں جو خیالات آتے ہیں یا جو سوچ ہوتی ہے اس کا بچے پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر بڑے خیالات ہیں تو بڑا اثر پڑتا ہے اگر اچھے ہیں تو اچھے ہیں تو اچھے۔ اس لئے حاملہ کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات پاک اور درست رکھے۔ پیغمبروں، بہادروں، نیک اور مشہور لوگوں کے واقعات پڑھتی رہے۔ انکی اچھی عادتوں اور انکی عمدہ نصیحتوں پر غور کیا کرے گفتگو میں اچھی باتوں کا ذکر کیا کرے اور خدا کی یاد میں زیادہ تر مصروف رہے۔ دعا مانگے، غیر قدرتی اور عجیب عجیب چیزوں کو مثلاً جڑے ہوئے بچوں یا غیر معمولی چھوٹے قد یا بد صورت لوگوں کو جہاں تک ہو سکے نہ دیکھے۔ جن، دیو، بھوت کی تصاویر نہ دیکھے تاکہ اس کا خیال اور شکل و صورت عورت کے ذہن میں نہ رہ جائے اور بچے کی صورت پر اثر نہ کرے۔

نہ بیہودہ قصہ کہانیوں میں وقت ضائع کیا کرے۔ بد صورت لوگوں کو جہاں تک ہو سکے زیادہ نہ دیکھے۔ خود میلی کچلی نہ رہے بلکہ خیالات کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی کا بہت خیال رکھے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ اسے چاہیے کہ رنج و فکر پریشانیوں اور اچانک تبدیلیوں سے خود کو بچائے رکھے۔ حاملہ کو چاہیے کہ ڈراؤنی، بے ہودہ یا مار دھاڑ سے بھرپور فلمیں نہ دیکھے۔ حاملہ کے خیالات صاف اور پاکیزہ ہونے چاہئیں۔ حاملہ کو ذہنی اور جسمانی بیمار لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ حمل کے دوران اچھی چیزوں کو دیکھے بلکہ کمرہ میں ایک خوبصورت تندرست بچے کی فوٹو رہنی چاہیے تاکہ ماں کی نظر اس پر پڑتی رہے۔



## حاملہ کے لئے احتیاطیں

### (PRECAUTIONS FOR PREGNANT FEMALE)

**تعارف (Introduction):** حمل کے دوران حاملہ عورت کو کئی اقسام کی احتیاطیں اختیار کرنی چاہئیں مثلاً حاملہ کے لئے زیادہ وزن اٹھانا خطرناک ہے اس سے اسقاط حمل ہو جانے یا دیگر تکالیف پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ماں اور بچے کے اندرونی تعلق کو قائم رکھنے کے لئے بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ ماں اور بچے کے اندرونی تعلق کو قائم رکھنے کے لئے ماں کو گرنے سے، چوٹ لگنے سے، چھلانگ لگانے، ڈانس کرنے، گھڑ سواری کرنے، لمبا اور دشوار گزار سفر کرنے، زیادہ وزن اٹھانے بہت زیادہ جھکنے سے اور کپڑے سینے کی پیروالی مشین چلانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیز دوائیں اور دماغی ہیجان بھی خطرناک ہے۔ مسلسل جسمانی بے چینی، بہت باریک کپڑے پہننے، بہت دیر تک جاگنے، بہت تنگ کپڑے پہننے، تھکا دینے والی تقاریب میں شرکت سے بھی احتیاط لازم ہے۔ زمانہ حمل میں عورت کو سردی سے بچنا چاہیے اور زیادہ ٹھنڈے پانی میں زیادہ دیر تک پاؤں بھگونے سے گردوں کی تکلیف ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

اگر حاملہ اپنی صحیح دیکھ بھال نہیں کرے گی اور صحت مندانہ عادات اختیار نہیں کرے گی تو اس سے نہ صرف وضع حمل میں دقت ہوگی اور بچے کی نشوونما متاثر ہوگی بلکہ وہ نازک یا بیمار پیدا ہوگا۔ زمانہ حمل میں حاملہ کو قبض نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تیز مرچ مصالحے کی خوراک سے پرہیز رکھیں۔ اگر زمانہ حمل میں حاملہ کا پیشاب گدلا ہو یا چہرے کی سوجن بہت زیادہ بڑھ گئی ہو تو پیشاب کا فوراً ٹیسٹ کروائیں۔

زمانہ حمل کے شروع اور آخری مہینوں میں وظیفہ زوجیت سے احتراز کریں۔ حمل کے دوران آخری دنوں میں بریسٹ اور نپل کو روزانہ نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ حاملہ کا انفیکشن کی بیماریوں سے بچنا لازم ہے۔ پیشاب کی حاجت ہو تو فوراً رفع کریں زیادہ دیر روکے نہ رکھیں۔ اگر زمانہ حمل میں کسی وقت خون جاری ہو جائے تو فوراً ایڈمیڈ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ حاملہ کو چاہیے کہ اونچی ایڑھی کے جوتوں کا استعمال کچھ عرصہ کے لئے ترک کر دے۔



## حاملہ کا کمرہ

### (PREGNANT FEMALE'S ROOM)

**تعارف (Introduction):** حاملہ کے بیڈروم اور سنگ روم میں خاص طور پر تازہ ہوا کی ہمیشہ آمد و رفت رہنی چاہیے کیونکہ کھلی ہوا پھیپھڑوں اور سینے کی ورزش کے لئے بہت مفید ہے۔ حاملہ کو چاہیے کہ تازہ ہوا میں گہرا سانس اندر کو لے کر آہستہ آہستہ باہر نکالے۔ حاملہ کی رہائش گاہ میں پینے کا اور دیگر استعمال کا صاف ستھرا پانی موجود ہونا چاہیے۔ کھڑکیوں پر جالی اور پردے لگے ہوں۔ کمرہ میں سیلن نہ ہو۔ خشک اور روشن کمرہ ہو۔ گھر میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کا درست انتظام موجود ہو یعنی پلاسٹک کی تھیلیوں میں گند وغیرہ نہ پھینکیں جبکہ کمرے میں پانی وغیرہ کے اخراج اور آب و ہوا، روشنی وغیرہ کا اچھا انتظام ہو اور کوڑے کرکٹ کے ڈبے کے اوپر ڈھکن بھی ضرور ہونا چاہیے۔



## حاملہ کی خوراک

### (PREGNANT FEMALE'S FOOD)

**تعارف (Introduction):** زمانہ حمل میں ماں کی خوراک نہ صرف ماں بلکہ بچے کے لئے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دوران حمل بہترین نارمل خوراک مناسب مقدار میں کھانے سے ڈیوری میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ خوراک سادہ بلکی اور کافی غذائیت کی ہونی چاہیے۔ خوراک میں نارمل چکنائی، نمکیات، وٹامنز، کاربوہائیڈریٹس اور فالک ایسڈ کی متوازن مقدار اور پانی شامل ہونا چاہیے۔

بہت سی خواتین یہ خیال کرتی ہیں کہ حاملہ کو دو آدمیوں کی خوراک کھانی چاہیے یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ دوسرا آدمی تو ابھی ذرا سا ہے جس کو کھانے میں زیادہ مقدار کی ضرورت نہیں۔ اس کو خوراک حاملہ کے خون سے پہنچتی رہتی ہے لیکن زیادہ مقدار میں کھا لینے سے حاملہ کا ہاضمہ خراب ہوتا رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہو سکتا یعنی خون کم بنتا ہے اور جب خون کم بنے گا تو ظاہر ہے کہ بچہ کو بھی کم پینچے گا لہذا یہ بات ضروری ہے کہ حاملہ کی خوراک مقدار میں زیادہ ہرگز نہ ہو بلکہ زیادہ خیال اس بات کا رکھنا ضروری ہے کہ حاملہ کی خوراک زیادہ تر طاقتور، بلکی اور جلد ہضم ہو جانے والی اور کم مقدار میں وقت مقررہ پر کھائی جائے۔ اس کے علاوہ جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

|   |                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | گھی یا تیل میں تلی ہوئی چیزیں قطعی طور پر ترک کر دی جائیں۔                                                                                                                                     |
| 2 | کھانا کھانے کیساتھ پانی نہ پیا جائے بلکہ ایک گھنٹہ بعد پینیں اور کافی مقدار میں پینیں یہ قبض کشا بھی ہے۔                                                                                       |
| 3 | صبح اٹھ کر خالی پیٹ محنت کا کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ ہلکا ناشتہ کرنے کے بعد کرنا چاہیے۔ اگر صبح متلی زیادہ ہو تو سب سے پہلے ایک کپ دودھ یا چائے پی کر تھوڑی دیر لیٹیں پھر اٹھ کر کام کریں۔ |

|   |                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | دن بھر میں سب سے پہلی غذا یا ناشتہ تھیل اور تلی ہوئی چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دودھ یا چائے ہو تو بہتر ہے اس کے ساتھ ٹوسٹ یا روٹی ہو تو کوئی حرج نہیں۔                             |
| 5 | جو غذاائیں حمل سے پہلے ہی موافق نہ آتی ہوں تو انہیں مکمل طور پر دوران حمل ترک کر دیں۔                                                                                                  |
| 6 | ایک آدھ وقت کا نانہ کرنا بھی اچھا ثابت ہوتا ہے لیکن جسمانی طور پر کمزور خواتین کو وقت مقررہ پر تھوڑا بہت ضروری کھانا پینا چاہیے۔                                                       |
| 7 | کھانا کبھی بے وقت نہیں کھانا چاہیے اس سے مطلب یہ ہے کہ کھانے کے اوقات مقرر ہوں۔ دن میں پانچ مرتبہ، لیکن تھوڑی مقدار میں کھانا بہتر ہے ایک ہی وقت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ |
| 8 | تیز مرچ مصالحے کی خوراک سے پرہیز کریں اس سے ہاضمے کی گڑبڑ سے محفوظ رہیں گے۔                                                                                                            |



## حاملہ کا غذائی معمول

### (FOOD HABITS OF PREGNANT FEMALE)

**تعارف (Introduction):** حمل کے دوران حاملہ کا غذائی معمول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ کھانے میں تقریباً وہ ساری چیزیں جو وہ اب تک کھاتی رہی ہے حمل کے دوران بھی کھاتی رہے۔ غذا میں مناسب تبدیلیاں کرتے رہنا چاہیے مثلاً ایک دن روٹی، دوسرے دن چاول، کبھی دال، کبھی مچھلی، کبھی انڈا، کبھی دہی اور کبھی کچھ اور لیکن گوشت حاملہ کے لئے زیادہ اچھی چیز نہیں ہے۔ گوشت کے ہضم کرنے میں جگر اور گردوں پر کافی بار پڑتا ہے۔ زیادہ چائے بھی بری ہے۔ سگریٹ نوشی بھی بچے پر برا اثر ڈالتی ہے۔ حاملہ کو چاہیے کہ خاص طور پر سبز ترکاریاں چکی یا پکی مثلاً ٹماٹر، گاجر، سلاد، دھنیا، پودینہ، پالک وغیرہ کافی مقدار میں کھاتی رہے۔ دودھ، انجیر، شہد، کھجور، کینو، سنگترہ، انار وغیرہ حاملہ کے لئے کافی اچھی چیزیں ہیں۔ کھانے کے بعد سوئف چبانے سے ہاضمہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور قبض بھی نہیں ہوتا اور پھر کوندہ، ملتانی مٹی یا چاک وغیرہ کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ حاملہ کو چاہیے کہ گلے سڑے اور غیر صاف شدہ پھل استعمال نہ کرے۔ عمدہ تازہ اور اچھی طرح دھلے ہوئے پھل کھانے چاہئیں۔ رات کو آخری کھانا سونے سے دو گھنٹے قبل کھالینا چاہیے تاکہ سوتے وقت تک ہضم ہو سکے۔ غذا کے بارے میں حمل کے دوران بڑی غلطی یہ ہے کہ کھانا معمول سے زیادہ کھایا جائے اور ورزش یا چلنا پھرنا اور ٹہلنا وغیرہ کم کر دیا جائے۔ سب سے پہلے اس پر توجہ دیں کہ قبض نہ ہونے پائے۔ غذاائیں ایسی کھائیں کہ جو قابض، بادی یا زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈی نہ ہوں۔ گردوں کو حمل کے دوران زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس لئے گوشت کم کھانا چاہیے۔ اگر گوشت کی عادت ہو تو رفتہ رفتہ کم کر دینا چاہیے۔ کھانا آرام و اطمینان کیساتھ کھانا چاہیے، جلدی جلدی بھاگ دوڑ میں یا غصہ کی حالت میں نہیں کھانا چاہئے۔

اسی طرح کھانا خوب چبا کر کھانا چاہیے۔ حمل کے زمانے میں بھوک زیادہ لگتی ہے لیکن پھر بھی غذا زیادہ پیٹ بھر کر نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس سے الٹی کمزوری ہو جاتی ہے یا پھر بچہ بہت جسامت والا پیدا ہوتا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے، بچے ہوئے تازہ پھل، زیادہ دودھ، مکھن وغیرہ استعمال کرنا چاہئے۔ تازہ پھل کارس بھی بہت مفید ہے۔ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی (جو ہمارے مذہب میں بالکل حرام ہے) سے مکمل پرہیز لازم ہے۔ یہ چیزیں ماں کو جو نقصان پہنچاتی ہیں وہ الگ اور اس کے علاوہ بچہ کی نشوونما دل و دماغ پر بھی بہت بُرا اثر ڈالتی ہیں۔ بچے کے دماغ اور خیالات و عادات پر ماں کے ہر عمل کا اثر قائم ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں انتہائی مضر ہیں۔ اگر اس کی عادت ہے تو مناسب ہوگا کہ حمل قائم ہونے سے پیشتر ماں باپ یہ عادتیں چھوڑ دیں یا رفتہ رفتہ کم کرتے چلے جائیں۔ یہ خود ان کے لئے اور ان کے بچوں کے لئے بہتر ہو گا۔ زیادہ کھٹائی، تیز مصالحہ، سرکہ، کوئلہ مٹی وغیرہ سب بُری چیزیں ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں دیتیں بلکہ نقصان ہی پہنچاتی ہیں ان سے پرہیز لازم ہے۔ اکثر صبح کو سب سے پہلے دودھ کا گلاس اور ایک سیب کا لینا تجویز کیا جاتا ہے جس کو ان کی عادت نہیں وہ اپنے معمول کے مطابق ناشتہ کریں۔



## دوران حمل کی غذائیں

(FOOD DURING PREGNANCY)

**تعارف (Introduction):** حمل کے دوران حاملہ کو اپنی نارمل غذا میں قدرے تبدیلی کرتے ہوئے مفید اور متوازن غذا استعمال کرنی چاہئے کیونکہ اچھی غذا اور وقت پر لی گئی بہترین خوراک نا صرف حاملہ کیلئے بلکہ پیدا ہونے والے بچے کے لئے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ حمل کے دوران حاملہ جو غذا روزانہ کھا سکتی ہے؛

|   |        |         |   |             |                  |
|---|--------|---------|---|-------------|------------------|
| 1 | چپاتی۔ | (Chip)  | 4 | سو جی۔      | (Semolina)       |
| 2 | چاول۔  | (Rice)  | 5 | موسمی پھل۔  | (Seasonal fruit) |
| 3 | دلیہ۔  | (Dulha) | 6 | مناسب پانی۔ | (Proper water)   |

کسی قسم کا سالن علاوہ ازیں صحت برقرار رکھنے اور نشوونما کے لئے بہت ضروری ہے کہ دودھ یا دہی یا موسم کے مطابق کسی دن میں ایک کلو تک پیئیں۔ ہفتہ میں دو مرتبہ گوشت، تین مرتبہ انڈا، مچھلی کم از کم ایک بار کھائیں۔ پالک، ساگ یا ہری سبزیاں، گاجر، ٹڈے، کدو، کرلا، مٹر وغیرہ موسم کے مطابق استعمال کریں۔ اسی طرح پھل، مالٹا، سنگترہ، کینو وغیرہ بھی موسم کے مطابق استعمال کریں۔ دوران حمل نمک کا استعمال کم کریں۔ لیموں پانی ہر دو تین گھنٹے بعد پیتی رہیں اس سے آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی اور آپ تندرست رہیں گی۔

سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ تندرست اور خوبصورت پیدا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کے یوٹرس کے اندر بچے کا ہر عضو بنتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اس لئے ماں کی اچھی غذا بچے کو بھی اچھی غذائیت پہنچائے گی۔ اس کے علاوہ بچے کے دماغ کی نشوونما بھی پیٹ کے اندر ہی ہوتی ہے۔ جسم کی طرح اس کے دماغ کی نشوونما کے لئے بھی آپ پیدائش سے پہلے ہی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ اچھی یعنی زود ہضم مناسب صاف ستھری غذا سے آپ کا بچہ جسمانی اور دماغی دونوں لحاظ سے تندرست پیدا ہوگا۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ گھی اور مٹھائی میں بہت طاقت ہوتی ہے مگر ان دونوں سے صرف موٹاپا بڑھتا ہے۔ زیادہ موٹاپا حمل اور پیدائش میں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ سادہ خوراک کھائیں۔ دودھ روزانہ پیئیں، گاجر مولی کھائیں، پھلوں میں بہت حیاتین اور وھاتیں ہوتی ہیں آپ سردی کے موسم میں سنگترے دو یا ایک روزانہ کھائیں۔ گرمی میں آم اور خربوزہ کھائیں۔ دالیں ملا جلا کر کھائیں۔ سبزیاں بھی کھائیں لیکن زیادہ نہ پکائیں۔ ہفتے میں ایک بار کبجی ضرور کھائیں لیکن ابال کر انہیں مصالحہ لگا کر آگ پر بھون کر لیموں کے ساتھ کھائیں۔ ہفتے میں ایک بار مچھلی بھی ضرور کھائیں۔

مناسب غذا کا استعمال بہت ضروری ہے کیونکہ پورے نو ماہ بچہ ماں کے جسم میں پرورش پاتا ہے اور ماں کے خون کے ذریعے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے اور اس طرح ایک چھوٹے انڈے سے ایک خوبصورت بچے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پورے نو ماہ وہ ماں کے جسم میں اور خون سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ بچہ اپنے منہ سے کوئی خوراک نہیں کھاتا بلکہ ماں کے جسم کے اندر پلے سینفا کے ذریعے خوراک حاصل کرتا ہے۔ پلے سینفا ایک طرف بچے کی ناف کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور دوسری طرف ماں کے یوٹرس کی دیوار کیساتھ۔ جو خوراک ماں کھاتی ہے وہ اس کے معدے میں ہضم ہو کر خون میں جذب ہوتی ہے۔ خون کا دوران اس خوراک کو پلے سینفا کے ذریعے بچے کو پہنچاتا ہے اور اس طرح بچہ طاقت حاصل کر کے نشوونما پاتا ہے۔



## حاملہ کیلئے ورزش

(EXERCISE FOR PREGNANT FEMALE)

**تعارف (Introduction):** آج کل کے تہذیب یافتہ زمانہ میں صحیح تندرستی یا صحیح طرز زندگی ناپید ہونے کی وجہ سے حمل کے دوران حاملہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہے لیکن اگر سادہ غذا، محتاط طرز زندگی اور مناسب ورزش اختیار کی جائے تو ڈیلیوری کا مرحلہ آسانی سے طے پا جاتا ہے اور دوران حمل سکون رہتا ہے۔

حاملہ کے لئے مناسب مقدار میں مناسب طریقہ سے ورزش کرنا کئی اعتبار سے مفید ہے لیکن ان عورتوں کو جو ہر وقت گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں یا گھر میں ملازم نہیں رکھتیں اور دن بھر آرام سے بستر پر نہیں رہتیں ان کو بالکل ورزش کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دن بھر میں صبح یا شام کسی

وقت آدھا گھنٹہ کھلی ہوا میں ٹہلنا ان کے لئے بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس پر زور دیتے ہیں کہ موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو، ٹہلنا ضروری ہے لیکن سردیوں میں جب تیز ہوائیں چلیں تو ٹہلنا روک دینا چاہیے۔ گھر کے اندر ٹہلنے میں یہ نقصان ہے کہ صاف ہوا جو خون کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہے وہ میسر نہیں آتی اور حاملہ کے لئے صاف ہوا بہت ضروری ہے۔

پچھلے دوروں میں صاف ہوا کی آمد و رفت سے خون صاف ہوتا ہے اور جسم کو مناسب مقدار میں آکسیجن ملتی رہتی ہے جس پر ہر جاندار کی زندگی موقوف ہے۔ حاملہ کے لئے بلحاظ صحت بچہ اور خود اپنے لئے خون کی یہ صفائی بہت ضروری ہے کیونکہ جس خون پر پیٹ میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے وہ جس قدر صاف ہوا چھا ہے۔ بند کمروں یا بند کونٹریوں میں جہاں ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو تو حاملہ کا رہنا مضر صحت ہے۔ لحاف یا چادر سے منہ ڈھانپ کر نہ لیٹیں بلکہ سوتے وقت منہ کھلا رکھنا چاہیے۔ کمروں میں صاف ہوا کی آمد و رفت جاری رکھنا چاہیے لیکن موسم کے لحاظ سے زیادہ ٹھنڈی یا زیادہ گرم ہوا سے بچنا بھی ضروری ہے۔

سب سے اچھی ورزش حاملہ کے لئے وہ ہے جس میں جسم کا آگے پیچھے مڑنا لازمی ہو اور لمبے لمبے سانس ناک کے ذریعے لینا۔ فرش پر پت لیٹ کر ایک ٹانگ آہستہ آہستہ اٹھانے کی کوشش کرنا پھر آہستہ آہستہ نیچے لیٹ کر ٹانگیں پھیلا کر اوپر کے جسم کو بغیر ہاتھوں کے سہارے کے آہستہ آہستہ اٹھانے کی کوشش کرنا بھی اچھی ورزش ہے جس سے نلوں، اعصاب، پٹھوں پر زور پڑتا ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہلکی سی ورزش روزانہ کر لی جائے اس سے وضع حمل میں آسانی ہوتی ہے اور اجابت بھی روزانہ ہوتی ہے۔ اس کا اثر وضع حمل تک بلکہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے لیکن ورزش زیادتی کے ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نہ ہی زیادہ بھاری اور مشکل ورزش کرنے کی ضرورت ہے۔ ورزش سے یہ مطلب نہیں کہ حاملہ تھک کر چور چور ہو جائے۔ شروع میں صرف ایک ایک دفعہ مندرجہ بالا ورزش کرنی چاہیے یہ کافی ہے پھر جہاں تک آسانی سے بغیر تھکے برداشت کر سکیں تو تعداد بڑھالیں۔

جن عورتوں کو اسقاط ہو جاتا ہو یا وہ بہت نحیف یا کمزور ہوں یا کسی اور مرض میں مبتلا ہوں ان کو ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر ورزش نہیں کرنی چاہیے ورزش بچے کو جسم میں زیادہ جسامت والا نہیں ہونے دیتی۔ پہلے دو ایک ہفتے ورزش کو عموماً جی نہیں چاہتا لیکن اگر کسی کو ورزش کی پہلے سے عادت ہو تو حمل قائم ہوتے ہی ورزش شروع نہیں کرنی چاہیے۔



## حاملہ کیلئے ورزش کا وقت

### (TIME FOR EXERCISE)

**تعارف (Introduction):** پہلے جسم کو اس تبدیلی کی عادت ہونے دیں جو حمل سے پیدا ہوتی ہے۔ حمل کے قائم ہونے کے بعد سے ڈاکٹر کی رائے کے مطابق ورزش شروع کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہی آپ کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد آپ کے لئے مناسب ورزش تجویز کر سکتی ہے۔

شروع شروع میں صرف ہلکی اور کم ورزش کرنی چاہیے۔ زیادہ جستی سے کو دنیا پھاندنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی ورزش سے تھک کر چور ہو جانا خصوصاً پسینہ میں شرابور نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ حاملہ کے لئے خطرناک ہے۔ جو عورتیں گھر سے باہر نہ جاسکیں ان کے لئے بہترین ورزش گھر کے کام کاج ہیں۔ یہ عمدہ ورزش ہے اس سے پیچھے پھروں، پٹھوں اور عضلات کو بھرپور آکسیجن مہیا ہوتی ہے لیکن حاملہ کو انتہائی سخت کام خصوصاً بھاری بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایسا کام جس کو کرنے سے سخت تھکن ہو سکتی ہو مثلاً ایک ہی وقت میں بہت سارے کپڑے دھونا۔ بہتر یہ ہے کہ تھوڑے کپڑے آج تھوڑے کل دھوئے جائیں۔ جہاں تک ہو سکے کھلی ہوا میں کام کریں یا کم از کم گھر کی کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھیں تاکہ صاف ہوا آتی رہے۔ حاملہ کو اونچی اڑھی کا جوتا نہیں پہننا چاہیے۔ اگر زیادہ اونچی ہیل پہننے کی عادت ہے تو دوران حمل اسے ترک کر دیں اور بالکل فلیٹ سادہ چپل پہننی چاہیے۔ بہت زیادہ اونچی ہیل سے یوٹرس کے بوجھ کی وجہ سے خصوصاً آخری مہینوں میں حمل گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔



## حاملہ کا غسل اور صفائی

### (PREGNANT FEMALE'S BATH)

**تعارف (Introduction):** حاملہ کو بہت تیز گرم پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً شروع اور آخر کے مہینوں میں سوائے اس صورت میں کہ کسی کو ہمیشہ تیز گرم پانی سے نہانے کی عادت ہو۔ زیادہ تیز گرم پانی سے غسل سے بھی اسقاط کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ حمل کے بعد بھی تیز گرم پانی سے نہانے سے جسم پر چھریاں پڑ جاتی ہیں اور کھال ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اگر سردی کا موسم ہے تو غسل سے پہلے نیم گرم زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ پیٹ پر ہلکے ہلکے مالش کریں۔ بچے کے بڑھتے ہوئے جسم کی وجہ سے حاملہ کے پیٹ کی کھال میں تناؤ اور کھجلی ہونے لگتی ہے اگر اس وقت کھجالیہ تو ہمیشہ کے لئے اس پر نشانات بن جاتے ہیں جو مشکل سے رفع ہوتے ہیں۔ یہ کھجلی پہلے حمل میں زیادہ محسوس ہوتی ہے اگر پہلے حمل میں نہیں کھجالیہ تو وہ بعد کے نشانات پھر نہیں ہوں گے۔ زیتون کے تیل کی مالش کھال کو نرم رکھتی ہے اور کھجلی نہیں ہونے دیتی۔ مالش کے ایک آدھ گھنٹہ بعد غسل کرنا چاہیے۔

بعض خواتین مہینے میں دو مرتبہ بعض ہفتے میں ایک دفعہ بعض تین روز اور بعض دن میں دو بار نہاتی ہیں لیکن غسل ہمیشہ اعتدال سے کرنا چاہیے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ سردیوں کے موسم میں غسل دن میں ایک بار جبکہ گرمی میں دو مرتبہ کافی ہے۔ غسل کے بعد جسم و روح کو عجیب سی فرحت و تازگی ملتی ہے جو حاملہ کیلئے ضروری ہے۔ حاملہ کو اپنا جسم اپنے کپڑے اور اپنا گھر صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ دانتوں کی صفائی نہایت اہم ہے۔ بچے کو کیشیم کی ضرورت ہوتی ہے جو ماں کے جسم سے پوری ہوتی ہے۔ حاملہ کو خصوصیت کے ساتھ چیچک اور خسرہ کے مریضوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حاملہ کو جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ ذہنی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی لڑائی، جھگڑا، حسد و رشک وغیرہ سے پرہیز کرے اور اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھے۔ پر امید رہے اور اچھے خیال رکھے۔ اس روحانی صفائی کا جسمانی صفائی پر بہت اثر پڑتا ہے۔ صرف ظاہری صفائی کافی نہیں بلکہ ذہن بھی صاف رکھنا چاہیے۔ حاملہ کے غم و غصے، شک و وہم غرض ہر قسم کے جذبات کا بچے پر بہت اثر پڑتا ہے۔



## حاملہ کی نیند

### (PREGNANT FEMALE'S SLEEP)

**تعارف (Introduction):** جو عورت دن بھر ست و کابل رہتی ہو اور آرام سے بستر پر لیٹی رہتی ہو اسے رات کی نیند کی خوشی کہاں میسر ہو سکتی ہے۔ اسے رات کو آرام سے گہری نیند کیسے آسکتی ہے یا بستر پر آرام کیسے مل سکتا ہے حالانکہ گہری نیند حاملہ کیلئے بہت ضروری ہے۔ سونے سے حاملہ کی دن بھر کی تھکان دور ہوتی ہے اور نیند بچے کی نشوونما کے لئے بھی ضروری ہے۔ نیند حاملہ کے لئے بہت ضروری ہے اگر کسی کو رات کو نیند نہ آئے تو اسے اگلے روز سو کر جاگنے کی کمی کو پورا کر لینا چاہیے۔ نیند کی کمی پوری نہ ہونے سے جسم کی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ چہرہ دہلا ہو جاتا ہے۔ سر خالی خالی سا معلوم ہوتا ہے۔ سر میں درد رہنے لگتا ہے۔ جسم نڈھال سا رہتا ہے۔ کسی کام کو دل نہیں چاہتا۔ کیا دن کی رات زندگی بری معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کا بچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے لیکن نیند لانے کے لئے زبردست نشہ والی یا نیند آور دواؤں کا استعمال سے کوئی فائدہ نہیں۔ نیند کی دوائیں انتہائی برے اثرات رکھتی ہیں اور بعد میں عادی ہو جانے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دوا بے اثر ثابت ہوتی ہے لہذا انکا عادی ہونے سے بچنا چاہیے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو اچھی سی کتاب پڑھیں۔ نیم گرم دودھ کے کپ میں اوٹھین ڈال کر پیئیں تاکہ رات کو ہی نیند پوری ہو جائے اور دن میں سونا نہ پڑے اور اگلے روز طبیعت ٹھیک رہے۔ حاملہ کو اپنے زیر مطالعہ زیادہ تر مذہبی اور پاکیزہ کتابیں رکھنی چاہئیں کیونکہ حاملہ کے ذہنی خیالات کا بچے کی شخصیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ حاملہ کو چاہیے کہ بہادر نیک اور مشہور لوگوں کے حالات زندگی کی کتابیں پڑھے۔ اچھی کتابیں اچھے خیالات پیدا کرتی ہیں۔



## دوران حمل کی معمولی بیماریاں اور تبدیلیاں

### (MILD CHANGES DURING PREGNANCY)

**تعارف (Introduction):** شادی کے بعد حمل ٹھہرنا ایک قدرتی اور خوش آئند عمل ہے۔ حمل چونکہ زندگی کی عام کیفیات سے ایک الگ کیفیت ہے لہذا حمل کے دوران عورت کے جسم اور خیالات میں کچھ معمولی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ تبدیلیاں کوئی بھی حاملہ عورت آسانی کے ساتھ قبول اور برداشت کر لیتی ہے لیکن چند نازک مزاج اور کمزور و نحیف حاملہ خواتین ان معمولی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ حمل کے دوران عورت کے جسم میں پیدا ہونے والی یہ معمولی تبدیلیاں درج ذیل ہیں:

﴿.....**قے (Vomiting):** کئی عورتوں کو حمل ہونے کے پہلے ہفتے میں ہی قے ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ ہر حاملہ کو شروع کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ خاص طور پر صبح کے وقت جی متلانا اور قے ہونا، اکثر شروع کے تین یا چار ماہ کے دوران ہی ہوتا ہے اسکے بعد کے پانچ ماہ میں متلی نہیں ہوتی۔

﴿.....**متلی (Nausea):** کیونکہ متلی یا قے عموماً صبح کے وقت ہوتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ علی الصبح صرف ایک سیب کھالیں یا ایک کپ چائے پی لیں۔ بعد ازاں طبیعت کچھ بہتر ہونے لگے تو ناشتہ کریں۔ ایک وقت میں زیادہ خوراک نہ لیں۔ اگر چار ماہ کے بعد بھی متلی و قے کا سلسلہ جاری رہے تو کسی لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

﴿.....**چھاتی کا بڑھ جانا (Breast Growth):** قدرتی بات ہے کہ بچے کی پیدائش سے قبل ہی چھاتی میں دودھ پلانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چھاتی کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ چھاتیوں میں ہلکا سا درد یا تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ حاملہ کے لئے اہم بات یہ ہے کہ غسل کے وقت چھاتی کی خصوصیت سے صفائی کرے۔ حمل کے ساتویں مہینے میں نہانے کے بعد نپل کو ہلکے سے پکڑ کر آہستہ آہستہ تیل کی مالش کرے۔ ایسا کرنے سے دودھ پلاتے وقت عورت کو دقت نہ ہوگی کیونکہ بچہ دودھ پیتے وقت طاقت سے نپل کو چوستا ہے۔ مالش سے نپل نرم ہو جائیں گے اور ماں کو تکلیف نہیں ہوگی۔

﴿.....**پیشاب کی بار بار حاجت محسوس ہونا (Polyuria):** حاملہ کو شروع مہینوں میں اور آخری مہینوں میں بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک قدرتی تبدیلی ہے کیونکہ حمل کے دوران یوٹرس بڑھتا ہے جو مثانے پر بوجھ ڈالتا ہے۔ اس دباؤ سے حاملہ کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ آخری مہینوں میں بھی حاملہ کو پیشاب کی جلدی جلدی حاجت ہوتی ہے۔ اگر کبھی حاملہ کو پیشاب میں درد یا جلن محسوس ہو تو لیڈی ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرے۔ ممکن ہے حاملہ کو یورینری ٹریکٹ کا کوئی انفیکشن ہو۔

﴿.....جلد (Skin): حمل کے دوران حاملہ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔﴾

﴿.....معدے کی جلن (Heart Burning): حاملہ کو آخری تین مہینوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھانا ہضم ہونے میں دقت ہو رہی ہے۔ حاملہ کو معدے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ حمل کے آخری مہینوں میں بڑھتے ہوئے یوٹرس کا دباؤ معدے پر بھی پڑتا ہے۔ معدے میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے غیر ہضم شدہ کھانا اور پانی ڈکار کی صورت گلے اور منہ میں آ جاتا ہے خصوصاً لیٹنے کی حالت میں۔ معدے میں جلن کے وقت پانی پینے سے وقتی افاقہ ہوتا ہے۔﴾

﴿.....کمر کا درد (Backache): کئی خواتین دوران حمل کمر کے درد کی شکایت کرتی ہیں۔ حاملہ کو ہر حال میں روزانہ دو گھنٹے دوپہر کو آرام ضروری ہے۔ آگے کو جھک کر بیٹھنے سے کمر دھری ہونے کی صورت میں حاملہ عورت کو جلدی تھکن ہو جاتی ہے لہذا حاملہ عورت ایک تو مناسب غذا کا استعمال کرے تاکہ اسے کمزوری نہ ہو اور دوسرے وزن زیادہ نہ اٹھائے تاکہ حمل گرنے کا اندیشہ نہ ہو۔﴾

﴿.....ماہواری کی بندش (Amenorrhoea): حمل کی ایک علامت یہ ہے کہ عورت کی ماہواری بند ہو جاتی ہے لیکن اگر حاملہ کو دوران حمل خون آنے لگے تو فوراً لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ یہ مس کیرج یا بارشن کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔﴾

﴿.....سوجن (swelling): اگر ہاتھ پیر میں سوجن بھاری پن محسوس ہو تو اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں اگر سوجن کافی زیادہ ہو تو نمک کھانا بند کر دیں۔﴾

﴿.....لیکوریہ (Leucorrhoea): دوران حمل اگر حاملہ کو لیکوریہ کی شکایت ہو تو لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ ٹھیک وقت پر صحیح علاج ہونے سے آپ اور آپ کا بچہ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اگر دوران حمل لیکوریہ رہے تو ہونیوالے بچے کے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور وہ دودھ نہیں پی سکتا۔ آپ کو چاہیے کہ حمل قائم ہونے کے بعد کسی قریبی مستند میسرٹی ہوم میں اپنا نام لکھوادیں اور کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو بہر حال ہر پندرہ روز یا ایک مہینے بعد اپنا چیک اپ کرواتی رہیں۔ آٹھویں مہینے ہی سے بچے کیلئے تیاری رکھیں۔ بچے کیلئے چھوٹے کپڑے گدے تیکے تیار کریں۔ سردی کا موسم ہو تو اونی کپڑے تیار کریں۔ گرمی میں نائیلون کی بجائے کاٹن یا ملل کے کپڑے بنائیں۔ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس جس میں ماں اور بچے کے کپڑے، صابن، تولیہ اور دیگر ضروریات کی چیزیں موجود ہوں تیار رکھیں تاکہ عین وقت پر کوئی دقت نہ ہو۔﴾

﴿..... بواسیر (Piles):﴾ کبھی کبھار قبض ہونے سے حاملہ کو بواسیر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات عام نہیں ہے تاہم اسکا علاج یہ ہے کہ اگر بواسیر معمولی درجہ کی ہے تو پانی زیادہ پینا چاہیے۔ لیکن کھانا کھانے کے ساتھ نہیں۔ اس طرح اگر قبض ہے تو روزانہ رات نیم گرم دودھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں انجیر کا استعمال بھی مفید ہے اور انجیر ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد کھانا اچھا ہے۔ اس سے اجابت روزمرہ ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں زیادہ کھڑا رہنا ٹھیک نہیں۔ قبض کشادہ کرائیں زیادہ استعمال نہ کریں۔ معدہ اور آنتوں کو ان کا عادی نہ بننے دیں ورنہ بعد میں قبض اور بھی بڑھ جائے گا۔ یہ بات ماں اور دودھ پیتے بچے دونوں کے لئے تکلیف دہ ہے۔



## عورتوں کا قد اور وزن

(HEIGHT AND WEIGHT OF WOMEN)

| قد          | کم وزن   | اوسط وزن | زیادہ وزن |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 4 فٹ 10 انچ | 93 پونڈ  | 102 پونڈ | 112 پونڈ  |
| 5 فٹ        | 100 پونڈ | 107 پونڈ | 116 پونڈ  |
| 5 فٹ 3 انچ  | 109 پونڈ | 116 پونڈ | 126 پونڈ  |
| 5 فٹ 4 انچ  | 112 پونڈ | 120 پونڈ | 130 پونڈ  |
| 5 فٹ 5 انچ  | 115 پونڈ | 123 پونڈ | 134 پونڈ  |
| 5 فٹ 6 انچ  | 119 پونڈ | 128 پونڈ | 138 پونڈ  |
| 5 فٹ 7 انچ  | 123 پونڈ | 132 پونڈ | 142 پونڈ  |
| 5 فٹ 9 انچ  | 131 پونڈ | 140 پونڈ | 150 پونڈ  |

عورتوں کو اپنی نسوانیت ہمیشہ برقرار رکھنی چاہیے۔ اپنی جلد اور جسم کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ گھریلو کام کاج سے نہ گھبرائیں یہ ایک طرح کی ورزش ہوتی ہے۔ کوشش کر کے وزن زیادہ نہ بڑھنے دیں ہمیشہ پر امید رہیں اور ماں یا باپ کبھی پہلے سے دل میں لڑکے یا لڑکی کی امید یا یقین کر کے نہ رہیں بلکہ خدا جو بھی دے اسے بخوشی قبول کریں اور شوق سے اس کی تربیت کا خیال کریں۔ جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا کا بھی خیال رکھیں خود بھی مذہب کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور بچے کو بھی شروع ہی سے مذہب کے متعلق وقتاً فوقتاً بتاتی رہیں۔



## یونٹ: 12

## ولادت اور اس کی ممکنہ پیچیدگیاں

(LABOUR AND IT's COMPLICATIONS)

## ولادت (بچہ کی پیدائش)

(لیبر)

(LABOUR)

**تعارف (Introduction):** حمل قرار پانے کے بعد ایک مخصوص عرصہ شکم مادر میں گزار کر بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس کی پیدائش کب ہوگی اس وقت کا بالکل درست علم تو صرف خدائے بزرگ برتر کو ہی ہوتا ہے لیکن سائنس نے جو ترقی کی ہے اس کی بنیاد پر ہم بچے کی پیدائش کی متوقع تاریخ ضرور معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اندازہ اس قدر سائنسی ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صرف چند دنوں کی ہی کمی بیشی ہوتی ہے۔ پیدائش کی تاریخ معلوم کرنے کے طریقے بہت آسان ہیں جو ہم نیچے درج کر رہے ہیں۔ اس کیلئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کو آنیوالے اپنے آخری حیض کی تاریخ یاد ہونی چاہئے۔ ذیل میں بچے کی پیدائش معلوم کرنے کے دو طریقے دیئے جا رہے ہیں:

**پہلا طریقہ (Method 1):** عورت کو جب آخری حیض آیا ہو اس تاریخ میں ایک سال جمع کر لیں پھر اس تاریخ سے تین ماہ منفی کر دیں اب جو تاریخ حاصل ہو اس میں 7 دن جمع کر دیں یہ پیدائش کی متوقع تاریخ ہوگی مثلاً:

|                                |               |                                    |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| (Last menstrual date)          | 8 Jul 2015    | عورت کے حیض آنے کی آخری تاریخ:     |
| (Add one year)                 | 8 Jul 2016    | ایک سال جمع کرنے پر تاریخ:         |
| (Subtract three months)        | 8 April 2016  | تین ماہ منفی کرنے پر تاریخ:        |
| (Add seven days)               | 15 April 2016 | اب اس میں 7 دن جمع کریں:           |
| (Expected Delivery Date) E.D.D | 15 April 2016 | لہذا بچے کی پیدائش کی متوقع تاریخ: |

**دوسرا طریقہ (Method 2):** یہ طریقہ اس سے بھی سادہ ہے۔ حیض کی آخری تاریخ میں 9 ماہ جمع کریں اور اس میں مزید 7 دن جمع کریں مثلاً:

|                                |             |                                    |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| (Last menstrual date)          | 10 May 2015 | حیض آنے کی آخری تاریخ:             |
| (Add nine months)              | 10 Feb 2016 | 9 ماہ جمع کرنے پر تاریخ:           |
| (Add seven days)               | 17 Feb 2016 | 7 دن جمع کئے تو تاریخ:             |
| (Expected Delivery Date) E.D.D | 17 Feb 2016 | لہذا بچے کی پیدائش کی متوقع تاریخ: |

**آغاز پیدائش کی وجوہات (Causes Of The Onset Of Labour):** اس وقت موضوع زیر بحث ہے کہ ولادت یا پیدائش کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم ولادت کے آغاز کی وجوہات تلاش کریں تو وہ درج ذیل ہیں:

|                                      |                                 |   |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| (Hormonal causes)                    | ہارمونل وجوہات۔                 | 1 |
| (Mechanical causes)                  | میکینکل وجوہات۔                 | 2 |
| (Fundal dominance)                   | فندس کا غلبہ۔                   | 3 |
| (Dilation of cervix)                 | سرویکس کا پھیلنا۔               | 4 |
| (Contraction & retraction of uterus) | یوٹرس کی کنٹریکشن اور ریٹریکشن۔ | 5 |

**1۔ ہارمونل وجوہات (Hormonal Causes):** حمل کے قرار پانے سے لے کر ولادت تک کے دورانیہ میں ہارمون کا نظام مسلسل کام کرتا ہے اور حاملہ کے جسم میں بہت سی ہارمونل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جو مختلف مراحل پر مختلف اثرات ظاہر کرتی ہیں۔ جب ولادت کا آغاز ہوتا ہے تو پوسٹیریئر پچوٹری سے ایک خاص ہارمون آکسی ٹوسن (Oxytocin) خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جو دوسرے ہارمونز کے ساتھ مل کر حاملہ کے یوٹرس کے سرویکس پر عمل کر کے سرویکس کو پھیلا نا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہی آکسی ٹوسن ہارمون، ایسٹروجن ہارمون جو ولادت کے وقت اپنی بلند ترین سطح (Optimum level) پر ہوتا ہے کے ساتھ مل کر ایک خاص کیمیائی مادہ پراسٹا گلینڈن (Prostaglandins) کا اخراج کرتا ہے جو کہ یوٹرس میں سکڑاؤ کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور چونکہ دوران ولادت آکسی ٹوسن کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے لہذا یہ مقدار ولادت کے آغاز میں کام آتی ہے۔ اس طرح یہ پراسٹا گلینڈنز اور آکسی ٹوسن باہم ملتے ہیں اور یوٹرس کے سکڑنے کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے جو ولادت کے آخر تک جاری رہتا ہے۔

2۔ **میکینکل وجوہات (Mechanical Causes):** ولادت کے آغاز کے وجوہات میں سے کچھ وجوہات میکانیکل بھی ہوتی ہیں۔ ولادت کے آغاز میں یوٹرس اور سرویکس کی میکانیکل تحریک بھی حصہ لیتی ہے۔ یوٹرس کے کھنچاؤ اور تناؤ کی وجہ سے سرویکس اور جنین کے اعضاء پر دباؤ پڑتا ہے جو ولادت کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ولادت میں تمام کام ہارمونز کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ اس کے میکانیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں۔

3۔ **فندس کا غلبہ (Fundal Dominance):** ولادت کے آغاز میں یوٹرس کے اوپری حصے فندس (Fundus) سے خاص طرح کی لہریں اٹھتی ہیں یہ لہروں کا اٹھنا یوٹرائن کانٹریکشن (Utrine contraction) کے باعث ہوتا ہے۔ ان لہروں کا احساس یوٹرس کے تمام حصوں تک پھیلتا ہے اور وہ یوٹرس کو دباتی ہیں جس کی وجہ سے رحم کے منہ کے کھلنے کا آغاز ہو جاتا ہے اور یوں ولادت ہو جاتی ہے۔

4۔ **سرویکس کا پھیلاؤ (Dilation Of Cervix):** جیسے ہی ولادت کا آغاز ہوتا ہے سرویکس میں پھیلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ولادت سے قبل یہ حصہ تنگ ہوتا ہے۔ ولادت پر اس میں فراخی آنا شروع ہوتی ہے اور یہ اس قدر کھلا ہو جاتا ہے کہ فیس اس میں سے با آسانی گزر جاتا ہے۔ سرویکس کے پھیلنے اور os کے کھلنے میں یوٹرس کردار ادا کرتا ہے۔ یوٹرس کے اندر موجود پانی کی تھیل کا دباؤ بھی اپنا کام دکھاتا ہے اور جنین کا اپنا وزن بھی کام کرتا ہے لہذا یہ تمام عوامل مل کر یوٹرس کا منہ کھول دیتے ہیں جو بچے کی ولادت میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔

5۔ **یوٹرس کی کنٹریکشن اور ریٹریکشن (Contraction & Retraction Of Uterus):** ولادت کے آغاز پر یوٹرس کے پھیلنے اور سکڑنے کا جو عمل شروع ہوتا ہے وہ کنٹریکشن اور ریٹریکشن کہلاتا ہے یہ وہ عمل ہے جو شدت اختیار کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یوٹرس پھیل اور سکڑ کر اندر موجود جنین کو باہر نکال دیتا ہے۔



## ولادت کا آغاز

### (آنسٹ آف لیبر)

#### (ONSET OF LABOUR)

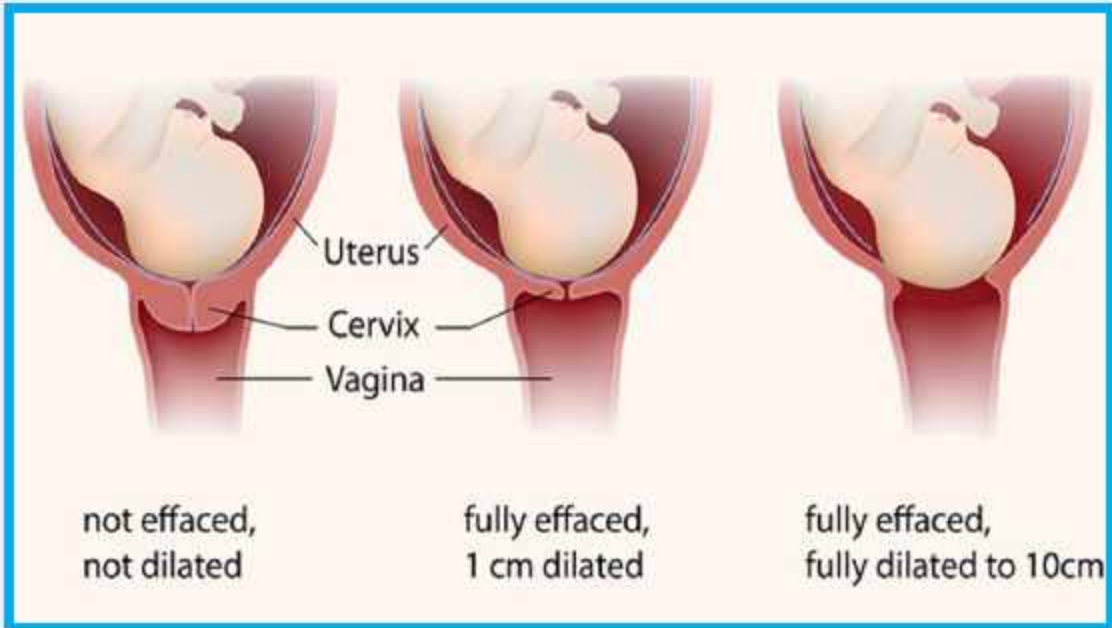
**تعارف (Introduction):** اس سے مراد ولادت کا آغاز ہے۔ اس موقع پر بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ولادت کے آغاز سے قبل آخری دنوں میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ پری مانیٹری سائنز آف لیبر (Premonitory Signs Of Labour) کہلاتی ہیں۔ اس کو ولادت کی پیش رو علامات کہا جاتا ہے۔ یہ علامات جو آخری دنوں میں ظاہر ہوتی ہیں درج ذیل ہوتی ہیں:

**جھوٹا درد (False Pains):** ایسے بھی ہوتا ہے کہ ولادت کی سچی دردوں سے قبل جھوٹی درویں ہوتی ہیں اس کو ولادت کا آغاز خیال کیا جاتا ہے لیکن یہ آغاز ولادت نہیں ہوتا۔ سچا درد کمر سے شروع ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے جبکہ جھوٹا درد پیٹ میں ہوتا ہے یا کہیں اور جگہ ہوتا ہے۔

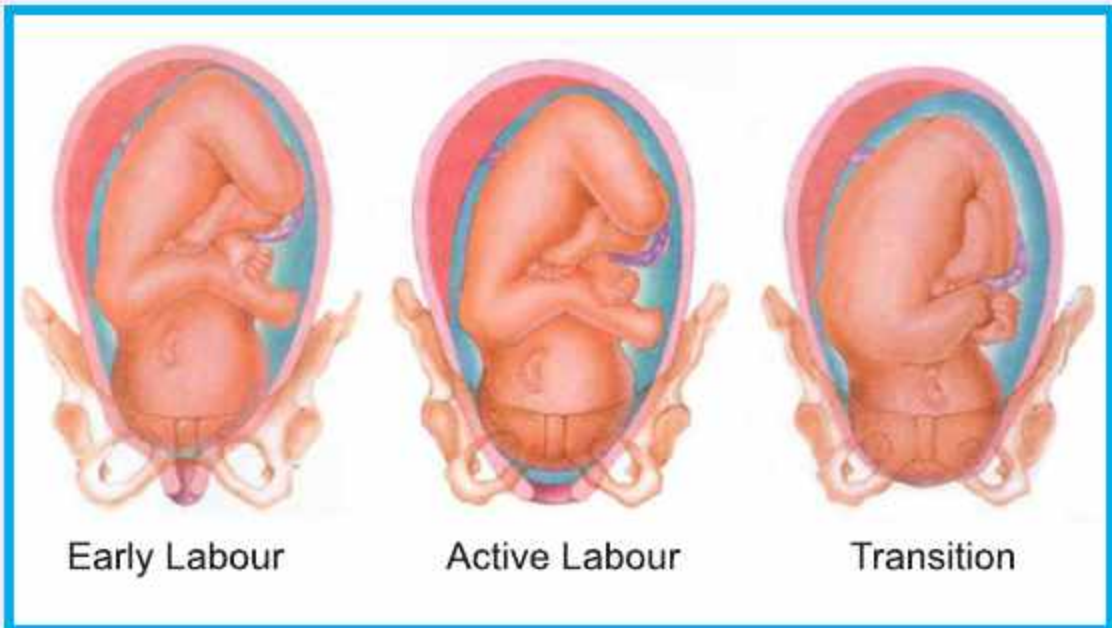
|        |                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | سچے درد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جبکہ جھوٹے درد میں ایسا نہیں ہوتا۔ |
| ☆..... | سچے درد میں ایک باقاعدگی ہوتی ہے جبکہ جھوٹے درد میں بے قاعدگی ہوتی ہے۔                       |
| ☆..... | سچے درد میں یوٹرس کا منہ کھلنے لگتا ہے جبکہ جھوٹے درد میں یوٹرس کا منہ نہیں کھلتا۔           |

**لائٹ ننگ (Lightning):** یہ علامت حمل کے آخری دنوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یوٹرس پیٹ کے زیریں حصہ میں اتر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے حاملہ سکون محسوس کرتی ہے اور سینے پر غیر ضروری دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ دل اور معدے کا فنکشن آسان ہو جاتا ہے۔ حاملہ اپنی طبیعت میں ایک خاص قسم کا ہلکا پن محسوس کرتی ہے اور قدرے بہتر محسوس کرتی ہے۔

**سرویکس کا اوپر اٹھنا (Taking Up The Cervix):** حمل کے آخری دنوں میں سرویکس (Cervix) اوپر کواٹھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ولادت کے مرحلے کیلئے ایک طرح کی تیاری ہو جاتی ہے۔



### Cervical Effacement And Dilatation



### Different Stages Of Labour

**بار بار پیشاب آنا (Bladder Irritation):** جب حمل کے آخری ایام میں لائٹنگ کی علامت کے باعث یوٹرس نیچے کی طرف اتر آتا ہے تو اس کا بوجھ مثانہ پر آ جاتا ہے اور اس وجہ سے حاملہ کو پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے اس وجہ سے مثانہ میں پیشاب جمع ہونے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔

**شو (Show):** حمل کے آخری دنوں میں یوٹرس سے ایک گلابی رنگ کی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے یہ علامت شو (Show) کہلاتی ہے جب یہ علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔



## پرورد ولادت

(ڈسٹوشیا)

(DYSTOCIA)

**تعارف (Introduction):** جب زچگی کے عمل میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے اور ولادت کا عمل مشکل ہو تو اس کنڈیشن کو ڈسٹوشیا یا پرورد ولادت کہتے ہیں۔ ڈسٹوشیا کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں:

|                                        |                                              |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| (Improper position of fetus in uterus) | یوٹرس میں بچے کی پوزیشن صحیح نہ ہو۔          | ☆..... |
| (Fetal anomalies)                      | غذائی کمی کی وجہ سے بچے کی بناؤٹ صحیح نہ ہو۔ | ☆..... |
| (Multiple pregnancy)                   | یوٹرس میں ایک سے زیادہ بچے موجود ہوں۔        | ☆..... |
| (If pregnant female is diabetic)       | اگر حاملہ شوگر کے مرض کی مریضہ ہو۔           | ☆..... |
| (Delayed labour)                       | اگر زچگی کا وقت لیٹ ہوتا جائے                | ☆..... |
| (Birth canal contraction)              | اگر پیدائش کا راستہ برتھ کینال تنگ ہو۔       | ☆..... |
| (Carcinoma cervix)                     | اگر سرویکس کا کینسر ہو۔                      | ☆..... |
| (Carcinoma uterus)                     | اگر یوٹرس کا کینسر ہو۔                       | ☆..... |
| (Low secretion of oxytocic hormone)    | اگر آکسی ٹوسک ہارمون کی کمی ہو۔              | ☆..... |
| (Placenta previa)                      | اگر پلے سینٹا غلط جگہ پر جڑا ہو۔             | ☆..... |



# زچگی کہ بعد کی دردیں

(پوسٹ پارٹم پینز)

(POST PARTUM PAINS)

**تعارف (Introduction):** زچگی کے بعد ہونیوالی دردیں پوسٹ پارٹم پین کہلاتی ہیں یہ دردیں عمومی طور پر بچے کی پیدائش کے فوراً بعد شروع ہوتی ہیں اور دو دن سے لیکر ایک ہفتہ تک جاری رہ سکتی ہیں۔ شدت کے لحاظ سے حساس و نازک مزاج خواتین میں یہ دردیں شدید ہوتی ہیں۔

**وجوہات (Etiology):** پوسٹ پارٹم پین درج ذیل وجوہات کی بناء پر ہوتے ہیں:

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | زچہ کے یوٹرس میں سکڑاؤ اور پھیلاؤ کی وجہ سے یہ دردیں ہوتی ہیں۔                    |
| ☆..... | پلے سینا یوٹرس سے علیحدگی کے وقت زخم پیدا کر دیتا ہے جو کہ درد کا باعث بنتا ہے۔   |
| ☆..... | اگر پلے سینا کا کوئی حصہ یوٹرس میں رہ جائے۔                                       |
| ☆..... | اگر زچہ کے یوٹرس میں انفکشن ہو جائے تو یہ دردیں شروع ہوتی ہیں۔                    |
| ☆..... | اگر زچہ پہلے ہی سے جوڑوں کے درد کی مریضہ ہو تو بھی یہ دردیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ |
| ☆..... | اگر زچہ پہلے ہی سے اعصابی دردوں کی مریضہ ہو۔                                      |
| ☆..... | اگر زچگی کے دوران یوٹرس، سرویکس یا ویجائنہ زیادہ زخمی ہو جائے۔                    |
| ☆..... | بچے کی پیدائش میں آسانی کے لئے ویجائنہ میں چیرا لگا کر ویجائنہ کا سائز بڑا کرنا۔  |
| ☆..... | اگر مریضہ حساس و نازک مزاج ہو اگر مریضہ پہلے ہی سے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو۔    |

**علاج (Treatment):** پوسٹ پارٹم پین کی وجوہات تلاش کر کے مناسب علاج کیا جائے اس کے علاوہ درد کش ادویات کا استعمال، گرم ٹکوریں اور مکمل آرام بہترین نتائج دیتا ہے۔ بہر حال درج ذیل ادویات پوسٹ پارٹم پین کیلئے عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں:

|                     |                        |                              |
|---------------------|------------------------|------------------------------|
| (Dicloran Inj 75mg) | (دردوں اور سوجن کیلئے) | ڈیکلوران انجکشن 75 ملی گرام۔ |
| (Tramal Inj)        | (شدید دردوں کیلئے)     | ٹرامال انجکشن۔               |
| (Nospa forte Tab)   | (مسکولر سپازم کیلئے)   | نوسپا فورٹ گولیاں۔           |
| (Ponstan forte Tab) | (دردوں کیلئے)          | پونستان فورٹ گولیاں۔         |

☆☆☆

## قبل از ولادت جریان خون

(اینٹی پارٹم ہیمریج)

(ANTI PARTUM HAEMORRHAGE)

**تعارف (Introduction):** اس سے مراد وہ جریان خون ہے جو کہ حمل کے اٹھائیس ہفتوں کے بعد سے لے کر زچگی کے دوسرے یا تیسرے درجے تک کسی بھی وقت ہو جائے۔

**وجوہات (Etiology):** اینٹی پارٹم ہیمریج کی وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں؛

|        |                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | کسی بھی بیرونی چوٹ یا دباؤ کی وجہ سے پلے سینفا کا جزوی طور پر علیحدہ ہو جانا۔                                              |
| ☆..... | یوٹرس کے انفیکشن کی وجہ سے پلے سینفا یوٹرس سے آسانی کے ساتھ علیحدہ ہو سکتی ہے۔                                             |
| ☆..... | امبالائیگل کارڈ کی لمبائی کم ہونے کی وجہ سے بھی پلے سینفا مسلسل کچھاؤ کی وجہ سے کسی بھی وقت جزوی طور پر علیحدہ ہو سکتی ہے۔ |
| ☆..... | عام جسمانی کمزوری بھی اینٹی پارٹم ہیمریج کا باعث بن سکتی ہے۔                                                               |
| ☆..... | فالک ایسڈ کی کمی بھی اینٹی پارٹم ہیمریج کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔                                                             |
| ☆..... | گردوں کی پرانی سوزش بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔                                                                                |
| ☆..... | پری ایک لیمپشیا کی وجہ سے بھی اینٹی پارٹم ہیمریج ہو سکتی ہے۔                                                               |
| ☆..... | نفراتل نیکروسس کی وجہ سے بھی اینٹی پارٹم ہیمریج ہو سکتی ہے۔                                                                |

**علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms):**

|        |                                                   |                                      |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ☆..... | حاملہ کو پیٹ میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا ہے۔     | (Vague abdominal pains)              |
| ☆..... | کسی بھی ظاہری وجہ کے بغیر یوٹرائن بلیڈنگ ہوتی ہے۔ | (Uterine bleeding without any cause) |
| ☆..... | بلیڈنگ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔                    | (Low or high bleeding)               |
| ☆..... | پورے یوٹرس میں سختی اور سخت قسم کا درد ہوتا ہے۔   | (Uterine pains)                      |

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (Severe pelvic pains)                   | ☆..... مریضہ پیلووس میں شدید درد ویس محسوس کرتی ہے۔          |
| (Severe vaginal bleeding)               | ☆..... ویجائٹل بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔                  |
| (Patient may go into shock)             | ☆..... مریضہ شاک کا شکار ہو سکتی ہے۔                         |
| (Hypotension)                           | ☆..... بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔                              |
| (Dilated cervix on vaginal examination) | ☆..... ویجائٹل ایگزامی نیشن پر سرویکس قدرے کھلا ہوا ملے گا۔  |
| (Enlarged uterus)                       | ☆..... اجتماع خون کی وجہ سے یوٹرس سائز میں بڑھ جاتا ہے۔      |
| (Nausea and vomiting)                   | ☆..... مریضہ کو متلی و قے ہوتی ہے۔                           |
| (Albuminuria)                           | ☆..... پیشاب میں البیومن پروٹین کا اخراج ہوتا ہے۔            |
| (Patient may become faint)              | ☆..... مریضہ بے ہوش ہو سکتی ہے۔                              |
| (No fetal heart sounds)                 | ☆..... پیٹ میں بچے کے دل کی آوازیں سنائی نہیں دیتیں۔         |
| (Patient may become pallor)             | ☆..... مریضہ کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہیں۔                       |
| (Shortness of breath)                   | ☆..... سانس میں وقت پیش آتی ہے۔                              |
| (Severe weakness)                       | ☆..... مریضہ میں حد درجہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔             |
| (All signs/symptoms of shock present)   | ☆..... مریضہ میں شاک کی تمام علامات و نشانیوں پائی جاتی ہیں۔ |

پیچیدگیاں (Complications): اگر اینٹی پارٹم ہیمریج کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو درج ذیل پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں:

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (Anaemia due to bleeding)            | ☆..... خون کے ضائع ہونے سے انیمیا ہو سکتا ہے۔    |
| (Shock due to severe pains/bleeding) | ☆..... خون کی کمی سے شاک ہو سکتا ہے۔             |
| (Renal failure due to shock)         | ☆..... شاک کی وجہ سے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں۔   |
| (Uraemia due to anaemia)             | ☆..... خون کی کمی سے یوریا کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ |
| (Abortion may take place)            | ☆..... ابارشن ہو سکتا ہے۔                        |

**علاج (Treatment):** اینٹی پارٹم ہیمریج کی وجوہات تلاش کر کے مناسب علاج کیا جائے اس کے علاوہ اینٹی بلیڈنگ اور درودکش ادویات کا استعمال اور مکمل آرام بہترین نتائج دیتا ہے۔ بہر حال درج ذیل ادویات اینٹی پارٹم ہیمریج کیلئے عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں:

|                              |                             |                       |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ٹرانزامن انجکشن۔             | (بلیڈنگ کنٹرول کرنے کیلئے)  | (Transamin Inj)       |
| ایناراکسل انجکشن۔            | (بلیڈنگ کنٹرول کرنے کیلئے)  | (Anaroxyl Inj)        |
| ٹرانزامن کپسول 500 ملی گرام۔ | (بلیڈنگ کنٹرول کرنے کے لئے) | (Transamin Cap 500mg) |
| ڈیکلوران گولیاں 50 ملی گرام۔ | (وردیں کنٹرول کرنے کیلئے)   | (Dicloran Tab 50mg)   |
| کیلسی پلس ساشے۔              | (لوبلڈ پریشر سے بچنے کیلئے) | (Calcee plus sachets) |
| پلازما ایکسپینڈر آئی۔وی۔     | (خون کی کمی کے لئے)         | (Plasma expander I.V) |
| شاک کا علاج کریں۔            | (صدے کی حالت کیلئے)         | (Treatment of shock)  |



## بعد از ولادت جریان خون

(پوسٹ پارٹم ہیمریج)

(POST PARTUM HAEMORRHAGE)

**تعارف (Introduction):** زچگی کے دوران طبعی طور پر ویجائن سے اخراج خون ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ اخراج خون غیر معمولی طور پر زیادہ ہو تو اسے پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں۔ عام طور پر زچگی کے بعد نارمل اخراج خون پانچ سو ملی لیٹر تک ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ہونے والے اخراج خون کو پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں۔ پوسٹ پارٹم ہیمریج زچگی کے فوراً بعد سے زچگی کی مدت یعنی چھ ہفتے کے دوران کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ اگر اخراج خون بچے کی پیدائش کے فوراً بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ہو اور اس کی مقدار پانچ سو ملی لیٹر سے زیادہ ہو تو اسے پرائمری پوسٹ پارٹم ہیمریج کہا جاتا ہے جبکہ اگر اخراج خون بچے کی پیدائش کے چوبیس گھنٹوں کے بعد سے لے کر چھ ہفتوں کے درمیان ہو تو اسے سیکنڈری پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں۔

### وجوہات (Etiology): پوسٹ پارٹم ہیمو رتیج کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں؛

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (Retained piece of placenta)          | ☆..... پلے سینٹیا یا اس کے کسی ایک ٹکڑے کا یوٹرس میں رہ جانا۔ |
| (Placenta previa)                     | ☆..... پلے سینٹیا کا یوٹرس میں کسی غلط مقام پر جڑا ہونا۔      |
| (Dystocia)                            | ☆..... پردر دولا دت کا ہونا۔                                  |
| (Cervical erosion during delivery)    | ☆..... زچگی کے دوران سرویکس کا زخمی ہو جانا۔                  |
| (Wounded birth canal during delivery) | ☆..... زچگی کے دوران برتھ کی نال کا زخمی ہو جانا۔             |
| (Abnormal labour)                     | ☆..... زچگی کا نارمل طریقہ سے نہ ہونا۔                        |
| (Partial detachment of placenta)      | ☆..... پلے سینٹیا کا یوٹرس سے جزوی طور پر علیحدہ ہونا۔        |
| (Multiple pregnancy)                  | ☆..... یوٹرس میں ایک سے زیادہ بچوں کی موجودگی کا ہونا۔        |
| (Polyhydramnios)                      | ☆..... یوٹرس میں امینیا ٹک فلوئیڈ کی زیادتی کا ہونا۔          |
| (Multiple gravida)                    | ☆..... جن عورتوں نے پہلے کئی بچے پیدا کئے ہوں۔                |
| (Early working after delivery)        | ☆..... زچہ کے جلدی چلنے پھرنے اور کام کرنے کی وجہ سے۔         |
| (Any bleeding disorder in female)     | ☆..... اگر زچہ میں خون جمنے کی صلاحیت نہ ہو۔                  |

### علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms): پوسٹ پارٹم ہیمو رتیج میں درج ذیل علامات و نشانیوں پائی جاسکتی ہیں۔

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| (Severe post partum haemorrhage) | ☆..... زچگی کے بعد بہت زیادہ جریان خون ہونا۔ |
| (Hypotension)                    | ☆..... بلڈ پریشر کا گر جانا۔                 |
| (Low pulse)                      | ☆..... نبض کی رفتار کم ہو جانا۔              |
| (Low respiration)                | ☆..... سانس کی رفتار کم ہو جانا۔             |
| (Oliguria)                       | ☆..... پیشاب کا اخراج کم ہو جانا۔            |
| (Fatigue)                        | ☆..... مریضہ کا تھکا ہوا حال ہو جانا۔        |
| (Cold and clammy hands/feet)     | ☆..... مریضہ کے ہاتھ پیروں کا ٹھنڈا پڑ جانا۔ |

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| (Pallor face)      | ☆..... چہرے کے رنگ کا پیلا پڑ جانا۔    |
| (Darkness in eyes) | ☆..... آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا جانا۔ |
| (Dryness of mouth) | ☆..... مریضہ کے منہ کا خشک ہونا۔       |

پیچیدگیاں (Complication): پوسٹ پارٹم ہیمریج کا اگر صحیح طریقہ سے بروقت علاج نہ کیا جائے تو درج ذیل پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں؛

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (Patient may go into shock)         | ☆..... مریضہ شاک میں جا سکتی ہے۔                          |
| (Patient may develop anaemia)       | ☆..... مریضہ انیمیا کا شکار ہو سکتی ہے۔                   |
| (Agalactia)                         | ☆..... مریضہ کی چھاتیوں میں دودھ کی پیدائش کم ہو سکتی ہے۔ |
| (May take more time to gain health) | ☆..... مکمل صحت یابی میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔           |
| (Generalized weakness)              | ☆..... مریضہ کو جنرل کمزوری ہو سکتی ہے۔                   |

علاج (Treatment): پوسٹ پارٹم ہیمریج کے علاج کے سلسلے میں درج ذیل نکات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے؛

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (Blood transfusion if necessary)          | ☆..... ضرورت کے مطابق خون چڑھانا چاہیے۔                        |
| (Diagnose the proper cause )              | ☆..... پوسٹ پارٹم ہیمریج کی وجہ معلوم کریں۔                    |
| (Use haemostatic drugs)                   | ☆..... ہلیڈنگ روکنے والی ادویات کا استعمال کریں۔               |
| (Ligate internal iliac artery if needed)  | ☆..... انٹرنل الیک آرٹری بند کریں تاکہ زیادہ خون نہ بہے۔       |
| (Do symptomatic treatment)                | ☆..... علامتی علاج کرنا چاہیے۔                                 |
| (Check blood pressure repeatedly)         | ☆..... بلڈ پریشر بار بار چیک کرنا چاہیے۔                       |
| (Check pulse repeatedly)                  | ☆..... نبض کی رفتار بار بار مشاہدہ کرنا چاہیے۔                 |
| (Check respiration repeatedly)            | ☆..... مریضہ کی سانس کی رفتار پر نظر رکھنی چاہیے۔              |
| (Check cardiac beat repeatedly)           | ☆..... مریضہ کے دل کی رفتار چیک کرتے رہنا چاہیے۔               |
| (Give glucose, Normal saline, Plasma I.V) | ☆..... گلوکوز یا نارمل سیلائن یا پلازما بذریعہ وین دینا چاہیے۔ |

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| (Transamin Inj)       | ☆..... ٹرانزامن انجکشن دیں۔              |
| (Methargine Tab)      | ☆..... میتھرجن گولیاں دیں۔               |
| (Calcee Plus sachets) | ☆..... کیلسی پلس ساٹھے دیں۔              |
| (Amoxil Inj)          | ☆..... ایماکسل انجکشن دیں۔               |
| (Danzen D.S Tab)      | ☆..... ڈین زین، ڈی ایس گولیاں دیں۔       |
| (Ponstan forte Tab)   | ☆..... پونستان فورٹ گولیاں دیں۔          |
| (Fefol Vit Cap)       | ☆..... فی فال وٹ کپسول دیں۔              |
| (Ciproxin 500mg Tab)  | ☆..... سپر اکسن 500 ملی گرام گولیاں دیں۔ |



## نارمل زچگی کے انتظامات

### (MANAGEMENT OF NORMAL LABOUR)

**تعارف (Introduction):** ایک نارمل زچگی کا کیس آنے پر لیڈی ڈاکٹر یا نرس یا دانی یا لیڈی ہیلتھ وزیٹر کو درج ذیل چار مرحلوں کا انتظام نہایت پروفیشنل طریقے اور مہارت سے کرنا چاہیے۔

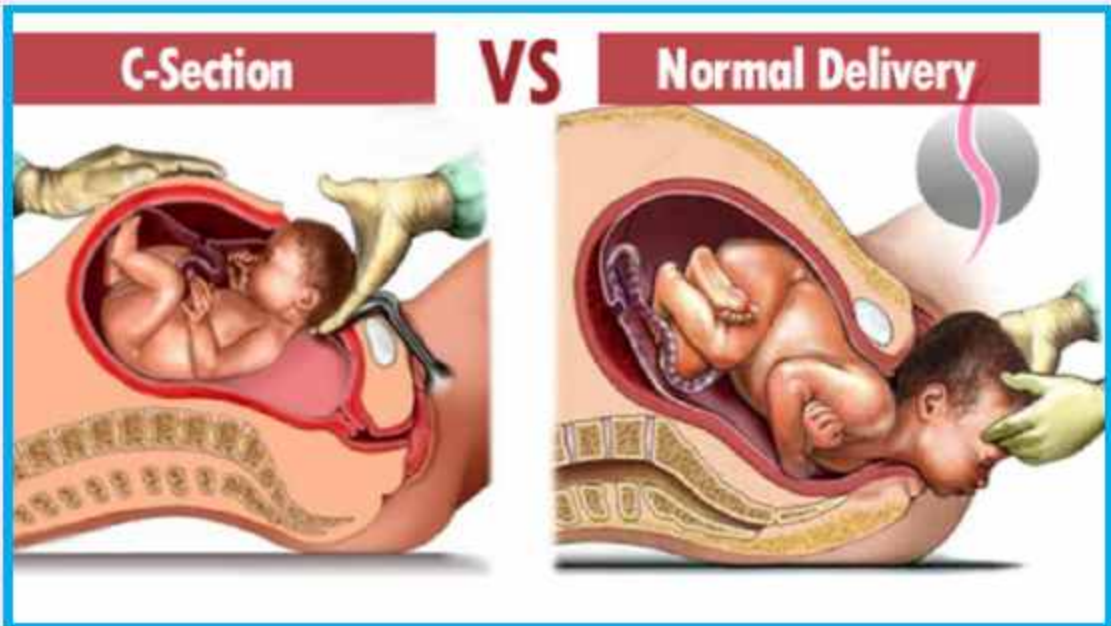
**1۔ پہلے مرحلے کا انتظام (First Stage Of Labour):** زچگی کے پہلے مرحلے میں حاملہ عورت کی طبعی صحت، نبض کی رفتار، جسمانی درجہ حرارت، بلڈ پریشر، سانس کی رفتار، پیشاب کا معائنہ، خون میں ہیموگلوبن، خون میں شوگر کی مقدار اور دل کی دھڑکن کی رفتار وغیرہ نوٹ کرنے کے علاوہ پپائٹائی ٹس بی اور سی کے ٹیسٹ، خون کے جمنے اور بہنے کے ٹیسٹ کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح حاملہ کے پیٹ کا معائنہ کر کے بچے کی پوزیشن کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا دروزہ یعنی لیبر پین جھوٹے ہیں یا سچے، سچے دروزہ کی صورت میں اندرونی معائنہ کر کے یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بچے دانی یعنی یوٹرس کا منہ کتنا کھل گیا ہے اور ایمینیا ٹک ممبرین پھٹ چکی ہے یا کہ نہیں اور زچگی میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ اسی مرحلے میں ضروری احتیاطی تدابیر کے طور پر ڈیوری میں مستعمل تمام آلات، اوزار، دستانے، پیڈ، پٹیاں، گلوں، روئی، چادریں وغیرہ جراثیموں سے پاک کر کے تیار رکھ لی جاتی ہیں۔ اسی طرح ولو اپر موجود بالوں کو صاف کر کے جراثیم کش محلول سے صاف کر لیا جاتا ہے۔ اسی مرحلے میں حاملہ عورت کو بار بار پیشاب کروا کر مثانہ بھی خالی کروایا جاتا ہے اور خوراک کے طور پر نیم ٹھوس و سیال غذا استعمال کرائی جاتی ہے اور اگر کھانا نہ کھایا جاسکے تو پھر گلوکوز ڈرپ بھی لگائی جاسکتی ہے۔ اگر مریض شوگر کے مرض کا شکار ہے تو گلوکوز ڈرپ کے بجائے نارمل سیلان ڈرپ لگائی جاتی ہے۔

**2۔ دوسرے مرحلے کا انتظام (Second Stage Of Labour):** زچگی کا دوسرا مرحلہ سرویکس کے پھیلاؤ سے لے کر یوٹرس سے بچے کی برآمدگی تک مشتمل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں حاملہ کے لئے چلنا پھرنا اور آہستہ آہستہ ٹھلنا بہتر ہوتا ہے لیکن عورت جو نہی یہ بتائے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پیٹ میں موجود بچہ نیچے کی جانب آ رہا ہے تو زچہ کو فوراً نرم، آرام دہ اور جراثیموں سے پاک صاف ستھرے بستر پر لٹا دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں ویجائٹل معائنہ پر یوٹرس کا منہ کھلا ہوا ہوگا اور پیدا ہوتے ہوئے بچے کا سر نظر آ رہا ہوگا۔ زچگی کروانے والی ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ ایک ہاتھ سے زچہ کے اعضاء تناسل کو سہارا دے کر دوسرے ہاتھ کی مدد سے بچے کے سر کو سہارا دیتے ہوئے نہایت آہستگی سے موڑتی رہے یہاں تک کہ بچے کا پورا سر باہر آ جائے۔ بسا اوقات بچے کا سر بڑا ہوتا ہے جس سے کہ زچگی میں زیادہ دیر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں زچہ کی ویجائنہ پر ایک خاص سرجیکل طریقے سے کٹ لگایا جاتا ہے جسے اپی ڈیلاٹومی (Episiotomy) کہتے ہیں تاکہ ویجائنہ کا سائز کھل جائے اور بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے۔ بچے کا سر باہر آتے ہی ویجائنہ میں انگلی ڈال کر یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ پلے سینا بچے کی گردن پر لپٹی ہوئی تو نہیں۔ اس کے علاوہ سر باہر آتے ہی بچے کی آنکھیں صاف کی جاتی ہیں۔ سر کے باہر آنے کے بعد بچے کے کندھے باہر آتے ہیں۔ اس موقع پر بچے کا سر نیچے کی جانب کر کے تھاما جاتا ہے تاکہ بچے کے منہ میں موجود رطوبات خارج ہو جائیں۔ اس موقع پر بچے کے دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد امبالائیکل کارڈ کو اس وقت تک نہیں کاٹا جاتا جب تک کہ بچہ زور سے نہ روئے چلائے، اگر بچہ پیدائش کے بعد نہ رو رہا ہو تو اس کا سر پکڑ کر پیٹھ کو تھپتھپانا چاہیے۔ جس سے کہ بچے کے پھیپھڑوں میں ہوا بھر جاتی ہے اور وہ رونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ امبالائیکل کارڈ میں ایک خاص قسم کی دھڑکن (Pulsation) ہوتی ہے جب یہ ختم ہو جائے تو امبالائیکل کارڈ کو دو کپڑوں کے درمیان باندھ کر صاف ستھرے جراثیموں سے پاک تیز دھار آلے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لئے جراثیموں سے پاک مضبوط دھاگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ امبالائیکل کارڈ کاٹ دینے کے بعد بچے کو گرم تولیے میں لپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہوا لگنے سے محفوظ رہ سکے۔

**3۔ تیسرے مرحلے کا انتظام (Third Stage Of Labour):** زچگی کا تیسرا مرحلہ بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر پلے سینا کے مکمل اخراج تک مشتمل ہوتا ہے۔ زچگی کے دوسرے مرحلے کے بعد یوٹرس کی حرکات کچھ دیر کے لئے بند ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ہی وقفے کے بعد یوٹرس اپنی پوری قوت سے سکڑتا ہے جس سے کہ پلے سینا اور امبالائیکل کارڈ کا بقیہ حصہ یوٹرس سے باہر نکل آتا ہے۔ پلے سینا، کارڈ اور تمام جھلیوں کے اخراج کے بعد زچہ کے اعضاء تناسل، ٹانگوں اور رانوں کو اچھی طرح جراثیم کش لوشن سے صاف کر کے خشک اینٹی سپٹک پیڈ رکھ دیئے جاتے ہیں اور زچہ کو ہر قسم کے انفکشن سے بچانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ اسی دوران زچہ کو مکمل بیڈ ریسٹ کروایا جاتا ہے اور غذا کے طور پر زود ہضم مائع متوازن خوراک استعمال کروائی جاتی ہے۔



Normal Vaginal Delivery



Caesarian Section & Normal Delivery

4۔ چوتھے مرحلے کا انتظام (Fourth Stage Of Labour): ترقی یافتہ ممالک میں زچگی کے چوتھے مرحلے کی دریافت گزشتہ چند سالوں سے ہوئی ہے۔ زچگی کے چوتھے مرحلے میں زچہ اور بچہ دونوں کا مکمل طور پر خیال کیا جاتا ہے یہ مرحلہ زچہ اور بچہ دونوں کی دیکھ بھال پر مشتمل ہوتا ہے اور دونوں کے لئے فائدہ مند ہے۔ اس مرحلے میں نہ صرف زچہ کی نبض، جسمانی درجہ حرارت، بلڈ پریشر، نفاس کے اخراج اور پیشاب کا بار بار معائنہ کیا جاتا ہے بلکہ بچے پر بھی بھرپور توجہ دیتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن، سانس کی رفتار، جسمانی درجہ حرارت، رنگت، بلڈ پریشر، سیرم بلی روبن اور خون کے ٹیسٹ وغیرہ کئے جاتے ہیں اس مرحلے میں زچہ یا بچہ میں کوئی پیچیدگی نظر آئے تو اس کا بروقت تدارک کر لیا جاتا ہے۔



## طبعی وضع حمل

(نارمل لیبر)

(NORMAL LABOUR)

تعارف (Introduction): طبعی وضع حمل ایک قدرتی عمل ہے جس میں حمل کی مدت پوری ہونے پر بچہ پلے سینا، کارڈ اور جھلیاں آٹھ سے سولہ گھنٹوں کے اندر اندر خود بخود بغیر کسی پیچیدگی کے یوٹرس سے خارج ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر حمل کی مدت تقریباً 280 دن تصور کی جاتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ حمل کی مدت 280 دن ہی ہو۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین میں بچہ کی پیدائش 280 دن سے کچھ پہلے یا 280 دن سے کچھ بعد میں ہوتی ہے اور بچہ نارمل وصحت مند ہوتا ہے۔ جوں جوں وضع حمل کا وقت قریب آتا چلا جاتا ہے تو یوٹرس کی تشنجی حرکات میں درجہ بدرجہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوٹرس سکڑ کر اپنے اندر موجود بچے کو باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یوٹرس کے سکڑنے سے زچہ میں درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے درد زہ یا لیبر پین کہتے ہیں۔ طبعی وضع حمل کو درج ذیل تین مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؛

|   |              |                       |
|---|--------------|-----------------------|
| 1 | پہلا مرحلہ۔  | (Stage of dilatation) |
| 2 | دوسرا مرحلہ۔ | (Stage of expulsion)  |
| 3 | تیسرا مرحلہ۔ | (Placental stage)     |

**1۔ پہلا مرحلہ (Stage Of Dilatation):** طبعی وضع حمل کا پہلا مرحلہ لیبر پین کے شروع ہونے سے لے کر یوٹرس کے منہ سرویکس کے مکمل طور پر کھل جانے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جونہی بچے کے پیدا ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو یوٹرس میں باقاعدہ تشنجی حرکات شروع ہو جاتی ہیں اور یوں یوٹرس پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ یوٹرس کے پھیلنے اور سکڑنے سے عورت میں درد کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے لیبر پین کہا جاتا ہے۔ یہ لیبر پین بڑی باقاعدگی اور شدت سے ہوتی ہیں۔ شروع شروع میں ہر تیس سے تیس منٹ بعد لیبر پین آتے ہیں اور تقریباً آدھ منٹ تک جاری رہتے ہیں یہاں تک کہ زچگی کے آخری اوقات میں یہ دروئیں ہر دو تین منٹ بعد ہوتی ہیں اور تقریباً ایک ایک منٹ تک جاری رہتی ہیں۔ ان لیبر پین کے دوران یوٹرس کے بار بار سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے یوٹرس کا منہ سرویکس کھلتا چلا جاتا ہے اور اس حد تک کھل جاتا ہے کہ سرویکس میں چار انگلیاں با آسانی داخل ہو سکتی ہیں۔ ایسی حالت کو سرویکس کا مکمل پھیلاؤ کہا جاتا ہے۔ اسی دوران یوٹرس سے خون ملے سیال مادے کا اخراج ہوتا ہے۔ سرویکس کے مکمل پھیلاؤ پر بچہ سر کے بل نیچے کی جانب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سرویکس کے پھیل جانے پر اس کے منہ پر پانی کی ایک تھیلی ایمینیا ٹنک ممبرین نظر آتی ہے جس کے پھٹ جانے کے بعد لیبر پین کی نوعیت یکسر تبدیل ہو جاتی ہے اور اس طرح طبعی وضع حمل کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔

**2۔ دوسرا مرحلہ (Stage Of Expulsion):** طبعی وضع حمل کا دوسرا مرحلہ سرویکس کے منہ کے کھلنے سے لے کر بچے کی پیدائش تک مشتمل ہوتا ہے۔ ایمینیا ٹنک ممبرین پھٹ جانے پر لیبر پین جلدی جلدی اور شدت کے ساتھ آنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں بچہ کافی نیچے آ جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ حاملہ عورت میں یہ مرحلہ تقریباً ایک گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے جبکہ ایک عورت اگر پہلے بھی حاملہ رہ چکی ہو اور اس تجربے سے کئی مرتبہ گزر چکی ہو تو یہ مرحلہ مختصر وقت میں گزر جاتا ہے۔ اس مرحلے میں لیبر پین جلدی جلدی آتی ہیں۔ بچے کا سر پیلوک فلور پر نظر آتا ہے۔ بچے کا سر یوٹرس کے منہ سرویکس پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے مزید کھول دیتا ہے۔ زچہ خود بھی سانس روک کر نیچے کی جانب زور لگاتی ہے اور اس طرح شدید درد کے ساتھ بچے کا سر اور پھر منہ باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے کے دونوں کندھے شدید درد کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں پھر پیٹ اور ناٹگیں باہر آ جاتی ہیں اور یوں بچے کی پیدائش کے بعد لیبر پین کچھ دیر کے لئے رک جاتے ہیں۔ یہاں بچے کی پیدائش کے طبعی وضع حمل کا دوسرا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔

**3۔ تیسرا مرحلہ (Placental Stage):** طبعی وضع حمل کا تیسرا مرحلہ بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر یوٹرس سے پلے سینا اور جھلیوں کے مکمل اخراج تک مشتمل ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد یوٹرس سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور لیبر پین تقریباً آٹھ گھنٹے کے اندر اندر بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد یوٹرس میں پھر تشنجی حرکات شروع ہو جاتی ہیں اور یوں یوٹرس کے بار بار سکڑنے اور پھیلنے سے پلے سینا اور اس کی جھلیاں شدید درد کے ساتھ خارج ہو جاتی ہیں۔ اس دوران ایک مناسب مقدار میں خون بھی خارج ہوتا ہے۔ اس تیسرے مرحلے میں یوٹرس کے سکڑنے سے یوٹرائن بلڈ ویسلز بھی سکڑنی شروع ہو جاتی ہیں جس سے کہ سیلان خون بھی خود بخود قدرتی طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اگر یوٹرس کسی بھی وجہ سے نہ سکڑے تو پھر سیلان خون جاری رہتا ہے جسے پوسٹ پارٹم ہیمروریج (P.P.H) کہتے ہیں۔



## غیر طبعی وضع حمل

(ابنارمل لیبر)

(ABNORMAL LABOUR)

**تعارف (Introduction):** جب بچے کی پیدائش کے دوران سر کے بجائے جسم کا کوئی دوسرا حصہ پہلے باہر آئے تو ایسی حالت کو غیر طبعی وضع حمل کہا جاتا ہے۔ جسم کے مختلف حصوں کے پہلے باہر آنے کے لحاظ سے غیر طبعی وضع حمل کی درج ذیل اقسام ہیں:

|                           |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| (Breech presentation)     | 1 | کولہے کے رخ پیدائش۔ |
| (Face presentation)       | 2 | چہرے کے بل پیدائش۔  |
| (Brow presentation)       | 3 | ماتھے کے بل پیدائش۔ |
| (Shoulder presentation)   | 4 | کندھے کے بل پیدائش۔ |
| (Transverse presentation) | 5 | بچے کا آڑا رخ۔      |

1- **کولہے کے رخ پیدائش (Breech Presentation):** جب پیدائش کے دوران بچے کے کولہے پہلے یوٹرس سے باہر نکلیں اور باقی اعضاء بعد میں باہر آئیں۔

2- **چہرے کے بل پیدائش (Face Presentation):** جب پیدائش کے دوران بچے کا چہرہ پہلے یوٹرس سے باہر آئے اور باقی اعضاء بعد میں باہر آئیں۔

3- **ماتھے کے بل پیدائش (Brow Presentation):** جب پیدائش کے دوران بچے کا ماتھا یعنی پیشانی پہلے یوٹرس سے باہر آئے اور باقی اعضاء بعد میں باہر آئیں۔

4- **کندھے کے بل پیدائش (Shoulder Presentation):** پیدائش کے دوران بچے کا بازو پہلے یوٹرس سے باہر آئے اور باقی اعضاء بعد میں باہر آئیں۔

5- **بچے کا آڑا رخ (Transverse Presentation):** جب پیدائش کے دوران بچہ یوٹرس سے ترچھے رخ خارج ہو۔

غیر طبعی وضع حمل کی وجوہات (Etiology Of Abnormal Labour): غیر طبعی وضع حمل کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں:

|                                |   |                                                    |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| (Pelvic deformities of female) | 1 | اگر ماں کے کو لہے، سکرے ہوئے اور مردوں کی طرح ہوں۔ |
| (Big sized baby)               | 2 | جب بچہ غیر معمولی طور پر بڑا ہو۔                   |
| (Polyhydramnios)               | 3 | جب امینیا ٹک فلوئڈ زیادہ ہو۔                       |
| (Incomplete baby)              | 4 | جب بچہ نامکمل ہو۔                                  |
| (Abnormal baby)                | 5 | جب بچہ اب نارمل ہو۔                                |
| (Tumor on the neck of baby)    | 6 | بچے کی گردن کے سامنے کوئی ٹیومر وغیرہ ہو۔          |
| (Uterine anomalies)            | 7 | جب یوٹرس پیداؤشی طور پر ناقص ہو۔                   |
| (Placenta previa)              | 8 | اگر پلے سینٹا درست جگہ پر پوسٹ نہ ہو۔              |

غیر طبعی وضع حمل کی تشخیص (Diagnosis Of Abnormal Labour): عام طور پر حمل کے 34 ہفتوں کے بعد بچے کا رخ بدل کر غیر طبعی رخ ہو جاتا ہے جو عموماً آخری وقت تک رہتا ہے اور وضع حمل غیر طبعی رخ پر ہوتا ہے اس کی تشخیص درج ذیل طریقوں سے ہو سکتی ہے:

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | پیٹ کے اوپر ٹوٹل کر یوٹرس کے اوپر بچے کا سر محسوس کیا جاسکتا ہے۔                                 |
| 2 | اگر بچے کے دل کی حرکات کی آواز ناف کے اوپر سنائی دے تو بھی بچے کے غلط رخ کی تشخیص ہو سکتی ہے۔    |
| 3 | اسی طرح ویجائنہ میں انگلی ڈال کر بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ بچے کا سر نیچے ہے یا چوتڑا نیچے ہیں۔ |
| 4 | حاملہ کا ایڈامٹیل یا ٹرانس ویجائٹل الٹراساؤنڈ کرنے سے بھی بچے کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے۔         |



## ولادت میں استعمال ہونے والی ادویات

### (USE OF MEDICINES DURING LABOUR)

**تعارف (Introduction):** اگر ولادت کے کسی مرحلے پر کوئی وقت پیش آئے تو ادویات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ان ادویات کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کسی وجہ سے جنین کے اخراج میں دیر ہو رہی ہو یا در دیں کمزور ہوں یا پھر جنین کا اخراج ہو جائے لیکن پلے سینا کا اخراج نہ ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ اخراج خون زیادہ ہو تو اس کا اخراج کم کرنے کیلئے بھی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ ولادت کیلئے یا اس کے دوران استعمال ہونے والی چند ادویات کا ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>☆..... اس انجکشن کا استعمال ضرورت کے مطابق 5 سے 10 یونٹ تک کیا جاتا ہے۔ یہ انجکشن انٹراسکولر استعمال کیا جاتا ہے لیکن خاص حالات میں اس انجکشن کا استعمال بذریعہ وین بھی کیا جاسکتا ہے۔</p> <p>☆..... اگر کوئی عورت ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو تو اس کو پیچیدگی سے بچاتا ہے۔ یہ ایک آکسی ٹوسک ایجنٹ (Oxytocic agent) ہے۔ یاد رہے جب تک رحم کا منہ نہ کھلے اس انجکشن کا استعمال ہرگز نہ کریں۔</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>سینٹوسینا انجکشن<br/>(Santocina Inj)</p>    |
| <p>☆..... اس انجکشن میں سینٹوسینا اور ارگومیترون دونوں اجزاء شامل ہوتے ہیں اس میں سینٹوسینا 5 یونٹ اور ارگومیترون 0.5 ملی گرام شامل ہوتا ہے۔ ان دونوں دواؤں کے اس مرکب کا اثر زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے یوٹرس کے سکڑنے کا عمل بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو پیدائش میں آسانی کا سبب بنتا ہے۔</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ارگومیترون انجکشن<br/>(Ergometrine Inj)</p> |
| <p>☆..... پروسٹین ایک بہت تیز اثر کرنے والی گولی ہے۔ یہ اندام نہانی کے اندر رکھنے والی گولی ہے۔ اس کا استعمال بھی اس وقت ہوتا ہے جب ولادت کے آثار شروع ہو جائیں۔</p> <p>☆..... اس گولی کو اندام نہانی کے اندر گہرائی میں سرویکس کے قریب رکھا جاتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ایک گولی کا منہ کرے تو 6 گھنٹے بعد دوسری گولی کا استعمال کیا جاتا ہے۔</p> <p>☆..... یہ گولی رحم کے قدرتی عمل کو ابھارتی ہے اور اس میں کنٹریکشن کے عمل کو تحریک دیتی ہے اور اس کے اثر سے رحم کا منہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور ولادت کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔</p> <p>☆..... اس کا استعمال احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ ایسی عورت جو چھ سے زیادہ بچوں کو پیدا کر چکی ہو اس میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر جھلی پھٹ چکی ہو تو اس کے بعد اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جس عورت میں بڑے آپریشن کی ہسٹری موجود ہو اس میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر بچے کی پوزیشن درست نہ ہو تو تب بھی اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔</p> | <p>پروٹین گولیاں<br/>(Prostin vaginal Tab)</p> |

☆☆☆

## ولادت میں درد کش ادویات کا استعمال

(لیبر اینل جیزیا)

(LABOUR ANALGESIA)

**تعارف (Introduction):** ولادت کا مرحلہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اور اس تکلیف کی شدت مختلف عورتوں میں مختلف ہوتی ہے۔ اس کا انحصار عورت کی صحت پر بھی ہوتا ہے اور عورت کی برداشت کی قوت پر بھی ہوتا ہے۔

☆..... اگر کوئی عورت بہت نازک مزاج ہو اور اس سے یہ درد برداشت نہ ہو رہی ہو تو حسب ضرورت درد کش ادویات کا بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ ضرورت ایسی عورتوں میں پیش آتی ہے جو پہلی مرتبہ ماں بن رہی ہوں۔

☆..... اس مقصد کیلئے ایسی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے استعمال سے درد کی شدت کم ہو جاتی ہے اور عورت آسانی کے ساتھ ولادت کے مرحلے سے گزر جاتی ہے۔ ان ادویات کے استعمال سے درد کا احساس کم ہو جاتا ہے۔

☆☆☆.....

## نشہ آور درد کش ادویات

(نارکائٹک انیلجیسکس)

(NARCOTIC ANALGESICS)

**تعارف (Introduction):** اس مقصد کیلئے ایسے انجکشن استعمال کئے جاتے ہیں جو نشہ آور اثر رکھتے ہیں۔ اس کے استعمال سے درد کا احساس کم ہو جاتا ہے اور مریضہ نشہ کی حالت میں چلی جاتی ہے۔ اس نشہ کی حالت میں ولادت ہو جاتی ہے اور حاملہ کیلئے درد کی اذیت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا انجکشن احتیاط سے استعمال کرنا چاہئے تاکہ جنین متاثر نہ ہو۔ اس مقصد کیلئے عام طور پر مندرجہ ذیل انجکشن استعمال کئے جاتے ہیں؛

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>☆..... اس انجکشن کا استعمال پشت پر لمبر کے مقام پر کیا جاتا ہے۔ یہ بہت تیز دوا ہے جو کمر کے مقام پر نشہ طاری کر دیتی ہے۔ اس سے درد کا احساس فوری ختم ہو جاتا ہے اور بچے کی پیدائش بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر 2 گھنٹے تک رہتا ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر آپریشن یا فورسپس ڈیلیوری میں کیا جاتا ہے۔ اسکو احتیاط سے استعمال کرنا چاہئے جو عورتیں کمر کی تکلیف میں مبتلا ہوں ان میں اس کا استعمال ممنوع ہے۔</p> | <p>اپی ڈیورل انجکشن<br/>(Epidural Inj)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ☆..... یہ ایک گیس کے استعمال کا طریقہ ہے۔ اس میں آکسیجن اور نائٹروجن کا استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں گیسوں کو برابر مقدار میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال ایک خاص ماسک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک آسان اور بے ضرر طریقہ ہے۔ اس کے استعمال سے تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔                   | انتوناکس<br>(Entonox)                  |
| ☆..... یہ ایک سادہ شکل کی مشین ہوتی ہے جو بیٹری کے ذریعے کام کرتی ہے۔ اس میں الیکٹرک کرنٹ درد کا احساس ختم کر دیتا ہے۔ اس میں استعمال کیلئے خاص طرح کے پیڈز ہوتے ہیں۔ ان کو درد والی جگہ پر لگایا جاتا ہے اور اس سے درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور یہ ایک محفوظ طریقہ ہے۔ | ٹائنز مشین<br>(Tiens Machine)          |
| ☆..... بیرون ممالک میں یہ طریقہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں عورت کو ولادت کے مرحلے میں مناسب گرم درجہ حرارت والے تالاب میں بٹھا دیا جاتا ہے جس سے درد کا احساس کم ہو جاتا ہے اور عورت سکون سے پیدائش کے مرحلے سے گزر جاتی ہے۔                                                                   | گرم پانی کا تالاب<br>(Warm Water Pool) |



## کارڈ پرولیپس

(CORD PROLAPSE)

**تعارف (Introduction):** یہ بھی ولادت کی پیچیدگیوں میں سے ایک پیچیدگی ہے۔ اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ ولادت کے وقت سب سے قبل بچے کا سر سامنے آنا چاہئے لیکن اس کی بجائے امبالائیکل کارڈ (Umbilical Card) سامنے آ جاتی ہے اور اس طرح اس کارڈ کی حیثیت پہلے اگلے حصے (First Frontal Part) کی سی بن جاتی ہے۔ حاملہ میں جب یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو تھیلی پھٹ چکی ہوتی ہے۔ یہ حالت کیوں پیدا ہوتی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے کچھ عام وجوہات کا ذکر درج ذیل ہے:

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... Breech Presentation کی حالت ہو تو اس کی وجہ سے کارڈ پرولیپس کی حالت ہو سکتی ہے۔ |
| ☆..... Shoulder Presentation کی وجہ سے بھی کارڈ پرولیپس کی حالت ہو سکتی ہے۔            |
| ☆..... Brow Presentation کی وجہ سے بھی کارڈ پرولیپس کی حالت ہو سکتی ہے۔                |

|        |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | تھیلی پھٹنے کے بعد اگر ایمینیا ٹک فلوئیڈ بہت تیزی سے بہہ جائے تو اس کی وجہ سے بھی کارڈ پروپس کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ |
| ☆..... | Multiple Pregnancy کی حالت کی وجہ سے بھی کارڈ پروپس کی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔                                          |
| ☆..... | اگر تھیلی پھٹنے کے بعد بچے کا سر درست وقت پر باہر نہ آئے تو کارڈ پروپس کی حالت ہو سکتی ہے۔                            |
| ☆..... | زیادہ بچوں والی عورتوں میں عضلات کے ڈھیلے پن سے بھی یہ حالت ہو سکتی ہے۔                                               |
| ☆..... | Pre Term Labour کی وجہ سے بھی یہ حالت ہو سکتی ہے۔                                                                     |

علاج (Treatment): کارڈ پروپس کے علاج کے لئے درج ذیل اقدامات اختیار کرنے چاہئیں:

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | علاج کیلئے سب سے قبل بچے کی پوزیشن معلوم کریں اور اس کو سامنے رکھ کر علاج کریں۔           |
| ☆..... | خیال رکھیں کہ کارڈ دبنے نہ پائے کیونکہ کارڈ کے دب جانے سے بچے کا دم گھٹ سکتا ہے۔          |
| ☆..... | کارڈ میں ایک نبض کی سی حالت ہوتی ہے اس کو محسوس کریں۔                                     |
| ☆..... | کارڈ کے دبنے سے بچے میں آکسیجن کی کمی (Hypoxia) واقع ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ |
| ☆..... | اگر زیادہ شدید حالت ہو تو چھوٹا آپریشن یعنی اپی زیٹومی (Episiotomy) کر لیں۔               |
| ☆..... | اگر کسی احتیاطی طریقہ سے کارڈ ہٹ جائے تو اس کو ہٹا دیں، اس طرح نارمل ولادت ہو سکتی ہے۔    |



## رحم کا الٹ جانا (ان وورژن آف یوٹرس) (INVERSION OF UTERUS)

**تعارف (Introduction):** بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ولادت کے تیسرے درجے میں رحم الٹا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی حالت بہت کم دیکھنے میں آتی ہے لیکن یہ ممکنہ پیچیدگی ہے اس حالت میں رحم کا فنڈ انس اندر کو دھنس جاتا ہے۔ اگر یہ حالت بہت سنگین ہو جائے تو زچہ مر بھی سکتی ہے۔

**وجوہات (Causes):** رحم کے الٹ جانے کی وجوہات درج ذیل ہیں:

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (Uterine weakness)                        | ☆ ..... رحم کی کمزوری کی وجہ سے رحم کے الٹنے کی حالت پیدا ہو سکتی ہے |
| (Atonic uterus)                           | ☆ ..... یوٹرس کی فالجی حالت میں رحم الٹ سکتا ہے۔                     |
| (Cord extract before uterine contraction) | ☆ ..... یوٹرس میں سکڑاؤ پیدا نہ ہوا اور کارڈ کو کھینچ لیا جائے۔      |
| (Placental expulsion wrongly)             | ☆ ..... پلے سینٹا کو خارج کرنے کیلئے غلط طریقہ اختیار کیا جائے۔      |
| (Extra pressure building by the female)   | ☆ ..... زچگی کے وقت عورت بلاوجہ زور لگائے۔                           |
| (It may happen in multigravida female)    | ☆ ..... زیادہ بچوں والی عورت میں رحم الٹ سکتا ہے۔                    |

**علامات و نشانیوں (signs/Symptoms):** رحم کے الٹ جانے کی علامات درج ذیل ہیں:

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (Severe pains)                          | ☆ ..... اس تکلیف کے باعث عورت کو شدید دروس ہوتی ہیں۔             |
| (Tense feeling at ovaries)              | ☆ ..... رحم کے الٹ جانے سے اووریز میں کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے۔      |
| (Uterus may be visible in vagina)       | ☆ ..... اگر کیس شدید ہو تو یوٹرس کو ویجاٹنا میں دیکھا جاسکتا ہے۔ |
| (Vaginal bleeding may or may not occur) | ☆ ..... اس میں جریان بھی ہو سکتا اور نہیں بھی ہوتا۔              |
| (Patient may go into shock)             | ☆ ..... مریضہ صدمے کی حالت میں جاسکتی ہے۔                        |
| (Hypotension may occur)                 | ☆ ..... اس حالت میں بلڈ پریشر عام طور پر کم ہو جاتا ہے۔          |
| (Irritation)                            | ☆ ..... حاملہ بہت زیادہ بے چینی اور بے قراری محسوس کرتی ہے۔      |

علاج (Treatment): رحم کے الٹ جانے کے علاج کے لئے درج ذیل اقدامات اختیار کرنے چاہئیں:

|        |                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | اگر مریضہ پر بے ہوشی یا Shock میں جانے کی علامات ظاہر ہو رہی ہوں تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔       |
| ☆..... | یوٹرس کی گردن یعنی سرویکس پر مناسب طریقہ سے دباؤ ڈالا جائے تاکہ یوٹرس اپنی اصل حالت پر آجائے۔                   |
| ☆..... | اخراج خون کی حالت میں اس کو روکنے کی کوشش کریں۔                                                                 |
| ☆..... | اگر یہ حالت پلے سینا کے اخراج سے قبل ہو تو پہلے یوٹرس کی حالت کو درست کریں پھر پلے سینا کی اخراج کا تدارک کریں۔ |



## دوران ولادت یوٹرس کا پھٹ جانا

### (RUPTURE OF UTERUS DURING LABOUR)

تعارف (Introduction): یوٹرس ولادت سے قبل بھی پھٹ سکتا ہے اور دوران ولادت بھی پھٹ سکتا ہے۔ اس وقت ہم یہاں دوران ولادت یوٹرس کے پھٹ جانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے اس سے پیچیدہ صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔

علامات و نشانی (signs/Symptoms): دوران ولادت یوٹرس کے پھٹ جانے کی عام علامات درج ذیل ہیں:

|        |                                                            |                                       |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ☆..... | حاملہ کو پیٹ اور پیلوئس میں شدید قسم کا درد محسوس ہوتا ہے۔ | (Severe abdominal / pelvic pains)     |
| ☆..... | درد کا یہ احساس مسلسل جاری رہتا ہے۔                        | (Continous pains)                     |
| ☆..... | اس درد کے ساتھ متلی بھی ہو سکتی ہے۔                        | (Nausea may occur)                    |
| ☆..... | جریان خون ہوتا ہے جو خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔                | (Vaginal bleeding may occur)          |
| ☆..... | اس حالت کی وجہ سے مریضہ صدمے میں جاسکتی ہے۔                | (Patient may go into shock)           |
| ☆..... | یوٹرس پھٹ جانے سے سکڑاؤ کی علامت ختم ہو جاتی ہے۔           | (No uterine contraction)              |
| ☆..... | بچے کی ولادت کیلئے پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔                | (Complication in delivery)            |
| ☆..... | یوٹرس کے پھٹنے سے جنین کا دم گھٹ سکتا ہے۔                  | (Fetal asphyxia may occur)            |
| ☆..... | اس حالت میں زچہ اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔      | (Life threatening for female / fetus) |

علاج (Treatment): یوٹرس کے پھٹ جانے کے علاج کے لئے درج ذیل اقدامات اختیار کرنے چاہئیں:

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ☆..... | جریان خون کی صورت میں خون کو فوری روکنے کے اقدامات کریں۔     |
| ☆..... | مریضہ شاک کی حالت میں ہو تو اسے کنٹرول کرنے کی اقدامات کریں۔ |
| ☆..... | بچے کو خطرہ ہو تو فوری آپریشن کے ذریعے اس کی جان بچائیں۔     |
| ☆..... | بچے کو بذریعہ آپریشن نکال کر یوٹرس کو ناکے لگائیں۔           |
| ☆..... | خون بہہ جانے کی صورت میں انتقال خون کا انتظام کریں۔          |
| ☆..... | خون لگانے سے قبل ایڈز اور ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کریں۔            |
| ☆..... | مناسب آئی وی لائن دیں۔                                       |
| ☆..... | مناسب سیٹرائیڈز کا استعمال کریں۔                             |
| ☆..... | مناسب اینٹی بائیوٹک دوا کا استعمال کریں۔                     |
| ☆..... | مناسب اینٹل جیسک دوا کا استعمال کریں۔                        |



## پلے سینٹا اندر رہ جانا

(ری ٹینڈ پلے سینٹا)

(RETAINED PLACENTA)

تعارف (Introduction): پیدائش کے تیسرے مرحلے میں پلے سینٹا قدرتی طور پر باہر آ جاتا ہے لیکن بعض حالتوں میں اس کے اخراج میں تاخیر ہو جاتی ہے یا اس کا اخراج رک جاتا ہے۔ یہ حالت Retained Placenta کہلاتی ہے۔

ری ٹینڈ پلے سینٹا کی وجوہات (Causes Of Retained Placenta): اس کی عام وجوہات درج ذیل ہیں:

|        |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | پلے سینٹا کے رک جانے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یوٹرس کی دیوار سے الگ ہی نہ ہو وہ بدستور یوٹرس کے ساتھ جڑا رہے۔                                                                                                  |
| ☆..... | ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ پلے سینٹا یوٹرس کی دیوار سے جدا تو ہو جاتا ہے لیکن یوٹرس سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ یوٹرس کی گردن سرویکس کے قریب آ کر رک جاتا ہے۔ اس دوسرے طریقے میں پلے سینٹا کو آسانی سے خارج کیا جاسکتا ہے۔ |

**ریٹینڈ پلے سینٹا کا علاج (Treatment Of Retained Placenta):** پلے سینٹا کے اخراج کیلئے درج ذیل تدابیر اختیار کی جاتی ہیں؛

**کارڈ ٹریکشن (Cord Traction):** اس طریقہ کے مطابق یوٹرس میں سکڑاؤ (Contraction) پیدا کرنے کیلئے انجکشن لگایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کارڈ کے بیرونی سرے کو ڈاکٹر انگلی کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیتی ہے اور انتظار کیا جاتا ہے کہ زچہ کے یوٹرس میں شدید سکڑاؤ (Severe Contraction) پیدا ہو اور جب یوٹرس میں سکڑاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو درد کی ایک لہریں اٹھتی ہے تو اسی اثناء کارڈ کو قدرے کھینچا جاتا ہے اور اس طرح کرنے سے پلے سینٹا الگ ہو کر باہر آ جاتا ہے۔ اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ جب تک یوٹرس میں کانٹرکشن پیدا نہ ہو اس وقت تک کارڈ کو ہرگز نہ کھینچا جائے کیونکہ غلط وقت پر کارڈ کو کھینچنے سے پیچیدگی کا خطرہ ہوتا ہے۔

**فندل پریشر کا استعمال (Using Fundal Pressuer):** یہ بھی پلے سینٹا کے اخراج کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں ڈاکٹر عورت کے دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر ہاتھ کی ہتھیلی سے یوٹراؤن فندس پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالتی ہے۔ اس میں خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ دباؤ کنٹرکشن کے وقت ڈالا جائے۔ اگر کنٹرکشن کے علاوہ دباؤ ڈالا جائے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ درست وقت پر دباؤ ڈالنے سے پلے سینٹا الگ ہو کر باہر آ جاتا ہے۔ پلے سینٹا کے الگ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کارڈ کے بیرونی حصہ کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویجائنا کے راستے سے خون کا اخراج ہونے لگتا ہے یوٹرس کی شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پلے سینٹا یوٹرس سے الگ ہو جاتا ہے اور ویجائنا میں آ کر رک جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو ہاتھ ڈال کر نکال لیا جاتا ہے۔

**پیچیدگیاں (Complications):** ریٹینڈ پلے سینٹا کی پیچیدگیاں درج ذیل ہیں جن کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے؛

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | اگر اس رُکے ہوئے پلے سینٹا کے اخراج کیلئے مناسب طریقے اختیار نہ کئے جائیں تو پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ |
| ☆..... | غلط طریقہ کی وجہ سے یوٹرس الٹ سکتا ہے۔                                                                |
| ☆..... | اس کی وجہ سے بعد از ولادت جریان ہو سکتا ہے اور زچہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔                         |

**ادویاتی علاج (Medicinal Treatment):** ریٹینڈ پلے سینٹا کی پیچیدگیوں کی صورت میں درج ذیل ادویات استعمال کی جاسکتی ہیں؛

|        |                      |                     |
|--------|----------------------|---------------------|
| ☆..... | انجکشن آکسی ٹوسن۔    | (Oxytocin Inj)      |
| ☆..... | انجکشن ٹرانزامن۔     | (Transamin Inj)     |
| ☆..... | میٹھر جن گولیاں۔     | (Methergine Tab)    |
| ☆..... | نیوبرال فورٹ گولیاں۔ | (Nuberal forte Tab) |
| ☆..... | آئی وی ڈرپ۔          | (I.V. Drip)         |



## ولادت بذریعہ سرجری

(آبسٹٹرک آپریشن)

(OBSTETRIC OPERATION)

**تعارف (Introduction):** بعض اوقات مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ نارمل ولادت ممکن نہیں رہتی اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ولادت میں سرجری کا استعمال کیا جائے۔ اس مقصد کیلئے سرجری کے جو طریقے اختیار کئے جاتے ہیں اس میں دو طرح کے طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔ ہم ان دونوں کی الگ الگ تفصیل درج کر رہے ہیں:

|   |                                             |                     |
|---|---------------------------------------------|---------------------|
| 1 | اپی زیوٹومی یعنی ویجائٹل کٹ لگانا۔          | (Episiotomy)        |
| 2 | سیزیرین سیکشن یعنی ولادت بذریعہ بڑا آپریشن۔ | (Caesarean Section) |



## اپی زیوٹومی

(EPISIOTOMY)

**تعارف (Introduction):** دوران ولادت دوسرے درجے میں بعض اوقات بچے کی پیدائش میں وقت پیش آتی ہے۔ جنین کا سر باہر نہیں آتا کیونکہ ولوا کے بیرونی سو راخ میں اس قدر جگہ نہیں ہوتی کہ سر باہر آ سکے۔ اس حالت میں ولادت کو آسان بنانے کیلئے Perineal Tissues کو کاٹ کر اس قدر جگہ بنائی جاتی ہے کہ جنین باہر آ سکے۔ چیرا لگا کر جنین کے باہر آنے کیلئے گنجائش پیدا کرنے کا یہ طریقہ اپی زیوٹومی یعنی چھوٹا آپریشن کہلاتا ہے۔

**وجوہات (Causes):** مندرجہ ذیل ممکنہ وجوہات کی بناء پر اپی زیوٹومی کی جاتی ہے یا یہ کہہ لیں کہ ان حالات میں اپی زیوٹومی ناگزیر ہو جاتی ہے:

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | ولادت کی وقت دور کرنے کیلئے اپی زیوٹومی کی جاتی ہے۔                            |
| ☆..... | عورت کو زچگی کی تکلیف (Maternal Trauma) سے بچانے کیلئے اپی زیوٹومی کی جاتی ہے۔ |

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | بچے پر آنے والے دباؤ کو کم کرنے کیلئے اپنی زیوٹومی کی جاتی ہے۔             |
| ☆..... | مریضہ کی ہسٹری پیچیدہ ہو تو تب آسانی کے لئے اس کا سہارا لیا جاتا ہے۔       |
| ☆..... | جنین کی پریزینٹیشن درست نہ ہو تو تب بھی اپنی زیوٹومی کی جاتی ہے۔           |
| ☆..... | پیری نیم کے مسلز کو ضرورت سے زیادہ کھنچاؤ سے بچانے کیلئے ایسا کیا جاتا ہے۔ |
| ☆..... | بچے کا سر نارمل سے بڑا ہو تو اپنی زیوٹومی کرنی پڑتی ہے۔                    |
| ☆..... | بچے کا سر نظر آ رہا ہو لیکن باہر آنے میں تاخیر ہو تب بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ |



## چیرا کی اقسام (TYPES OF INCISION)

**تعارف (Introduction):** جب اپنی زیوٹومی کیلئے چیرا لگایا جاتا ہے تو اس کیلئے نشتر یا قینچی استعمال کی جاتی ہے لیکن ضرورت اور حالات کے مطابق چیرا لگانے کیلئے مختلف طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔ عام طور پر مندرجہ ذیل طریقے اختیار کئے جاتے ہیں؛

|        |                            |                           |
|--------|----------------------------|---------------------------|
| ☆..... | میڈیول ایٹرل اپنی زیوٹومی۔ | (Medio lateral episotomy) |
| ☆..... | میڈیل اپنی زیوٹومی۔        | (Medial episotomy)        |
| ☆..... | لیٹرل اپنی زیوٹومی۔        | (Lateral episotomy)       |

مذکورہ بالا طریقہ ہائے کار میں چیرا لگانے کے مقام اور زاویہ وغیرہ کا فرق ہوتا ہے۔ پہلی قسم میں پیری نیم کے سائیڈ اور قدرے وسطی حصے میں چیرا لگایا جاتا ہے۔ دوسرے طریقے میں ویجائنا کے نیچے پیری نیم کے عین وسط میں چیرا لگایا جاتا ہے جبکہ تیسرے طریقے میں پیری نیم کے سائیڈ حصے سے چیرا لگایا جاتا ہے۔

**چیراگانے کا مناسب وقت (Time Of Incision):** اپنی زیوٹومی کے عمل میں چیراگانے کے وقت کا بڑا عمل دخل اور اہمیت ہے۔

☆..... اگر وقت سے قبل چیراگا دیا جائے تو خون بلاوجہ بہتا رہے گا جو زچہ کیلئے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

☆..... لیکن اگر یہ چیرا درست وقت پر لگایا جائے تو زچہ کا خون کم سے کم نکلے گا۔

☆..... اس کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب بچے کا سر نظر آنے لگتا ہے اور وہ باہر آنے کو تیار ہوتا ہے۔

☆..... اس طرح کرنے سے خون کم ضائع ہوتا ہے اور فوری ولادت ہو جاتی ہے۔

☆..... اگر چیراگانے میں تاخیر ہو جائے تب بھی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے اور اس طرح پیری نیم پر خود بخود چیرا آ سکتا ہے جو مشکل پیدا کر سکتا ہے۔

☆..... چیراگانے سے پیری نیم کی جلد پیری نیم کے مسلز اور ویجائنا کی عقبی دیوار کٹتی ہے جسے بعد میں ٹانکے لگا دیئے جاتے ہیں۔

**پیری نیم کو سن کرنا (Perineal Anesthesia):** جب چیراگانا ہوتا ہے تو اس سے قبل مقامی طور پر پیری نیم کو سن کر لیا جاتا ہے۔ اس مقصد

کیلئے زائیلو کین کا انجکشن (Inj. Xylocaine) استعمال کیا جاتا ہے۔ انجکشن لگنے کے چند منٹ بعد پیری نیم اور اس سے ملحقہ علاقہ سن ہو جاتا

ہے۔ وہاں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور پھر چیراگا دیا جاتا ہے۔

☆..... زائیلو کین انجکشن ایک خاص طریقے سے لگایا جاتا ہے یہ انجکشن عضلات میں لگایا جاتا ہے۔ زائیلو کین انجکشن چیراگاتے وقت پیری نیم

کے سامنے تقسیم کر کے دو سے تین جگہ پر لگایا جاتا ہے۔

**چیراگانا (Incision):** اپنی زیوٹومی کے عمل کے دوران چیراگانے کے لئے خاص طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؛

☆..... چیراگانے کے خاص طریقے کے لئے خاص قسم کی قنچی یا خاص قسم کا نشتر یعنی سر جیکل بلنڈ استعمال کیا جاتا ہے۔

☆..... یوٹرائن کانٹریکشن کے وقت جب مسلز تناؤ میں ہوتے ہیں تو اس وقت چیراگایا جاتا ہے۔

☆..... مقاصد کے حصول کیلئے تین سے چار سینٹی میٹر تک لمبا کٹ لگایا جاتا ہے۔

☆..... چیرا ہمیشہ مناسب وقت پر لگایا جاتا ہے۔

☆..... جب چیراگانے کا وقت ہوتا ہے تو بچے کا سر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔

☆..... چیراگاتے وقت اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچے کا سر زخمی نہ ہونے پائے۔

**پیری ٹیم کی مرمت (Perineal Repair):** چیراگانے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اگلا مرحلہ پیری ٹیل ری پیئر کا ہوتا ہے؛

☆..... چیراگانے کے بعد جب بچہ باہر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے زچہ کا خون بند کیا جاتا ہے۔

☆..... متعلقہ جگہ کو سن کر کے ٹانگے لگا کر مرمت کر دی جاتی ہے۔

☆..... ٹانگوں والی جگہ کو جراثیم کش دوپائیوڈین (Pyodine) سے دھو دیا جاتا ہے۔

☆..... ٹانگے لگانے کے بعد عورت کو آرام سے لٹا دیا جاتا ہے۔

☆..... زچہ کو روزمرہ کاموں میں خصوصی طور پر احتیاط کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔



## سیزیرین سیکشن

(ولادت بذریعہ آپریشن)

(CAESAREAN SECTION)

**تعارف (Introduction):** ولادت کے لئے سرجری کی یہ دوسری صورت ہے جس کو عام روزمرہ کی زبان میں بڑا آپریشن کہتے ہیں اور یہ میڈیکل کی اصطلاح میں سیزیرین (Caesarean) کہلاتا ہے۔ یہ ایک میجر سرجری ہے۔ اس میں پیٹ میں کٹ لگا کر جنین کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اس آپریشن کے کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ وجوہات کے اعتبار سے اس آپریشن کو دو اہم اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک میں قبل از وقت فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور دوسرے میں بروقت فیصلہ کیا جاتا ہے۔

**قبل از وقت فیصلہ (Elective Caesarean Section):** عقل مند خواتین حمل قرار پانے کے ساتھ ہی کسی ڈاکٹر یا L.H.V سے رابطہ قائم کر لیتی ہیں اور مناسب وقفہ سے اپنا چیک اپ کراتی رہتی ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر حاملہ کی حالت سے مسلسل آگاہ رہتی ہے اور اگر حمل کے آخر میں ایسی حالت ہو جس کی وجہ سے ڈاکٹر محسوس کرے کہ ولادت آپریشن کے بغیر نہیں ہوگی تو اس کا فیصلہ قبل از وقت کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح قبل از وقت فیصلہ برائے آپریشن مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔

- ☆..... رحم میں ایک سے زیادہ جنین ہونے کی وجہ سے کوئی پیچیدگی ہو تو آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
- ☆..... پلے سینفا پر یو یا ہوا اور پلے سینفا نے یوٹرس کے منہ کو بند کر رکھا ہو تو اس حالت میں نارمل ڈیلیوری ممکن نہیں ہوتی تو آپریشن کیا جاتا ہے۔
- ☆..... کمزور خواتین میں یوٹرس کی کمزوری کی وجہ سے اگر وہ ولادت کی تکلیف برداشت نہ کر سکتی ہوں تو بھی آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
- ☆..... جن عورتوں کا اس سے قبل بھی آپریشن ہو چکا ہو ان کی ولادت دوبارہ بذریعہ آپریشن ہی کی جاتی ہے۔
- ☆..... جن عورتوں میں پیلوئس بہت تنگ ہو تو ان میں نارمل ڈیلیوری ممکن نہیں ہوتی تو ایسے میں ڈیلیوری بذریعہ آپریشن کی جاتی ہے۔
- ☆..... اگر کسی وجہ سے بچے کی پوزیشن درست نہ ہو تو نارمل ولادت ممکن نہیں ہوتی لہذا قبل از وقت آپریشن کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔

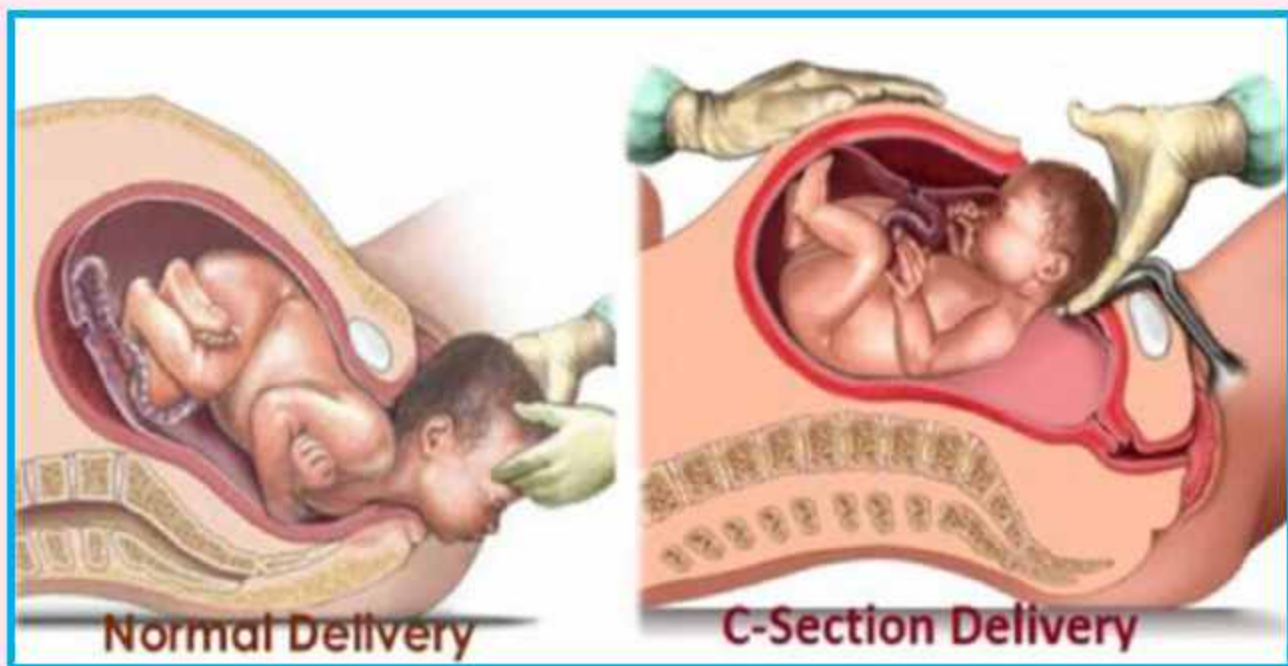
**ہنگامی فیصلہ (Emergency Caesarean Section):** بعض اوقات حمل کے حالات یکلخت تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایسی صورت سامنے آتی ہے کہ نارمل ولادت ممکن نہیں رہتی۔ اس صورت میں ڈاکٹر ہنگامی طور پر آپریشن کا فیصلہ کرتی ہے۔ ایمرجنسی یا ہنگامی طور پر آپریشن کا فیصلہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے:

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | اگر کسی پیچیدگی سے یوٹرس پھٹ جائے تو ہنگامی آپریشن ناگزیر ہوتا ہے۔                         |
| ☆..... | بعض اوقات ولادت کے مراحل کے دوران جنین باہر نہیں آتا اور آپریشن کرنا پڑتا ہے۔              |
| ☆..... | فورسپس ڈیلیوری ناکام ہو جائے تو آپریشن ناگزیر ہوتا ہے۔                                     |
| ☆..... | اگر جنین کو باہر لانے کیلئے وکیوم کا طریقہ بھی ناکام ہو جائے تو آپریشن کیا جاتا ہے۔        |
| ☆..... | قبل از ولادت جریان خون سے زچہ کی جان کو خطرہ ہو تو تب آپریشن کرنا لازم ہو جاتا ہے۔         |
| ☆..... | زچہ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں فوری طور پر آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔   |
| ☆..... | ولادت کا دوسرا مرحلہ طویل ہو جائے تو جنین کی زندگی بچانے کیلئے آپریشن لازمی ہو جاتا ہے۔    |
| ☆..... | دوران ولادت کارڈ پروفلس (Cord Prolapse) ہونے سے آپریشن کرنا پڑتا ہے۔                       |
| ☆..... | اگر ایک لیمپٹیا یا پری ایک لیمپٹیا کی حالت پیدا ہو جائے تو بھی آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ |

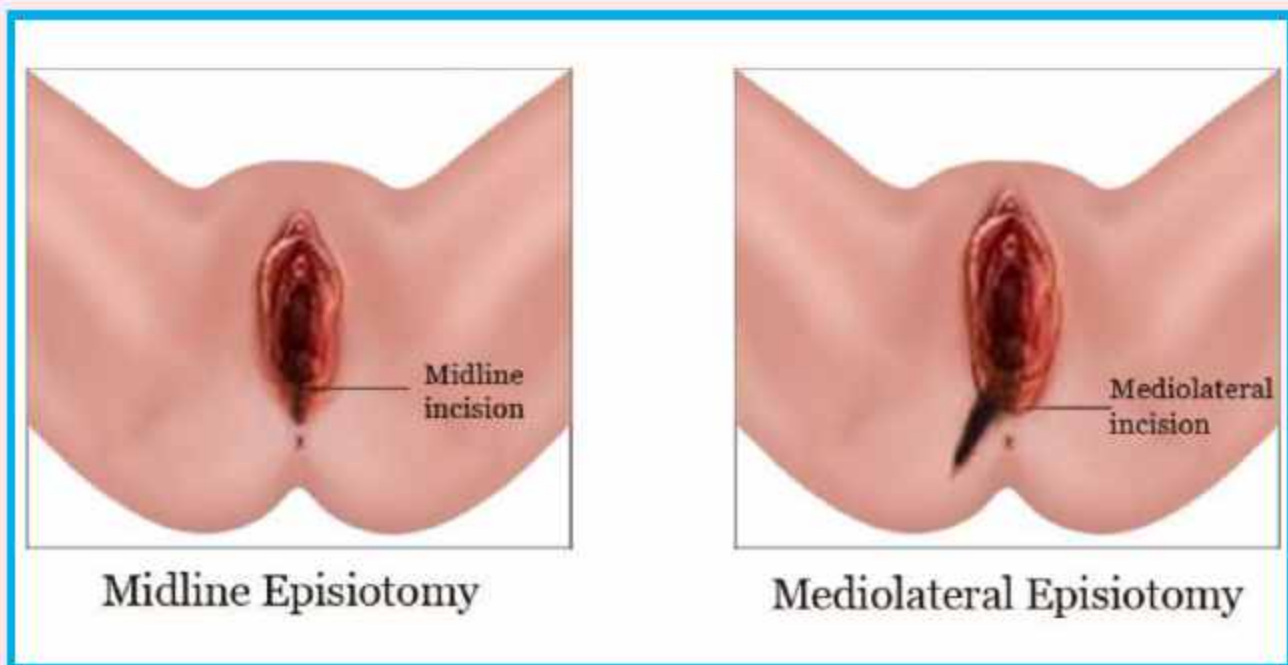
## آپریشن کیلئے تیاری (Preparation Of Operation):

|        |                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | عورت کو ذہنی طور پر آپریشن کیلئے تیار کریں اور اس کو آپریشن کی نوعیت سے آگاہ کر دیں۔                                        |
| ☆..... | آپریشن سے قبل عورت کا ٹمبر پچر، بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائیٹس بی، ہیپاٹائیٹس سی اور بلیڈنگ ٹائم وکلائنگ ٹائم چیک کیا جاتا ہے۔ |
| ☆..... | عورت کے زیر ناف بال صاف کئے جاتے ہیں۔                                                                                       |
| ☆..... | انیہما کے ذریعے ریکٹم خالی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ زچہ کو پیشاب کروا کر مثانہ بھی خالی کر دیا جاتا ہے۔                   |
| ☆..... | خون کا ٹیسٹ کر کے خون کا گروپ معلوم کر لیا جاتا ہے تاکہ انتقال خون کی صورت میں وقت نہ ہو۔                                   |
| ☆..... | آپریشن تھیز کو جراثیم کش ادویات سے دھو دیا جاتا ہے۔                                                                         |
| ☆..... | آپریشن میں استعمال ہونے والے تمام اوزار سٹرلائز کئے جاتے ہیں۔                                                               |
| ☆..... | ایئر جیسی کیلئے آکسیجن سلنڈر کا انتظام کیا جاتا ہے۔                                                                         |
| ☆..... | آپریشن تھیز کا درجہ حرارت مناسب رکھا جاتا ہے۔                                                                               |
| ☆..... | آنے والے مہمان کیلئے کپڑوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔                                                                           |
| ☆..... | ایئر جیسی کی صورت میں استعمال کیلئے جزیئر کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔                                                        |
| ☆..... | آپریشن سے قبل ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے اور جو کپڑے پہنے ہوں وہ بھی جراثیم سے پاک ہوں۔                            |
| ☆..... | ہر طرح کا انتظام مکمل کر کے اللہ کا نام لے کر آپریشن کر دیا جاتا ہے۔                                                        |





Normal &amp; C-Section Delivery



Types Of Episiotomy

## فورسپس ڈیلیوری

(ولادت بذریعہ فورسپس)

(FORCEPS DELIVERY)

**تعارف (Introduction):** جس طرح بعض اوقات ولادت کیلئے سرجری کا سہارا لینا پڑتا ہے اسی طرح ولادت کروانے کے ایک طریقہ کو ولادت بذریعہ فورسپس (Forceps Delivery) کہتے ہیں۔ اس طرح کی ڈیلیوری میں ایک خاص آلہ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو فورسپس کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ بظاہر صورتحال نارمل ڈیلیوری کی نظر آتی ہے، یوٹرائن کانٹرکشن کی علامات موجود ہوتی ہیں۔ یوٹرس درست انداز میں سکڑ رہا ہوتا ہے لیکن اس سکڑاؤ اور عورت کے مناسب زور لگانے کے باوجود جنین باہر نہیں آتا تو اس وقت فورسپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فورسپس کا استعمال کیس کی نوعیت اور درجہ بندی کے پیش نظر کیا جاتا ہے یہ درجہ بندی درج ذیل ہے؛

|   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | ہائی کیویٹی یعنی زیادہ جوف۔ | (High Cavity) |
| 2 | مڈ کیویٹی یعنی درمیانہ جوف۔ | (Mid Cavity)  |
| 3 | لو کیویٹی یعنی کم جوف۔      | (Low Cavity)  |

اس میں High Cavity اور Mid Cavity کا استعمال آپریشن کی صورت میں ہوتا ہے اور Low Cavity کا استعمال ویجاٹا کے راستے ڈیلیوری میں ہوتا ہے۔

**فورسپس کے استعمال کی وجوہات (Causes Of Forceps Use):** مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر فورسپس استعمال کیا جاتا ہے؛

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | ولادت کا دوسرا درجہ بہت طوالت اختیار کر لے تو فورسپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔              |
| ☆..... | زچہ بہت زیادہ تھک جائے اور رحم کا سکڑاؤ کمزور پڑ جائے تو فورسپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔   |
| ☆..... | دوران ولادت جنین دباؤ کا شکار ہو تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔                            |
| ☆..... | بچے کی پوزیشن میں معمولی فرق ہو تو فورسپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔                         |
| ☆..... | اگر حاملہ زور نہ لگ سکے یا اس کیلئے زور لگانا خطرناک ہو تب بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ |
| ☆..... | ایسی کمزور اور نحیف حاملہ جس میں جسمانی رد عمل بہت کمزور ہو تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ |

### فورسپس کا استعمال (Use Of Forceps): فورسپس کو استعمال کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے؛

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | سب سے پہلے فورسپس (Forecps) کو جراثیم پاک کرنے کیلئے سٹرلائز کریں۔                    |
| ☆..... | حاملہ کے ولوا کے بال صاف کر دیئے جائیں۔                                               |
| ☆..... | حاملہ کے مثانہ کو خالی کر دیا جائے۔                                                   |
| ☆..... | جنین (Fetus) کی پوزیشن کا مکمل اندازہ کر لیں۔                                         |
| ☆..... | فورسپس اندر داخل کرتے وقت دھیان رکھیں کہ اس کے دونوں بلیڈ بچے کے سر کے اطراف میں ہوں۔ |
| ☆..... | ایسا ہرگز نہ ہو کہ بلیڈ بچے کے چہرے یا کسی اور حصہ کی جانب ہوں۔                       |
| ☆..... | اس کے بعد فورسپس کے ہینڈل کو باہم ملا لیا جائے اور ہینڈل کو پکڑ لیں۔                  |
| ☆..... | اب کانٹرکشن کا انتظار کریں جب درد کی لہر اٹھے تو اس وقت احتیاط سے فورسپس کھینچیں۔     |
| ☆..... | اس طرح کرنے سے بچہ باہر آ جائے گا۔                                                    |

### فورسپس ڈیلیوری کی پیچیدگیاں (Complications Of Forceps Delivery): فورسپس ڈیلیوری کے جہاں پر فائدے ہیں اور اس سے ولادت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں اس کے نقصان یا پیچیدگیاں بھی ہیں اس طرح کی ولادت سے درج ذیل پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؛

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ☆.....                                   | اس طرح کے عمل میں بچے کو زخم یا خراشیں آ سکتی ہیں۔     |
| ☆.....                                   | بچے کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔                     |
| ☆.....                                   | بچے کی کھوپڑی کی ہڈیاں دباؤ میں آ کر متاثر ہو سکتی ہے۔ |
| ☆.....                                   | سر پر دباؤ آنے سے بچہ کسی معذوری کا شکار ہو سکتا ہے۔   |
| ☆.....                                   | عورت کے اعضاء زخمی ہو سکتے ہیں۔                        |
| ☆.....                                   | عورت پر ٹراوما (Trauma) کی حالت آ سکتی ہے۔             |
| ☆.....                                   | اندام نہانی کی دیواروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔          |
| ☆.....                                   | زچہ بچہ کسی شدید پیچیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔          |
| (Abrasions on baby)                      |                                                        |
| (Trauma to baby brain)                   |                                                        |
| (Pressure effects on baby cranium)       |                                                        |
| (Abnormality due to cranial pressure)    |                                                        |
| (Birth canal may wounded)                |                                                        |
| (Female may suffer from trauma)          |                                                        |
| (Vaginal walls may wounded)              |                                                        |
| (Any complication occur for baby/mother) |                                                        |



## پلے سنٹل ابریپشن

(پلے سینٹا کا یوٹرس سے علیحدہ ہو جانا)

### (PLACENTAL ABRUPTION)

**تعارف (Introduction):** یہ حالت بھی حمل کی پیچیدگیوں میں سے ایک پیچیدگی ہے۔ اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ حمل کے تقریباً 28 ہفتے کے بعد کسی وجہ سے پلے سینٹا یوٹرس کی دیوار سے الگ ہو جاتی ہے۔ جسے Premature Separation Of Placenta کہتے ہیں یعنی زچہ میں پلے سینٹا، یوٹرس کی دیواروں سے وقت سے پہلے الگ ہو جاتی ہے۔ اپنی کیفیت اور شدت کے لحاظ سے اس کو تین اقسام میں بانٹا جاسکتا ہے:

|   |                             |                               |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | ہلکا پلے سنٹل ابریپشن۔      | (Mild Placental Abrupton)     |
| 2 | درمیانہ پلے سنٹل ابریپشن۔   | (Moderate Placental Abrupton) |
| 3 | بہت زیادہ پلے سنٹل ابریپشن۔ | (Severe Placental Abrupton)   |

#### 1۔ ہلکا پلے سنٹل ابریپشن (Mild Placental Abrupton):

- ☆..... یہ پلے سنٹل ابریپشن کی معمولی کیفیت ہوتی ہے۔ اس حالت میں پلے سینٹا کا معمولی سا حصہ الگ ہوتا ہے۔
- ☆..... معمولی طور پر پلے سینٹا کے الگ ہونے سے عام طور پر زچہ بچہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔
- ☆..... اس کنڈیشن میں محض توجہ اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مسلسل نگرانی کی جائے تو زچہ پیدائش تک کا عرصہ بغیر خوبی گزار لیتی ہے۔
- ☆..... اس کی وجہ سے حاملہ کسی خاطر خواہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتی۔
- ☆..... اس معمولی علیحدگی کے باوجود بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس کی ہر طرح کی ضرورت پلے سینٹا کے ذریعے پوری ہوتی رہتی ہے۔
- ☆..... اس میں معمولی جریان خون ہوتا ہے جسے کنٹرول کرنے سے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔

#### 2۔ درمیانہ پلے سنٹل ابریپشن (Moderate Placental Abrupton):

- ☆..... یہ بھی پلے سینٹا کے الگ ہونے کی ایک صورت ہے اس میں پلے سینٹا کی علیحدگی درمیانے درجے کی ہوتی ہے۔
- ☆..... اس درمیانے درجہ میں پلے سینٹا کا  $1/4$  حصہ الگ ہو جاتا ہے۔

- ☆..... اس کی وجہ سے جریان خون ہوتا ہے اور خون کافی مقدار میں بہتا ہے۔ اگر یہ جریان خون شدید ہو تو ایک لیٹر تک خون بہہ سکتا ہے۔
- ☆..... یہ حالت خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔
- ☆..... اس حالت میں عام طور پر مریضہ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔
- ☆..... جنین کی حالت بے یقینی والی ہوتی ہے۔ اس کے زندہ بچ جانے اور مرجانے کے امکانات برابر ہوتے ہیں۔
- ☆..... اس کی وجہ سے جنین کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی کمی سے جنین مرجاتا ہے اور اگر آکسیجن کی کمی نہ ہو تو زندہ رہتا ہے۔
- ☆..... اس حالت میں زچہ اور بچہ دونوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

### 3۔ بہت زیادہ پلے سینٹل ابرپشن (Severe Placental Abruption):

- ☆..... یہ پلے سینٹا کے الگ ہونے کی ایک زبردست خطرناک حالت ہوتی ہے۔
- ☆..... اس حالت میں پلے سینٹا کا تقریباً 60% حصہ الگ ہو جاتا ہے۔
- ☆..... اس میں جریان خون انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ شدید حالت میں خون کا اخراج دو لیٹر تک ہو سکتا ہے۔
- ☆..... یہ انتہائی خطرناک جریان خون زچہ کی جان لے سکتا ہے۔
- ☆..... اس حالت میں بلڈ پریشر انتہائی درجہ تک کم ہو جاتا ہے۔
- ☆..... اس طرح کی حالت میں جنین کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔
- ☆..... اکثر کیسوں میں جنین مرجاتا ہے۔
- ☆..... بہت سے کیسوں میں جریان خون کے باعث زچہ بھی مرجاتی ہے۔

### پلے سینٹل ابرپشن کی علامات (Signs & Symptoms Of Placental Abruption): پلے سینٹا کے الگ ہونے کی جوتین

صورتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے حوالے سے علامات میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ہم ان علامات کا ذکر کر رہے ہیں جو سب میں مشترک ہو سکتی ہیں؛

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (Upper abdominal pain)     | ☆..... عام طور پر پیٹ میں بالخصوص بالائی حصہ میں درد کا احساس ہوتا ہے۔ |
| (Nausea and vomiting)      | ☆..... متلی اور قے کی حالت ہو سکتی ہے جو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔       |
| (Headache in some females) | ☆..... بعض عورتوں میں سر درد کا بھی احساس ہوتا ہے۔                     |

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (Pallor due to haemorrhage) | ☆.....جریان خون کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے اور رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ |
| (Generalized oedema)        | ☆.....مریضہ کے چہرے اور ہاتھوں پر اڈیما کی حالت پیدا ہوتی ہے۔           |
| (Hypotension)               | ☆.....اس کی وجہ سے مریضہ کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے۔                       |
| (Patient may go into shock) | ☆.....بعض صورتوں میں مریضہ شاک میں چلی جاتی ہے۔                         |
| (Blurring of vision)        | ☆.....بعض صورتوں میں نظر دھندلا جاتی ہے یعنی زچہ کو کم نظر آتا ہے۔      |
| (Perspiration)              | ☆.....اکثر اس حالت میں مریضہ کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔                    |
| (Generalized irritation)    | ☆.....زچہ پر ایک بے چینی، بے قراری اور پریشانی کی حالت طاری ہوتی ہے۔    |

### پیچیدگیاں (Complications): پلے سینٹل ابریشن کی پیچیدگیاں درج ذیل ہیں؛

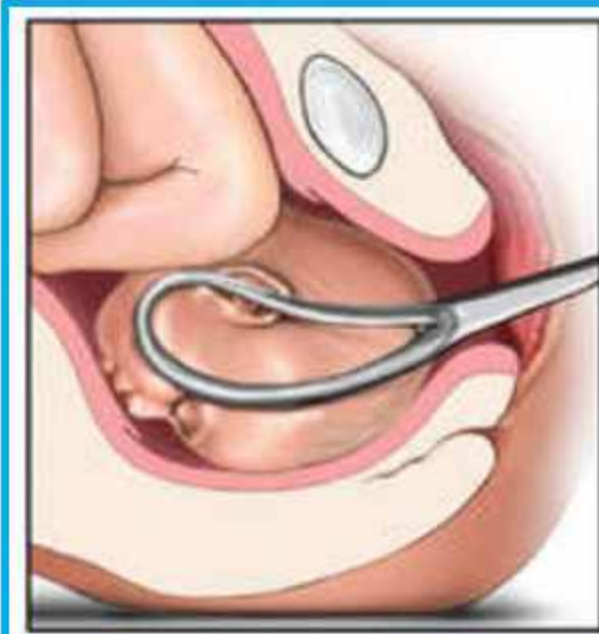
|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (Death may occur due to bleeding)  | ☆.....جریان خون نقصان دہ ہو سکتا ہے جس سے مریضہ کی جان جاسکتی ہے۔ |
| (Severe anaemia)                   | ☆.....خون کی شدید کمی پیدا ہو جاتی ہے۔                            |
| (Hypoxia may occur in baby)        | ☆.....فیش کو آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے۔                            |
| (Hypoxia may occur in patient)     | ☆.....زچہ میں بھی آکسیجن کی کمی کی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔          |
| (Both may die in severe condition) | ☆.....شدید حالت میں زچہ بچہ میں سے کوئی ایک یا دونوں مر سکتے ہیں۔ |
| (Other complications may occur)    | ☆.....اس کے علاوہ بھی بہت سی پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں۔           |

### علاج (Treatment): پلے سینٹل ابریشن کا علاج نہایت احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ کرنا چاہیے؛

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| (Control B.P)       | ☆.....بلڈ پریشر کنٹرول کریں۔                  |
| (Haemostatic drugs) | ☆.....خون بند کرنے کے اقدامات کریں۔           |
| (Complete bed rest) | ☆.....مریضہ کو فوری طور پر مکمل آرام کروائیں۔ |

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (Blood transfusion)          | ☆.....خون زیادہ بہہ جانے کی صورت میں خون کے انتقال کا انتظام کریں۔ |
| (Disinfected blood)          | ☆.....صحت مند آدمی کا خون لگوائیں جو جراثیموں سے پاک ہو۔           |
| (O <sub>2</sub> Inhalation)  | ☆.....سانس کی وقت کی صورت میں فوری آکسیجن کا انتظام کریں۔          |
| (I.V. Drip)                  | ☆.....آئی وی ڈرپ لگائیں۔                                           |
| (Anti bleeding drugs)        | ☆.....اینٹی بلیڈنگ ڈرگز استعمال کروائیں۔                           |
| (Suitable Antibiotic)        | ☆.....حسب ضرورت مناسب اینٹی بائیوٹک کا استعمال کریں۔               |
| (Normal saline/glucose drip) | ☆.....نارمل سیلین یا گلوکوز ڈرپ لگائیں۔                            |
| (Transamin Inj)              | ☆.....ٹرانز امین انجکشن لگائیں۔                                    |
| (Valium Inj)                 | ☆.....ولیئم انجکشن لگائیں۔                                         |
| (Cefixime Inj)               | ☆.....سیف ایگزائم انجکشن لگائیں۔                                   |
| (Methargine Tab)             | ☆.....میٹھرجن گولیاں۔                                              |
| (Xanax 0.25mg Tab)           | ☆.....زینیکس گولیاں 0.25 ملی گرام۔                                 |
| (Buscopan plus Tab)          | ☆.....بسکوپان پلس گولیاں۔                                          |
| (Cefspan 400mg Cap)          | ☆.....سینفس پان کیپسولز 400 ملی گرام۔                              |





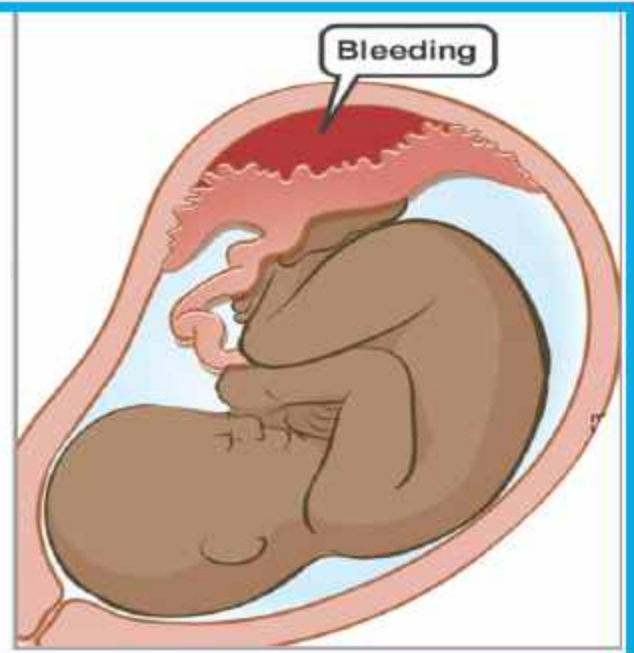
Forceps Delivery



Vacuum Extraction



Normal Placenta



Placental Abruption

## پری ایکلیمپسیا - ایکلیمپسیا

### (PRE ECLAMPSIA & ECLAMPSIA)

پری ایکلیمپسیا (Pre Eclampsia): حمل کے اٹھائیسویں ہفتے کے بعد کسی بھی وقت، خاص طور پر حمل کی تکمیل پر حاملہ عورت میں مندرجہ ذیل علامات کے پیدا ہوجانے کی حالت کو پری ایکلیمپسیا کہتے ہیں؛

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (Hypertension)                           | ☆..... حاملہ عورت کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔                    |
| (Oliguria)                               | ☆..... اس کا پیشاب بہت کم ہو جاتا ہے                           |
| (Proteinuria)                            | ☆..... پیشاب میں پروٹین خارج ہوتے ہیں۔                         |
| (Generalized oedema)                     | ☆..... عام طور پر اڈیما ہو جاتا ہے۔                            |
| (Increase in weight)                     | ☆..... مریضہ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔                               |
| (Oedematous body)                        | ☆..... جسم میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔                           |
| (Headache)                               | ☆..... مریضہ کو سر میں درد ہوتا ہے۔                            |
| (Blurring of vision)                     | ☆..... مریضہ کو آنکھوں کے سامنے دھبے سے نظر آتے ہیں۔           |
| (Vomiting)                               | ☆..... مریضہ کو قے ہوتی ہے۔                                    |
| (If not treated may developed Eclampsia) | ☆..... اگر مناسب علاج نہ ہو تو مریضہ کو ایکلیمپسیا ہو جاتا ہے۔ |

پری ایکلیمپسیا کی مریضہ کی دیکھ بھال بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسے آرام کرنے کی ہدایت کی جائے۔ اسے ایسی متوازن غذائی جائے جس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتا کہ پیشاب میں خارج ہونے والی پروٹین کی کمی کو پورا کیا جاسکے۔ اڈیما کی حالت میں مریضہ کو نمک نہ کھانے کی ہدایت کی جائے۔ پیشاب کا معائنہ اور مریضہ کا وزن روزانہ چیک کیا جائے اور اسے علامات کے مطابق ادویات دی جائیں تاکہ ایکلیمپسیا سے بچا جاسکے۔

ایکلیمپسیا (Eclampsia): ایکلیمپسیا وضع حمل سے پہلے، دوران میں یا بعد میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر پری ایکلیمپسیا کے بعد ہوتا ہے۔ یہ حالت پری ایکلیمپسیا سے کہیں زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کنڈیشن میں زچہ کی جان بچانے کیلئے حمل کو ضائع کرنا پڑتا ہے۔ ایکلیمپسیا کی علامات پری ایکلیمپسیا سے انتہائی شدید ہوا کرتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں؛

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (Severe headache)                  | ☆..... مریضہ کو شدید سر درد ہوتا ہے۔               |
| (Severe vomiting)                  | ☆..... مریضہ کو شدید قے آتی ہے۔                    |
| (Oliguria)                         | ☆..... پیشاب کا اخراج بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔        |
| (Dimness of vision)                | ☆..... مریضہ کی نظر انتہائی کمزور ہو جاتی ہے۔      |
| (Smoke in front of eyes)           | ☆..... اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھا جاتی ہے۔    |
| (Diplopia)                         | ☆..... مریضہ کو ایک ایک کے دو دو نظر آتے ہیں۔      |
| (Lightning in front of eyes)       | ☆..... آنکھوں کے سامنے روشنیاں نظر آتی ہیں۔        |
| (Severe abdominal pain)            | ☆..... مریضہ کو پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔          |
| (Hypertension)                     | ☆..... مریضہ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے۔     |
| (Severe vaginal bleeding)          | ☆..... بہت زیادہ ویجاٹل بلیڈنگ ہوتی ہے۔            |
| (Ringings in the ears)             | ☆..... کانوں میں گھنٹیوں کی سی آوازیں آتی ہیں۔     |
| (All signs of shock are present)   | ☆..... صدمے کی تمام علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔       |
| (Weak puls)                        | ☆..... نبض کم چلتی ہے۔                             |
| (Difficulty in breathing)          | ☆..... سانس میں وقت ہوتی ہے۔                       |
| (Semiconsciousness is present)     | ☆..... نیم بے ہوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے۔            |
| (Pallor face)                      | ☆..... مریضہ زرد پڑ جاتی ہے۔                       |
| (Perspiration)                     | ☆..... پسینہ بہت زیادہ آتے ہیں۔                    |
| (Patient is irritated)             | ☆..... بے چینی بہت ہوتی ہے۔                        |
| (At last patient becomes comatose) | ☆..... آخر کار مریضہ کو ماکہ حالت میں چلی جاتی ہے۔ |

اگر مریضہ کا فوری علاج نہ کیا جائے تو؛

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (Recurrent fits of coma)            | ☆..... مریضہ پر کوما کے دورے بار بار پڑتے ہیں۔                         |
| (Death may occur)                   | ☆..... مریضہ کی موت واقع ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔               |
| (Patient should laydown calmly)     | ☆..... ایسی حالت میں مریضہ کو خاموشی سے لیٹے رہنا چاہیے۔               |
| (Check B.P repeatedly)              | ☆..... وقفے وقفے کے بعد مریضہ کا بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے۔             |
| (Note Pulse & Temp: 4 hourly)       | ☆..... ہر چار گھنٹے کے بعد مریضہ کی نبض اور درجہ حرارت نوٹ کرنا چاہیے۔ |
| (Note breathing every 15 minutes)   | ☆..... ہر پندرہ منٹ کے بعد مریضہ کی سانس کی رفتار کو دیکھنا چاہیے۔     |
| (No noise/light near the patient)   | ☆..... مریضہ کے قریب زیادہ روشنی یا شور نہیں ہونا چاہیے۔               |
| (Don't touch the patient)           | ☆..... مریضہ کو بلا ضرورت چھونا نہیں چاہیے۔                            |
| (Faintness may occur due to touch)  | ☆..... چھونے سے مریضہ پر بے ہوشی کا دورہ طاری ہو سکتا ہے۔              |
| (Insert cathetre for urination)     | ☆..... پیشاب کے اخراج کے لئے کیتھیٹر لگانا۔                            |
| (Urine R/E)                         | ☆..... خارج ہونے والے پیشاب کا معائنہ کروائیں۔                         |
| (Measurement of urinary Albumin)    | ☆..... پیشاب میں خارج ہونے والی البیومن کی مقدار کو نوٹ کریں۔          |
| (Record urinary output)             | ☆..... مریضہ کے خارج ہونے والے پیشاب کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے۔      |
| (Incontinence of urine during fits) | ☆..... دورے کی حالت میں مریضہ کا پیشاب خود بخود بھی خارج ہو سکتا ہے۔   |
| (Repeated fits may occur)           | ☆..... ہوش میں آنے سے پہلے مریضہ پر دوسرے دورے کا حملہ ہو سکتا ہے۔     |
| (Cerebral haemorrhage may occur)    | ☆..... مریضہ کو سیربرل ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔                          |
| (Patient laid down at side)         | ☆..... دورے کی حالت میں مریضہ کو کروٹ دے کر لٹا دینا چاہیے۔            |
| (Emergency treatment is given)      | ☆..... مریضہ کو فوری طور پر ضروری علاج مہیا کرنا چاہیے۔                |
| (Perform caesarean section)         | ☆..... ضرورت ہو تو سیزیرین سیکشن کیا جائے۔                             |

**تشخیص (Diagnosis):** پری ایکلیمپسیا یا ایکلیمپسیا کی بروقت تشخیص انتہائی ضروری ہے جس کے لئے درج ذیل ٹیسٹ کئے جاتے ہیں؛

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| (Urine R/E)           | ☆..... پیشاب کا عام امتحان کرنا چاہیے۔                |
| (B.P monitoring)      | ☆..... مریضہ کا بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے۔             |
| (Note urinary output) | ☆..... پیشاب کے اخراج پر نظر رکھنی چاہیے۔             |
| (C.B.C with E.S.R)    | ☆..... خون کا مکمل معائنہ اور ای، ایس، آر کرنا چاہیے۔ |
| (Blood Culture test)  | ☆..... بلڈ کلچر ٹیسٹ کرنا چاہیے۔                      |
| (Urine Culture test)  | ☆..... یورین کلچر ٹیسٹ کرنا چاہیے۔                    |

**علاج (Treatment):** پری ایکلیمپسیا یا ایکلیمپسیا کا علاج نہایت توجہ اور تیزی کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ زچہ اور بچہ دونوں کو خطرہ ہوتا ہے۔

|                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (Expulsion of baby from uterus)          | ☆..... یوٹرس سے بچے کو نکال دینا چاہیے۔                            |
| (Control B.P effectively)                | ☆..... بلڈ پریشر موثر طور پر کنٹرول کرنا چاہیے۔                    |
| (Symptomatic treatment may be done)      | ☆..... علامات کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔                            |
| (Magnesium Sulfate for convulsions)      | ☆..... دورے روکنے کیلئے میگنیشیم سلفیٹ دینی چاہیے۔                 |
| (Aldomet Tab for hypertension)           | ☆..... ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کیلئے ایڈومت گولیاں دیں۔         |
| (Corticosteroids for thrombocytopenia)   | ☆..... پلیٹ لیٹس بڑھانے کیلئے کارٹیکوسٹیرائڈز احتیاط سے دیں۔       |
| (Ceftriaxone Inj for infection)          | ☆..... انفیکشن کیلئے انجکشن سیف ٹرائی ایگزون دیں۔                  |
| (Lasix Inj for diuresis)                 | ☆..... پیشاب لانے کیلئے لاسکس انجکشن دیں۔                          |
| (I.V drip if needed)                     | ☆..... ضرورت پڑنے پر آئی وی ڈرپ لگائیں۔                            |
| (Methyle dopa Inj for emergency in B.P.) | ☆..... بلڈ پریشر کو ایمرجنسی کنٹرول کیلئے میتھائل ڈوپا انجکشن دیں۔ |

☆☆☆

## زچگی کی ممکنہ پیچیدگیاں

### (COMPLICATIONS OF LABOUR)

**تعارف (Introduction):** حمل کے مکمل ہو جانے کے بعد زچگی کا ہونا ایک قدرتی نارمل عمل ہے لیکن بسا اوقات زچگی کے نارمل عمل میں کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں جن کا بروقت تدارک ضروری ہے ورنہ زچہ یا بچہ کے نقصان کا احتمال رہتا ہے۔ زچگی کے دوران جو ممکنہ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں ان کا تذکرہ درج ذیل ہیں؛

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (Uterus may burst during delivery)          | ☆..... زچگی کے دوران یوٹرس پھٹ سکتا ہے۔                    |
| (Placenta previa)                           | ☆..... پلے سینٹا یوٹرس کے نچلے حصے پر بھی جڑا ہو سکتا ہے۔  |
| (Severe post partum haemorrhage)            | ☆..... زچگی کے بعد نہایت زیادہ سیلان خون ہو سکتا ہے۔       |
| (Pelvic infection may occur after delivery) | ☆..... زچگی کے بعد پیلوئس کے اعضاء کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔  |
| (Severe psychological depression)           | ☆..... زچہ کو بچے کی پیدائش کا حد سے زیادہ خوف ہو سکتا ہے۔ |
| (Cervical walls may be wounded)             | ☆..... زچگی کے دوران سرویکس کی دیواریں زخمی ہو سکتی ہیں۔   |

اسی طرح بعض کیسز میں وضع حمل کے بعد بہت زیادہ جریان خون ہوتا ہے جوڑکنے میں نہیں آتا اس کنڈیشن کو پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں۔



## سچے اور جھوٹے دردزہ میں فرق

(TRUE & FALSE LABOUR PAINS)

| جھوٹے دردزہ (False Labour Pains)                                | سچے دردزہ (True Labour Pains)                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| یہ درد پیٹ کے نچلے حصے یا کسی اور حصے سے شروع ہوتے ہیں۔         | 1 یہ درد کمر سے شروع ہوتے ہیں اور سامنے کی جانب آتے ہیں۔      |
| یہ پیٹ کے کسی بھی حصے کی جانب پھیل جاتے ہیں۔                    | 2 یہ زیادہ تر رانوں اور پیٹ کے نچلے حصے کی جانب آتے ہیں۔      |
| جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ درویں نہیں بڑھتی بلکہ مستقل رہتی ہیں۔ | 3 جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ درویں بڑھتی رہتی ہیں۔             |
| یہ درویں ٹھنڈ، بد ہضمی، گیس یا تشنگ وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔   | 4 سچے دردزہ ہمیشہ یوٹرائن کا ٹریکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔       |
| عورت سرویکس کھلتا محسوس نہیں کرتی بلکہ سرویکس بند ہی رہتا ہے۔   | 5 عورت یوٹریس کا نچلا حصہ سرویکس کھلتا ہوا محسوس کرتی ہے۔     |
| جھوٹے دردزہ میں یوٹریس سے ایمینیا ٹک فلوئیڈ خارج نہیں ہوتا۔     | 6 سچے دردزہ میں یوٹریس سے ایمینیا ٹک فلوئیڈ خارج ہوتا ہے۔     |
| انیہا دینے سے عام طور پر درویں کم ہو جایا کرتی ہیں۔             | 7 انیہا دینے سے درووں کی شدت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔          |
| جھوٹے دردزہ میں پیٹ میں درویں نہیں ہوتیں اور نہ ہی بڑھتی ہیں۔   | 8 سچے دردزہ میں پیٹ میں درویں ہوتی ہیں جو بڑھتی جاتی ہیں۔     |
| اگر عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھا جائے تو درویں بڑھیں گی یا کم ہوگی۔ | 9 اگر عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھا جائے تو یوٹریس سخت معلوم ہوگا۔ |
| جھوٹے دردزہ میں سانس لینے پر درویں نہ کم نہ زیادہ ہوتی ہیں۔     | 10 سچے دردزہ میں حاملہ عورت ہر سانس پر درویں محسوس کرتی ہے۔   |
| جھوٹے دردزہ کی درووں میں حاملہ عورت کو سردی محسوس نہیں ہوتی۔    | 11 سچے دردزہ کی درووں میں حاملہ عورت کو سردی محسوس ہوتی ہے۔   |



## پرسوت کا بخار

### (PUERPERAL PYREXIA)

**تعارف (Introduction):** زچگی کے دوران جس کا عرصہ چھ ہفتوں پر محیط ہوتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے زچہ کے جسم کا درجہ حرارت 100 ڈگری فارن ہائیٹ سے بڑھ جائے تو ایسے بخار کو پرسوت کا بخار کہتے ہیں۔

**پرسوت کے بخار کی وجوہات (Causes Of Puerperal Pyrexia):** پرسوت کے بخار کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں؛

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (Gynaecological infections)                 | ☆..... اعضائے مخصوصہ کا انفیکشن۔                      |
| (Mastitis)                                  | ☆..... پستان کی سوزش۔                                 |
| (Urinary tract infection)                   | ☆..... نظام بول کا انفیکشن۔                           |
| (Thrombosis in legs)                        | ☆..... پیروں کی وریدوں کا تھرامبوسس۔                  |
| (Other internal infections like Bronchitis) | ☆..... دوسرے اندرونی انفیکشن مثلاً براؤنکائٹس،        |
| (Pneumonia)                                 | ☆..... نمونیہ۔                                        |
| (Influenza)                                 | ☆..... انفلوئنزا۔                                     |
| (Enteric fever)                             | ☆..... مائٹی فائیڈ بخار۔                              |
| (Malaria)                                   | ☆..... ملیریا۔                                        |
| (Retention of lochia)                       | ☆..... نفاس یعنی لوشیا اگر تین دن کے بعد بند ہو جائے۔ |

**پرسوت کے بخار کی علامات و نشانیائیں (Signs & Symptoms Of Puerperal Pyrexia):** اسکی علامات درج ذیل ہیں؛

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| (Increase in temperature) | ☆..... مریضہ کو بخار زیادہ ہوتا جائے گا۔   |
| (Feeling of cold)         | ☆..... مریضہ کو ٹھنڈ یا سردی لگے گی۔       |
| (Shivering and rigors)    | ☆..... مریضہ کو کپکپاہٹ و لرزہ محسوس ہوگا۔ |

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (Fever 103 to 105 F)           | ☆..... بخار 103 سے 105 ڈگری فارن ہائیٹ تک ہوگا۔          |
| (Rapid pulse)                  | ☆..... نبض کی رفتار تیز ہوگی۔                            |
| (Headache)                     | ☆..... سر میں درد ہوگا۔                                  |
| (Backache)                     | ☆..... کمر میں درد ہوگا۔                                 |
| (Abdominal pain)               | ☆..... پیٹ میں درد ہوگا۔                                 |
| (Generalized myalgia)          | ☆..... تمام جسم میں درد ہوگا۔                            |
| (Nausea / Vomiting)            | ☆..... بعض اوقات مریضہ کو متلی اور قے بھی ہوگی۔          |
| (Polydipsia)                   | ☆..... مریضہ کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔                      |
| (Sometimes delirium may occur) | ☆..... مریضہ کو بعض اوقات ہذیان بھی ہو سکتا ہے۔          |
| (Redness of eyes and face)     | ☆..... چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوں گی۔                       |
| (Xerostomia)                   | ☆..... ہونٹ ومنہ خشک ہوں گے۔                             |
| (Difficulty in breathing)      | ☆..... تنگی تنفس ہو سکتی ہے۔                             |
| (Sometimes mania may occur)    | ☆..... بعض اوقات پاگل پن کی علامات بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ |

پرہیز کے بخار کا علاج (Treatment Of Puerperal Pyrexia): علاج کے ضمن میں درج ذیل نکات کا خیال رکھا جاتا ہے:

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | زچگی کے بعد تمام انفیکشنوں کی روک تھام کرنی چاہیے۔                                        |
| ☆..... | مریضہ کی جنرل صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔                                          |
| ☆..... | مریضہ کو اپنے اعضائے مخصوصہ و پیشاب کی راستوں کی صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ |
| ☆..... | جراثیموں سے پاک کپڑے و بستر استعمال کرنے چاہئیں۔                                          |
| ☆..... | جراثیموں سے پاک آلات استعمال کرنے چاہئیں۔                                                 |
| ☆..... | زچگی کے دوران صحت کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہنا چاہیے۔                                 |
| ☆..... | زچہ کی خوراک، رہائش اور لباس سب حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہئیں۔                 |

پر سوت کے بخار کا ادویاتی علاج (Medicinal Treatment Of Puerperal Pyrexia): اس کا ادویاتی علاج درج ذیل ہے؛

|                     |                               |        |
|---------------------|-------------------------------|--------|
| (Velosef Inj 500mg) | ویلو سیف انجکشن 500 ملی گرام۔ | ☆..... |
| (Panadol Tab 500mg) | پیناڈول گولیاں 500 ملی گرام۔  | ☆..... |
| (Tarivid Tab 200mg) | ٹیری ویڈ گولیاں 200 ملی گرام۔ | ☆..... |
| (Motilium Tab)      | موٹیلیم گولیاں۔               | ☆..... |
| (Buscopan Plus Tab) | بسکوپان پلس گولیاں۔           | ☆..... |
| (Sangobion Cap)     | سینگوبیان کپسول۔              | ☆..... |
| (I.V. Drip)         | آئی وی ڈرپ۔                   | ☆..... |



## نفاس

(لوشیا)

(LOCHIA)

**تعارف (Introduction):** نفاس یعنی لوشیا ایک قدرتی طور پر یوٹرس سے خارج ہونے والی رطوبت ہے جس میں کہ خون اور یوٹرس کے ٹوٹے ہوئے خلیات ہوتے ہیں۔ لوشیا زچگی کے بعد تین سے چار ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ لوشیا کی رنگت مشاہداتی لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ لوشیا کا رنگ مختلف مرحلوں میں مندرجہ ذیل ہوتا ہے؛

**1۔ لوشیا ربرا (Lochia Rubra):** اس مرحلے میں لوشیا کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور لوشیا میں خون و خون کے جے ہوئے ٹکڑے شامل ہوتے ہیں۔ لوشیا ربرا زچگی کے بعد تین سے چار دن تک جاری رہتا ہے اور بعد میں یہ سرخ لوشیا آہستہ آہستہ پیلا پڑتا جاتا ہے اور یہ مرحلہ تقریباً ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے۔

2۔ **لوشیا سروسا (Lochia Serosa):** اس مرحلے میں لوشیا کا رنگ نسواری یا پیلا ہو جاتا ہے جس میں کہ مائع خون اور خون کے سفید ذرات شامل ہوتے ہیں اور زچگی کے بعد تقریباً دوسرے ہفتے میں یہ جاری رہتا ہے۔

3۔ **لوشیا البہ (Lochia Alba):** اس مرحلے میں لوشیا تقریباً سفید اور گاڑھا ہو جاتا ہے جس میں کہ خون کے سفید ذرات اور میو کس شامل ہوتا ہے یہ مرحلہ عام طور پر زچگی کے بعد تیسرے ہفتے میں جاری رہتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ چوتھے ہفتے تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ لوشیا کاری ایکشن اساسی ہوتا ہے اور اس کی اپنی ہی ایک خاص بو ہوتی ہے جبکہ لوشیا خون کے سرخ ذرات، سفید ذرات، پلازما کے پروٹین، فائبرین، یوٹرس کی تہہ کے تباہ شدہ خلیات و بچانہ کے اپنی تحلیل خلیات اور میکٹیریا پر مشتمل ہوتا ہے۔



## پلے سینٹا پریویا (PLACENTA PREVIA)

**تعارف (Introduction):** پلے سینٹا پریویا سے مراد پلے سینٹا کا یوٹرس میں غیر طبعی مقام پر جڑا ہونا ہے۔ پلے سینٹا پریویا میں عموماً پلے سینٹا یوٹرس کے نچلے مقام پر جڑا ہوتا ہے جبکہ طبعی طور پر پلے سینٹا یوٹرس کے فنڈس پر جڑا ہونا چاہیے۔ پلے سینٹا پریویا میں چونکہ پلے سینٹا غیر معمولی مقام پر پیوست ہوتا ہے اس وجہ سے وضع حمل کے موقع پر جب یوٹرس کا نچلا حصہ سرویکس پھیلا کرتا ہے تو پلے سینٹا کا وہ حصہ جو وہاں جڑا ہوا ہوتا ہے اکھڑ کر سیلان خون یعنی بلیڈنگ کا باعث بنا کرتا ہے چونکہ سیلان خون تیزی سے ہوا کرتا ہے لہذا حاملہ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور کسی بھی قسم کی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔

**پلے سینٹا پریویا کی علامات و نشانیوں (signs & Symptoms Of Placenta Previa):** اس کی علامات درج ذیل ہو سکتی ہیں:

|        |                                                                            |                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ☆..... | حمل کے بارہ ہفتوں کے بعد یوٹرس سے خون کا کم یا زیادہ مقدار میں اخراج ہونا۔ | (Uterine bleeding)       |
| ☆..... | پیٹ یا پیلوکس میں درد کے بغیر ویجائنل بلیڈنگ ہونا۔                         | (Vaginal bleeding)       |
| ☆..... | بغیر کسی وجہ سے ویجائنل بلیڈنگ کا ہونا۔                                    | (Bleeding without cause) |
| ☆..... | زچگی کے دوسرے یا تیسرے مرحلے میں خون کا زیادہ مقدار میں اخراج ہونا۔        | (Severe haemorrhage)     |
| ☆..... | بچے کی پرورد، تکلیف دہ ولادت ہونا۔                                         | (Dystocia)               |

**پلے سینٹا پریویا میں احتیاطی تدابیر (Precautions Of Placenta Previa):** اس میں درج ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہئیں؛  
 حمل کے اٹھائیس ہفتوں کے بعد جو نبی ویجائٹل بلیڈنگ ہو تو ممکنہ طور پر یہ پلے سینٹا پریویا ہی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ویجائٹل معائنہ سے حتی الامکان طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ پلے سینٹا پریویا کی تشخیص کیلئے الٹراساؤنڈ سے مدد لینی چاہیے۔ پلے سینٹا پریویا کی تشخیص کنفرم ہونے کے بعد حاملہ کو باقی وقت بستر پر مکمل آرام کرنے کی صورت میں گزارنا چاہیے۔ زچگی کے لئے حاملہ کو ہاسپٹل ریفر کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی ممکنہ پیچیدگی سے نمٹا جاسکے اگر ماں یا بچے دونوں کی جان بچانے کیلئے بڑا آپریشن یعنی سیزرین سیکشن بھی کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے۔ بسا اوقات بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ڈیلیوری محض اوزاروں کی مدد سے ہی کر دی جاتی ہے۔ مریضہ کو اگر زیادہ اخراج خون ہو گیا ہو تو مریضہ کو خون لگا دینا چاہیے۔

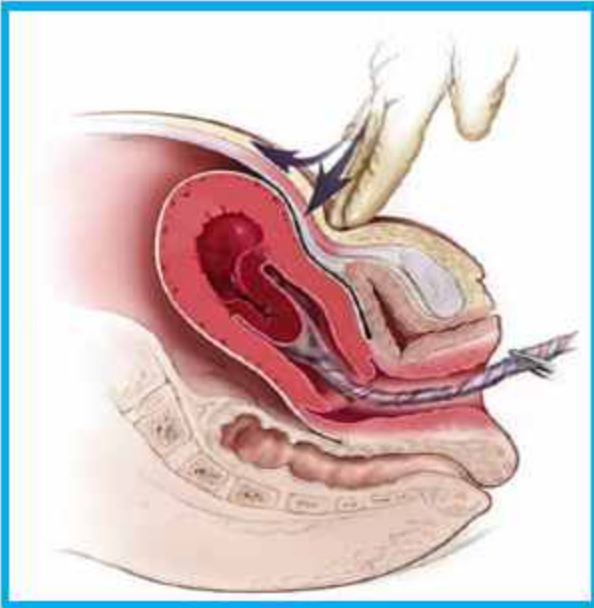


## پلے سینٹا اور پلے سینٹا پریویا میں فرق

(PLACENTA & PLACENTA PREVIA)

| پلے سینٹا (Placenta)                                            | پلے سینٹا پریویا (Placenta Previa)                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 پلے سینٹا یوٹرس کے فنڈس میں واقع ہوتا ہے۔                     | پلے سینٹا پریویا عموماً یوٹرس کے نچلے حصے میں واقع ہوتا ہے۔   |
| 2 خون کی صحیح سپلائی کے باعث پلے سینٹا کی موٹائی زیادہ ہوتی ہے۔ | خون کی سپلائی نارمل نہ ہونے کی وجہ سے اسکی موٹائی کم ہوتی ہے۔ |
| 3 یوٹرس کے سکڑنے سے اخراج خون نہیں ہوتا۔                        | یوٹرس کے سکڑنے سے اخراج خون ہوتا ہے۔                          |
| 4 ویجائٹل معائنہ کے دوران اخراج خون نہیں ہوتا۔                  | ویجائٹل معائنہ کے دوران اخراج خون ہوتا ہے۔                    |

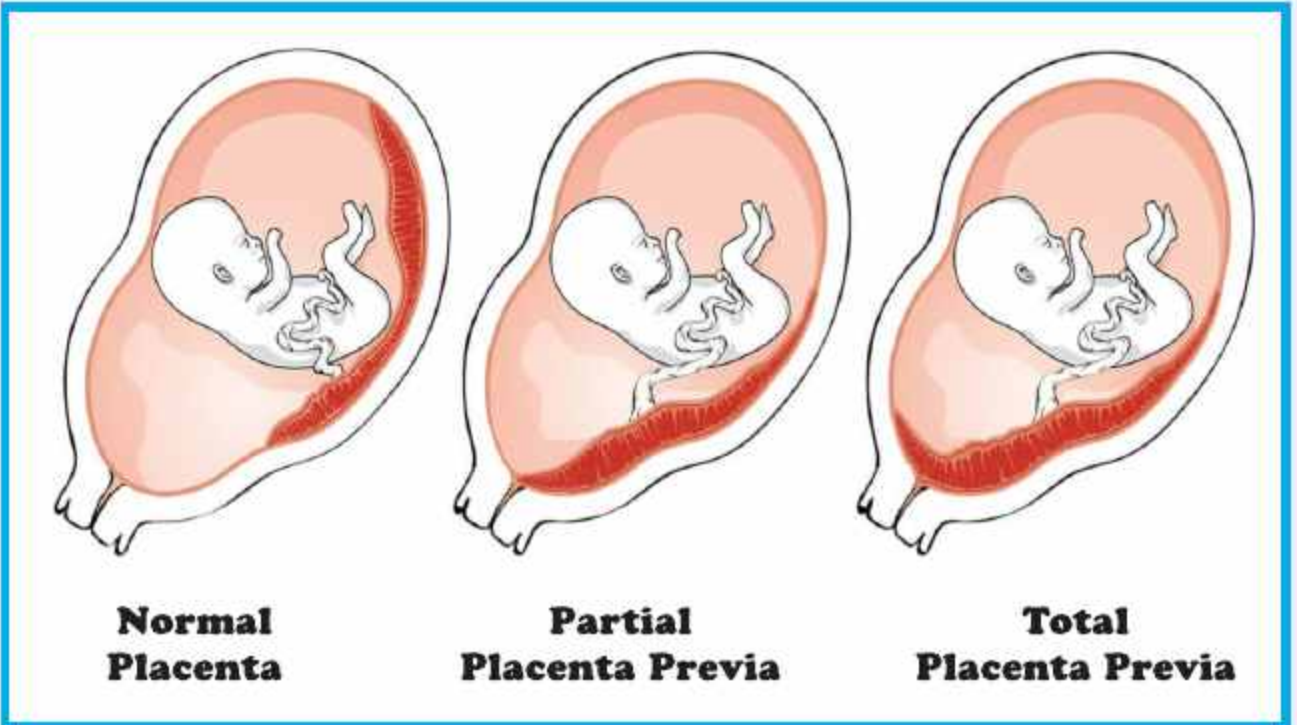




Retained Placenta



Cord Prolapse



**Normal  
Placenta**

**Partial  
Placenta Previa**

**Total  
Placenta Previa**

Placental Positions

## یونٹ: 13

## جڑواں بچوں کی پیدائش کے انتظامات

## (LABOUR MANAGEMENT OF TWIN BABIES)

**تعارف (Introduction):** بچوں کی پیدائش ایک قدرتی امر ہے۔ عام طور پر ایک پریگ نینسی کے نتیجے میں ایک ہی بچہ پیدا ہوا کرتا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ بعض اوقات ایک پریگ نینسی کے نتیجے میں دو یا دو سے زیادہ بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اکثر اوقات جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی فی میل کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہونی ہو تو ایسی ڈیلیوری کیلئے عام ڈیلیوری سے زیادہ انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جڑواں بچوں کی ڈیلیوری کیلئے درج ذیل انتظامات اور احتیاطیں مد نظر رکھنا چاہئیں:

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | ڈیلیوری کے دوران طاقتور سیڈیشن ڈرگز (Heavy Sedation Drugs) کا اہتمام کرنا چاہیے۔    |
| ☆..... | ڈیلیوری کے وقت ایک یا ایک سے زائد بچوں کی پیدائش کے لئے زائد سامان میسر ہونا چاہیے۔ |

**جڑواں ڈیلیوری کا سامان (Items For Twin Delivery):** جڑواں بچوں کی ڈیلیوری کیلئے درج ذیل سامان کی ضرورت ہوتی ہے:

|        |                                    |                               |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|
| ☆..... | کارڈ کلیمپ۔                        | (Cord clamp)                  |
| ☆..... | قینچی۔                             | (Scissor)                     |
| ☆..... | ڈرا شیٹ۔                           | (Draw sheet)                  |
| ☆..... | انکوبیٹر۔                          | (Incubator)                   |
| ☆..... | بچے کے کپڑے۔                       | (Baby clothes)                |
| ☆..... | بچے کا کابل۔                       | (Baby blanket)                |
| ☆..... | کھائی پر چسپاں کرنے کی ٹاپ کی ٹیپ۔ | (Written name tape for wrist) |
| ☆..... | آکسیجن سلنڈر۔                      | (Oxygen cylinder)             |

**جڑواں ڈیلیوری کیلئے اہتمام (Management For Twin Delivery):** جڑواں بچوں کی ڈیلیوری کیلئے درج ذیل اہتمام کریں:

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | بیک وقت دو ڈیلیوری ٹرالیوں (Delivery Trollys) تیار ہونی چاہیے۔             |
| ☆..... | بلڈ پریشر، نبض، ٹمپریچر، سانس کو باقاعدہ ریکارڈ کر کے نوٹ کرتے رہنا چاہیے۔ |
| ☆..... | فیٹس کے دل کی دھڑکن کی آوازیں (Fetal Heart Sounds) سنتے رہنا چاہیے۔        |

|        |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | کمرے کا اندرونی درجہ حرارت موسم کی ضرورت کے مطابق حسب ضرورت ہو۔                                           |
| ☆..... | حاملہ کو مزید تکلیفوں کا سہارا دے کر سکون اور آرام پہنچایا جائے۔                                          |
| ☆..... | ڈیلیوری کے لئے بہتر اور موزوں پوزیشن (Position) کو اختیار کیا جائے۔                                       |
| ☆..... | ضرورت کے پیش نظر اپی زیٹومی (Episiotomy) کی جائے۔                                                         |
| ☆..... | بچے کی پیدائش کے بعد پہلے سانس کے راستے (Respiratory Passage) کو صاف کیا جائے۔                            |
| ☆..... | کارڈ کو فوراً کلیمپ (Clamp) کر دیا جائے یا جراثیم سے پاک دھماگے سے باندھ دیا جائے۔                        |
| ☆..... | ناک اور منہ کو سکر مشین (Sucker Machine) کے ذریعے صاف کیا جائے۔                                           |
| ☆..... | سب سے پہلے بچے کو حفاظت میں لیا جائے اور بے بی کو گرم اور سٹریلائزڈ تولیے میں رکھا جائے۔                  |
| ☆..... | پیدائش کے فوراً بعد بے بی کو انکوبیٹر میں رکھا جائے اور خصوصی توجہ دی جائے۔                               |
| ☆..... | حاملہ کے پیٹ کو دوسرے بچے کی پیدائش کے لئے ٹھنڈا کیا جائے۔                                                |
| ☆..... | دوسرے بچے کے دل کی آواز (Fetal Heart Sound) کو سنا جائے۔                                                  |
| ☆..... | تین سے چار منٹ بعد دوبارہ کنٹرکشن کی صورت میں حاملہ کو پیٹ کے نیچے رخ زور لگانے کو کہا جائے۔              |
| ☆..... | دوسرے فیٹس کی پوزیشن (Presentation) کو معلوم کیا جائے۔                                                    |
| ☆..... | پیٹ کے زیریں حصے یوٹرس پر ماساژ (Massage) کیا جائے تاکہ یوٹرس میں حرکت پیدا ہو۔                           |
| ☆..... | پہلے بچے کے پندرہ منٹ بعد دوسرے بچے کو بھی پیدا ہو جانا چاہیے۔                                            |
| ☆..... | اس کیلئے انجکشن ارگومیترین (Inj Ergometrine I.V. 0.5mg) کا لگایا جائے۔                                    |
| ☆..... | دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد پلے سینا کے اخراج کے بعد عورت کو دو گھنٹے تک اپنی خصوصی نگرانی میں رکھا جائے۔ |
| ☆..... | عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد آرام کرنے دیا جائے جس کے لئے ہلکی سکون آور (Sedative) ادویات دی جائیں۔       |
| ☆..... | تمام گیلے اور خون آلود کپڑے ہٹا دیئے جائیں اور جسم کو اچھی طرح صاف کر دیا جائے۔                           |
| ☆..... | ویجائنا کو اچھی طرح نیم گرم اینٹی سپٹک (Warm Antiseptic) سے صاف کر کے سٹریلائزڈ پیڈر کھدیئے جائیں۔        |



## یونٹ: 14

## پری میچورٹی

## (PREMATURITY)

**تعارف (Introduction):** ایسا بچہ جس کی پیدائش 37 ہفتوں یا 259 دن سے پہلے ہو اور اس کا وزن ڈھائی کلو گرام یا ساڑھے پانچ پاؤنڈز سے کم ہو تو ایسے بچے کو پری میچور بے بی (Premature Baby) کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ 37 ہفتوں کا اندازہ حاملہ کی آخری ماہواری کے پہلے دن سے شروع کرتے ہیں۔ اس مرض کی شرح تقریباً پانچ سے دس فیصد خواتین میں ہوتی ہے۔

**پری میچورٹی کی وجوہات (Causes Of Prematurity):** پری میچورٹی کی وجوہات ماں، بچے، پلے سینفا میں یا نامعلوم ہو سکتی ہیں؛

(1) **ماں میں پری میچورٹی کی وجوہات (Maternal Causes Of Prematurity):** ماں میں اس کی وجوہات درج ذیل ہیں؛

☆..... **ماں کا قد چھوٹا ہونا (Short Stature Of Mother):** اگر حاملہ خاتون کا قد 5 فٹ سے کم، غذائی کمی، کام کی زیادتی، وزن میں زیادتی اور دوران حمل سگریٹ نوشی یا حقہ نوشی کی علامات موجود ہوں تو اس میں پری میچورٹی کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔

☆..... **دوران حمل بلڈ پریشر کی زیادتی اور اکلیمپسیا (Pregnancy Induced Hypertension & Eclampsia):** اگر دوران حمل بلڈ پریشر کی زیادتی ہو یا اکلیمپسیا کی ہسٹری موجود ہو تو ایسی خاتون میں مایومیٹریم (Myometrium) جو کہ یوٹرس کے مسلز ہوتے ہیں، بہت متحرک ہو جاتے ہیں اور آکسی ٹھن کے اثرات کی وجہ سے ایسی خاتون پری میچور بچے کو جنم دیتی ہے۔

☆..... **اینتی پارٹم ہیمریج (Antepartum Haemorrhage):** اگر حادثاتی طور پر ماں میں ویسجائل ہیمریج شروع ہو جائے تو اس صورت میں حمل خود گرا ناپڑ جاتا ہے۔ اگر پلے سینفا پر یوٹرس ہو تو پھر بعض اوقات حمل گر جاتا ہے اور بچے کی وقت سے پہلے پیدائش ہو جاتی ہے۔

☆..... ذیابیطس (Diabetes Mellitus): ذیابیطس سے متاثرہ حاملہ خواتین میں پری میچورٹی کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسکی ایک بڑی وجہ وراثتی نقائص (Congenital Malformations)، حاملہ کے پیشاب میں بیکٹیریا کا اخراج (Bacteriuria)، پولی ہائیڈریمینیا (Polyhydramnios)، دوران حمل بلڈ پریشر کی زیادتی ہو جانا (Pregnancy Induced Hypertension) یا یوٹرس کے اندر بچے کی موت ہو جانا وغیرہ ہو سکتی ہے۔

☆..... دل کی بیماریاں (Cardiac Diseases): حاملہ عورت میں دل کی بیماریوں یعنی ہارٹ ڈیزیزز بالخصوص کھیسٹو ہارٹ فیلور (Congestive Heart Failure) میں پری میچور بچے کی پیدائش کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔

☆..... دوران حمل فائبرائیڈز کا ہونا (Pregnancy With Fibroids): جن خواتین کے یوٹرس میں فائبرائیڈز زیادہ تعداد میں موجود ہوں تو ایسی صورت میں پری میچورٹی کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں یوٹرس کی جسامت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے لئے حمل جاری رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے اور لیبر پہلے شروع ہو جاتی ہے۔

☆..... سروائیگل ان کمپیٹنس (Cervical Incompetence): اس حالت میں سرویکس بہت ڈھیلی ہوتی ہے اس لئے یا تو بچہ وقت سے پہلے ہو جاتا ہے یا پھر ابارشن (Abortion) ہو جاتی ہے۔

☆..... یوٹرس میں پیدائشی نقائص (Congenital Malformations Of Uterus): اس صورت میں بچہ اپنی جسامت نہیں بڑھا سکتا اور اسی لئے وہ پری میچور پیدا ہو جاتا ہے۔

☆..... شدید انفیکشن (Acute Infection): شدید انفیکشن کی صورت میں حاملہ عورت کو بخار ہو جاتا ہے اور اس سے حاملہ کے دماغ کے ایک حصے ہائپوتھیلامس (Hypothalamus) پر اثر ہوتا ہے اور ہارمونز کی مقداروں میں کمی پیشی آ جاتی ہے، جس سے بچہ پری میچور پیدا ہوتا ہے۔

☆..... سرجیکل آپریشن (Surgical Operation): دوران حمل آپریشن بالخصوص پیٹ کا آپریشن کرنے پر استھیزیا کے اثرات کی وجہ سے لیبر وقت سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔

☆.....نفسیاتی صدمہ (Psychological Shock): خاتون جذباتی صدمے کا شکار ہو جائے تو کسی بھی وقت لیبر پین سٹارٹ ہو سکتا ہے۔

☆.....مالی شکستگی (Poor Socio-economic Status): کام کی زیادتی اور غذا کی کمی بھی وقت سے پہلے لیبر کا باعث بن سکتی ہے۔

☆.....اسنشیئل ہائپر ٹینشن (Essential Hypertension): بلڈ پریشر میں شدید زیادتی کی وجہ سے حمل کو وقت سے پہلے ختم کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں بچے کی یوٹرس کے اندر ہی موت واقع ہو سکتی ہے۔

☆.....وراثتی عوامل (Genetic Factors): یہ عوامل زیادہ تر ان خواتین میں ہوتے ہیں جن کے اندر بار بار پری میچورٹی ہسٹری موجود ہو۔

☆.....پریگی گریویڈا (Primigravida): اگر حاملہ خاتون کی عمر بیس سال سے کم ہو تو اس میں پری میچورٹی کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔

☆.....چوٹ (Trauma): اگر یوٹرس پر براہ راست چوٹ لگ جائے تو اس سے لیبر فوراً ہی شروع ہو سکتی ہے۔

☆.....تپ دق (Tuberculosis): چونکہ تپ دق سے خاتون میں خون کی کمی واقع ہوتی ہے اسلئے پری میچورٹی کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔

☆.....آئفک (Syphilis): اس بیماری کی وجہ سے مردہ بچے کی پیدائش بھی ہو سکتی ہے اور پری میچور بچے کی بھی پیدائش ہو سکتی ہے۔

(2) بچے میں پری میچورٹی کی وجوہات (Foetal Causes Of Prematurity): فیٹس میں اس کی وجوہات درج ذیل ہیں؛

☆.....ملٹی پل پریگ نیسی (Multiple Pregnancy): جن خواتین میں جڑواں بچے ہوتے ہیں ان میں پری میچورٹی کا چانس زیادہ ہوتا ہے اور 38 ہفتے سے پہلے پہلوں کی پیدائش ہو جاتی ہے۔

☆.....پولی ہائیڈرامنیوز (Polyhydramnios): اس میں پراسٹا گلیٹنڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جسکی وجہ سے پری میچور ڈیلیوری ہوتی ہے۔

☆..... بچے کی خرابیاں (Foetal Abnormalities): پاٹرز سنڈروم (Potter's Syndrome) میں بچے پر میچور پیدا ہوتے ہیں

☆..... ری سس آنسو امیونائزیشن (Rhesus Isoimmunization): اس حالت میں بھی پر میچورٹی بہت عام ہے۔

☆..... میل پر زینٹیشن (Malpresentation): اس میں جھلیاں وقت سے پہلے پھٹ جاتی ہیں اور پر میچور ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔

☆..... انٹرایوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن (Intrauterine Growth Retardation): اس حالت میں بچہ جتنی دیر ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے اتنا اس کی نشوونما کم ہوتی ہے اور یوٹرس کے اندر ہی بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لئے حمل کا دورانیہ ختم ہونے سے پہلے ہی حاملہ عورت کی ڈیلیوری کروادی جاتی ہے۔

(3) پلے سینٹا کی وجوہات (Causes Of Placenta): بعض اوقات پلے سینٹا کے اندر ایسے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں کہ ڈیلیوری وقت سے پہلے ہو جاتی ہے اور بچہ پر میچور پیدا ہو جاتا ہے۔

(4) نامعلوم وجوہات (Idiopathic Causes): بعض اوقات پر میچورٹی کی بظاہر کوئی وجہ تلاش نہیں کی جاسکتی۔

پر میچورٹی کی تشخیص (Diagnosis Of Prematurity): پر میچورٹی کی تشخیص درج ذیل طریقوں سے کی جاسکتی ہے:

☆..... نائٹرازین پیپر ٹیسٹ (Nitrazine Paper Test): اس ٹیسٹ میں خاتون کے ویجائنہ کی پی ایچ (pH) معلوم کی جاتی ہے۔ ویجائنل فلوئیڈ کی پی ایچ 4.5 اور 5.5 کے درمیان ہوتی ہے جبکہ ایمینیا ٹک فلوئیڈ کی پی ایچ 7.0 اور 7.5 کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر ویجائنل فلوئیڈ کی پی ایچ 6 سے زیادہ ہو تو نائٹرازین پیپر بلیورنگ کا ہو جائے گا اور اسی طرح ایمینیا ٹک فلوئیڈ کی پی ایچ اگر 8 سے زیادہ ہو تو نائٹرازین پیپر بلیو رنگ کا ہو جائے گا۔ نائٹرازین پیپر کے بلیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ویجائنل فلوئیڈ یا ایمینیا ٹک فلوئیڈ ایسڈک یعنی تیزابی ہے اور ایمینیا ٹک ممبرین پھٹ چکی ہیں جو کہ پر میچورٹی کیس کو ظاہر کرتی ہیں۔

☆..... نائل بلیو سلفیٹ ٹیسٹ (Nile Blue Sulphate Test): یہ ٹیسٹ 32 ہفتے سے پہلے قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے بچے کی میچورٹی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

پری میچورٹی کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Prematurity): پری میچورٹی کی علامات و نشانیوں درج ذیل ہیں:

|        |                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | بچے کا وزن 2.5 کلو گرام سے کم ہوتا ہے اور حمل کا دورانیہ 37 ہفتوں سے کم ہوتا ہے۔                                                                                                      |
| ☆..... | بچے کی کراؤن ہیل لینتھ (Crown Heel Length) 47 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے جبکہ بچے کے سر کا آکسی پیٹو فرنٹل سرکیم فی رینس (Occipitio-Frontal Circumference) 33 سینٹی میٹر سے کم ہوتا ہے۔ |
| ☆..... | بچے کی جلد سرخ اور پتلی ہوتی ہے جس پر ہا آسانی جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔                                                                                                               |
| ☆..... | بچے کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں معمول سے ذرا لمبی محسوس ہوتی ہیں۔                                                                                                                     |
| ☆..... | لینوگو (Lanugo) یعنی پیدائشی بال کافی زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔                                                                                                                 |
| ☆..... | ورنیکس کیزیوزا (Vernix Caseosa) جو کہ سپے شیس میٹریل (Sebaceous Material) پر مشتمل ہوتی ہے وہ یا تو بالکل غائب ہوتی ہے یا پھر بہت ہلکی مقدار میں موجود ہوتی ہے۔                       |
| ☆..... | کھوپڑی کی ہڈیاں پتلی ہوتی ہیں۔ تالوکی ہڈیاں (Fontanelles) بڑی ہوتی ہیں جبکہ سوچرز (Sutures) نمایاں ہوتے ہیں۔                                                                          |
| ☆..... | سرباقی جسم کے مقابلے میں بہت بڑا نظر آتا ہے۔                                                                                                                                          |
| ☆..... | کان نرم اور چھوٹے ہوتے ہیں اور کھوپڑی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔                                                                                                                         |
| ☆..... | بچے کے ٹیسٹیز ابھی تک پوری طرح سکروٹم میں نہیں پہنچے ہوتے۔                                                                                                                            |
| ☆..... | لیبیا ماینورا بالکل واضح دکھائی دے رہی ہوتی ہیں کیونکہ لیبیا میجورا کی نشوونما پوری طرح نہیں ہوئی ہوتی اور ان میں بہت کم مقدار میں چکنائی موجود ہوتی ہے۔                              |
| ☆..... | بچے کو بہت کم مقدار میں پیشاب آتا ہے۔ بعض اوقات تو بچے کو پہلے تین دن تک بالکل پیشاب نہیں آتا۔                                                                                        |
| ☆..... | بچے کی چیخ بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔                                                                                                                                                      |
| ☆..... | چونکہ بچے میں پٹھے پوری طرح سے طاقتور نہیں ہوتے اس لئے اس میں چوسنے یا نگلنے کی صلاحیت بہت کمزور ہوتی ہے۔                                                                             |
| ☆..... | بچے میں یرقان بہت شدید ہو سکتا ہے کیونکہ بائل کی صفائی بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔                                                                                                       |
| ☆..... | بچے کی تمام حرکات اور افعال بہت آہستہ اور ہلکے ہوتے ہیں۔                                                                                                                              |
| ☆..... | جسم کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور بے ترتیب بھی ہوتا ہے۔                                                                                                                                |
| ☆..... | بچے کا عمل تنفس تیز ہوتا ہے اور کئی مرتبہ بچہ سانس لیتے ہوئے اچانک سانس لینا بند کر دیتا ہے اور پھر اس کا سانس بحال ہو جاتا ہے۔                                                       |

|        |                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | بچے کے لیٹنے کا بھی ایک مخصوص انداز ہوتا ہے بچے کے کو لہے اکٹھے ہوتے ہیں گھٹنوں کے جوڑ (Knee Joint) اور ٹخنے کے جوڑ (Ankle Joint) مڑے ہوئے (Flexed) ہوتے ہیں۔ |
| ☆..... | موروری فلیکس (Moro Reflex) بہت تیز ہوتے ہیں۔                                                                                                                  |
| ☆..... | ایکسرے فلم پر فیمر یعنی ران کی ہڈی (Femur Bone) کا ٹچلا کنارہ اور نچلے پیر کی کیوبائیڈ ہڈی (Cuboid Bone) میں آسی فی کیشن (Ossification) بالکل نہیں ہوتی۔      |

پری میچورٹی کا علاج (Treatment Of Prematurity): پری میچورٹی کا علاج درج ذیل نکات کے تحت کیا جاتا ہے؛

(الف) پری میچور لیبر سے بچاؤ (Prevention Of Premature Labour): اس سے درج ذیل طریقے سے نمٹا جاسکتا ہے؛

1۔ اچھی اینٹی نیٹل کیئر (Antenatal Care)۔

2۔ وہ تمام حالتیں جن میں لیبر وقت سے پہلے شروع ہو سکتی ہو یا جن میں حمل کو وقت سے پہلے ختم کرنا مقصود ہو ان کا صحیح طریقے سے علاج کریں مثلاً

|        |                                |                                  |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|
| ☆..... | پولی ہائیڈرایمنیاس۔            | (Polyhydramnios)                 |
| ☆..... | جزواں حمل۔                     | (Twin Pregnancy)                 |
| ☆..... | اسینٹیل ہائپر ٹینشن۔           | (Essential Hypertension)         |
| ☆..... | گردوں کی بیماری۔               | (Renal Disease)                  |
| ☆..... | دوران حمل بلڈ پریشر کی زیادتی۔ | (Pregnancy Induced Hypertension) |
| ☆..... | سروائیکل ان کمپی ٹینس۔         | (Cervical Incompetence)          |

3۔ سموتھ مسلز (Smooth Muscles) یعنی پلین مسلز کو ڈھیلا کر نیوالی ادویات استعمال کریں۔ اس مقصد کیلئے سمپتھو مائی ٹیک ادویات (Sympathomimetic Drugs) استعمال کی جاتی ہیں۔ ان ادویات کے استعمال سے لیبر کا عمل دیر سے شروع ہوتا ہے۔ ایسے کیسوں میں عام طور پر مستعمل سمپتھو مائی ٹیک ڈرگز درج ذیل ہیں؛

(i)۔ سالبوٹامول (Salbutamol) کا پانچ ملی گرام (ایک ملی لٹر) کا انفیوژن، 5 فیصد ڈیکسٹروز واٹر (5% Dextrose water) کے 500 ملی لیٹر میں ملایا جاتا ہے اور اس انفیوژن کو 10 قطرے فی منٹ کے حساب سے لگاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہر پانچ سے دس منٹ بعد 10 قطرے بڑھا دیتے ہیں حتیٰ کہ رحم کی حرکت بند ہو جائے یا قطروں کی تعداد 50 قطرے فی منٹ تک پہنچ جائے۔ یہ رفتار ہر 20 منٹ بعد 80 قطرے فی منٹ تک کی جاسکتی ہے اگر رفتار بڑھانے کے باوجود بھی یوٹرس کی حرکت نہ رُکے یا دوا کے مضر اثرات رونما ہونا شروع ہو جائیں تو

پھر ایسی صورت میں انفیوژن کی رفتار کم کر دیں اور منہ کے ذریعے سالیوٹامول کی گولی دیں۔

(ii)۔ ریٹوڈرین (Ritodrine) کو رگ کے ذریعے انفیوژن کی صورت میں دیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لئے 100 ملی گرام ریٹوڈرین کو 500 ملی لیٹر پانچ فیصد ڈیکسٹروز وائٹر میں ملا کر انفیوژن کو چار قطرے فی منٹ کی رفتار سے چلایا جاسکتا ہے۔ ہر پندرہ منٹ بعد چار قطروں کو بڑھایا جاسکتا ہے حتیٰ کہ یوٹرس کی حرکت یا توڑک جائے یا ماں کے دل کی دھڑکن کی رفتار 130 فی منٹ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ دوسری صورت میں اسے منہ کے ذریعے 10 سے 20 ملی گرام ہر دو سے چھ گھنٹے بعد بھی دیا جاسکتا ہے۔

(iii)۔ ڈایلاتال (Dilatol) کے پانچ ملی گرام انجکشن کو 500 ملی لیٹر 5% ڈیکسٹروز وائٹر میں ملا کر رگ کے ذریعے دیا جاسکتا ہے۔

(iv)۔ اینٹی پراسٹاگلیکینڈنز (Antiprostaglandins)۔ ایسے کیسوں میں بوقت ضرورت اینٹی پراسٹاگلیکینڈنز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

4۔ آرام (Rest): پری میچورٹی کے کیسز میں حاملہ کو مکمل بیڈریسٹ یعنی آرام کرنے سے متعلق مشورہ دیا جاتا ہے۔

5۔ نیند آور ادویات (Sedatives): ان ادویات کے استعمال میں مارفین وغیرہ سے بچیں کیونکہ اس سے سانس میں تنگی ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لئے پیٹھی ڈین (Pethedine) استعمال کی جاسکتی ہے۔

6۔ گوشت میں ٹیکے کی صورت میں وٹامن کے (Vitamin-K) بچے کو دیں یا پھر 10 ملی گرام ماں کو لگا دیں تاکہ خون کے اخراج کی بیماریاں (Bleeding Disorders) سے بچا جاسکے۔

7۔ بی ٹامیٹھاسون (Betamethasone) کو عضلاتی ٹیکے (I.M) کی صورت میں 12 ملی گرام (3 ملی لیٹر) ضرور لگائیں۔ 1 سے 12 گھنٹے بعد دوبارہ بھی لگایا جاسکتا ہے۔ آخری ٹیکہ لگنے کے 12 گھنٹے بعد ڈیوری کروائی جاسکتی ہے۔

(ب) لیبر اور ڈیلیوری میں حفاظتی تدابیر (Conduct of Labour & Delivery): لیبر اور ڈیلیوری میں یہ حفاظتی تدابیر اپنائیں؛

|        |                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | خاتون کو بیڈ پر لٹا کر رکھیں اور اسے اٹھنے سے منع کریں۔                                              |
| ☆..... | اگر سر ویکس کا منہ کھل چکا ہے اور لیبر شروع ہوگئی ہے تو خاتون کو انیما کروائیں۔                      |
| ☆..... | ویجائٹل ایگزامی نیشن ایسے کریں کہ جراثیم اندر نہ جاسکیں۔                                             |
| ☆..... | چیک کریں کہ جھلیاں پھٹ چکی ہیں اور کارڈ پر ویکس کا خطرہ تو نہیں؟                                     |
| ☆..... | مصنوعی طور پر جھلیوں کو پھاڑنا یا آکسی ٹوسن انجکشن کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا۔                        |
| ☆..... | درودور کرنے کے لئے کم سے کم دوا دی جائے۔                                                             |
| ☆..... | اگر لیبر کا دورانیہ زیادہ ہونے لگے تو خاتون کو حفظہ ماتقدم کے طور پر اینٹی بائیوٹکس استعمال کروائیں۔ |
| ☆..... | دس سے بیس ملی لیٹر 1 فیصد لگنوکین (Lignocaine 1%) لگانے کے بعد اپنی زیاٹومی (Episiotomy) کریں۔       |
| ☆..... | انٹرا کرینیئل ہیمرج سے بچنے کیلئے (Wrigley's Forceps) استعمال کروایا جاسکتا ہے۔                      |
| ☆..... | اگر بچے کی پوزیشن بریچ پری زینیشن (Breech Presentation) ہو تو پھرسی سیکشن (C-Section) تجویز کریں۔    |

(ج) پری میچور بچے کی دیکھ بھال (Management Of Premature Infant): پری میچور بے بی کی دیکھ بھال میں خیال کریں کہ:

- 1- جسم کے درجہ حرارت کی حفاظت: اگر بچے کو کپڑوں میں لپیٹا ہوا ہے تو پھر درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ (86 فارن ہائیٹ) ہونا چاہیے اور اگر بچے کو انکیوبیٹر (Incubator) میں لٹایا ہوا ہے تو پھر انکیوبیٹر کا درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ (95 فارن ہائیٹ) جبکہ کمرے کا درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ (86 فارن ہائیٹ) پر ہونا چاہیے۔ یہ درجہ حرارت پری میچور بچے کے لئے مناسب ہے۔
- 2- کمرے میں نمی (Humidity) 70 سے 80 فیصد کے درمیان ہونی چاہیے۔
- 3- 40 فیصد آکسیجن گرم پانی سے بلبوں کی صورت میں پہنچائی جائے۔
- 4- بچے کو اینٹی بائیوٹکس دیں تاکہ اسے انفیکشن سے بچایا جاسکے۔
- 5- کمرے میں صفائی کے لئے خاص طریقے استعمال کریں تاکہ گرد کی وجہ سے بچے کو کوئی انفیکشن نہ لگ جائے۔
- 6- بچے کو اٹھاتے وقت اپنے ہاتھ اچھی طرح دھولیں۔
- 7- غذا کو صاف برتن میں تیار کریں اور بچے کی ٹیپی (Nappy) صاف کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح دھولیں۔
- 8- بچے کی غذا (Feeding): پری میچور بچے کی غذا کے لئے درج ذیل نکات ذہن میں رکھیں؛

i۔ **بریسٹ فیڈنگ (Breast Feeding):** بچے میں اتنی طاقت ضرور موجود ہوتی ہے کہ وہ چھاتی سے دودھ پی سکے اسلئے ڈیلیوری کے فوراً بعد بچے کو دودھ دینا شروع کر دیں۔ بچے کو وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا دودھ پلاتی رہیں تاکہ پہلے 24 گھنٹے میں بچے کے معدے پر زیادہ دباؤ نہ پڑ جائے اور وہ پھول نہ جائے۔ روزانہ 30 ملی لیٹر دودھ بڑھاتی جائیں حتیٰ کہ یہ 180 ملی لیٹر روزانہ تک پہنچ جائے۔ دودھ دینے کے درمیان وقفہ 3 گھنٹے کافی ہے، ہر تین گھنٹے بعد بچے کو دودھ پلاتی رہیں حتیٰ کہ بچے کا وزن تین کلوگرام ہو جائے تو پھر ہر چار گھنٹے بعد دودھ پلایا جاسکتا ہے۔

ii۔ بوتل والا دودھ دینے سے ہر قیمت پر پرہیز کیا جائے۔

iii۔ **نیزو گیسٹرک ٹیوب فیڈنگ (Nasogastric Tube Feeding):** اس صورت میں دینی چاہیے جب بچہ دودھ نہ چوس سکے۔ اس صورت میں بھی ماں کا دودھ ترجیحاً استعمال کرنا چاہیے۔

iv۔ **انٹرا وینس فیڈنگ (Intravenous Feeding):** اگر بچہ نہ تو دودھ پی سکے اور نہ ٹیوب کی مدد سے دودھ ہضم کر سکے تو ایسی صورت میں بچے کو غذا رگ کے ذریعے دینی پڑے گی۔



## پری میچورٹی کی پیچیدگیاں

### (COMPLICATIONS OF PREMATURITY)

پری میچورٹی کی پیچیدگیاں درج ذیل ہیں؛

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| (Respiratory Distress Syndrome) | ☆..... ریسپائرٹری ڈسٹریس سائنڈروم۔ |
| (Recurrent Apnoea)              | ☆..... ری کرنٹ اپنیا۔              |
| (Hypothermia)                   | ☆..... ہائپو تھرمیا۔               |
| (Hypoglycemia)                  | ☆..... ہائپو گلائیمیہ۔             |
| (Hypocalcemia)                  | ☆..... ہائپو کیلسمیا۔              |
| (Hyperbilirubinemia)            | ☆..... ہائپر بلی روبی نیسمیا۔      |
| (Kenicterus)                    | ☆..... کینک ٹیرس۔                  |
| (Infections)                    | ☆..... انفیکشنز۔                   |

|                                           |                              |        |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------|
| (Cerebral Anoxia)                         | سیربرل ایناگزیا۔             | ☆..... |
| (Intracranial Hemorrhage)                 | انٹراکریئینل ہیمیرج۔         | ☆..... |
| (Reterolental Fibroplasia)                | ریٹرولینٹیل فائبروپلے زیا۔   | ☆..... |
| (Necrotizing Enterocolitis)               | نیکروٹائیزنگ انٹیروکولائیٹس۔ | ☆..... |
| (Disseminated Intravascular Coagulopathy) | ڈی آئی سی۔                   | ☆..... |
| (Anemia of Prematurity)                   | پری میچورٹی انیمیا۔          | ☆..... |

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

عُثْمَانِيَّةٌ بِلِي كِي شَر

## یونٹ: 15

## پوسٹ میچورٹی

## (POST MATURITY)

**تعارف (Introduction):** جب حمل کا دورانیہ نارمل دورانیے یعنی 280 دن سے مزید 14 دن یا اس سے زائد ہو جائے تو اسے پوسٹ میچورٹی (Postmaturity) کہتے ہیں۔ پوسٹ میچورٹی کا چانس عام طور پر پریگی گریویڈا (Primigravida) یعنی پہلے حمل میں زیادہ ہوتا ہے جبکہ ملٹی گریویڈا (Multigravida) میں پوسٹ میچورٹی کا چانس کم ہوا کرتا ہے۔

### پوسٹ میچورٹی کی وجوہات (Causes Of Post Maturity): پوسٹ میچورٹی کے حمل کی عام وجوہات درج ذیل ہیں:

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (Good socio-economic conditions) | ☆..... بہتر معاشی حالات۔                                  |
| (Diabetic females)               | ☆..... ذیابیطس سے متاثرہ خواتین میں۔                      |
| (Hereditary factors)             | ☆..... وراثتی عوامل۔                                      |
| (High level of progesterone)     | ☆..... پروجیسٹران ہارمون کی زیادتی۔                       |
| (Congenital anomalies)           | ☆..... پیدائشی پیچیدگیاں۔                                 |
| (Idiopathic causes)              | ☆..... کچھ خواتین میں پوسٹ میچورٹی کی کوئی وجہ نہیں ملتی۔ |

### پوسٹ میچورٹی کی پیتھوفزیالوجی (Pathophysiology Of Post Maturity): پوسٹ میچورٹی کی پیتھوفزیالوجی درج ذیل ہے:

(1) **پلے سینٹا کے افعال پر اثرات (Effects On Placental Function):** پلے سینٹا کی بھی دیگر اعضا کی طرح ایک خاص عمر ہوتی ہے اور جب ڈیلیوری کا وقت آ جاتا ہے تو پلے سینٹا کے افعال میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ پلے سینٹا میں کئی طبعی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں مثلاً پلے سینٹا کی طرف خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور پلے سینٹا کے خون کی زیادہ تر ٹالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ پلے سینٹا کی جانب خون کی کم گردش کی وجہ سے پلے سینٹا سے غذائی اجزاء کا گزر بھی کم ہو جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر ایمنیوٹک فلوئڈ (Amniotic Fluid) کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔

امبالائیکل کارڈ سے گزرنے والا خون 30 ویں ہفتے میں 90 فیصد آکسیجن سے سیر شدہ (70% Saturated with O<sub>2</sub>) ہوتا ہے جبکہ 43 ویں ہفتے میں خون میں آکسیجن کی مقدار 39 فیصد رہ جاتی ہے۔ جیسے جیسے بچے کی عمر ماں کے پیٹ میں بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے پلے سینا کے افعال میں کمی کی وجہ سے بچے میں غذائی کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس طرح کئی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔

(2) بچے پر اثرات (Effects On Foetus): پوسٹ میچورٹی کی وجہ سے بچے میں درج ذیل اثرات سامنے آسکتے ہیں؛

- ☆..... بچے میں ہیموگلوبن ایف (Haemoglobin-F) کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔
- ☆..... بچے کی طرف آکسیجن کی مقدار بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔
- ☆..... بچے میں سیربیرل پالسی (Cerebral Palsy) اور فیٹل ڈسٹریس (Foetal Distress) کا چانس چار گنا بڑھ جاتا ہے۔
- ☆..... پوسٹ میچور بچوں کے لیکوئر (Liquor) میں میکونیم (Meconium) ملا ہوا ہوتا ہے۔
- ☆..... پوسٹ میچورٹی کی وجہ سے بچے کے سر کی ہڈیاں سخت ہو جاتی ہیں۔
- ☆..... ایسی صورت میں ڈیلیوری بہت مشکل سے ہوتی ہے اور بچے کے دماغ کے اندر جریان خون ہو سکتا ہے۔

(3) ماں پر اثرات (Effects On Mother): پوسٹ میچورٹی کی وجہ سے ماں میں درج ذیل اثرات سامنے آسکتے ہیں؛

- ☆..... ماں میں لیبر کا مرحلہ بہت لمبا ہو سکتا ہے۔
- ☆..... ماں میں بچے کی پیدائش آپریشن کے ساتھ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔
- ☆..... پوسٹ پارٹم ہیمرج (Postpartum Haemorrhage) کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔
- ☆..... ماں میں خون جمانے والے عوامل (Clotting Factors) کی کمی ہو جاتی ہے۔
- ☆..... ماں میں انفیکشن کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔

پوسٹ میچورٹی کی علامات (Signs & Symptoms Of Post Maturity): پوسٹ میچورٹی کے حمل کی عام علامات درج ذیل ہیں؛

- ☆..... خاتون کی دھیان سے ماہواری کی ہسٹری لیں۔ اس میں ماہواری کی باقاعدگی اور ردہم کے بارے میں ضرور استفسار کریں۔
- ☆..... ایسی خواتین کا پہلا ایٹنی ٹیل وزٹ جلد از جلد ہو جانا چاہیے کیونکہ اس وقت یوٹرس کی جسامت کا اندازہ صحیح انداز میں لگایا جاسکتا ہے۔
- ☆..... کوئکننگ (Quickening) کے وقت کے بارے میں پوچھیں۔

☆..... پریگی گریوڈا خواتین میں یہ وقت عام طور پر 18 ہفتے جبکہ ملٹی گریوڈا میں یہ وقت 16 ہفتے ہوتا ہے۔

☆..... تیسری سہ ماہی سے پہلے فنڈس کی اونچائی کا ریکارڈ بڑا اہم ہو سکتا ہے۔

☆..... لیکوئر کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے۔

☆..... ڈیلیوری کا وقت ہو جانے کے بعد ماں کے وزن میں اضافہ رک جاتا ہے۔

☆..... ویجائٹل ایگزائی نیشن پر بچے کا سر انگیج ملتا ہے۔

☆..... حاملہ کا سرویکس بھی بہت ہی پتلی تہہ کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔

☆..... **پوسٹ میچورٹی کی تشخیص (Diagnosis Of Post Maturity):** پوسٹ میچورٹی کے حمل کی عام تشخیص درج ذیل طریقہ سے کی جاتی ہے؛

☆..... **ریڈیالوجیکل ایگزائی نیشن (Radiological Examination):** عام طور پر ایکس رے پر فیمر بون یعنی ران کی ہڈی کے نچلے

کنارے پر آ سی فی کیشن سنٹرز (Ossification Centers) 36 ویں ہفتے میں نمایاں ہو جاتے ہیں جبکہ ٹیپا ہڈی کے اوپری کنارے اور کیوبا نیڈل ہڈی میں یہ سینٹرز ڈیلیوری کی میعاد پوری ہو جانے پر واضح ہوتے ہیں۔

☆..... **پیلوک الٹراساؤنڈ (Pelvic Ultrasound):** الٹراساؤنڈ پر اگر بچے کا بائی پیرائیٹل ڈایامیٹر (Biparietal diameter)

9.8 سینٹی میٹر ہو تو یہ میچورٹی کو ظاہر کرتا ہے اور اگر یہ ڈایامیٹر 10.1 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو یہ پوسٹ میچورٹی کو ظاہر کرتا ہے۔

☆..... **امنیو سینٹی سس (Amniocentesis):** اگر لیسیتھن (Lecithin) اور اسفنگو مائییلین (Sphingomyelin) کے درمیان شرح

2.5:1 سے زائد ہو تو یہ میچورٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح کریٹینین (Creatinine) کا لیول کروانے پر گردوں کی میچورٹی کا صحیح اندازہ ہو جاتا

ہے اگر کریٹینین لیول دو ملی گرام فی 100 ملی لیٹر ہو تو یہ میچورٹی کو ظاہر کرتا ہے۔

☆..... **سینٹو سینان سٹریس ٹیسٹ (Syntocinon Stress Test):** اس ٹیسٹ میں آکسی ٹون کے انجکشن کی 0.01 سے 0.1 یونٹ حاملہ

کی وین میں لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد یوٹرس کی حرکت اور لیبر پر اس کے اثرات کو نوٹ کیا جاتا ہے۔

☆..... **امنیاسکوپ (Amnioscopy):** اس ٹیسٹ کی مدد سے بآسانی پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ڈسٹریس (Distress) کا شکار تو نہیں ہے۔

☆..... **ہارمونز کی مقداریں (Concentrations Of Hormones):** اگر حاملہ عورت کے پلازما میں اور اسی طرح پیشاب میں

پریگنین ڈائی اول (Pregnandiol) اور ایسٹراڈائی اول (Estradiol) ہارمونز کی مقداریں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہوں تو یہ پلے سینا کے

انفعال میں کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔

**پوسٹ میچورٹی کا علاج (Treatment Of Post Maturity):** پوسٹ میچورٹی کا علاج درج ذیل اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے:

(1) جب تشخیص واضح نہ ہو تو ایسی صورت میں متوقع علاج کریں اور مندرجہ ذیل طریقوں سے کنفرم کریں:

☆..... بچے کی حرکت (Foetal Activity) کو نوٹ کریں۔

☆..... سرویکس کی ایفیس منٹ (Effacement) اور کھلے پن (Dilation) کا اندازہ لگائیں۔

☆..... ایمنیا سکوپی (Amnioscopy) کریں تاکہ ایمنیا ٹک فلوئیڈ (Amniotic Fluid) میں میکونیم (Meconium) کا پتہ چلے۔

☆..... پلازما ایسٹرائی اول (Plasma Estriol) کو وقفے وقفے سے چیک کروائیں۔

(2) جب پوسٹ میچورٹی پیدا ہونے کا چانس ہو تو پھر ایسی صورت میں درج ذیل اقدامات اختیار کئے جائیں:

☆..... اگر خاتون میں دوران حمل بلڈ پریشر کی زیادتی (Pregnancy Induced Hypertention) یا سسٹیمک بلڈ پریشر کی زیادتی

(Systemic Hypertension) کی ہسٹری ہو یا تھریٹنڈ ابارشن (Threatened Abortion) کا خدشہ ہو یا خاتون کی عمر

30 سال سے زائد ہو اور وہ پہلی مرتبہ ماں بن رہی ہو تو ایسی صورت میں حمل کو اپنی مدت سے آگے قطعاً نہ بڑھنے دیں کیونکہ اس سے بچے کے خون

میں آکسیجن کی شدید کمی ہو جائے گی اور بچہ فیمل ایناگزیا (Foetal Anoxia) کا شکار ہو جائے گا۔

☆..... اگر حاملہ عورت کے یوٹرس میں بچے کی بریج پریزنٹیشن (Breech Presentation) کے ساتھ پوسٹ میچورٹی کا خطرہ موجود ہو تو

پھر حاملہ کا سیسین (C-Section) کروائیں۔

☆..... اس وقت حمل گرا دیں جب ماں کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے اور ماں کے پیٹ کا سائز کم ہونے لگ جائے اور بچے کی حرکات دس سے

بارہ گھنٹے بعد معلوم ہوں یا ایمنیا ٹک فلوئیڈ (Amniotic Fluid) کی مقدار بہت کم ہو جائے۔

☆..... جب یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ حاملہ عورت کی ڈیلیوری کروانا اب ضروری ہے تو پھر حاملہ عورت کی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید فیصلہ

کریں۔ حاملہ کو چیک کریں کہ اسے سی پی ڈی (CPD) تو نہیں ہے اور بچے کا سر پیلوئس میں آگنج (Engage) ہو چکا ہے یا نہیں۔ اسکے بعد حاملہ

کا دیجیٹل ایگزامینیشن (Vaginal Examination) کریں اور پیلوئس کی جسامت، بچے اور پیلوئس کی جسامت کے درمیان نسبت اور

سرویکس کی حالت کا اندازہ لگائیں۔

☆..... وہ پری می گریویڈا (Primigravida) خواتین جن کی عمر 30 سال سے تجاوز کر گئی ہو اور ان میں پہلے بے اولادی (Infertility) کی

ہسٹری موجود ہو یا جن میں دوران حمل بلڈ پریشر کی زیادتی کی ہسٹری ہو یا پھر سرویکس ابھی تک پوری طرح تیار نہ ہو ہو تو ایسی حاملہ خواتین میں بھی

سی سیکشن (C-Section) کروانا ضروری ہو جاتا ہے۔

- ☆..... دیگر خواتین میں لیبر کے لئے ایمنیا ٹومی (Amniotomy) کریں بشرطیکہ اس خاتون میں پہلے سی سیکشن (C-Section) نہ ہوا ہو۔
- ☆..... پراسٹاگلینڈنز، ای ٹو (Prostaglandins-E2) دو سے تین ملی گرام ویجائز میں رکھنے سے بھی لیبر شروع ہو سکتی ہے۔
- ☆..... ایمنیا ٹومی کریں اور دیکھیں کہ اگر لیکوئر (Liquor) کی مقدار کم ہے یا اس میں میکوئیم موجود ہے تو پھر فوری طور پر سی سیکشن کریں تاکہ بچے کو فیٹل ڈسٹریس (Foetal Distress) سے بچایا جاسکے۔
- ☆..... آکسی ٹوسن (Oxytocin) کی انفیوژن چلا دیں اور اسے ایمنیا ٹومی کے فوراً بعد لگائیں یا چار سے چھ گھنٹے لیبر شروع ہونیکا انتظار کریں۔
- ☆..... اس عرصے کے دوران بچے کی دل کی دھڑکن اور یوٹرس کی حرکت کو کارڈیوٹوکوگراف (Cardiotocograph) پر نوٹ کرتے رہیں تاکہ فیٹل ڈسٹریس (Foetal Distress) سے بچا جاسکے۔
- ☆..... لیبر کی دوسری سٹیج میں فیٹل ڈسٹریس ہونے پر فورسپس ڈیلیوری یا وکیوم ایکسٹریکشن (Vaccum Extraction) کریں۔
- ☆..... اگر چھ گھنٹے کے اندر سینٹوسینان (Syntocinon) یوٹرس کے اندر حرکت پیدا کرنے سے قاصر رہے تو سی سیکشن ضروری ہو جاتا ہے۔
- ☆..... سر کی پیدائش کے بعد شولڈر ڈسٹوشیا (Shoulder Dystocia) ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ بچے کی بڑی جسامت ہو سکتی ہے۔ حاملہ کو لتھا ٹومی پوزیشن (Lithotomy Position) میں لٹا دیا جاتا ہے۔ فنڈس سے دباؤ ڈال کر بچے کے سر کو نیچے اور پیچھے کی طرف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ بچے کا سر پیلوس کے ایکسس (Axis) میں آجائے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

عثمانیہ سائنس کی پیشکش

## یونٹ: 16

## قبل از ولادت اور بعد از ولادت حاملہ کی نگہداشت

(PRENATAL AND POSTNATAL CARE)

## (قبل از ولادت حاملہ کی نگہداشت)

(PRENATAL CARE)

**تعارف (Introduction):** جب بھی کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اسکے جسم میں کچھ طبعی اور نفسیاتی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اس مرحلے پر حاملہ عورت کی صحیح طور پر نگہداشت نہ کی جائے تو نہ صرف حاملہ عورت بلکہ اس کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے پر بھی اس کا منفی اثر ہو سکتا ہے لہذا زچگی سے قبل حاملہ عورت کی نگہداشت کرنا حمل کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے۔ حمل کے دوران حاملہ کی نگہداشت میں درج ذیل تین اہم نکات کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے تاکہ ایک نارمل حمل جاری رہے اور اس کے نتیجے میں ایک تندرست بچہ حاصل ہو۔

|   |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| 1 | حاملہ کا کلینیکل معائنہ۔ | (Clinical Examination) |
| 2 | کلینیکل ٹیسٹ۔            | (Clinical Test)        |
| 3 | حفظان صحت کے اصول۔       | (Hygienic Principles)  |

**1۔ حاملہ کا کلینیکل معائنہ (Clinical Examination):** حمل اور زچگی کے درمیانی عرصہ میں ایک حاملہ کو کم از کم تین مرتبہ اپنا کلینیکل معائنہ کروانا چاہیے۔ پہلا کلینیکل معائنہ حمل ٹھہر جانے کے چھ ہفتوں سے لے کر سولہویں ہفتے تک کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس کلینیکل معائنے کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ حمل کے لحاظ سے عورت کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جائے کہ آیا عورت حمل کی ذمہ داریاں آسانی سے برداشت کر لے گی یا نہیں۔ علاوہ ازیں حمل صحیح طور پر اور صحیح مقام پر قرار پایا ہے اور حاملہ عورت کسی بیماری مثلاً خون کی کمی، ٹی بی، سمیت حمل یا کسی اور جنسی و جسمانی بیماری میں مبتلا تو نہیں غرضیکہ پہلے کلینیکل معائنے سے حاملہ کی نگہداشت کا موثر پہلو شروع ہو جاتا ہے یعنی اگر پہلے ہی کلینیکل معائنے کے دوران کسی بھی مرض کا پتہ لگتا ہے تو اس مرض کا موثر علاج شروع کیا جاسکتا ہے۔

حاملہ عورت کا دوسرا معائنہ بتیسویں سے چھتیسویں ہفتے کے درمیان ہونا چاہیے۔ دوسرے کلینیکل معائنے میں ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کی کیفیت، زاویے اور پوزیشن و نشوونما سے متعلق اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا بچے کے قدرتی وضع اور پوزیشن کے

وقت کیا کیا پیچیدگیاں پیش آسکتی ہیں اور یہ کہ بچے کی اس کیفیت کو کسی طریقے سے قدرتی وضع میں لایا جاسکتا ہے کہ نہیں۔ اس معائنے کے موقع پر لیڈی ڈاکٹر حاملہ کے پیٹ کا دیکھ کر، ٹول کر، آلے سے سن کر، بچے کی پوزیشن، نشوونما اور کیفیت کا اندازہ لگاتی ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت کا تیسرا کلینیکل معائنہ حمل کے 38 ویں یا 39 ویں ہفتے میں ہونا چاہیے۔ تیسرے کلینیکل معائنے کے دوران لیڈی ڈاکٹر یہ معلوم کر سکتی ہے کہ آیا بچہ معمول کے مطابق نارمل طریقے سے پیدا ہو جائے گا یا نہیں۔ اس معائنے کے نتیجے میں وضع حمل کے طریقہ کار سے متعلق وضاحت ہو سکتی ہے کہ بچہ قدرتی طریقے پر پیدا ہوگا یا خدائے خدا سے آپریشن وغیرہ کی ضرورت پڑے گی۔

**2۔ کلینیکل ٹیسٹ (Clinical Tests):** کلینیکل ٹیسٹ بھی زچگی سے قبل حاملہ کی نگہداشت کا ایک اہم پہلو ہے اس نگہداشت کے دوران ہر حاملہ عورت کے چند کلینیکل ٹیسٹ ضرور لینے چاہئیں مثلاً پیشاب کا معائنہ، بلڈ پریشر کی پیمائش، خون کا معائنہ خصوصاً ہیموگلوبن کی مقدار کی پیمائش کسی بھی جنسی بیماری سفلس، گنوریا، ایڈز کا ٹسٹ، اسی طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ، وزن کی پیمائش وغیرہ اور دوسرے ضروری ٹیسٹ ضرور کر لینے چاہئیں تاکہ حمل اور زچگی کے دوران کسی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح بلڈ گروپ اور آر، ایچ فیکٹر بھی ضروری طور پر چیک کیا جاتا ہے تاکہ خون کی ضرورت پڑنے پر مطلوبہ خون حاملہ عورت کو دیا جاسکے۔ اسی طرح ضروری الٹرا سائونڈ اور ایکس رے بھی کئے جاتے ہیں۔

**3۔ حفظانِ صحت کے اصول (Hygienic Principles):** حاملہ عورت کو درج ذیل حفظانِ صحت کے اصولوں پر کاربند رہنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرے اور اپنا میڈیکل چیک اپ وقتاً فوقتاً ضرورت اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کراتی رہے۔ حمل کے دوران تجویز کی گئی دوائیں اور ویکسین پابندی سے لگوائے۔ عورت اپنے وزن، بلڈ پریشر اور پیشاب کے ٹیسٹ پر مکمل نظر رکھے۔ حاملہ عورت زیادہ سے زیادہ مائع غذا استعمال کرے تاکہ قبض نہ ہو۔ وزن زیادہ ہونے کی صورت میں عورت کو چکنائی، نشاستہ اور پروٹین متوازن طور پر استعمال کرنا چاہئیں۔ غذا اتنی متوازن ہوتا کہ ضروری پروٹین، نشاستہ، چربی، وٹامن اور منرل سائٹس کی جسم میں کمی واقع نہ ہونے پائے۔ اسی طرح حاملہ کی نیند خصوصی طور پر مکمل ہو۔ بلکی پھلکی ورزش اور پیدل چلنا نہ صرف حاملہ کے جسم بلکہ ذہن پر بھی خوشگوار اثر ڈالتا ہے۔ ٹانگوں کی ورزش اور پہلو کے عضلات کی ورزش زچگی میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ حاملہ کا لباس قدرے ڈھیلا ڈھالا اور ترجیحاً سوتی ہونا چاہیے تاکہ جسم اور خصوصاً پیٹ کو ہوا لگتی رہے۔ زچگی سے تقریباً ہفتہ دس دن پہلے حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پستانوں کو صابن سے دھو کر خشک کرے اور ہاتھ سے مساج کرے تاکہ پستان میں موجود دودھ کی نالیاں کھل جائیں اور زچگی کے فوراً بعد دودھ باآسانی اتر آئے، اسی طرح اگر ممکن ہو تو حاملہ عورت کو حمل کے دوران حمل اور زچگی سے متعلق لٹریچر، کتابوں اور رسائل وغیرہ کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔



## حاملہ کا معائنہ

### (PRENATAL EXAMINATION)

**تعارف (Introduction):** قبل از ولادت حاملہ کا معائنہ پری نٹل ایگزامی نیشن کہلاتا ہے جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

- ☆..... اس معائنہ سے بچے کی حالت کا مسلسل علم ہوتا رہتا ہے۔
- ☆..... حاملہ کی صحت کا مسلسل علم ہوتا رہتا ہے۔
- ☆..... اگر حمل یا بچے میں کوئی پیچیدگی ہو تو بروقت علم ہو جاتا ہے۔
- ☆..... معائنہ کیلئے حاملہ کے پاس پہلی مرتبہ ڈاکٹر یا L.H.V کے آنے پر اس سے متعلق تمام معلومات اکٹھی کر لی جاتی ہیں۔
- ☆..... یہ معلومات پورے حمل کے دوران آئندہ ہونے والے معائنوں میں بھی مفید ثابت ہوتی ہیں۔
- ☆..... حاملہ کے معائنہ کیلئے ایک شیڈول دیا جاتا ہے جس کے مطابق وہ اپنا معائنہ کرواتی ہے۔
- ☆..... حمل قرار پانے کے بعد 28 ہفتے تک ضروری ہے کہ حاملہ ہر 4 ہفتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا معائنہ کروائے۔
- ☆..... اس کے بعد 36 ہفتے تک ضروری ہوتا ہے کہ حاملہ ہر 15 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا معائنہ کروائے۔
- ☆..... اس کے بعد پیدائش تک ضروری ہوتا ہے کہ حاملہ ہر 7 روز کے بعد جا کر معائنہ کروائے۔

اس طرح کے معائنہ کے دوران مندرجہ ذیل باتیں معلوم کی جاتی ہیں:

- ☆..... حاملہ کی مکمل موجودہ اور سابقہ سٹری معلوم کی جاتی ہے۔
- ☆..... حاملہ کی ظاہری صحت کا مکمل شیڈول تیار کیا جاتا ہے۔
- ☆..... حاملہ کے پیٹ کا مکمل معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ حمل کے علاوہ کسی اور خرابی کا علم ہو سکے۔
- ☆..... حاملہ کا پیشاب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تاکہ کوئی بیماری ہو تو علم میں آجائے۔
- ☆..... حاملہ کے خون کے مختلف ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جن میں ہیموگلوبین اور خون میں شوگر معلوم کرنے کا ٹیسٹ بہت اہم ہے۔
- ☆..... ہر وزٹ پر حاملہ کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے اور اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔

- ☆..... حاملہ کے کوہے کا تفصیلی معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ پیدائش کیلئے درکار گنجائش موجود ہے یا نہیں۔
- ☆..... ہر معائنہ پر آخری ہفتوں میں بچے کی دل کی دھڑکن کا مکمل معائنہ کیا جاتا ہے۔
- ☆..... دوران حمل اگر کسی طرح کا ڈسپارچ ہو رہا ہو تو اس کی تفصیل جانی جاتی ہے۔
- ☆..... معلوم کیا جاتا ہے کہ حاملہ لیکوریا وغیرہ میں تو مبتلا نہیں۔
- ☆..... اس طرح کی معلومات اور مسلسل معائنہ سے حاملہ ہر طرح کی پیچیدگی سے بچ جاتی ہے۔
- ☆..... اس طرح حمل کا دورانیہ محفوظ طریقے سے گزر جاتا ہے اور یوں ایک نارمل ڈیلیوری کو یقینی بنایا جاتا ہے۔



## حاملہ کے لئے فائدہ مند مشورے

### (ADVISES FOR PREGNANT WOMAN)

**تعارف (Introduction):** حمل کے دوران ڈاکٹر کسی بھی حاملہ عورت کو بہت سی احتیاطوں پر عمل کرنے کو کہتی ہے۔ بہت سے مفید مشورے دیتی ہے، بہت سی ہدایات پر عمل کرنے کو کہتی ہے تاکہ حاملہ کے حمل کے دورانیہ میں کوئی خرابی یا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور وہ مکمل طور پر صحت مندرہ سکے۔ ڈاکٹر کی جانب سے عام طور پر مندرجہ ذیل مشورے دیئے جاتے ہیں؛

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (Care in use of medicines)  | ☆..... ادویات کے استعمال میں احتیاط۔ |
| (Mental relaxation)         | ☆..... ذہنی سکون کا خیال۔            |
| (Care in marital relations) | ☆..... مباشرت میں احتیاط۔            |
| (Rest and sleep):           | ☆..... نیند اور آرام۔                |
| (Fresh air)                 | ☆..... تازہ ہوا۔                     |
| (Care in intake of food)    | ☆..... غذائی احتیاط۔                 |
| (Suitable shoes)            | ☆..... مناسب جوتے۔                   |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| (Bathing precautions)     | ☆..... غسل کی احتیاط۔    |
| (Forbidden for narcotics) | ☆..... نشہ سے ممانعت۔    |
| (Care in travelling)      | ☆..... سفری احتیاط۔      |
| (Sun light)               | ☆..... سورج کی روشنی۔    |
| (Suitable cloths)         | ☆..... مناسب لباس۔       |
| (Suitable exercise)       | ☆..... مناسب ورزش۔       |
| (Climate precautions)     | ☆..... موسم کی احتیاط۔   |
| (Care of breasts)         | ☆..... پستانوں کی حفاظت۔ |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (Care In Use Of Medicines): | ☆..... ادویات کے استعمال میں احتیاط: |
|-----------------------------|--------------------------------------|

- ☆..... دوران حمل ادویات کے استعمال کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس حوالہ سے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور یونانی ہر طرح کی ادویات کا استعمال احتیاط سے اور ڈاکٹر کے مشورہ سے کرنا چاہئے۔
- ☆..... لوگ ذاتی علم کی بنیاد پر دوا استعمال کر لیتے ہیں۔
- ☆..... حمل کے دوران خود سے کوئی دوا استعمال نہیں کرنی چاہئے۔
- ☆..... دوا کا استعمال صرف کو الیفائیڈ ڈاکٹر یا L.H.V کے مشورہ سے کریں۔
- ☆..... دوران حمل کسی بھی ڈاکٹر سے دوا لینے جائیں تو اس کو حمل کے بارے میں ضرورت بتائیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔
- ☆..... بہت سے عطائی مختلف دعوے کرتے ہیں ایسے کسی فرد سے دوا ہرگز نہ لیں۔

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| (Mental Relaxation): | ☆..... ذہنی سکون کا خیال: |
|----------------------|---------------------------|

- ☆..... کسی بھی حاملہ عورت کے ذہنی سکون کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ حمل اور بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔
- ☆..... تمام گھروالوں کی ذمہ داری ہے کہ حاملہ عورت کو خوش رکھیں۔
- ☆..... خاوند کا فرض ہے کہ بیوی کو ہر طرح سے ذہنی طور پر مطمئن رکھے۔

- ☆..... فکر، غم، پریشانی سے حمل پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
- ☆..... ایک پریشان اور بے سکون ماں غیر صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہے۔
- ☆..... ایک خوش و خرم اور مطمئن ماں صحت مند بچے کو جنم دے گی۔

## (Care In Marital Relations):

## ☆..... مباشرت میں احتیاط:

- ☆..... مباشرت شادی شدہ جوڑے کیلئے جنسی لذت کا ذریعہ ہے لیکن جب عورت حاملہ ہو جائے تو مباشرت میں احتیاط کرنی چاہئے۔
- ☆..... مباشرت کے لئے سادہ طریقہ استعمال کرنا چاہئے۔
- ☆..... جماع کی کثرت سے اجتناب کریں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔
- ☆..... مباشرت میں بے احتیاطی کرنے سے ابارشن ہو سکتا ہے۔
- ☆..... حمل کے آخری دنوں میں مباشرت بند کر دینی چاہئے۔
- ☆..... مباشرت ضرور کریں لیکن اپنے جذبات کو اعتدال میں رکھیں تاکہ آنے والے مہمان کو کوئی نقصان نہ ہو۔
- ☆..... جب عورت کا پیٹ بڑھ جائے اور اس کو مرد کے اوپر آنے سے دقت ہو تو کوئی اور آرام دہ پوزیشن اختیار کریں۔
- ☆..... حمل کے دوران اگر رحم سے خون آئے تو مباشرت ہرگز نہ کریں۔

## (Rest And Sleep):

## ☆..... نیند اور آرام:

- ☆..... حاملہ عورت کے لئے نیند اور آرام بہت ضروری چیز ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔
- ☆..... ہمیشہ خیال رکھیں کہ حاملہ کو سونے کیلئے آرام دہ بستر فراہم کریں۔ حاملہ کو 24 گھنٹوں میں کم از کم 10 گھنٹے سونا چاہئے۔
- ☆..... بعض افراد سونے کیلئے نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں حاملہ کو کبھی بھی نیند آور دوا استعمال نہ کروائیں۔
- ☆..... حاملہ سے زیادہ کام نہ کروائیں کہ جس سے اس کو تھکاوٹ ہو جائے۔
- ☆..... حمل کے آخر میں آرام کی ضرورت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔
- ☆..... اگر نیند کی کمی ہو تو حاملہ کے سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔
- ☆..... سونے سے قبل حاملہ کو نیم گرم دودھ دیں اس سے بہت نیند آئے گی۔
- ☆..... نیند کے علاوہ دیگر اوقات میں آرام دہ حالت میں بیٹھیں اور لیٹیں۔

(Fresh Air):

☆.....تازہ ہوا:

- ☆.....تازہ ہوا ہر انسان کیلئے ضروری ہے۔ حاملہ کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
- ☆.....حاملہ کو تازہ ہوا کی ضرورت اس لئے بڑھ جاتی ہے کیونکہ بچے کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ☆.....کسی تاریک اور گھٹن والی جگہ پر حاملہ کو ہرگز نہ رکھیں۔
- ☆.....اگر حاملہ کو تازہ ہوا نہ ملے تو اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔

(Care In Intake Of Food):

☆.....غذائی احتیاط:

- ☆.....جسمانی نشوونما میں خوراک یا غذا بنیادی چیز ہے حاملہ کو خاص غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو غذا کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔
- ☆.....حاملہ کی غذا کا چارٹ ماہر ڈاکٹر کی مدد سے تیار کریں۔
- ☆.....حاملہ کو متوازن غذا دیں جس میں تمام غذائی اجزاء شامل ہوں۔
- ☆.....ایسی غذا دیں جس میں فولاد اور کیلشیم کی مناسب مقدار ہو۔
- ☆.....ہمیشہ متوازن، سادہ اور زود ہضم غذا دیں۔
- ☆.....پھلوں، سبزیوں اور دودھ کا باقاعدہ استعمال کروائیں۔
- ☆.....قابلض غذا نہ دیں اسی طرح نفخ پیدا کرنے والی غذا نہ دیں۔

(Suitable Shoes):

☆.....مناسب جوتے:

- ☆.....مناسب جوتے بھی حاملہ کیلئے ضروری ہیں۔
- ☆.....دوران حمل پیروں پر سوجن ہو جاتی ہے اس لئے تنگ جوتے استعمال نہ کریں۔
- ☆.....دوران حمل ایڑی والے جوتوں کے استعمال سے گریز کریں۔
- ☆.....عورت کو بتائیں کہ وہ ہموار فرش پر چلے اور بغیر ایڑی والا آرام دہ جوتا استعمال کرے۔

## (Bathing Precautions):

## ☆..... غسل کی احتیاط:

- ☆..... حاملہ کے لئے فائدہ کی بات ہے کہ وہ روزانہ غسل کرے۔
- ☆..... غسل کے لئے پانی کا درجہ حرارت موسم کی مناسبت سے ہو۔
- ☆..... غسل سے جلد کے مسام کھلے رہتے ہیں اور گندے مادے پسینہ کے ذریعے خارج ہوتے رہتے ہیں۔
- ☆..... بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ سرد پانی استعمال نہ کریں۔
- ☆..... غسل کرنے سے طبیعت میں فرحت اور تازگی آتی ہے۔

## (Forbidden For Narcotics):

## ☆..... نشہ سے ممانعت:

- ☆..... حاملہ عورت کیلئے نشہ آور اشیاء زہر قاتل ہیں ان سے بچائیں۔
- ☆..... بڑے گھرانوں کی عورتیں نشہ کرتی ہیں دوران حمل اس کو کنٹرول کریں۔
- ☆..... نشہ کے استعمال سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔
- ☆..... حمل کے دوران شراب کا استعمال بہت نقصان دیتا ہے۔
- ☆..... کلوٹین کا زہر نقصان دہ ہے اس لئے حاملہ کو سگریٹ نوشی سے بچائیں۔
- ☆..... سگریٹ نوشی سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے جو پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے۔
- ☆..... نشہ سے بچے کے دل اور پھیپھڑے متاثر ہو سکتے ہیں۔

## (Care In Travelling):

## ☆..... سفری احتیاط:

- ☆..... دوران حمل سفری احتیاط بہت ضروری ہے۔
- ☆..... حمل کے دوران پہاڑی علاقے یا ناہموار راستے کا سفر نہ کریں۔
- ☆..... ایسا سفر جس میں جمپ ہوں ہرگز نہ کریں۔
- ☆..... سمندری سفر سے گریز کریں ورنہ پیچیدگی ہو سکتی ہے۔
- ☆..... ہوائی جہاز کا سفر ڈاکٹر کے مشورہ سے کریں۔
- ☆..... آرام دہ اور ہموار سفر کریں۔ تیز رفتار سفر سے بھی گریز کریں۔

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| (Sun Light): | ☆..... سورج کی روشنی: |
|--------------|-----------------------|

- ☆..... سورج کی روشنی زندگی کی چند بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ اس کی حاملہ کو بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔
- ☆..... تاریک ماحول جہاں سورج کی روشنی نہ جاتی ہو وہاں حاملہ کو ہرگز نہ رکھیں۔
- ☆..... سورج کی روشنی سے قدرتی طور پر وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے۔
- ☆..... روشنی اور سورج کی روشنی والا ماحول حاملہ کو فائدہ دیتا ہے۔

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (Suitable Cloths): | ☆..... مناسب لباس: |
|--------------------|--------------------|

- ☆..... دوران حمل مناسب اور درست لباس کا استعمال بہت اہم ہے۔
- ☆..... دوران حمل تنگ کپڑوں کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
- ☆..... لباس کا استعمال موسم کی مناسبت سے کریں۔
- ☆..... دوران حمل ڈھیلا ڈھالا لباس اور کاٹن کا استعمال بہترین ہے۔
- ☆..... حاملہ کو صاف، ہلکا اور جراثیم سے پاک لباس پہننا چاہئے۔

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| (Suitable Exercise): | ☆..... مناسب ورزش: |
|----------------------|--------------------|

- ☆..... دوران حمل ورزش کی جاسکتی ہے لیکن ڈاکٹر کے مشورہ سے ہلکی قسم کی ورزش کی جاسکتی ہے سخت بھاری ورزش نقصان دہ ہو سکتی ہے
- ☆..... دوران حمل باقاعدگی سے چہل قدمی کرنا ایک بہترین ورزش ہے۔
- ☆..... گھریلو عورت کے لئے گھر کے معمول کے کام کرنا بھی ایک ورزش ہے لیکن وزنی کام نہ کریں۔

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| (Climate Precautions): | ☆..... موسم کی احتیاط: |
|------------------------|------------------------|

- ☆..... موسم انسان کی صحت پر بہت اثرات مرتب کرتا ہے اس لئے حاملہ کو موسمی اثرات سے بچا کر رکھنا چاہئے۔
- ☆..... موسم سے بچنے کیلئے ہمیشہ مناسب لباس استعمال کریں۔
- ☆..... چھڑکے موسم میں چھڑدانی کا استعمال کریں۔
- ☆..... سرد موسم میں سرد ہوا سے حاملہ کو بچائیں۔

(Care Of Breasts):

☆.....پستانوں کی حفاظت:

☆.....پستانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آنے والے وقت میں بچے کیلئے دودھ کا ذریعہ بنتے ہیں۔

☆.....باقاعدگی سے پستانوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔

☆.....حاملہ کو چاہئے کہ آرام دہ بریزرز کا استعمال کرے، تنگ بریزرز کا استعمال نہ کرے۔

☆.....اگر پستان کی بھٹنی میں چیر آجائے تو ڈاکٹر کے مشورے سے مناسب کریم استعمال کریں۔

☆☆☆

## بعد از ولادت حاملہ کی نگہداشت

(POSTNATAL CARE)

**تعارف (Introduction):** زچگی یعنی ڈیلیوری ہو جانے کے بعد سے لے کر چھ ہفتے تک ماں کی نگہداشت کو پوسٹ نٹل کیئر کہتے ہیں۔ اسی عرصہ کو طبی اصطلاح میں پیورپیریم (Puerperium) بھی کہا جاتا ہے۔ پوسٹ نٹل کیئر میں ایک ڈاکٹر کو ماں کی حالت پر خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس عرصے میں ماں کے تمام تر خلیات بہت حد تک اپنے آپ کو حمل سے قبل کی حالت میں لے آتے ہیں۔

پوسٹ نٹل کیئر میں ماں کے بلڈ پریشر، نبض کی رفتار، جسمانی درجہ حرارت، خون کی کمی اور جریان خون کا خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ جسمانی درجہ حرارت کا بڑھنا جسمانی انفکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر بڑھنے کا مطلب سمیت حمل یعنی سپٹی سیسیا اور بلڈ پریشر گھٹ جانے کا مطلب جریان خون یا صدمہ یعنی شاک کی حالت کو ظاہر کرتا ہے لہذا زچگی کے بعد ماں کو ان حالتوں سے بچانے کیلئے درج بالا نکات پر نظر رکھنا لازمی ہے۔

زچگی کے بعد رحم یعنی یوٹرس کا آہستہ آہستہ بتدریج سکڑ کر واپس اپنی طبعی حالت میں آنا بھی ایک ضروری امر ہے لہذا پوسٹ نٹل کیئر کے دوران یوٹرس کا سکڑ کر اپنی طبعی حالت میں واپس آنے کا بھی جائزہ لینا ایک ضروری پہلو ہے۔ زچگی کے بعد طبعی طور پر یوٹرس، سرویکس اور ویجائنہ سے ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جسے نفاس یعنی لوشیا (Lochia) کہتے ہیں۔ یہ رطوبت نفاس دراصل خون، پلے سینٹا اور ڈیسی ڈوا جھلی کے مردہ خلیات اور ویسلز کے ٹوٹے ٹھوٹے ٹکڑوں وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ رطوبت طبعی طور پر دس سے پندرہ روز تک آتی رہتی ہے اور پھر بتدریج اس کا رنگ سرخ سے پیلا اور پھر ہلکا سفید ہوتے ہوئے بند ہو جاتی ہے۔ زچگی کے بعد نفاس پر خصوصی نظر ہونی چاہیے۔ عام طور پر دس سے پندرہ دن تک اس رطوبت کا اخراج خود بخود بند ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کا اخراج بند نہ ہو تو اس کا عموماً مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوٹرس میں کوئی انفیکشن سرایت کر گیا ہے۔

زچگی کے بعد پوسٹ نٹل کیئر کے طور پر پستانوں کی حالت اور دودھ کے اخراج پر بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ زچگی کے فوراً بعد ہی دودھ کی طرح کی ایک گاڑی سی رطوبت کولاسٹرم (Colostrum) پستانوں سے خارج ہوتی ہے جو کہ دودھ کی نامکمل شکل ہے اور پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے۔ زچگی کے دوسرے روز پستانوں کا نہایت نرمی سے مساج کرنا چاہیے تاکہ پستانوں میں موجود دودھ کی نالیاں کھل جائیں اور تیسرے روز سے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیے۔ بسا اوقات پہلی زچگی کے بعد کئی عورتوں میں دودھ کی پیدائش کم ہوتی ہے یا پھر بچے میں دودھ چوسنے کی طاقت کم ہوتی ہے۔

کئی عورتوں میں زچگی کے بعد نفسیاتی خوف کی وجہ سے پہلے یا دوسرے روز تک پیشاب رُک جانا ایک عام سی بات ہے۔ عام طور پر زچگی کے چھ گھنٹے بعد ماں کو پیشاب آجایا کرتا ہے۔ اگر پیشاب نہ آئے تو مٹانہ کے اوپر مساج یا ہلکی سکاٹی کرنے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ کئی عورتوں میں زچگی کے بعد قبض ہو جانا بھی ایک عام شکایت ہے۔ قبض اگر کئی دنوں تک جاری رہے تو پھر اس کا موثر توڑ کرنا چاہیے جس کے لئے ادویات کے علاوہ انیما بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ زچگی کے بعد ماں کو اپنی نیند، آرام اور سکون کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور رات کے علاوہ بھی دوپہر کو ہلکی نیند اور آرام کرنے سے ماں کی حالت جلد از جلد سنبھل جایا کرتی ہے۔

زچگی کے بعد ماں کی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ماں کی خوراک حفظانِ صحت کے اصولوں کے عین مطابق متوازن، زود ہضم اور طاقتور ہونی چاہیے۔ اسی طرح زچہ عورت کی ہلکی پھلکی ورزش بھی پوسٹ نٹل کیئر کا اہم پہلو ہے۔ زچگی کے دوسرے روز سے ہی ماں کو بستر سے اٹھا کر ٹھلانا چاہیے اور گہرے گہرے سانس لینے کی ترغیب دینی چاہیے جس سے تمام جسم کا دورانِ خون بہتر ہو جاتا ہے اور یوٹرس بھی سکڑ کر اپنی طبعی جگہ پر آسانی سے آ جاتا ہے۔

زچہ اور بچہ کی صفائی و ستھرائی بھی انتہائی ضروری امر ہے تاکہ زچہ اور بچہ کو کوئی انفکشن نہ ہو سکے لہذا ضروری ہے کہ ہر روز زچہ اپنے پستانوں اور اعضائے تناسل کو دافعِ عفونت یعنی اینٹی سپٹک محلول سے دھوئے۔ اسی طرح بچے کی ناف کو بھی اینٹی سپٹک محلول سے دھونا چاہیے اور خشک ہونے پر اینٹی سپٹک پاؤڈر چھڑکنا چاہیے۔ اسی طرح زچہ اور بچہ کا لباس و بستر بھی مناسب، پاک، صاف اور جراثیموں سے محفوظ ہونا چاہیے۔

زچگی کے چھٹے ہفتے کے آخر میں زچہ کا تفصیلی میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی پیچیدگی یا بیماری کی موجودگی کی صورت میں اس کا سدباب کیا جاسکے۔ اسی طرح اگر ماں اولاد میں وقفہ چاہتی ہے تو اسے اس کے تمام جائز اور مناسب طریقے بتا دینے چاہئیں اور ہر طریقے کے فائدے و نقصان بھی بتا دینے چاہئیں اور مزید معلومات و دیگر طریقوں کے لئے ماں کو فیملی پلاننگ کلینک ریفر کر دینا چاہیے۔





Prenatal Care



Postnatal Care

یونٹ: 17

## گائنا کولاجیکل اینڈ آبسٹیٹریکل الٹراساؤنڈ

(GYNAECOLOGICAL & OBSTETRICAL ULTRASOUND)

**الٹراساؤنڈ کا تعارف (Ultrasound An Introduction):** الٹراساؤنڈ میڈیکل پریکٹس میں استعمال ہونے والا ایک انتہائی اہم ٹیسٹ ہے۔ الٹراساؤنڈ کے ذریعے ہم جسم کے کئی حصوں کی بیماریوں کا پتہ لگا سکتے ہیں مثلاً گردوں، پیٹ، سینے، گلینڈز کی بیماریوں اور حمل کے دوران بچے کی پوزیشن ونشونما کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ الٹراساؤنڈ کی تصویر پلازمیکوٹیکنیک (Pulse Echo Technique) کے ذریعے لی جاتی ہے اس میں الٹراساؤنڈ مشین میں لگے ہوئے ٹرانسڈیوسر (Transducer) سے الٹراساؤنڈ کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور جسم سے گزرتی ہوئی اعضاء سے ٹکرا کر الٹراساؤنڈ مشین میں لگے ہوئے ٹرانسڈیوسر کی طرف واپس آ جاتی ہیں۔ الٹراساؤنڈ کی مشین واپس آنے والی لہروں کا تجزیہ کرتی ہے اور اسکے مطابق ایک تصویر بنا دیتی ہے۔ یہ تصویر چھوٹے چھوٹے نقطوں (Dots) کی صورت میں ہوتی ہے۔ ہر نقطے کی چمک اس بات پر منحصر ہے کہ کس شدت سے آواز ٹکرا کر واپس آئی ہے اس طرح اگر معالج انسانی جسم کا صحیح علم رکھتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ تصویر جسم کے کس حصے کی ہے۔



## بانجھ پن

(انفرٹیلٹی)

(INFERTILITY)

**تعارف (Introduction):** خواتین میں بانجھ پن ایک عام مسئلہ ہے بہت سی خواتین شادی کے کافی عرصے بعد ماں بنتی ہیں۔ اگر شادی کے ایک سال بعد تک خاتون ماں نہ بن سکے بشرطیکہ اس کا خاوند اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھے تو ایسی عورت کا معائنہ ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کے لئے دوسرے ہارمونل ٹیسٹوں اور پروجسٹرز کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی ٹیسٹ الٹراساؤنڈ ہے۔



## بانجھ پن کی تشخیص بذریعہ ٹرانس ایبڈامینل اسکیننگ

### (DIAGNOSIS OF INFERTILITY BY TRANSABDOMINAL SCANNING)

**طریقہ (Procedure):** اس تکنیک میں مریضہ کا مثانہ بھرا ہوا ہونا چاہیے اس سے یوٹرس تقریباً افقی (Longitudnal) رخ پر آ جاتا ہے اور پھر اس کا معائنہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا الٹراساؤنڈ پیٹ کے اوپر سے کیا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے درج ذیل نسوانی اعضاء آسانی سے نظر آ جاتے ہیں اور ان کی ساخت کو جاننے میں بھی کافی مدد مل جاتی ہے؛

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | یوٹرس اس کی پوزیشن اور اس میں موجود سولیوں یا فائبرائیڈز کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ |
| ☆..... | اووریز اور اس کی ساخت میں تبدیلی کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔                         |
| ☆..... | فیلوپین ٹیوب اور اس کی بیماریاں بھی اس الٹراساؤنڈ سے پتہ چل جاتی ہیں۔                |



## ٹرانس ویجائینل اسکیننگ

### (TRANSVAGINAL SCANNING)

**تعارف (Introduction):** ویجائینل کے راستے سے پیلوک کیوٹی کے اعضاء کا معائنہ اب عام ہوتا جا رہا ہے اور جب سے یہ تکنیک آئی ہے، ٹرانس ایبڈامینل الٹراساؤنڈ کی اہمیت کم ہو گئی ہے کیونکہ اس نئی تکنیک سے یوٹرس، اووریز اور فیلوپین ٹیوبز کا بہتر طریقے سے معائنہ کیا جاسکتا ہے۔

**افادیت (Advantages):** ٹرانس ویجائینل الٹراساؤنڈ کی افادیت درج ذیل ہے؛

|        |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | ٹرانس ویجائینل اسکیننگ سے نسوانی اعضاء مخصوصہ میں معمولی سے معمولی خرابی کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔                      |
| ☆..... | اس الٹراساؤنڈ سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے میں درد، یوٹرس، اووریز یا فیلوپین ٹیوبز کی وجہ سے ہے۔           |
| ☆..... | اگر اووریز آسانی سے حرکت نہ کر سکتی ہوں تو اس الٹراساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں اووریز آنتوں سے چپکی ہوئی تو نہیں؟ |
| ☆..... | اگر یوٹرس کے اندر یا باہر کوئی رسولی (Mass) موجود ہو تو اس الٹراساؤنڈ سے پتہ چلایا جاسکتا ہے۔                         |

|        |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | اس الٹراساؤنڈ سے آسانی پتہ چلتا ہے کہ رسولی یوٹرس کے اندر (Intrauterine) ہے یا کہ باہر (Extrauterine) ہے۔    |
| ☆..... | اس الٹراساؤنڈ سے ایکٹا پک پرگ نیسی (Ectopic Pregnancy) کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔                                |
| ☆..... | اس الٹراساؤنڈ کے ذریعے تھریٹنڈ ابارشن (Threatened Abortion) کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔                           |
| ☆..... | اسی طرح پیلوک کیوٹی (Pelvic Cavity) میں موجود رسولی کا پتہ کرنے کے لئے بھی اسی الٹراساؤنڈ سے مدد لی جاتی ہے۔ |



## دوران حمل الٹراساؤنڈ کا استعمال

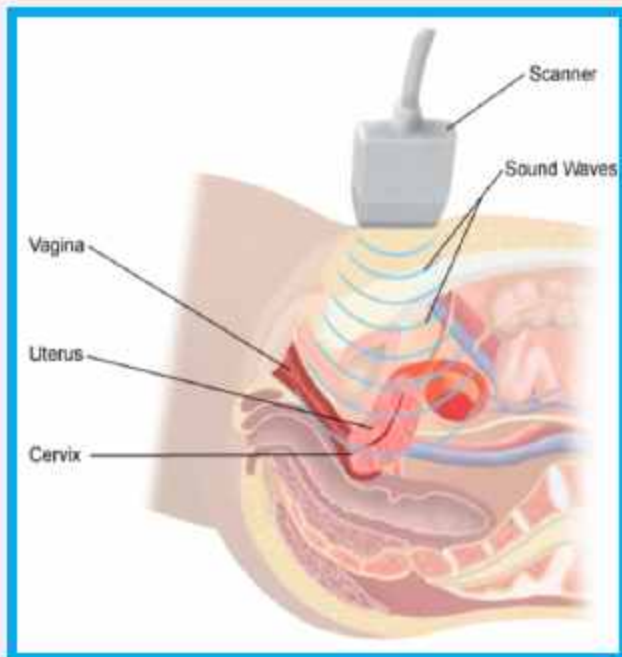
(USE OF ULTRASOUND DURING PREGNANCY)

**تعارف (Introduction):** حمل کے دوران یوٹرس کے اندر موجود بچے کی تشخیص الٹراساؤنڈ کی مدد سے آسانی سے کی جاسکتی ہے۔ اس مقصد کے لئے ریئل ٹائم اسکین (Real Time Scan) ٹیکنیک کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لئے الٹراساؤنڈ پیٹ کے اوپر سے یا پھر ویجائنہ کے راستے سے کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لئے ٹرانسڈیوسر کم از کم 3 ہرٹز یا اس سے زیادہ طاقت کا ہونا چاہیے لیکن ویجائنہ سے الٹراساؤنڈ کرنے کے لئے 5 ہرٹز سے زیادہ طاقتور ٹرانسڈیوسر استعمال کیا جاتا ہے۔ بچے پر الٹراساؤنڈ کی لہریں کم سے کم ڈالی جائیں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ریئل ٹائم اسکین بچے کی حالت کے بارے میں جاننے کے لئے اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس سے اس کے جسم کی حرکت، دل کی حرکت اور تنفس کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔ اس ٹیکنیک سے بچے کے جسم کے حصوں کی سٹڈی (Fetal Anatomy) اور ان کی پیمائش بھی آسانی سے کی جاسکتی ہے۔ حمل کے ابتدائی دنوں میں ویجائنہ کے راستے الٹراساؤنڈ کی مدد سے بچے کی صحیح نشوونما کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔





Ultrasound Machine



Transabdominal Ultrasound



Transvaginal Ultrasound



Ultrasound Technique

# حمل کی پہلی سہ ماہی کا الٹراساؤنڈ

(فرسٹ ٹرائی مسٹر سونو گرافی)

(FIRST TRIMESTER SONOGRAPHY)

**تعارف (Introduction):** حمل کے ابتدائی 3 مہینوں میں پیٹ کے اوپر سے الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ اگر پیٹ کے اوپر سے الٹراساؤنڈ کچھ صاف نظر نہ آئے تو پھر ٹرانس ویجائٹل الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے اور بچے کے بارے میں درج ذیل معلومات حاصل کی جاتی ہیں؛

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | جیسٹیشنل سیک (Gestational Sac) کے محل وقوع (Location) کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔                              |
| ☆..... | ایمبریو (Embryo) کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔                                                                     |
| ☆..... | اس کی کراؤن ریمپ لینتھ (Crown Rump Length) کی پیمائش کی جاتی ہے۔                                              |
| ☆..... | ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پیمائش کراؤن ریمپ لینتھ کے ذریعے کی جاتی ہے۔                                        |
| ☆..... | کراؤن ریمپ لینتھ کے معیاری چارٹ (Standard Charts) مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔                                      |
| ☆..... | ریئل ٹائم اسکین کی مدد سے بچے کی زندگی کے شواہد معلوم کئے جاتے ہیں۔                                           |
| ☆..... | بچے کے دل کی دھڑکن 7 ہفتے سے پہلے پیٹ کے الٹراساؤنڈ سے معلوم نہیں کی جاسکتی۔                                  |
| ☆..... | ٹرانس ویجائٹل الٹراساؤنڈ کے ذریعے بچے کے دل کی دھڑکن چھٹے ہفتے میں ہی معلوم کی جاسکتی ہے۔                     |
| ☆..... | ٹرانس ویجائٹل الٹراساؤنڈ کے ذریعے یوٹرس کے اندر نمو پانے والے بچے یا بچوں کی تعداد معلوم کی جاسکتی ہے۔        |
| ☆..... | ٹرانس ویجائٹل الٹراساؤنڈ کے ذریعے یوٹرس کی حالت کا اندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے۔                                |
| ☆..... | اگر یوٹرس میں کوئی رسولی، مایوما (Myoma) یا ایڈینکسل ماس (Adnexal Mass) ہو تو اس کا فوری پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ |





Placenta in USG



Yolk Sac in USG



Gestational Sac in USG



Embryo / Yolk Sac / Amnion

# حمل کی دوسری اور تیسری سہ ماہی کا الٹراساؤنڈ

(سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرائی مسٹر سونو گرافی)

(2nd & 3rd TRIMESTER SONOGRAPHY)

|        |                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | اس میں بچے کے دل کی دھڑکن، رفتار، ردھم (Rhythm) وغیرہ نوٹ کیا جاتا ہے۔                                                       |
| ☆..... | اس میں پلے سینٹا (Placenta) کی تعداد اور سیک نمبرز (Sac Numbers) کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔                                     |
| ☆..... | اس میں بچے کا سائز (Size Of Baby)، بچے کے بیرونی جنسی اعضاء (External Genitalia) کا پتہ کرتے ہیں۔                            |
| ☆..... | اس میں یوٹرس کے ایمینٹیکل فلوئیڈ (Amniotic Fluid) کی مقدار کا بھی پتہ چلایا جاسکتا ہے۔                                       |
| ☆..... | اس میں پلے سینٹا کا مقام، شکل اور اندرونی سروائیگل اوز (Internal Cervical Os) کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔                        |
| ☆..... | اس میں بچے کی یوٹرس کے اندر عمر (Gestational Age) کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔                                                    |
| ☆..... | اس میں بچے کے سر کی پیمائش (Head Circumference) اور کوہے کی ہڈی (Femur) کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔                              |
| ☆..... | اس میں بچے کی نشوونما اور وزن تیسرے ٹرائی مسٹر (Trimester) میں معلوم کئے جاسکتے ہیں۔                                         |
| ☆..... | اس کے لئے بچے کے پیٹ کی پیمائش، گولائی (Diameter)، احاطہ (Circumference) کا ہونا بھی ضروری ہے۔                               |
| ☆..... | اس میں یوٹرس اور اس کے ساتھ متعلقہ اعضاء کے متعلق بھی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔                                            |
| ☆..... | اس میں بچے کے دیگر اعضاء مثلاً دل، سیربیرل وینٹریکل، ریڑھ کی ہڈی، معدہ، مثانہ اور امبالائیگل کارڈ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ |
| ☆..... | اس میں بچے کے بہت سے وراثی نقائص کا بروقت پتہ لگ سکتا ہے جس کے باعث ان کا تدارک کیا جاسکتا ہے۔                               |
| ☆..... | یہاں یہ بات یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ بچے کے ہر نظام میں پائی جانے والی خرابیاں الٹراساؤنڈ پر تشخیص نہیں ہو سکتیں۔         |

☆☆☆.....



Early 1st Trimester USG



Late 1st Trimester USG



2nd Trimester USG



3rd Trimester USG

## یوٹرسہ میں فرسٹ ٹرائی سٹر کے دوران آنہ والی تبدیلیاں

(NORMAL EARLY FIRST TRIMESTER INTRAUTERINE CHANGES)

**تعارف (Introduction):** ویجائٹل الٹراساؤنڈ کی مدد سے فی میل میں بہت جلد حمل کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ حمل کے دوران پہلی سہ ماہی یعنی فرسٹ ٹرائی سٹر کے دوران درج ذیل تبدیلیاں دیکھی جاسکتی ہیں؛

**چھٹا ہفتہ (6th Week):** ایمبریو یعنی جنین ایک ہائپرا ایکوئیک (Hyperechoic) یعنی چمکتی ہوئی لائن کی طرح نظر آتا ہے اور یہ سائز میں تقریباً 5 ملی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ یہ یوک سیک (Yolk Sac) کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اس لائن کے اندر دل کی حرکت بھی دکھائی دیتی ہے۔

**ساتواں ہفتہ (7th Week):** ایمبریو کے سر کے اندر ایک این ایکوئیک (Anechoic) وینٹریکل (Ventricle) نظر آتا ہے۔ کارڈل سیکشن (Coronal Section) میں دونوں پاؤں کے بڈز (Lower Limb Buds) پھوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ دل کا سائز تقریباً 2 ملی میٹر قطر کا ہوتا ہے اور اسکے دھڑکنے کی رفتار 112 سے 136 بیٹ فی منٹ تک ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن کارڈیوہم بھی معلوم ہو سکتا ہے۔

**آٹھواں ہفتہ (8th Week):** غیر تقسیم شدہ وینٹریکلز میں ایک ابھرا ہوا حصہ (Bulge) نظر آنے لگ جاتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کے ابھار (Upper & Lower Limb Buds) بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں جبکہ ابھی تک فٹس کے جسم کی حرکات نمایاں نہیں ہوتیں۔

**نواں ہفتہ (9th Week):** ابھی تک ایمنیاں (Amnion) اور کوریان (Chorion) مل کر ایک نہیں ہوئے ہوتے جبکہ ایمبریو کے بازو اور ٹانگیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ حرکت بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ جسم کی حرکت بھی نظر آتی ہے۔ پورا سپائن یا ریڑھ کی ہڈی کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ امبلیکال کارڈ (Umbilical Cord) بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں سے آنت نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ وینٹریکلز (Ventricles) کی پارٹیشن اب نظر آنے لگ جاتی ہے۔ دماغ کے اندر کورائیڈ پلکسس (Choroid Plexus) ایک ہائپرا ایکوئیک ایریا کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور دماغ کا عقبی حصہ جسے ہائینڈ برین (Hind Brain) یا روٹین سینفلان (Rhombencephalon) کہتے ہیں نظر آتا ہے۔

**دسواں ہفتہ (10th Week):** اس میں ایمبریو کے چہرے کی ہڈیاں مینڈیبل (Mandible) اور میکزلا (Maxilla) واضح دکھائی دیتی ہیں۔ بازو اور ٹانگیں اپنی پوزیشن تبدیل کرتی، گھومتی اور ان میں ایبڈکشن (Abduction) ہوتے ہوئے لمحہ بہ لمحہ دکھائی دے سکتی ہیں۔

**بارہواں ہفتہ (12th Week):** اس میں ایمبریو کی انگلیاں، ناک اور ہونٹ بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔

**چودھواں ہفتہ (14th Week):** اس ہفتے میں ایمبریو کی آنت گھومتی (Rotate) ہوتی ہے اور پیٹ میں چلی جاتی ہے۔

**دو مزید اہم نکات (Two Important Points):** اس قسم کے الٹراساؤنڈ میں درج ذیل دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے:

**1۔ جیسٹیشنل سیک (Gestational Sac):** اگر سیک گول ہو تو صرف ایک پیمائش معلوم کرنیکی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سیک بیضوی (Ovoid) ہو یا کسی اور شکل میں ہو تو پھر پیمائش کیلئے تین عمودی لائنیں کھینچی جاتی ہیں اور تینوں کی اوسطاً پیمائش لی جاتی ہے یعنی تکنیکی طور پر بیضوی سیک کا اوسطاً ڈایامیٹر (Diameter) لیا جاتا ہے۔

**2۔ ایمبریو کا سائز اور دل کی حرکت (Size Of Embryo & Cardiac Beat):** یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک نارمل ایمبریو میں دھڑکتا ہوا دل دکھائی دے سکتا ہے بشرطیکہ اگر ایمبریو کی کراؤن رمپ لمبائی (Crowon Rump Length) 4 سے 5 ملی میٹر تک ہو۔ یہ ابتدائی مرحلے میں ایمبریو کی پہچان کا ایک اچھا طریقہ ہے۔





13 Weeks Pregnancy USG



20 Weeks Pregnancy USG



Early Staged  
Twin Babies USG



Late Staged  
Twin Babies USG

## دوران حمل الٹراساؤنڈ کرنے کا طریقہ

(اسکننگ ٹیکنیک ان پریگننسی)

(SCANNING TECHNIQUE IN PREGNANCY)

**تعارف (Introduction):** جب ابتدائی دورانیے کے حمل کا الٹراساؤنڈ کرنا ہو تو اس سے پہلے خاتون کا مٹانہ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اس طرح یوٹرس کو باآسانی دیکھا جاسکتا ہے یوں افقی اور عمودی دونوں خطوط میں یوٹرس کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح یوٹرس میں موجود جسٹیشل سیک (Gestational Sac) کو بھی فوری طور پر دیکھا جاسکتا ہے اور اس کی پیمائش بھی لی جاسکتی ہے۔ ایڈنکسل ایریا (Adnexal Area) کا بھی معائنہ کرنا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی رسولی تو نہیں ہے اور یوٹرس میں بھی رسولی کا معائنہ کرنا چاہیے۔

☆..... پلے سینا (Placenta) ایک ہموار، موٹی اور ایکوجینک (Echogenic) یعنی چمکتی ہوئی سیک کی دیوار کی صورت میں نظر آتا ہے۔ 12 ویں ہفتے کے بعد اسے باآسانی دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر پلے سینا نیچے واقع ہو تو پھر اس مقصد کے لئے مریضہ کا مٹانہ ضرور بھرا ہوا ہونا چاہیے۔

☆..... 13 ویں ہفتے کے بعد بچے کی پیمائش کرنے کیلئے بائی پیرائیٹل ڈایامیٹر (BPD) لیا جاتا ہے۔ الٹراساؤنڈ اس طرح لیا جاتا ہے کہ فاکس (Falx) ٹوٹے ہوئے نمونے کی صورت میں نظر آتا ہے اور اس کیساتھ کیوم پٹنم پلے سیڈم (Cavum Septum Placidum) بھی دکھائی دیتی ہے۔

☆..... بچے کی جنس کے بارے میں جاننے کے لئے پہلے بچے کی دونوں ٹانگوں کی شناخت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ترچھا اور افقی ویو لیا جاتا ہے جس سے بچے کے جنسی اعضاء نظر آتے ہیں جس سے یہ اندازہ آسانی سے لگایا جاسکتا ہے کہ فٹس میل ہے یا بی میل ہے۔

☆..... بچے کی انٹرایوٹرائن پریزنٹیشن (Intrauterine Presentation) بھی الٹراساؤنڈ پر باآسانی دیکھی جاسکتی ہے۔

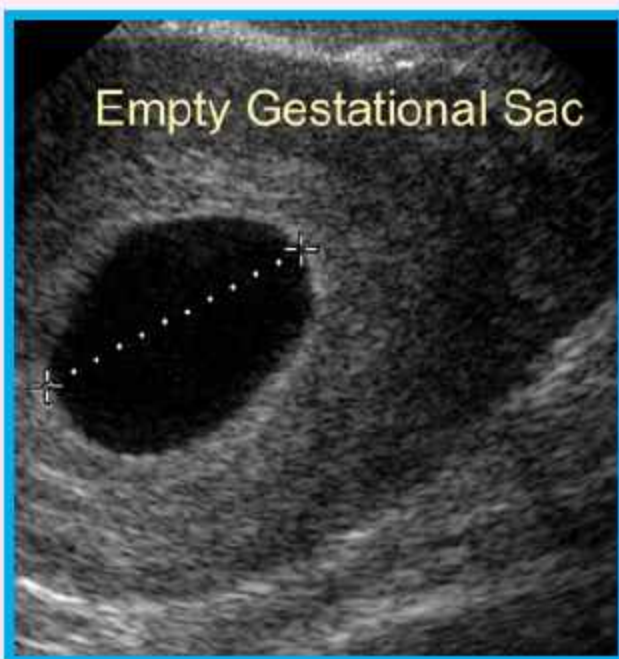
☆..... اسی طرح بچے کی پوزیشن دیکھنے کے لئے الٹراساؤنڈ پر مختلف ویوز (Views) استعمال کئے جاسکتے ہیں۔



Multiple Pregnancy in USG



Gestational Sac in USG



Empty Gestational Sac



Crown Rump Length in USG

☆..... اگر پلے سینا نیچے واقع ہو اور آگے کی طرف ہو تو اسے باسانی دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک افقی سکین (Longitudnal Scan) ہی اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر پلے سینا پیچھے کی طرف واقع ہو یا بچے کے سر کے رخ پر ہو تو اس صورت میں پلے سینا کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آرام سے بچے کے سر کو تھوڑا سا اوپر کی طرف دھکیلا جائے تو پلے سینا نظر آ جاتا ہے یا اگر خاتون کی کمر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا جائے تو بھی اس سے بچے کا سر اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے اور پلے سینا صاف طور پر نظر آ جاتا ہے۔



## فیٹل اسٹیج ان الٹراساؤنڈ (FETAL STAGE IN ULTRASOUND)

**تعارف (Introduction):** جب ماں کے یوٹرس کے اندر بڑھتے ہوئے بچے کو 9 سے 10 ہفتے ہو جاتے ہیں تو پھر اسکے سر اور تھوریکس (Thorax) کا درمیانی فاصلہ الٹراساؤنڈ کی مدد سے ناپا جاسکتا ہے۔ فیٹس کی عمر (Fetal Age) کا اندازہ لگانے کے لئے کراؤن رمپ لینتھ (Crown Rump Length) کا طریقہ سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت بچے کی لمبائی تقریباً 5 سے 6 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے جبکہ اس کا وزن صرف ایک اونس ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے جسم کے اعضاء پختہ ہوتے ہیں اور ان میں نکھار پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگلے سات ماہ میں بچے میں جوتہ دیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

☆..... **تیسرا ماہ (3rd Month):** اس ماہ کے دوران بچے کی حرکت (Fetal Activity) بڑھ جاتی ہے۔ سانس لینے جیسی حرکات بھی محسوس ہوتی ہیں اور ایمینیا نک فلوئیڈ میں یوریا (Urea) بھی مل سکتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچے کے گردے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔

☆..... **چوتھا ماہ (4th Month):** بچے یا فیٹس (Fetus) کی لمبائی 18 سینٹی میٹر تک ہو جاتی ہے۔ بچے کا قد پیدائش کے وقت کے قد کا نصف ہو جاتا ہے۔ بچے کے تمام جنسی اعضاء بن چکے ہوتے ہیں اور بچے میں ہر طرح کی حرکت محسوس کی جاسکتی ہے۔ مثلاً انگوٹھا چوسنا پیلنگی وغیرہ لینا۔ بچے میں تمام ری فلیکسز (Reflexes) موجود ہوتے ہیں ماسوائے آواز کو محسوس کرنے اور سانس لینے کے۔



Third Trimester : Stages of Fetal Development



Third Trimester : Stages of Fetal Development in USG

☆..... پانچواں ماہ (5th Month): اب بچے کا قد تقریباً 24 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور وزن بھی تقریباً ایک پاؤنڈ ہو جاتا ہے۔ ماں اب بچے کی حرکات کو خود واضح طور پر محسوس کر سکتی ہے چونکہ بچہ امینیاٹک سیک (Amniotic Sac) میں تیر رہا ہوتا ہے اس لئے وہ ہر طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ درحقیقت اس وقت تک زیادہ تر بچے 75 فیصد تک حرکت کر سکتے ہیں۔

☆..... چھٹا ماہ (6th Month): ریل ٹائم اسکین (Real Time Scan) کی مدد سے اس وقت بچے کی سانس کی حرکات 30 سے 100 فی منٹ باسانی محسوس کی جاسکتی ہیں اور یہ حرکات پیدائش تک جاری رہتی ہیں۔

☆..... ساتواں ماہ (7th Month): جو بچے اس ماہ کے دوران پیدا ہو جاتے ہیں ان میں زندہ رہنے کا چانس موجود ہوتا ہے لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب بچے کی انتہائی نگہداشت کی جائے۔ اس وقت تک بچے کے اندر باہر کے ماحول میں زندہ رہنے کیلئے صلاحیت کافی حد تک پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کا دماغ اس حد تک طاقتور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ آزادانہ باہر کے ماحول میں زندہ رہ سکے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں اس وقت تک حرکت کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ امینیاٹک سیک میں پھنس جائے۔ ایک نارمل مکمل معیاد کے بچے کا دوران 280 دن ہے البتہ بچہ ماں کے یوٹرس کے باہر 180 دن بعد رہنے کے قابل ہو جاتا ہے لیکن اس صورت میں بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔



## پہلی سہ ماہی کے دوران بچے میں پیدا ہونے والی خرابیاں (FIRST TRIMESTER ABNORMALITIES)

تعارف (Introduction): پہلی سہ ماہی کے دوران نارمل بچے میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو پیچھے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ عام طور پر اللہ کی حکمت سے تقریباً تمام ہی پیدا ہونے والے بچے نارمل ہوا کرتے ہیں لیکن بسا اوقات ماں کے پیٹ میں موجود بچے حمل کے دوران پہلی سہ ماہی میں ہی کچھ خرابیوں کا شکار ہو سکتے ہیں جن کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے:

|        |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | جسٹیشنل سیک (Gestational Sac) کا غیر واضح ہونا۔ اس صورت میں جسٹیشنل سیک اپنی صحیح شکل میں نظر نہیں آتی۔   |
| ☆..... | یہاں تک کہ بعض اوقات جسٹیشنل سیک کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔                                          |
| ☆..... | جسٹیشنل سیک کی نشوونما کا رُک جانا دراصل ایمبریونک ڈیٹھ (Embryonic Death) کو ظاہر کرتا ہے۔                |
| ☆..... | جسٹیشنل سیک کا یوٹرس میں بہت نیچے بڑھنا بھی ابارشن (Abortion) کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔                  |
| ☆..... | 10 ہفتے بعد بھی ایمبریونک ایکو اور سایہ (Embryonic Echoes and Shadows) کا محسوس نہ ہونا۔                  |
| ☆..... | اگر الٹراساؤنڈ میں درج بالا علامت ملے تو اس کا مطلب ہے کہ خاتون کے اندر بلائیٹڈ اووم (Blighted Ovum) ہے۔  |
| ☆..... | اگر حمل کے 10 ہفتے بعد بھی بچے کے دل کی ٹون اور دل کی حرکت نہ ملے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچہ زندہ نہیں ہے۔ |



## این ایمبریونک جسٹیشن (مسڈ ابارشن)

### (ANEMBRYONIC GESTATION - MISSED ABORTION)

**تعارف (Introduction):** یہ ایک ایسا حمل ہوتا ہے جس میں حاملہ عورت کے یوٹرس یعنی بچے دانے میں ایمبریون موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس حالت میں یوٹرس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے جبکہ حمل زیادہ دنوں کا ہوتا ہے۔

☆..... **الٹراساؤنڈ پر علامات (ULTRASOUND FINDINGS):** یوٹرس میں جسٹیشنل سیک (Gestational Sac) صحیح حالت میں موجود ہوتی ہے لیکن اس میں ایمبریون نظر نہیں آتا۔ الٹراساؤنڈ کرنے پر اگر سیک (Sac) کا قطر 2.5 سینٹی میٹر سے کم ہو اور اس میں سے ایمبریون کی بازگشت (Fetal Echoes) نہ آ رہی ہوں تو یہ این ایمبریونک جسٹیشن (Anembryonic Gestation) کی تصدیق کرتا ہے۔ بعض اوقات سیک (Sac) کی شکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں فلوئیڈ لیول (Fluid Level) بھی موجود ہو سکتا ہے۔



## نامکمل ابارشن (ان کمپلیٹ ابارشن) (INCOMPLETE ABORTION)

**تعارف (Introduction):** اس قسم کے ابارشن میں حاملہ عورت کی بچے وانی یعنی یوٹرس مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا بلکہ حمل کی کچھ نہ کچھ باقیات (Products of Conception) یوٹرس میں رہ جاتی ہیں۔ حاملہ کو مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جبکہ سروکس کا منہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔

**الٹراساؤنڈ پر علامات (Ultrasound Findings):** یوٹرس میں جینیٹل سیک بے ترتیب ہوتی ہے۔ ایمبر یو بھی واضح حالت میں دکھائی نہیں دیتا اور ایمبر یو کے دل کی دھڑکن بھی محسوس نہیں ہوتی۔ بعض اوقات الٹراساؤنڈ اسکوینگ میں جما ہوا خون یا ڈیسی ڈوا (Decidua) کے کچھ حصے یوٹرس میں نظر آ جاتے ہیں۔ حاملہ کے سروکس کا منہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔



## مکمل ابارشن (کمپلیٹ ابارشن) (COMPLETE ABORTION)

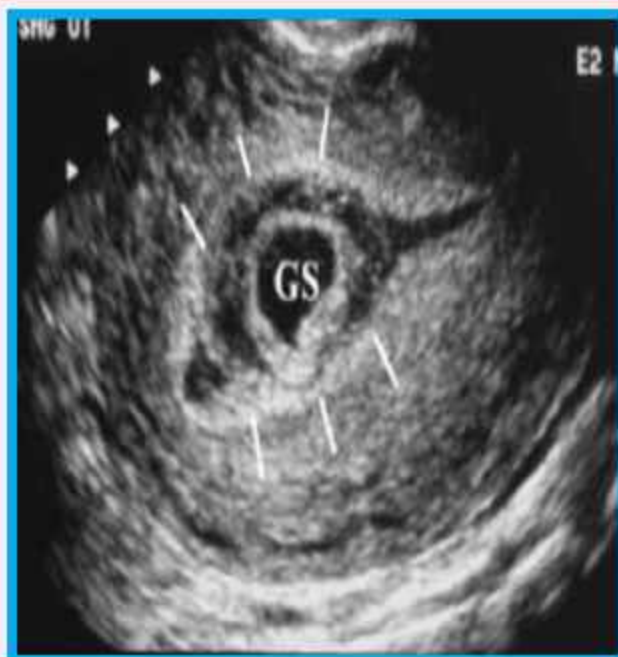
**تعارف (Introduction):** اس میں حاملہ خاتون کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور یوٹرس سے حمل کی تمام باقیات بھی نکل جاتی ہیں۔

**الٹراساؤنڈ پر علامات (Ultrasound Findings):** اس میں اینڈومیٹریل کینال (Endometrial Canal) بالکل نارمل نظر آتی ہے اور یوٹرس کے اندر حمل کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ حمل کی کوئی باقیات (Products of Conception) بھی نظر نہیں آتیں۔





Complete Abortion



Incomplete Abortion



Missed Abortion



Fetal Death

## ایمبریونک ڈیٹھ

## (EMBRYONIC DEMISE)

**تعارف (Introduction):** اگر ایمبریو دوران حمل یوٹرس میں ہی مر جائے تو اسے ایمبریونک ڈیٹھ (Embryonic Death) کہتے ہیں۔ ایسے کیس میں حاملہ عورت کے یوٹرس میں بے جان ایمبریو نظر آتا ہے جبکہ یوٹرس سے کوئی بھی ٹشو باہر نہیں نکلتا۔ ایسے کیس میں حاملہ کو بلیڈنگ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی جبکہ خون میں ہیومن کوریونک گونیڈوٹروفن (HCG) کی مقدار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔

**الٹراساؤنڈ پر علامات (Ultrasound Findings):** یوٹرس کے اندر جسٹیشنل سیک نظر آتی ہے جس میں ایمبریو بھی موجود ہوتا ہے لیکن بچے کے دل کی دھڑکن محسوس نہیں ہوتی۔ فیش اپنے دنوں کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اس علامت کو سمال فار ڈیٹھ (Small for Date) بھی کہتے ہیں۔ الٹراساؤنڈ میں کوریان (Chorion) کے پیچھے خون کے اخراج کے نشانات مل سکتے ہیں۔



## ایکٹا پک پریگننسی

(یوٹرس کے علاوہ کسی اور جگہ پر حمل کا ہونا)

## (ECTOPIC PREGNANCY)

**تعارف (Introduction):** ہر وہ حمل جو کہ یوٹرس کے باہر پروان چڑھے ایکٹا پک حمل (Ectopic Pregnancy) کہلاتا ہے۔ عورت میں یوٹرس یعنی بچے دانی کے باہر درج ذیل تین جگہوں پر حمل ٹھہر کر پروان چڑھ سکتا ہے:

|                       |                                    |    |
|-----------------------|------------------------------------|----|
| (In Fallopian Tube)   | فیلوپین ٹیوب میں حمل ٹھہر سکتا ہے۔ | ☆☆ |
| (In Ovary)            | اوواری میں حمل ٹھہر سکتا ہے۔       | ☆☆ |
| (In Abdominal Cavity) | پیٹ کے اندر حمل ٹھہر سکتا ہے۔      | ☆☆ |

ہر 100 حاملہ خواتین میں سے ایک کو ٹیوب کے اندر حمل ہو جاتا ہے۔ ایسے حمل کو ٹیوبل پریگننسی (Tubal Pregnancy) کہتے ہیں۔



## الٹراساؤنڈ میں بچہ کی پوزیشن

(فیٹل پوزیشن ان الٹراساؤنڈ)

(FETAL POSITION IN ULTRASOUND)

- تعارف (Introduction):** چونکہ ایمیناٹک فلوئیڈ کی موجودگی کی وجہ سے بچہ یوٹرس میں آسانی حرکت کر سکتا ہے اس لئے الٹراساؤنڈ کے دوران بچے کی پوزیشن کا پتہ لگانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بچہ عام طور پر ان تین پوزیشنوں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے:
- 1۔ سینٹیکلک پریزنٹیشن (Cephalic Presentation): اس میں بچے کا سر انٹرنل آؤز (Internal Os) پر موجود ہوتا ہے۔
  - 2۔ بریچ پریزنٹیشن (Breech Presentation): اس میں بچہ اُٹنا اور اسکے کو لہے انٹرنل آؤز (Internal Os) کی طرف ہوتے ہیں۔
  - 3۔ ٹرانس ورس پریزنٹیشن (Transverse Presentation): اس حالت میں بچہ یوٹرس کے اندر افقی طور پر پڑا ہوتا ہے۔



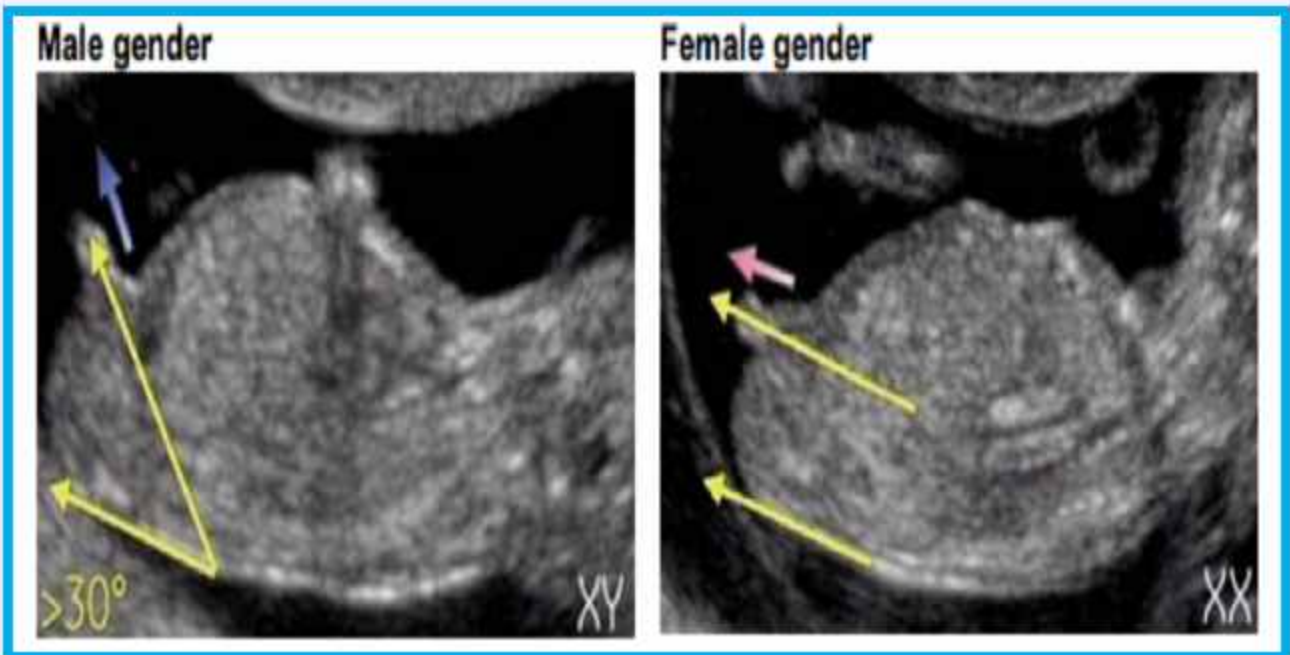
## الٹراساؤنڈ کی مدد سے بچہ کی عمر کا اندازہ لگانا

(FETAL AGE WITH THE HELP OF ULTRASOUND)

- تعارف (Introduction):** مختلف چارٹوں اور گرافوں کی مدد سے بچے کی عمر کی جسامت اور اس کی عمر کی پختگی کا پتہ چلایا جاسکتا ہے اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ایک سادہ اور آسان فارمولا ہے۔ اگر بچے کی سر کے سائز کو چار سے ضرب دیں تو یہ بچے کی عمر کے بارے میں بتا دے گا لیکن جب بچے کی سر کا سائز 7 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو پھر 4 کی بجائے 3.8 سے ضرب دیں۔
- اگر بچے کا بائی پیریامیٹل ڈایامیٹر (Biparietal Diameter) یعنی B.P.D معلوم کرنا ہو تو یہ صرف 15 اور 26 ویں ہفتے کے دوران کرنا چاہیے۔ اس اسٹیج پر تمام پیرو میٹرز (Perimeters) صرف عمر سے متاثر ہوتے ہیں جبکہ اس کے بعد پیرو میٹرز عمر اور جسامت دونوں کے حساب سے ہوتے ہیں بالخصوص 26 ویں ہفتے کے بعد۔ وہ دیگر عوامل جو کہ حمل کا دورانیہ بتانے میں مددگار ہو سکتے ہیں درج ذیل ہیں:



Ectopic Pregnancy in Ultrasound



Male & Female Gender Recognition in USG

1۔ **فیمر کی پیمائش (Femur Measurement):** فیمر بون کی پیمائش 14 ویں اور 22 ویں ہفتے کے دوران بہت فائدہ مند ہے۔ اس وقت یہ پیمائش بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ اسکی مدد سے عمر میں کمی بیشی زیادہ سے زیادہ 7 دن کی ہو سکتی ہے۔

2۔ **پیٹ کی پیمائش (Abdominal Measurement):** پیٹ کی پیمائش وہاں کی جاتی ہیں جہاں پر پیمائش کرنے کے لئے دیگر پیمانے نہ ہوں۔ اس سے حمل کے دورانے کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے لیکن یہ بالکل صحیح اور درست اندازہ نہیں ہوا کرتا۔

3۔ **جسٹینل سیک کی پیمائش (Gestational Sac Measurement):** اگر حاملہ عورت یعنی پریگنٹ ٹی میل انٹرایوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن (Intrauterine Growth Retardation) کی مریضہ ہو تو ایسی صورت میں بچے کے سر کی پیمائش زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ بچے کا سر سب سے آخر میں متاثر ہوتا ہے۔ اس میں بچے کے پیٹ کی پیمائش بھی ساتھ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ایک نارمل حمل میں بچے کا سر اور چھاتی، دونوں کی پیمائش ایک جیسی ہی ہونی چاہیے۔ اگر دونوں کے سائز میں 1.5 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ کا فرق ہو تو ایسی صورت میں انٹرایوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن (IUGR) کا شک ضرور کرنا چاہیے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ بچے کا سر 3 ملی میٹر فی ہفتہ یا ایک سینٹی میٹر فی ماہ کے حساب سے بڑھتا ہے۔ اگر بچے کا سر اس سے زیادہ یا کم کی شرح سے بڑھ رہا ہو تو اسے زیادہ غور سے چیک کرنا چاہیے۔



## ملٹی پل پریگننسی (MULTIPLE PREGNANCY)

1۔ **جڑواں بچوں والا حمل (Twin Pregnancy):** اس کی تشخیص اس وقت بہت آسان ہو جاتی ہے جب دو بچوں کے جسم اور دو علیحدہ پلے سینا نظر آجائیں۔ الٹراساؤنڈ کرنے والے کو بڑی احتیاط سے ہر سمت سے الٹراساؤنڈ کرنا چاہیے تاکہ تشخیص غلط نہ ہو جائے۔ جب واضح تصویر بن جائے تو اس میں ہر بچے کے جسم کے تمام اعضاء کو دیکھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی عضو زیادہ تو نہیں۔ جب دو بچوں کے سر واضح نظر آجائیں تو اس سے سیدھا نیچے بچے کے باقی اعضاء کو بھی چیک کرتے جانا چاہیے۔ اگر دو پلے سینا بالکل الگ ہوں تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دونوں بچے مشابہ نہیں ہونگے۔ ایسے حمل کا الٹراساؤنڈ ایم۔ ماڈ (M-Mode)، ریل ٹائم اسکین (Real Time Scan) اور ڈاپلر اسکین (Doppler Scan) کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔

2۔ تین بچوں والا حمل (Triplet Pregnancy): اصولاً ایک اسکین میں تینوں بچوں کے سر نظر آنے چاہئیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں الٹراساؤنڈ کریو الے کوئی طرف سے اسکین کرنا پڑتا ہے تاکہ تین بچوں والے حمل یعنی ٹریپلٹ پریگننسی کی درست تشخیص ہو سکے۔

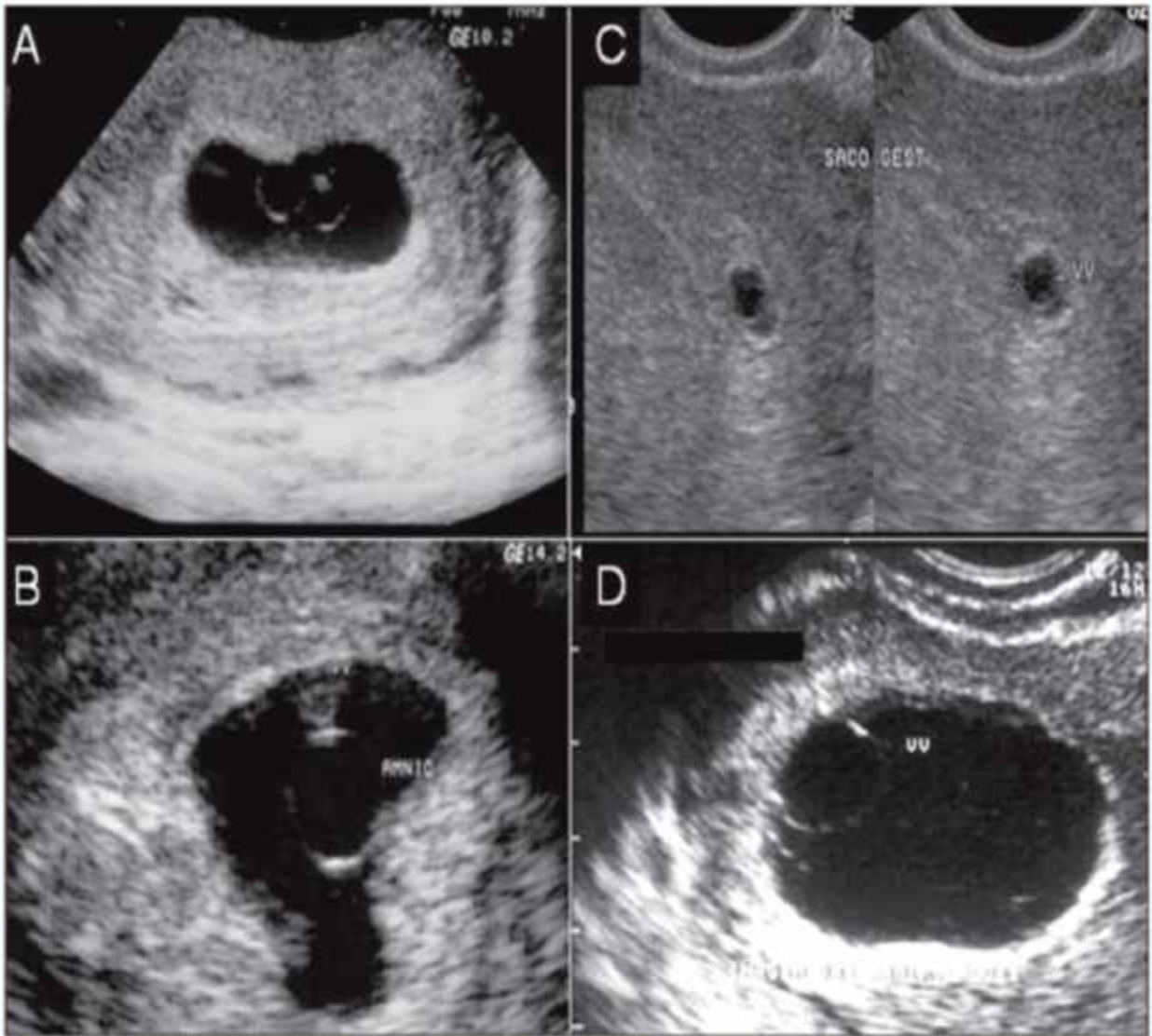


## بچہ کی موت کی تشخیص بذریعہ الٹراساؤنڈ (DIAGNOSIS OF FETAL DEATH BY ULTRASOUND)

تعارف (Introduction): اگر الٹراساؤنڈ سے ماں کے پیٹ میں بچے کی موت کی تصدیق کرنی ہو تو اس کیلئے ان علامات کا ہونا ضروری ہے؛

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | الٹراساؤنڈ میں بچے کے دل کی حرکت دکھائی نہیں دیتی۔                                                         |
| ☆..... | اسکی تصدیق ریئل ٹائم اسکین (Real Time Scan)، ڈاپلر (Doppler) یا ایم ماڈ (M-Mode) سے ہوتی ہے۔               |
| ☆..... | سپالڈنگ کی علامت (Spalding's Sign) یعنی بچے کے سر کی ہڈیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں یا ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں۔ |
| ☆..... | ہیلو کی علامت (Halo's Sign) یعنی بچے کے سر کی آؤٹ لائن ڈبل نظر آتی ہے۔                                     |
| ☆..... | بچہ بری طرح تیر رہا ہوتا ہے اور اس کے مسلز کی ٹون (Musclur Tone) بالکل نہیں ہوتی۔                          |



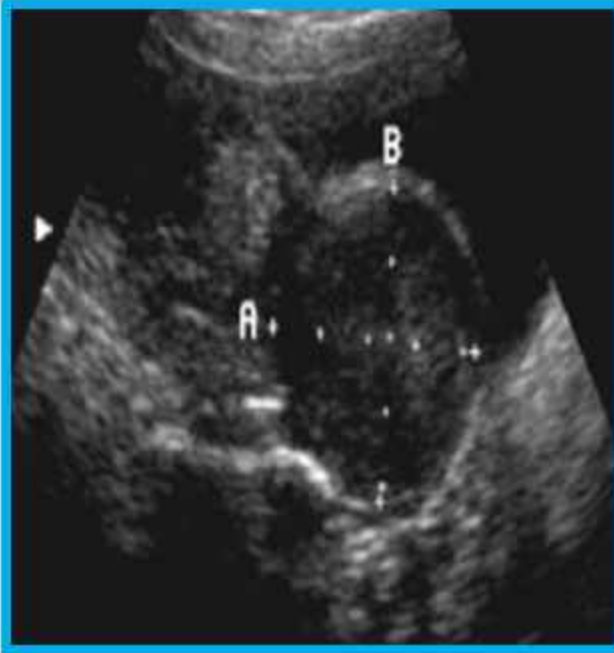


Sonographic signs of early embryo death.

**A,B:** Small amniotic cavity.

**C:** Delayed growth of the gestational sac with disproportionate yolk sac.

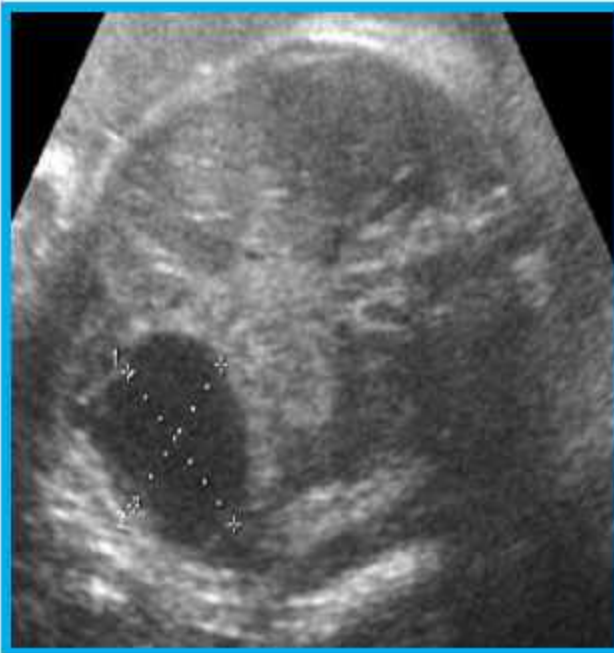
**D:** Hydrophic yolk sac and ruptured amniotic sac with floating branches in the chorionic cavity.



Uterine Fibroid



Multiple Uterine Fibroids



Ovarian Cyst



Multiple Ovarian Cysts

## یونٹ: 18

## نومولود بچہ

## (NEWBORN BABY)

**تعارف (Introduction):** نارمل نومولود بچہ (Normal Newborn baby): جب کوئی بچہ پیدا ہوا اور پیدائش کے بعد اس کا رنگ، وزن، قد، سانس کی رفتار، دل کے دھڑکنے کی رفتار، رونے کی شدت اور وقفہ، شہد، دودھ یا کھٹی پلانے پر نکلنے کا عمل، ہاتھ پیروں کی حرکات اور سونے جاگنے کے اوقات درست ہوں تو ایسے نومولود بچے کو نارمل نومولود بچہ یا نارمل نیو بارن بے بی قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد ایک چلڈرن اسپیشلسٹ جب بچے کا تفصیلی معائنہ کرے اور بچے کو تندرست اور توانا پائے تو وہ اسے نارمل نومولود بچہ قرار دیتا ہے۔

☆..... نومولود بچے کی نگہداشت (Management of Newborn baby): جب بچہ اللہ کے فضل سے نارمل ہو تو اس کی بہتر نگہداشت کیلئے درج ذیل نکات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے:

1۔ امبالائیکل کارڈ کی دیکھ بھال (Management Of Umbilical Cord): کارڈ کو سب سے پہلے کلیپ (Clamp) کیا جاتا ہے اور پھر جونہی اس میں حرکت (Pulsation) ختم ہو جاتی ہے تو اسے احتیاط کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے کارڈ کو لائیگیٹ (Ligate) نہ کیا جائے تو بچے کا بہت خون ضائع ہو سکتا ہے۔ کارڈ کو ربر بینڈ (Rubber Band) یا ٹیپ سے باندھا جاتا ہے۔ نومولود بچے میں خون کی مقدار 80 سے 100 ملی لیٹر فی کلو گرام جسم کے وزن کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد بچے کے گلے کو اچھی طرح صاف کریں تاکہ بچہ کہیں میکونیئم (Meconium)، خون (Blood) یا میوکس (Mucus) کو نگل نہ لے۔ اس مقصد کے لئے مکینیکل سکشن (Mechanical Suction) کا طریقہ اپنائیں۔

2۔ پیدائش کے وقت بچے کی حالت کا اندازہ لگانا (Assessment Of Baby's Condition At Birth): اے، پی، جی، اے، آر، سکورنگ سسٹم (APGAR Scoring System) ایک انتہائی مستند اور مانا جانے والا سسٹم ہے جس کی مدد سے بچے کی حالت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یہ سکور بچے کی پیدائش کے ایک منٹ بعد کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ بچے کی حالت کا اندازہ لگانے کے لئے پانچ منٹ بعد کیا جاتا ہے۔ اگر پیدائش کے ایک منٹ بعد یہ سکور 3 یا اس سے کم ہو تو پھر بچے کو انتہائی نگہداشت کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور اسے مکمل طور پر ری سسیٹیشن

(Resuscitation) کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کنڈیشن میں بچے کا بیرونی طور پر دل کا مساج (External Cardiac Massage)، انٹیویشن (Intubation) اور وینٹیلیشن (Ventilation) شامل ہیں۔ اگر پانچویں منٹ پر ہونے والا سکور 6 یا اس سے کم ہے تو یہ پیری نیٹل اسفلکسیا (Perinatal Asphyxia) کی شکایت ہو سکتی ہے جو کہ ایک خطرناک علامت ہے۔ پیدائش کے تین منٹ کے اندر اندر زیادہ تر بچے اپنا سانس قدرتی طور پر خود ہی بحال کر لیتے ہیں۔

| علامات                                            | 0- سکور                                  | 1- سکور                                           | 2- سکور                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| چلد کارنگ<br>Skin Color                           | سایا نوسس (Cyanosis)<br>پیلا پن (Pallor) | پیریفرل سایا نوسس<br>Peripheral Cyanosis          | پنک<br>Pink                       |
| پٹھوں کی سختی<br>Muscular Tone                    | ڈھیلا پن<br>Flaccid                      | ٹانگوں اور بازوؤں کو حرکت دینا<br>Limbs Movements | بہتر<br>Good                      |
| سانس لینے کے لئے زور لگانا<br>Respiratory Efforts | بالکل نہیں<br>None                       | تپکیاں لینا<br>Gasps                              | بہتر<br>Good                      |
| دل کی دھڑکن<br>Heart Rate                         | بالکل نہیں<br>None                       | 100 مرتبہ فی منٹ سے کم<br><100                    | 100 مرتبہ فی منٹ سے زیادہ<br>>100 |
| متوجہ ہونا<br>Response                            | بالکل نہیں<br>None                       | معمولی سا متوجہ ہونا<br>Slight                    | بہتر<br>Good                      |

3۔ نومولود بچے کی فزیالوجی (Physiology Of The Newborn): پیدائش کے بعد نومولود بچے کی فزیالوجی کا اندازہ درج ذیل علامات اور نشانیوں کے ذریعے لگایا جاتا ہے:

☆.....طبعی یرقان (Physiological Jaundice): بچے کی پیدائش کے دوسرے سے لیکر پانچویں دن تک کے درمیان تقریباً ایک تہائی بچوں میں طبعی یرقان یعنی فزیالوجیکل جائنڈس کی علامت سامنے آتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک تو گلوکورونائل ٹرانسفریز انزائم سسٹم کی جگر میں عدم موجودگی (Absence Of Glucoronyl Transferase Enzyme System) اور دوسرے بچے کے خون میں موجود خون کے سرخ ذرات (Foetal RBCs) کی عمر کم ہونا ہو سکتا ہے۔ پیدائش کے تین ماہ بعد تک ہیموگلوبن جو کہ پیدائش کے وقت 200 گرام فی لیٹر ہوتا ہے سے کم ہو کر 110 گرام فی لیٹر تک رہ جاتا ہے۔ اگلے تین ماہ میں یہ لیول دوبارہ بلند سطح حاصل کر لیتا ہے۔

☆..... **پاخانہ (Stool):** پیدائش کے پہلے دو سے تین دن تک میکونیم (Meconium) خارج ہوتا رہتا ہے۔ میکونیم زیادہ تر جھڑنے والے خلیات، میوکس اور بائل پگ منس پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیدائش کے 36 گھنٹوں کے اندر میکونیم کا اخراج شروع ہو جانا چاہیے۔ پیدائش کے وقت آنتوں میں کوئی جراثیم نہیں ہوتے مگر چند گھنٹوں کے اندر ہی بیکٹیریا آنتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح انداز میں بنا ہوا پاخانہ نومولود کو تقریباً پانچویں دن آتا ہے جو کہ ہلکے رنگ کا ہوتا ہے اور اس سے پاخانے کی مخصوص بو بھی آنے لگتی ہے۔

☆..... **عمل تنفس (Respiratory System):** فیس کے پھیپھڑے ہوا کے بغیر ہوتے ہیں اور ان میں پھیپھڑوں کا فلوئیڈ اور ایمینیا ٹک فلوئیڈ (Amniotic Fluid) ہوتا ہے۔ فیس (Foetus) کے خون میں آکسیجن کا دباؤ تقریباً 4.5 سے 5.5 کلو پاسکل ہوتا ہے۔ جونہی پیدائش کے بعد بچہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے تو اس کے خون میں آکسیجن کا دباؤ فوراً نارمل ہو جاتا ہے۔ شروع میں عمل تنفس کی رفتار 40 مرتبہ فی منٹ تک ہوتی ہے مگر اس میں کچھ بے ترتیبی ہو سکتی ہے۔ پیدائش کے 8 گھنٹے بعد یہ رفتار 40 مرتبہ فی منٹ سے کم پر مستقل ہو جاتی ہے۔

☆..... **پیشاب (Urine):** جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لیکور (Liquor) نگل لیتا ہے جو کہ بعد میں خون میں جذب ہو کر گردوں کے راستے سے خارج ہوتا ہے۔ پیدائش کے دو گھنٹے کے اندر اندر بچے کو پیشاب آ جانا چاہیے۔

☆..... **جینیٹل سسٹم (Genital System):** ایسٹروجنز (Estrogens) کے ختم ہونے کے اثرات واضح ہو جاتے ہیں۔ چھاتیاں معمولی سی پھول جاتی ہیں۔ لڑکے (Male baby) میں معمولی سا ہائیڈروسیل (Hydrocele) جبکہ لڑکی (Female Baby) کے ویجائنہ میں معمولی سی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن ان علامات کیلئے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔

☆..... **دل اور خون کی نالیوں کا نظام (Cardiovascular System):** جونہی بچہ پہلا سانس لیتا ہے اس کے پھیپھڑوں میں ہوا بھر جاتی ہے اور وہ پھول جاتے ہیں۔ اس کیساتھ ہی پلمونری ویکسلز (Pulmonary Vessels) بھی ڈھیلی (Relax) ہو جاتی ہیں۔ ڈکٹس آریٹریوسس (Ductus Arteriosus) تیزی سے پھولتا اور سکڑتا ہے اور دائیں وینٹریکل میں موجود سارا خون پھیپھڑوں کی طرف منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ اس طرح بچے کے دل کے بائیں ایئریم میں خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے جبکہ دائیں ایئریم میں خون کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور اسکے نتیجے میں دل کی درمیانی دیوار سپٹم کا سوراخ فورامین اوویلی (Foramen Ovale) بند ہو جاتا ہے اور ڈکٹس آریٹریوسس فوراً بند ہو جاتا ہے جبکہ چوتھے ہفتے تک تو یہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ فورامین اوویلی آہستہ آہستہ بند ہوتا ہے اور اس میں اسے کئی ماہ لگ جاتے ہیں مگر عملی طور پر یہ سوراخ فوراً بند ہو جاتا ہے۔

4۔ بچے کا عمومی مشاہدہ (Routine Observation): بچے کی پیدائش کے بعد بطور مشاہدہ درج ذیل نکات نوٹ کئے جاتے ہیں؛

☆..... وزن (Weight): پیدائش کے بعد پہلے تین دن سے چار دن تک بچے کے وزن میں کمی واقع ہوا کرتی ہے۔ جبکہ اگلے دس دن کے اندر بچے کو اپنے پیدائشی وزن (Birth Weight) کے برابر ہو جانا چاہیے۔

☆..... درجہ حرارت (Temperature): نومولود کا عمومی درجہ حرارت 36.7 سینٹی گریڈ ہوتا ہے لیکن پہلے ہفتے میں کچھ بے قاعدگی ہو سکتی ہے۔

☆..... نبض (Pulse): اسے اسٹیکس بیٹ (Apex beat) پر اسٹیتھو سکوپ کی مدد سے گنا جاسکتا ہے۔ بچے کی نبض عام طور پر 120 سے 150 مرتبہ فی منٹ تک ہونی چاہیے۔

☆..... عمل تنفس (Respiration): شروع میں بچے کے عمل تنفس کی رفتار 40 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے جو کہ بعد میں کم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے پہلے ہفتے میں بچے کے تنفس کی رفتار میں بے قاعدگی ممکن ہے۔

☆..... خوراک (Feed): لیبر وارڈ میں بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کریں۔ جن بچوں کو مصنوعی دودھ کی ضرورت ہو تو انہیں چھ گھنٹے بعد پہلی غذا دے دیں۔ ماسوائے اس کے کہ بچے کی نشوونما بہت کم ہو ایسے بچے کو فوری طور پر دودھ شروع کروادیں۔

☆..... پاخانہ (Stool): چوتھے دن تک بچے کا میکونیم (Meconium) خارج ہونے کے بعد پاخانہ نارمل اور صحیح حالت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پاخانے کی رنگت پیلی اور پاخانے کی بدبو بھی آتی چاہیے۔ ماں کا دودھ پینے والے بچوں میں نارمل پاخانہ جلد شروع ہو جاتا ہے۔

☆..... قے (Vomit): چھوٹے شیرخوار بچوں میں قے کا آنا ایک معمول کی بات ہے لیکن اگر یہ علامت برقرار رہے تو پھر بچے کو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اگر قے شدہ مواد میں بائل شامل ہو تو یہ ایک خطرناک علامت ہوتی ہے اور یہ آنتوں میں بندش (Intestinal Obstruction) کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے بچے کو فوری طور پر معائنے اور ٹیسٹ کے لئے بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس بھجوائیں۔

☆..... دودھ پینے سے ہچکچاہٹ (Reluctance To Feed): وہ بچے جو ماں کا دودھ پینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کا ضرور معائنہ کروانا چاہیے۔ ایسے بچوں میں انفیکشن یا خون میں گلوکوز کی کمی (Hypoglycemia) کی وجہ ہو سکتی ہے۔

5۔ بچے کی دیکھ بھال (Nursing Care Of New Born): نومولود کی پیدائش کے بعد درج ذیل نکات پر خاص زور دیا جاتا ہے؛

☆..... وٹامن "کے" کا دینا (Vitamin-K Administration): تمام نومولود بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد وٹامن کے (Vitamin-K) کا ٹینک 0.5 ملی گرام گوشت میں یا ایک ملی گرام منہ کے ذریعے ضرور دیں تاکہ بچے میں ایک خطرناک مرض جسے ہمیریکک ڈیزیز آف نیو بارن (Haemorrhagic Disease of New Born) کہتے ہیں، سے بچا جاسکے۔ جب بچے کو منہ کے ذریعے وٹامن کے دیا جائے اور وہ ماں کا دودھ پی رہا ہو تو پھر اسے مزید وٹامن کے کی ایک ماہ بعد ضرورت پڑے گی۔ اگر ماں مرگی روکنے والی ادویات یا وہ دورے سے بچاؤ کے لئے ادویات لے رہی ہے تو پھر بچے کو وٹامن کے دینا اور ضروری ہو جاتا ہے۔ جونہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا باپ بھی سرہانے موجود ہوتا ہے۔ بچہ ماں کو دے دیا جاتا ہے اور امبالائیکل کارڈ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ بچے کو کم از کم آدھا گھنٹہ مسلسل ماں کے ساتھ لگا کر رکھنا چاہیے تاکہ وہ ماں کا لمس محسوس کر سکے اور یہ بات بچے میں دودھ پینے کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہے۔ پیدائش کے چھ سے آٹھ گھنٹے بعد بچے کو نہلایا جاتا ہے اور اسے ایک گاؤن میں لپیٹ کر بے بی کاٹ (Baby Cot) میں لٹا دیا جاتا ہے اس وقت کمرے کا درجہ حرارت اٹھارہ سے بیس سینٹی گریڈ کے درمیان ہونا چاہیے۔ ماں اور بچے کے درمیان پیار کا رشتہ پیدا کرنے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے اور دونوں دن کا زیادہ وقت ایک ساتھ گزاریں۔

6۔ نومولود بچے کی غذا (Infant Feeding): پیدائش کے فوراً بعد بچے کی غذائیت اہم ہے کیونکہ ابتدائی چھ ماہ کے دوران بچے کے جسم کی نشوونما بہت تیزی سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے متوازن غذا کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ پانچ ماہ کی عمر میں بچے کے جسم کا وزن پیدائشی وزن سے دوگنا ہو جاتا ہے جبکہ ایک اور دو سال بعد بچے کا وزن بالترتیب تین گنا اور چار گنا ہو جاتا ہے۔ بچے کی نشوونما کو صحیح رکھنے کے لئے صحیح غذا کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کے ہاضمہ کا نظام بڑی مشکل سے غذا ہضم کرنے کے لئے تیار ہوا ہوتا ہے۔ پہلے ہفتے میں بچے کا وزن یا تو کم ہو جاتا ہے یا پھر وہیں پر برقرار رہتا ہے۔ اس دورانیے کے بعد بچے کی غذائی ضرورت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی غذا میں مناسب مقدار میں پروٹین، وٹامن، نمکیات، چکنائیاں، نشاستے، مائعیات کی صورت میں شامل ہونی چاہئیں جو ماں کے دودھ یا گائے کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں۔ ہر بچے میں غذائی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ اس لئے کوئی اصول تو نہیں بنایا جاسکتا ہے البتہ بچوں کو اوسطاً مائعیات کی مقدار 150 ملی لیٹر فی کلو گرام جسم کا وزن 24 گھنٹے میں درکار ہوتی ہے۔



**Neonatal  
Forehead Measurement**



**Neonatal  
Weight Measurement**



**Neonatal Chest Examination**



**Neonatal Care**

☆.....**حرارے (Calories):** بچے کو 24 گھنٹے میں 110 حرارے یا کیلوریز فی کلوگرام جسم کے وزن کے حساب سے درکار ہوتی ہیں۔ وہ بچے جن کا پیدائشی وزن 3.2 کلوگرام یا 7 پاؤنڈ سے کم ہو تو اسے زیادہ مائع اور حرارے درکار ہوتے ہیں۔ پہلے چار ماہ کے لئے بچے کو صرف ماں کا دودھ ہی کافی ہوتا ہے۔

☆.....**کلاstrum (Colostrum):** ماں کا پہلا دودھ آنے سے پہلے چھاتیوں سے پیلے رنگ کی اساسی خواص رکھنے والی رطوبت نکلتی ہے جسے کلاstrum کہتے ہیں۔ یہ رطوبت چھاتیوں میں حمل کے آخری ماہ میں موجود ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش کے دو سے تین دن تک موجود رہتی ہے۔ اس کے بعد دودھ کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ پانچویں دن سے بالکل مکمل دودھ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کلاstrum میں بہت ہی مفید چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ بچے کی صحت کے لئے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ اس میں پروٹین اور اینٹی باڈیز بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں یہ اینٹی باڈیز IgA گروپ سے تعلق رکھتی ہیں اور بچے کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز بچے میں صرف پیدائش کے پہلے دو سے تین دن تک جذب ہو سکتی ہیں۔ اسکے بعد ان کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کلاstrum میں چند جراثیموں مثلاً ای کولائی (E.Coli) اور رونا وائرس (Rota Virus) کے خلاف اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں۔ یہ جراثیم بچوں میں اسہال کا مرض پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح بچے اس مرض سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

☆.....**چکنائیاں (Fats):** ماں کے دودھ میں چکنائیاں زیادہ تر غیر سیر شدہ فیٹی ایسڈز (Unsaturated Fatty Acids) کی صورت میں موجود ہوتی ہیں جبکہ اس میں کولیسٹرول کی بھی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ بچے کے دماغ کی بڑھوتری کیلئے یہ دونوں اجزاء ضروری ہیں۔

☆.....**نشائے (Carbohydrates):** ماں کے دودھ میں سب سے زیادہ پایا جانے والا نشائے لیکٹوز (Lactose) ہے۔ لیکٹوز بھی دماغ کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور دماغ کے لئے ضروری مرکب گلیکولیپڈ (Galactolipid) بناتا ہے۔ یہ مرکب آنتوں سے کیلشیم کے انجذاب میں بھی مدد دیتا ہے۔

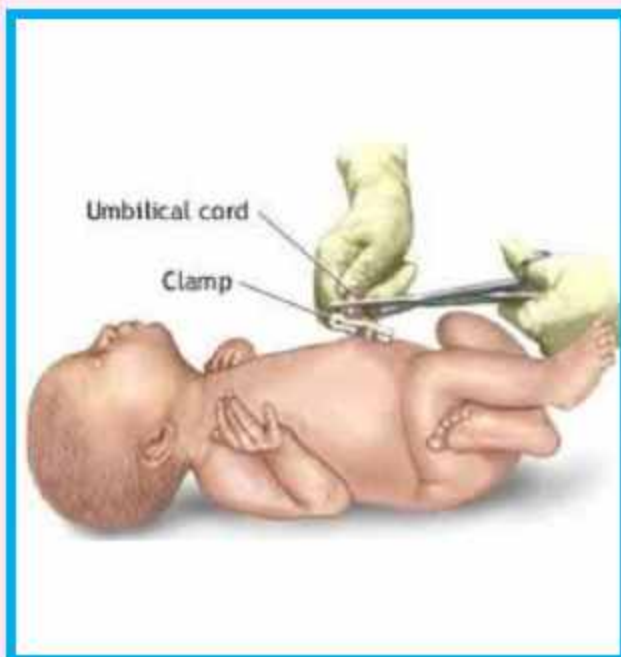
☆..... پروٹین (Protein): بچے کی نشوونما کیلئے پروٹین نہایت ضروری ہیں۔ ماں کے دودھ میں سب سے زیادہ پائے جانے والی پروٹینز ذیل ہیں:

|                    |                      |        |
|--------------------|----------------------|--------|
| (Casein)           | کیسین -              | ☆..... |
| (Alphalactalbumin) | ایلفالیکٹ البیومن -  | ☆..... |
| (Lactoferrin)      | لیکٹو فیرین -        | ☆..... |
| (Immunoglobulin-A) | ایمونوگلوبولن - اے - | ☆..... |
| (Lysozyme)         | لائسوزائم -          | ☆..... |
| (Albumin)          | البیومن -            | ☆..... |

☆..... خامرے (Enzymes): چونکہ ماں کے دودھ میں وٹامن، گائے کے دودھ میں موجود وٹامنز سے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے نومولود کی صحت اور بیماریوں سے بچاؤ اور نشوونما کے لئے ماں کا دودھ بچے کے لئے انتہائی بہترین غذا ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

عثمانیہ نیا پتہ سی کمیشنرز



Infant's Cord Clamping



Infant's Chest Examination



Infant's Lactation



Infant's Care

## یونٹ: 19

## نوزائیدہ کی اقسام

(KINDS OF NEWBORN)

## (زندہ بچے)

(ALIVE BORN)

**تعارف (Introduction):** اس سے مراد وہ بچے ہیں جو زندہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو زندہ قرار دینے کیلئے مندرجہ ذیل شواہدات ہوتے ہیں:

|        |                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | بچہ سانس لیتا ہے اور ہم اس کے پھیپھڑوں کے پھیلاؤ اور پیٹ کی حرکت محسوس کرتے ہیں۔                            |
| ☆..... | یہ بچے عام طور پر مکمل قد کے یعنی سولہ سے بیس انچ لمبے ہوتے ہیں۔                                            |
| ☆..... | ان بچوں کا وزن تقریباً اڑھائی سے تین کلو تک ہوتا ہے۔ بعض خاص حالتوں میں بچے کا وزن پانچ کلو بھی ہو سکتا ہے۔ |
| ☆..... | ایسے بچوں کے سر پر بال اور ہاتھوں کے ناخن واضح طور پر موجود ہوتے ہیں۔                                       |
| ☆..... | یہ بچے پیدائش کے فوری بعد رونے لگتے ہیں جو زندگی کی دلیل ہے۔                                                |
| ☆..... | بچوں کی عضلاتی حرکات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔                                                               |
| ☆..... | بچے کے دوران خون اور دل کی دھڑکن زندگی کی گواہی دیتی ہے۔                                                    |
| ☆..... | زندہ نومولود کی جلد کی رنگت تیز سرخ ہوتی ہے۔                                                                |
| ☆..... | بچے کی انٹریوں میں موجود ہوا سے بھی بچے کے زندہ ہونے کا ثبوت مل سکتا ہے۔                                    |
| ☆..... | بچے کے مثانے میں پیشاب موجود ہوتا ہے۔                                                                       |
| ☆..... | گردے اور مثانے کے مشاہدے سے یورک ایسڈ کے ذرات ملتے ہیں۔                                                     |
| ☆..... | ناک کے مقام پر سوزش ہوتی ہے کیونکہ سوزش صرف زندہ پیدا ہونے والے بچے میں ہی ہوتی ہے۔                         |



## خاموش نوزائیدہ

(STILL BORN)

☆..... یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو شکم مادر میں کم از کم 28 ہفتے گزار چکے ہوتے ہیں۔

☆..... یہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ خاموش بچے ہوتے ہیں۔

☆..... ایسے بچوں میں قلبی حرکات موجود ہوتی ہیں۔

☆..... ان بچوں میں پیدائشی طور پر کسی خرابی کی وجہ سے سانس کا عمل جاری نہیں ہوتا۔

☆..... اگر ولادت کے فوری بعد انکلوپی امدادیں اور مصنوعی طریقہ سے سانس جاری کر نیکی کوشش کریں تو اس طرح یہ بچہ بچ جاتا ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ خاموش بچہ دراصل زندہ بچہ ہوتا ہے صرف سانس کی نظام کی خرابی کی وجہ سے یہ بظاہر مردہ نظر آتا ہے۔ ایسے بچوں کو بعض نا تجربہ کار دایہ مردہ تصور کرتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بچہ زندہ ہوتا ہے لہذا اس طرح کے بچے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔



## مردہ بچہ

(DEAD BORN)

تعارف (Introduction): وہ بچہ جو مردہ پیدا ہو مردہ بچہ کہلاتا ہے۔ اس بچے کی درج ذیل علامات ہوتی ہیں؛

☆..... اگر پیدائش سے قبل نومولود ایمنیا ٹک فلوئیڈ میں ہی مرجائے تو بچہ مردہ تصور ہوگا۔

☆..... بچے کے جسم میں یہ رطوبت جذب ہونے سے اس کا جسم نرم و ملائم ہو جاتا ہے اور اس سے ناخوشگوار قسم کی بو آتی ہے۔

☆..... بچے کے جسم کی رنگت سرخی مائل تو ہوگی لیکن اس پردہ سے پڑے ہوں گے۔

☆..... بچے کی کھوپڑی کی ہڈیاں الگ ہوتی ہیں۔

☆..... کھوپڑی میں سبزی مائل سرخ رنگ کا داغ نظر آتا ہے۔

☆..... بعض حالتوں میں بیرونی ماحول میں آتے ہی بچے کے گلنے سڑنے کی علامات شروع ہو جاتی ہیں ایسا بچہ (Decompose) کہلاتا ہے۔

☆..... خون کی کمی یا رحم کی رطوبت کی کمی سے بچہ سوکھ جاتا ہے یہ بچہ Mumification کہلاتا ہے۔





Alive Born Baby



Premature Born Baby



Still Born Baby



Dead Born Baby

## نومولود کی بیماریاں

### (DISEASES OF NEW BORN)

**تعارف (Introduction):** پیدائش کے بعد نومولود بچے میں زچگی کے مرحلے میں کسی بھی موقع پر انفیکشن کے ہو جانے یا کسی دوسری وجہ مثلاً دباؤ اور خون کی خرابی وغیرہ سے کئی ایک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جن میں سے کچھ تو پیدائش کے کچھ عرصہ بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو بچے کے مر جانے یا ہمیشہ کے لئے معذور ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ذیل میں نومولود بچے کی عام بیماریوں کا ذکر اختصار کیساتھ دیا گیا ہے۔



### اکٹیرس نیونیٹرم

#### (ICTEROUS NEONATORUM)

**تعارف (Introduction):** یہ نومولود بچوں میں پائے جانے والے یرقان کی فزیالوجیکل قسم ہے۔ یہ عام طور پر خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے جو پیدائش کے فوراً بعد جگر اور تلی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ مرض عام طور پر بچے کی پیدائش کے تین سے سات روز کے درمیانی عرصہ میں ہوتا ہے اور تقریباً پندرہ روز تک رہ کر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ بچے کے خون میں پیدا ہونے والی ایک فزیالوجیکل کیفیت ہوتی ہے اس لئے اس کے لئے کوئی خصوصی علاج درکار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس قسم کے یرقان کے ساتھ کوئی دوسری علامات پائی جاتی ہیں۔



### ایس فیگز یا نیونیٹرم

#### (ASPHYXIA NEONATORUM)

**تعارف (Introduction):** نومولود بچے میں دوران پیدائش کسی وجہ سے دباؤ پڑنے سے تنگی تنفس کا پیدا ہو جانا ایس فیگز یا نیونیٹرم کہلاتا ہے۔ نومولود میں تنگی تنفس زچگی کے عمل کے دوران زخمی ہو جانے سے، گلے میں پلے سینفا کے پھنس جانے، سینے پر پلے سینفا کا دباؤ پڑنے، دماغ میں زہریلے مادوں کے بھر جانے اور بچے کے منہ اور ناک وغیرہ میں میوکس یا ماں کی رطوبتوں کے بھر جانے یا یوٹرس کی رطوبت ایمنیا ٹک فلوئڈ میں ڈوب جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت میں نومولود بچے کا شریانی اور ویدی خون مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے نیلا یرقان ہو جاتا ہے۔ بچے کو آکسیجن پوری طرح نہیں مل سکتی اور اسے تنگی تنفس کی شکایت ہو جاتی ہے اس حالت میں بچے کے جسم پر نیلے داغ

پڑ جاتے ہیں۔ شروع شروع میں بچہ سانس خود بخود لینے کی کوشش نہیں کرتا لیکن تھوڑے وقفے کے بعد وہ آہستہ آہستہ سانس لینے کی کوشش کرتا ہے جس کے تھوڑی دیر بعد وہ تیز سانس لینے کی کوشش کے بعد ایک چیخ مارتا ہے۔

تنگی تنفس کی دوسری حالت میں بچے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس حالت میں بچے کے سانس لینے کے مرکز میں ناطا قتی پیدا ہو جاتی ہے اور آخر کار سانس لینے کا مرکز ماؤف ہو جاتا ہے کیونکہ بچے کو آکسیجن پوری طرح نہیں مل سکتی اور جسم میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جمع ہو جاتی ہے۔ بچے کے اعضاء میں عضلات کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ نومولود میں تنگی تنفس کی یہ ایک خطرناک حالت ہے جس میں اکثر بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔



## ایریتھرو بلاسٹوسس فیٹالس

(ERYTHROBLASTOSIS FETALIS)

**تعارف (Introduction):** نومولود بچے میں یا ماں کے پیٹ میں موجود آخری دنوں کے جنین میں ہیملوٹینک انیمیا کا ہو جانا ایریتھرو بلاسٹوسس فیٹالس کہلاتا ہے۔ نومولود میں یہ بیماری ماں کے خون کے سیرم میں اینٹارمل اینٹی باڈیز کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ماں کے خون میں اینٹارمل اینٹی باڈیز عام طور پر آر، ایچ فیکٹر کے بے جوڑ میل کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں جو بچے میں ہیملوٹینک انیمیا کا باعث بنتے ہیں۔



## آپتھلمیا نیونٹورم

(OPHTHALMIA NEONATORUM)

**تعارف (Introduction):** یہ نومولود بچے کی آنکھ میں پائی جانے والی ایک خطرناک انفیکشن ہوتی ہے جو عام طور پر زچگی کے آخری درجے میں بچے کو ویجائٹ کے نچلے حصے اور ولوا میں سے گزرتے ہوئے لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ انفیکشن لیبر کے دورانیے کے لمبا ہو جانے سے جھلیوں کے پھٹ جانے سے پہلے بھی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہی انفیکشن پیدائش کے بعد ماں یا دایہ کے ہاتھوں یا کپڑوں وغیرہ سے جراثیم کے بچوں کی آنکھوں میں منتقل ہو جانے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ انفیکشن بچے کے یوٹرس میں ہوتے وقت ہوئی ہو تو علامات کا اظہار پیدائش کے فوری بعد ہو جاتا ہے جبکہ پیدائش کے آخری درجے میں ہونے والی انفیکشن کی وجہ سے علامات دو تین دن بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ اکثر یہ انفیکشن گونو کوس کے ذریعے بھی ہوا کرتی ہے۔ اس مرض میں عام طور پر پیدائش کے دو تین دن بعد بچے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے پیوٹوں میں

اڈیما اور سوجن ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے پیپ ملا مواد خارج ہونے لگتا ہے۔ یہ مواد بچے کے پیوٹوں کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو آنکھ کا سفید پردہ جس میں تھوڑی سی سوجن اور اڈیما پہلے سے موجود ہوتے ہیں، مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس مرض کا علامات کے مطابق فوری علاج بہت ضروری ہے تاکہ بچہ پیدا ہوتے ہی ہمیشہ کے لئے نابینا نہ ہو جائے۔



## امبالائیکل ہرنیا

(UMBILICAL HERNIA)

**تعارف (Introduction):** نومولود بچے میں امبالائیکل ہرنیا کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری افریقی بچوں میں بہت عام ہوتی ہے۔ ابھی تک اس بیماری کے لئے میڈیکل علاج دریافت نہیں ہوا اور یہ عموماً بچے کے تین سال کی عمر کے ہونے تک خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ہرنیا خود بخود غائب نہ ہو تو پھر پیڈیاٹرک سرجن یعنی بچوں کے سرجن سے معائنہ کروا کر بذریعہ آپریشن و سرجری امبالائیکل ہرنیا کا علاج کروانا گزیر ہو جاتا ہے۔



## امبالائیکل انفیکشن

(UMBILICAL INFECTION)

**تعارف (Introduction):** نومولود بچے کی ناف میں پیدا ہونے والی انفیکشن بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف بچے کے پیٹ کی دیواروں میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے بلکہ ناف کی ورید کے ساتھ ساتھ انفیکشن بڑھ کر جگر تک پہنچ سکتا ہے۔ نومولود بچے میں بہت سی بیماریاں اس قسم کی انفیکشن کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں اس لئے بچے کی پیدائش کے بعد یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی امبالائیکل کارڈ کو نہایت احتیاط کے ساتھ کاٹ کر اس پر کوئی بے ضرر سائینیٹی سپنک اس وقت تک لگاتے رہنا چاہیے جب تک کہ یہ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو جائے۔ ناف پر لگانے کے لئے میٹھیلیڈ سپرٹ ایک بہترین انٹی سپنک ہے۔



## منہ کے چھالے

(THRUSH)

**تعارف (Introduction):** نومولود بچے کی زبان اور منہ کی اندرونی سطح پر چھالے ہونا بھی نومولود کی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ ان چھالوں کی وجہ سے بچے کو دودھ پیتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ماں کا پستان منہ میں لے کر چھوڑ دیتا ہے۔ نومولود میں یہ چھالے زبان اور منہ کی اندرونی سطح پر سفید دھبوں کی صورت میں ہوتے ہیں جن میں سوزش پائی جاتی ہے اور بچہ دودھ نگلنے میں انتہائی تکلیف محسوس کرتا ہے۔



## زخم

(WOUNDS)

**تعارف (Introduction):** دوران پیدائش بے احتیاطی سے پکڑنے یا پیدائش کے دوران کسی اوزار کے لگ جانے سے بچہ زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ دباؤ پڑنے سے بھی نومولود کے جسم کے کسی حصے کو مثلاً بازو، ٹانگ یا سر وغیرہ کو چوٹ آ سکتی ہے۔ عام طور پر بچے کے سر یا ماتھے پر زخم فار سپس ڈیلیوری کے باعث ہوتا ہے۔



## سر کی سوجن

(CRANIAL SWELLING)

**تعارف (Introduction):** دوران زچگی ماں کو اگر زیادہ زور لگانا پڑے تو بچے کے سر کا دریدی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسا بچے کے سر پر زیادہ دباؤ پڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کا سر نیلا ہو جاتا ہے۔ یہ علامت عام طور پر بچے کی پیدائش کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات چوٹ کے زیادہ لگنے سے پیری اوٹیم پر زخم ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس میں سے خون خارج ہونے لگتا ہے اور سر کی سوجن بڑھ جاتی ہے جسے ٹھیک ہونے میں ڈیڑھ سے دو ماہ تک لگ جاتے ہیں۔



## اسہال

## (DIARRHOEA)

**تعارف (Introduction):** نومولود میں یہ بیماری عموماً ای کولائی جراثیم کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بیماری میں نومولود کئی مرتبہ دست کرتا ہے اور نتیجے کے طور پر بدن میں پانی اور نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بچے بے جان تڑھال سا ہو جاتا ہے۔ یہ تکلیف پیدائش کے کچھ دن بعد شروع ہو سکتی ہے۔ ناقص اور گندماحول بھی اس مرض کا سبب بنتا ہے جس کے باعث نومولود کو اسہال کی بیماری لگ سکتی ہے۔



## بچے کا لباس

## (BABY'S DRESS)

**تعارف (Introduction):** بچے کا لباس نہایت سادہ ہونا چاہیے۔ سلائی یا ترپائی دیز تہہ کی نہ ہوں جو بچے کی نرم کھال میں چھتی ہیں۔ چٹٹیس، پلیٹ، فیتہ وغیرہ نہ ہو۔ لباس پر خوبصورتی کے لئے گوشہ کناری بھی نہ ہو۔ بچے کا لباس نہ زیادہ تنگ ہو نہ زیادہ ڈھیلا۔ تنگ لباس بچے کیلئے مفید نہیں ہے۔ بچے کے سر پر ٹوپی نہ ہو لیکن اگر بہت سردی ہو تو ہلکا سا ٹوپا صبح اور شام کے لئے کافی ہے جس سے بچے کے کان بھی ڈھک جائیں۔ گرم کپڑے ہر وقت نہ پہنائے جائیں۔ دوپہر میں دھوپ کے وقت کپڑے ذرا کچھ کم کر دیئے جائیں ورنہ بچے کو دن رات گرم کپڑوں میں لپٹائے رکھنے سے سردی لگ جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ ہر وقت گرم کپڑے پہنانے سے بچے کو گرم کپڑوں کی عادت ہو جائے گی۔ اس سے پھر سردی رفع نہ ہوگی اور پیشاب پاخانہ صاف کرنے کے لئے جو نبی بچے کو کھولا جائے گا تو اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بچے کے لئے ہلکے رنگوں کے کپڑے اچھے لگتے ہیں۔



## بچے کی غذا

## (BABY'S DIET)

**تعارف (Introduction):** بچے کے لئے دنیا بھر میں سب سے اچھی غذا ماں کا دودھ ہے۔ دوسرے درجے پر کسی اور عورت کا دودھ ہے جس کا اسی عمر کا اپنا بچہ ہو اور جس کی عمر اس کی ماں کی عمر کے برابر ہو۔ تندرستی اچھی ہو اور وہ خطرناک امراض سے پاک ہو۔ تیسرے درجے پر گائے کا تازہ دودھ ہے اور چوتھے درجہ پر مصنوعی خشک پاؤڈر یعنی ڈبے کا دودھ۔ ماں کا دودھ بچے کے لئے بہترین غذا ہے۔ ہر ماں کو لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو

اپنا دودھ ضرور پلائے اور اوپری دودھ بحالت مجبوری دے۔ حمل کے نو ماہ میں قدرت نے بچے کی غذا ماں پر منحصر رکھی ہے اور یہ بھی انتظام کیا ہے کہ بعد از ولادت بھی بچہ ماں کے ہی دودھ پر پرورش پائے گا۔ کا دودھ بچے کے لئے نہیں بلکہ گائے کے بچھڑے کیلئے موزوں ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کیلئے قدرتی غذا ہے۔ مذہب اسلام میں ہر مسلمان عورت کو لازم ہے کہ تندرستی کی حالت میں اپنے بچے کو دو سال تک اپنا دودھ پلائے۔



## گائے کا دودھ

(COW'S MILK)

**تعارف (Introduction):** گائے کا دودھ انسانی بچے کے لئے بھاری اور ثقیل ہے۔ بے شک آپ اس میں پانی ملا کر اسے ہلکا کر لیں۔ پھر بھی وہ ماں کے دودھ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے ایک ماں کا دودھ ہر بچے کے لئے یا ہر ماں کا دودھ ایک بچے کے لئے بہترین غذا ثابت نہ ہو۔ لیکن جس بچے کو ماں نے نو مہینے اپنے خون و غذا سے پرورش کیا ہے وہ ہی اس کی بہترین غذا کی ضامن ہے۔ ماں کا دودھ جراثیم سے پاک اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ قیمتی سے قیمتی دودھ کا ڈبہ خواہ تازہ خریدیں لیکن پھر بھی وہ کم و بیش غیر متوازن ہوگا۔ ماں کے دودھ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ نیم گرم اور جراثیم سے پاک نکلتا ہے۔ دوسرے دودھ کو پہلے تیار کرنا پڑتا ہے جو بچے کو دیا جاسکتا ہے۔ اگر ماں اپنا ہاضمہ بگڑنے نہ دے اور تندرستی کا خیال رکھے اور جسم کو صاف ستھرا رکھے اور اسے کوئی متعدی بیماری نہ ہو تو اس کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں ہے۔ بچے کو ماں کی چھاتی سے دودھ پینے میں محنت کرنی پڑتی ہے جو ہر طرح سے بچے کے لئے مفید ہے۔ بوتل سے دودھ پینے میں محنت کم کرنی پڑتی ہے۔ نپل پرانا ہو جانے سے نپل کا سوراخ کھل جاتا ہے اور ذرا سادبانے سے زیادہ دودھ نکل آتا ہے۔ بچے کو اس طرح دودھ پلانا کسی طور مناسب نہیں۔ اوپری دودھ میں خرچ بھی ہوتا ہے اور فائدہ مقابلتہً اتنا نہیں ہوتا۔ ماں کے دودھ میں علیحدہ سے کوئی خرچہ نہیں۔ ماں کا دودھ پلانے میں نہ صرف روپیہ بچتا ہے بلکہ محنت اور وقت جو دودھ تیار کرنے میں لگتا ہے بچ جاتا ہے اور اس طرح سے فکر اور پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ ماں کے دودھ میں وہ سب ضروری اجزاء ہوتے ہیں جو بچے کی تندرستی اور صحیح نشوونما کے لئے درکار ہیں اور کسی دودھ میں اتنی افادیت نہیں ہے۔ ماں کو غذا میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ شروع میں بچے کو صحیح غذا نہ ملنے کا اکثر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دانت کمزور ہوتے ہیں یا ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں یا پتلی پتلی رہ جاتی ہیں یا ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ بعض بچے بظاہر صرف دودھ اور پانی پلانے پر پھولتے جاتے ہیں اور تندرست دکھائی دیتے ہیں لیکن صرف پیدائشی طور پر تندرست و توانا بچے ہی اس طرح پل سکتے ہیں لیکن بعد میں ان کی صحت اچھی نہیں رہتی۔



## دودھ پلانا

### (LACTATION)

**تعارف (Introduction):** بچے کو ڈبے کا دودھ پلانے کے دوران ایسا لگتا ہے کہ اس کی پرورش ٹھیک ہو رہی ہے لیکن آگے جا کر بچے میں بہت سی خطرناک بیماریوں کے آثار پیدا ہو سکتے ہیں مثلاً سوکھے کا مرض، دست وغیرہ۔ ماں کے دودھ میں وہ اجزاء جن سے بچے کو صحیح طاقت پہنچتی ہے، بہت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک بچے کو ہر مصنوعی دودھ موافق بھی نہیں آتا۔ اگر بالفرض بچے کو اس مصنوعی دودھ کی عادت بھی ہو جائے تو اس میں وہ اجزاء کہاں جو بچے کی نشوونما کے لئے ضروری ہیں اور ماں کے دودھ میں موجود ہوتے ہیں۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کو فکر و غم یا ذہنی پریشانی کی حالت میں دودھ نہ پلائے بلکہ کچھ دیر کے لئے ذاتی پر اہم بھول کر اطمینان سے بچے کو دودھ پلائے کیونکہ دودھ کے ذریعے ماں کے خیالات کا اثر بچے کے ذہن تک پہنچتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ دودھ پلانے کے زمانے میں زیادہ تر خوش رہنے کی کوشش کرے۔ یہ دودھ بننے کے لئے ضروری ہے۔ زیادہ مقدار میں رقیق چیزیں پیئیں خصوصاً پانی زیادہ پیئیں۔ پھل، سلاڈ وغیرہ بھی ضروری ہیں۔ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اسے بد ہضمی کی شکایت عموماً کم ہوتی ہے۔ ایسے بچے بہترین طریقے پر اپنی نشوونما کی منازل طے کرتے ہیں۔ کسی بھی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے پستانوں میں دودھ کی مقدار کو بڑھانے کے لئے دودھ اور مقوی غذاؤں کا استعمال زیادہ کرے تاکہ ماں میں دودھ اچھی خاصی مقدار میں پیدا ہو اور بچے کی نشوونما اور پیٹ بھرنے کے لئے مناسب مقدار میں دودھ میسر آ سکے۔



عثمانیہ نیا پبلشرز

## معیاری وزن کے مطابق بچہ کیلئے دودھ کی مطلوبہ مقدار

| عمر           | دودھ کی مقدار  | دن بھر میں | درمیانی وقفہ |
|---------------|----------------|------------|--------------|
| پیدائش کے وقت | ڈھائی اونس     | 6 مرتبہ    | 3 گھنٹے      |
| ایک ہفتہ      | ڈھائی اونس     | 6 مرتبہ    | 3 گھنٹے      |
| دو ہفتہ       | تین اونس       | 6 مرتبہ    | 3 گھنٹے      |
| تین ہفتہ      | ساڑھے تین اونس | 6 مرتبہ    | 3 گھنٹے      |
| ایک ماہ       | ساڑھے تین اونس | 6 مرتبہ    | 3 گھنٹے      |
| دو ماہ        | پانچ اونس      | 5 مرتبہ    | 4 گھنٹے      |
| تین ماہ       | چھ اونس        | 5 مرتبہ    | 4 گھنٹے      |
| چار ماہ       | سات اونس       | 5 مرتبہ    | 4 گھنٹے      |
| پانچ ماہ      | ساڑھے سات اونس | 5 مرتبہ    | 4 گھنٹے      |
| چھ تا آٹھ ماہ | آٹھ اونس       | 5 مرتبہ    | 4 گھنٹے      |

اگر بچے کا باضمر درست ہو تو پانچ چھ ماہ کی عمر کے بعد وہ صحیح مقدار میں دودھ پینے کے بعد بھی اکثر بھوکا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کیساتھ اسے کسی اور ہلکی ٹھوس غذا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد دلیہ، چاول، بسکٹ یا کیلے وغیرہ کھانا آہستہ آہستہ شروع کریں۔ بچے کو چھ ماہ کے بعد سے نیم ٹھوس غذا شروع کر دیں۔



## نومولود کو دودھ پلانا

### (LACTATION TO NEWBORN)

**تعارف (Introduction):** پیدا ہوتے ہی نومولود کو شہد اور ابلا ہوا پانی پلانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ چوبیس گھنٹے سوائے پانی کے اور کچھ نہ دیا جائے۔ جب تک پہلا پاخانہ نہ ہو جائے تو سوائے ابلے ہوئے پانی کے نومولود کو کچھ نہ دیا جائے۔ بچے کی عمر کے پہلے دو ہفتے میں اکثر دودھ پلانے کی دقتیں پیش آتی ہیں مثلاً بعض دفعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے۔ بچے کو دوسرے روز سے ایک یا دو وقت کوئی عمدہ کھٹی دینی چاہیے۔ پیدائش کے تھوڑی دیر بعد جب زچہ و بچہ فوری ضروریات مثلاً غسل، صفائی، تبدیلی وغیرہ سے فارغ ہو چکیں تو بچے کو ماں کے دودھ پر لگایا جائے تاکہ ماں کے پستان میں اول اول جو گاڑھا دودھ کلا سٹرم ہوتا ہے وہ بچے کے پیٹ میں پہنچ جائے۔ یہ گاڑھا گاڑھا دودھ بچہ پر ملتین یعنی قبض کشا کا سا اثر رکھتا ہے۔ اس سے بچہ کا معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے میں اکثر شروع شروع میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن جو نبی بچہ صحیح طریقہ سے دودھ چوسنا شروع کرتا ہے تو یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور دودھ بھی کافی مقدار میں آنے لگتا ہے۔ اگر دودھ آنے میں دقت ہو تو چھاتی کو گرم پانی سے دھونے سے یا گرم پانی میں بھیکے تولیہ سے سینکائی کرنے سے یہ تکلیف جاتی رہتی ہے۔ جب بچہ ماں کا دودھ خوب پینے لگے اور کم از کم ایک ماہ کا ہو چکے تو اس کو میٹھے سگترے کا جوس دینا شروع کریں۔ اس سے ہاضمے میں مدد ملتی ہے۔ سگترے کا عرق بغیر ہضم کرنے کی محنت کے جزو بدن بن جاتا ہے لیکن کھانسی نمونیہ یا سردی کے امراض میں سگترے کا عرق بغیر ڈاکٹر سے پوچھے نہیں دینا چاہیے۔ اگر موسم سردی کا ہے تو عرق سگترے کو ہلکا سا گرم کر کے دینا چاہیے۔ اگر ڈھائی دن کے بعد بھی ماں کو دودھ نہ اترے تو ابلے ہوئے پانی اور شہد کے علاوہ پانی ملا کر ہلکا کیا ہوگا گائے کا دودھ دینا چاہیے لیکن کبھی فوراً ماں کا دودھ چھڑا کر بچے کو اوپری دودھ پر نہ لگا دیا جائے کیونکہ ایک دم زیادہ دیر تک دودھ پینے سے بچہ تھک جاتا ہے اور بچے کا پیٹ ضرورت سے زیادہ بھر جاتا ہے۔ بچے کو دودھ پلانے میں یہ ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت سے لے کر صبح چھ بجے تک دودھ نہ دیا جائے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ بچے کو شروع ہی سے یہ عادت ڈالیں کہ وہ رات بھر سوتا رہے اور دودھ بالکل نہ مانگے تو دوران رضاعت بچہ ماں کو کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ اگر رات کے آٹھ گھنٹے ماں کو سونے کے لئے مل جائیں تو اس طرح وہ آرام اور نیند پوری کر سکتی ہے۔ نیند میں کمی نہ آنے کی وجہ سے ماں اور بچہ دونوں ہشاش بشاش رہتے ہیں۔ ماں کو گھریلو کام کاج اچھی طرح کر لینے کا اور دن میں تفریح اور ورزش کے لئے وقت مل جاتا ہے۔ بچے کو بھی پرسکون نیند آتی ہے کیونکہ اسے رات میں بار بار دودھ پینے کی عادت شروع ہی سے نہیں ڈالی گئی۔ اس طرح رات کو دودھ نہ دینے اور دن کو وقت مقررہ پر دودھ دینے سے بادی النظر میں بڑی دقت معلوم ہوتی ہے کہ کون بار بار گھڑی دیکھے لیکن ایسا کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں بہت آرام اور فائدہ ہے مثلاً بچے کو وقت پر دودھ ملے گا تو وقت پر سوئے گا، اپنے وقت پر ہی اٹھے گا اور جب دودھ کا وقت ہوگا تب ہی دودھ مانگے گا۔ درمیان میں اگر بچہ روئے تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ کا وقت نہیں ہے۔ لہذا بچہ دودھ کی بھوک سے نہیں رویا ہے بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہے۔ ایسے بچے کو پاخانہ بھی کئی بار یا بے وقت نہیں ہوتا ہے۔ اگر بچہ رات کو روئے اور دودھ مانگے تو بجائے دودھ کے ابلا ہوا نیم گرم پانی دیں اس طرح سے وہ رات کو بے وقت اٹھنے کی عادت چھوڑ دے گا۔



## ماں کا دودھ

### (MOTHER'S MILK)

**تعارف (Introduction):** یہ بات بہت ضروری ہے کہ دودھ پلانے کے دوران ماں اپنی غذا خوب چبا کر کھائے۔ دن یا رات میں سخت غصہ یا شدید رنج اور صدمہ کی حالت میں بچہ کو ماں کا دودھ ہرگز نہ پلایا جائے۔ بہتر ہے کہ ایک وقت کے دودھ کا ناغہ کیا جائے۔ ایک وقت بچے کو دودھ نہ دینے سے کوئی نقصان نہیں ہے، تھکان، پریشانی، اضطرابی کیفیت، فکر، غصہ رنج کی حالت میں ماں کا دودھ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ ایسی حالتوں میں دودھ پلانے سے سخت نقصان ہو جاتا ہے۔ غصہ اور رنج کا اثر دودھ کے ذریعہ بچہ کو پہنچتا ہے اور بچہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس طرح دودھ پلانے کے بعد اکثر بچے کو دورے پڑنے لگتے ہیں اور بعض دفعہ صبح دیکھ بھال نہ ہونے اور مسلسل غصے کی حالت کا دودھ پینے سے بچے کو مختلف دورے پڑنے لگتے ہیں جن سے بچہ مر بھی سکتا ہے۔ ایسی صورت حال میں بچے کو دودھ کی بجائے شہد ملائم گرم پانی دیں۔ ماں کے دودھ میں تبدیلی بہت کم واقع ہوتی ہے لیکن اگر ماں ایسی غذا کھائے کہ جس سے ریاح پیدا ہوں یا سگریٹ نوشی یا شراب نوشی کرے یا ماں کو قبض ہو اور مستقل رہے تو بچے کو وہ خالص غذا نہیں ملتی جو کہ اس کی ضرورت ہے اور اسے ماں کے دودھ سے ملنی چاہیے تھی یا اگر ماں ضرورت سے زیادہ انڈے، دودھ، ملائی، مکھن وغیرہ کھائے تو اس کے دودھ میں ضرورت سے زیادہ طاقت پیدا ہوگی اور غذائی توازن بگڑ جائے گا جس سے بچے کو تکلیف ہوگی۔ ماں کو چاہیے کہ عام صحت بخش سادہ غذا کھائے معمولی سادہ زندگی بسر کرے اپنے دانتوں اور معدہ کا خیال رکھے۔ کھانا نہایت مناسب مقدار میں کھائے اور پانی زیادہ پئے اس سے ماں کا دودھ بچے کو موافق آئے گا۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ دودھ کی قسم خراب نہیں ہوتی بلکہ مقدار شروع میں زیادہ ہوتی ہے یا کبھی کبھی کم۔ ولادت کے بعد یوٹرس اور اندرونی اعضاء کے درست ہونے تک ماں جو لیٹی رہتی ہے تو اس دوران دودھ زیادہ پیدا ہوتا ہے اور زیادہ مائیں ایسا کرتی ہیں کہ بچہ کو سارا دودھ پلا دیتی ہیں چونکہ بچے کا معدہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو دن بھر میں دو سوتا چار سو گرام تک ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچہ کو دن بھر میں چھ بار تین سے پانچ منٹ تک دودھ پلایا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بچہ اس مقدار سے کہیں زیادہ دودھ پی لیتا ہے جو اس کی ضرورت ہے اور اس طرح زیادہ مقدار میں بار بار دودھ پلانے سے عام تکالیف بچوں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض بچے دودھ پیتے ہی تھوڑا بہت دودھ اگل دیتے ہیں یا تھوڑی دیر بعد ہی کی شکل میں نکال دیتے ہیں یا بچے کو پاخانہ پتلا آنے لگتا ہے یا زیادہ پاخانہ بار بار آنے لگتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو زیادہ دودھ دے دیا گیا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلانے کے وقفے کو بڑھاتی جائے۔ اگر بچہ کمزور نہیں ہے تو بجائے تین گھنٹے کے بعد کے اسے چار گھنٹے کے بعد دودھ پلایا جائے۔



## بچہ کی نشوونما

### (DEVELOPMENT OF CHILD)

**تعارف (Introduction):** عموماً بچہ چھ ماہ بعد بیٹھنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح بچہ آٹھ ماہ میں ریٹکنا شروع کرتا ہے اور یوں بچہ دس ماہ میں کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے۔ ڈیڑھ سال میں بچہ چل پھر سکتا ہے اور بغیر سہارے بیٹھ سکتا ہے۔ بچے کی لمبائی پیدائش کے وقت چالیس سے پچاس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ ایک سال کے بعد بچے کے قد میں بیس سے تیس سینٹی میٹر تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ دو سال کی عمر سے پانچ سال کی عمر تک بچے کا قد ہر سال نو سینٹی میٹر تک بڑھتا رہتا ہے۔ پیدائش کے وقت عموماً ایک صحت مند بچے کا وزن ساڑھے تین کلو گرام تک ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت کا وزن چھ ماہ کی عمر میں دو گنا ہو جاتا ہے۔ ایک سال میں بچے کا وزن تین گنا تک بڑھ جاتا ہے۔



## بچہ کے لئے دودھ میں احتیاطیں

### (PRECAUTIONS FOR BABY IN LACTATION)

**تعارف (Introduction):** اکثر مشکل پیش آتی ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لئے ناکافی ہوتا ہے۔ اس کا اظہار کئی طرح ہوتا ہے مثلاً دودھ پلانے کے وقت مقررہ سے پہلے ہی بچہ نیند سے جاگ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کسی طرح چپ نہیں ہوتا یا بچے کو قبض ہو جاتا ہے۔ پاخانہ خشک یا نہایت ہی تھوڑا ہونے لگتا ہے اور بچہ کمزور ہونے لگتا ہے اور وزن یا تو کم ہو جاتا ہے یا بے حد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ ایسی صورتحال میں فکر و پریشانی سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ اگر ماں دودھ، پانی یا سیال چیزیں زیادہ مقدار میں پینے لگے، ہر دفعہ دودھ پلانے سے پہلے چھاتی کو نیم گرم پانی سے دھویا کرے اور مناسب مقدار میں ناریل اور ناریل کے پانی کا استعمال رکھے تو رفتہ رفتہ دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی طرح ماں کے دودھ کی مقدار نہ بڑھے تو گائے یا بکری کا دودھ پانی ملا کر پتلا کر کے بچے کو پلائیں۔ ڈاکٹر سے ایسی حالت میں مشورہ کی ضرورت ہے۔ علاج ہونے پر دوبارہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلائے۔ کبھی ایسا نہ کریں کہ فوراً مکمل طور پر اپنے بچے کا دودھ چھڑا کر اوپری دودھ پر ڈال دیں۔ وقتی طور پر علاج ہونے تک پانی ملا کر اوپری دودھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی بھوک پوری ہو جائے۔ ہر دفعہ دودھ پلاتے وقت سائیڈ بھی تبدیل کریں یعنی اگر صبح کو پہلے دہنی طرف سے پلایا تھا بعد میں بائیں طرف سے تو اب دوپہر کو پہلے بائیں طرف سے بعد میں دائیں طرف سے بچے کو دودھ پلایا جائے۔ ہر دفعہ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے دو تین قطرے دودھ دبا کر باہر نکال دینا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کو چھاتی دھو کر دودھ پلائیں۔ جسم سے چھوئے والا کپڑا پاک صاف ہونا چاہیے۔ دودھ پینے کے بعد بچے کو کمر پر تھکی دیں تاکہ ہضم ہونے میں آسانی ہو۔ دودھ پیتے ہی بچہ کو دودھ اُگلنے نہ دیں اور

نہی سونے دیں بلکہ بچے کو تھوڑی دیر بعد سلائیں۔ بچے کو نپل منہ میں دے کر ہرگز نہ سلائیں۔ بچے کو رات کو دودھ پینے کی عادت بھی نہ ڈالیں۔ دودھ پینے کے بعد ناول بچے کا پیٹ ذرا سا باہر کو نکلا ہوا ہونا چاہیے نہ کہ پہلوان کی طرح کسا ہوا یا اندر کو۔ دودھ پلانے والی ماں سیال چیزیں زیادہ استعمال کرے۔ مثلاً دودھ کا استعمال اعتدال سے کرنے سے ماں میں دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ماں کو بدل بدل کر خوراک کھانی چاہیے ایک ہی کھانے سے جی بھر جاتا ہے۔ بعض مائیں ترش چیزوں سے پرہیز کرتی ہیں حالانکہ ماں کو دوسروں کی طرح دنیا کی ہر چیز اعتدال سے استعمال کرنی چاہیے۔ صرف بہت زیادہ ترش یا تیز گرم یا زیادہ بادی ٹھنڈی تاثیر والی غذاؤں سے بچنا چاہیے تاکہ ننھے بچے پر ان کی تیزی کا اثر نہ ہو۔ اگر ماں کی بجائے آیا کا دودھ پلایا جائے تو اس بات کا خیال کر لینا چاہیے کہ آیا تندرست ہو۔ اس کے خاندان میں کسی کو مہلک امراض مثلاً ٹی بی وغیرہ نہ ہوئی ہو اور پھوڑے پھنسیاں بھی نہ ہوں۔ آیا کا اپنا بچہ اس بچے کی عمر کا ہو یا کچھ بڑا ہو۔ آیا اچھی ذات کی باعزت جوان خوبصورت عورت ہو۔ اسے سینے کی کسی قسم کی بیماری نہ ہو۔ ماں کے دودھ میں بچے کی عمر کے نو ماہ تک کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس زمانہ میں قدرتی طور پر بچے کو مقدار میں زیادتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کو خالص دودھ پر جلدی نہیں لانا چاہیے۔ نو ماہ کی عمر میں عموماً بچے کے اگلے چار دانت نکل آتے ہیں۔ اس وقت رفتہ رفتہ بچے کو خالص دودھ کی طرف لانا چاہیے۔



## اوپری دودھ

(NON-MOTHER'S MILK)

**تعارف (Introduction):** ایک سال کی عمر سے پہلے بچے کو اوپری دودھ پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ عام طور پر بچے سال یا سوا سال کی عمر تک خالص دودھ ہضم کرنے لگتے ہیں لیکن اگر بچے کے دانت ٹھیک نکل رہے ہیں اور اعضاء معمولاً مضبوط ہیں اور چہرے پر صحت کارنگ ہے تو خالص دودھ پر لانے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے کو نمٹے اور چھوڑے کے پانی پر رکھا جاتا ہے یا چاولوں کی کھیر دی جاتی ہے۔ یہ پانی بچے کی پوری غذا نہیں ہے اور یہ کھیر اس کے لئے کافی ثقیل اور دیر میں ہضم ہونے والی خوراک ہوتی ہے۔ دونوں سے نقصان کے علاوہ فائدے کی امید نہیں اور بچے کو محض چائے پر رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ چائے میں شامل اجزاء کی وجہ سے بچہ بیمار اور دبا ہوا جاتا ہے اور یہ بھی پوری غذا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مجبوری ہے کہ بچے کو اوپری غذا کی عادت ڈالی جائے۔ گائے کے دودھ میں پانی ملا کر مرغی کے تازہ انڈے کی سفیدی کچی ملا کر خوب پھینٹیں اور ایک چھوٹا چمچ چینی شامل کر کے پلائیں۔ اگر ولادت کے فوراً بعد ماں کا انتقال ہو جائے تو اس وقت تین دن کے بعد سے یہ آمیزہ پلا سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہفتہ بعد زردی کے کچھ قطرے شامل کر لیں اور سردی کے موسم میں مچھلی کے تیل کے پانچ قطرے بھی ملا لیں۔

چھ ماہ کی عمر کے بعد سردیوں میں گوشت کی بخنی کے دس قطرے بھی پلائیں۔ اگر بچے کو اوپری دودھ پر رکھنا لازم ہو تو چند باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دودھ کو نیم گرم حالت میں پلائیں۔ دوسرے یہ کہ برتن، بوتل اور دودھ کی صفائی کا بہت خیال رکھا جائے۔ کوشش کریں کہ دودھ ہر قسم کے جراثیم سے پاک حالت میں بچے تک پہنچے، یہ دودھ اگر فیڈر (بوتل) سے پلایا جائے تو اس کے نپل جلدی جلدی بدلتے رہیں۔ نپلز زیادہ پرانے نہ ہوں اور بچے کو ذرا مشقت سے دودھ ملے۔ جو چیزیں ماں کے دودھ میں بچے کی نشوونما کرتی ہیں وہ جہاں تک ممکن ہوں اس دودھ میں بھی بہم پہنچائی جائیں۔ گائے یا بکری کا دودھ سوائے ماں کے دودھ کے ہر دودھ سے اچھا ہے کیونکہ یہ قدرتی ہے اور باسانی و متیاب ہے اور سستا ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر گائے کے دودھ میں ٹی بی کے جراثیم ہو سکتے ہیں اس لئے بچے کے لئے تندرست موٹی تازی گائے کا دودھ حاصل کرنا چاہیے۔ گائے کے بچے کو سوکھے کا مرض نہ ہو ورنہ انسانی بچے کو بھی ہونے کا خطرہ ہے۔ گائے کا دودھ اکثر بکری کے دودھ سے بہتر غذا ہے۔ بکری کے دودھ میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے اور یہ دودھ میں مہلک جراثیم بھی پیدا کرتی ہے لیکن اگر بکری کی غذا کی طرف خاص توجہ ہو تو اس کا دودھ اچھا ہے۔ بھینس کا دودھ ثقیل اور دیر ہضم ہے۔ بھیڑ کا دودھ اچھا نہیں قابل ہضم بہت ہے اور بچے میں درد قولنج پیدا کرتا ہے۔ دودھ کو ایک نہیں دو جوش دیں۔ بہت تیز آگ کے مقابلے میں ہلکی آگ پر پکانا بہتر ہے۔ بعض چھوٹے بچے گائے کا خالص دودھ ہضم کر لیتے ہیں لیکن اس کی عادت ڈالنے کی کوشش شروع میں ہی کرنی چاہیے۔ بظاہر یہ دودھ با آسانی ہضم ہوتا ہے لیکن اس بات کا امکان ہے کہ کسی وقت گردوں اور معدہ پر زیادہ بوجھ پڑ جائے تو اس لئے جب گائے کا دودھ بچے کو دیں تو اس میں کچھ پانی ضرور ملا لیں۔ گائے کے دودھ میں چربی ماں کے دودھ کے برابر ہوتی ہے لیکن مٹھاس ماں کے دودھ سے کم ہوتی ہے اور نمک کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ پانی ملا دینے سے چربی اور خصوصاً مٹھاس بہت کم ہو جاتی ہے اس لئے اس کمی کو پوری کرنے کو ایک چھچھنی ملا دینی چاہیے۔ بچے کو ٹھنڈا دودھ نہ دیں اور ہمیشہ نیم گرم پانی ملا لیں۔ ذیل میں مختلف اقسام کے دودھ میں پانی کی مقدار بیان کی گئی ہے:

|   |                     |                         |
|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | انسانی دودھ میں -   | 84.4% پانی ہوا کرتا ہے۔ |
| 2 | گائے کے دودھ میں -  | 87.4% پانی ہوا کرتا ہے۔ |
| 3 | بکری کے دودھ میں -  | 85.2% پانی ہوا کرتا ہے۔ |
| 4 | بھینس کے دودھ میں - | 81.8% پانی ہوا کرتا ہے۔ |



## بچے کو فیڈر (بوٹل) سے دودھ پلانا

### (FEEDER'S MILK)

**تعارف (Introduction):** فیڈر سے دودھ پینے میں بچہ کو اوسطاً دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں لیکن بچہ آخر میں پیٹ بھر جانے اور تھک جانے اور دودھ پینے کی مشقت سے آہستہ آہستہ پینے لگتا ہے۔ اس وجہ سے دودھ پلانے کے لئے فیڈر کے نیل کا سوراخ درمیانہ ہو تو مناسب ہے۔ نئے فیڈر کو پہلے ہی ایک دفعہ پانی میں خوب ابالنے سے اس کی مضبوطی بڑھ جاتی ہے اور جراثیم سے بھی نجات ملتی ہے۔ ٹھنڈے پانی میں فیڈر ڈال کر چولہے پر رکھ دیں تاکہ بوتل اور پانی ساتھ ساتھ گرم ہوں۔ آگ پر سے پانی کو اتار کر ٹھنڈا ہونے تک بوتل کو پانی میں ہی رہنے دیں بلکہ دو فیڈر ہنگامی حالت کے لئے رکھیں۔ دودھ پلانے کے بعد فیڈر کو ہمیشہ ٹھنڈے پانی میں ڈالے رکھنا چاہیے اس طرح بوتل گردوغبار سے بچی رہتی ہے اور کبھی وغیرہ بھی بیٹھنے پاتی۔ کبھی بچہ فیڈر سے منہ نہ لگائے تو اس کے نیل پر شہد لگائیں۔ بوتل ہمیشہ برش سے دھوئیں۔ ہر بار پہلے برش دھوئیں پھر بوتل گرم پانی سے دھوئیں۔ دن میں یا ہفتہ بھر میں ایک بار پوٹاشیم پرمینگنیٹ سے بوتل دھوئیں۔ یہ وہی دوا ہے جو پانی کے کنویں کی صفائی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ بوتل دھونے کے لئے نہایت تھوڑی مقدار میں دوا ڈالیں جس سے پانی کا رنگ ہلکا اودا ہو جائے۔ زیادہ دوا نہ ڈالیں ورنہ دوا بوتل میں لگی رہنے سے نقصان دے گی۔ اس دوا کے دھونے سے فیڈر کے کنارے میں جو جراثیم لگے رہ جاتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بچے کو دوست یا چپیش ہو جاتی ہو تو وہ اس طرح سے صفائی کر لینے سے آئندہ نہ ہوگی۔ اوپری دودھ ہمیشہ ناپ سے دیں۔ اس سے کوئی دقت نہیں ہوگی اور یہ صحیح اندازہ رہے گا کہ بچے نے صحیح مقدار میں دودھ پیا ہے یا نہیں اور بچے کی خوراک بڑھ رہی ہے یا نہیں۔ گائے کے دودھ کو جلدی سے ابال لیں اور جس قدر جلدی ممکن ہو ٹھنڈا کر لیں۔ زیادہ دیر تک آگ پر رکھے رہنے سے یا بار بار ابلتے رہنے سے دودھ کے کئی اجزاء جل جاتے ہیں۔ دودھ کو ہمیشہ ایک یا دو جوش سے زیادہ نہ پکائیں۔ بچے کو ہمیشہ دودھ ایک سا گرم دینا چاہیے۔ بوتل بھرنے کے بعد ہاتھ لگا کر چیک کر لیں کہ مناسب گرم ہے یا نہیں۔ اگر بچہ دودھ بہت دیر میں پیتا ہے اور دودھ پیتے پیتے ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب بھی دودھ پلانے کے دوران ایک دفعہ گرم پانی میں بوتل رکھ کر گرم کر لیں۔ بچے کو دودھ کے علاوہ رونے سے چپ کرانے کے لئے ہر وقت نیل کا استعمال اچھی عادت نہیں ہے۔ ہر وقت نیل منہ میں دیئے رہنے سے دانتوں کی شکل خراب ہو جاتی ہے۔ بچہ کو صرف مقررہ وقت میں دودھ دینا چاہیے۔ جب بچہ روئے تو اسے چپ کرانے کے لئے وقت بے وقت دودھ پلانے سے بچے کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور خصوصاً ماں کو ہر وقت دودھ تیار رکھنا پڑتا ہے اور اس طرح ماں دن رات دودھ پلانے میں لگی رہتی ہے۔ اگر دودھ وقت مقررہ پر پینے کی عادت ہو تو وہ بچہ چار گھنٹہ بعد ہی دودھ مانگے گا۔ رات کو دس بجے سے صبح چھ بجے کے درمیان بھی دودھ نہیں مانگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دودھ کے وقت کے علاوہ وہ رو رہا ہے تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو کوئی تکلیف ہے جس سے وہ رو رہا ہے مثلاً ہاضمہ کی خرابی سے اسکے پیٹ میں گیس اور درد ہو سکتا ہے اور اگر ماں یہ سمجھ کر کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے اس کو دودھ پلا دیتی ہے تو اس سے پیٹ کی گیس اور خرابی بڑھ جاتی ہے۔



## دودھ بوتل کی صفائی

### (CLEANLINESS OF FEEDER)

**تعارف (Introduction):** دودھ کی بوتل کی صفائی بے حد ضروری ہے۔ گندے فیڈر سے چھوت کی بیماریاں، دست یا پچیش یا الٹی ہو سکتی ہے۔ دودھ پلانے کے فوراً بعد فیڈر کو دھو لینا چاہیے۔ نپل اور فیڈر کو اندر سے برش اور صابن کے ذریعے اچھی طرح سے صاف کریں۔ بوتل اور نپل کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور اچھی طرح دھو کر ڈھانپ کر رکھیں۔ ہمیشہ اپنے ساتھ دو بوتلیں رکھیں تاکہ ایک خراب ہو جائے یا صاف کرنے میں دیر لگے تو دوسری صاف شدہ بوتل میں دودھ پلا سکیں۔ ابلا ہوا پانی یا جوس چھان کر بوتل کے ذریعے بھی دیا جاسکتا ہے۔ دودھ پلانے کے بعد اگر بچہ روئے تو سمجھ جائیں کہ یا تو وہ بھوکا رہ گیا یا ہو سکتا ہے کہ دودھ کے ساتھ اس کے پیٹ میں ہوا بھی داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے۔ اس کو آرام دینے کے لئے اسے گود میں لیجئے۔ پھر آہستہ آہستہ پیچھے سے کمر سہلائیں تاکہ اسے ڈکار آجائے۔ بچے کو دودھ ہضم کرنے میں مدد دینے کے لئے کسی قسم کے بازاری وائر کی عادت نہ ڈالیں اس لئے کہ وہ بعد میں اس کا عادی ہو جائے گا اور پھر اس کے بغیر دودھ ہضم نہ کر سکے گا۔ بچے اگر نارمل دودھ پینے آرام سے ہضم کریں تو انہیں سونف یا سونف کا پانی دینے کی ضرورت نہیں۔

بچے نارمل کھانا کھائیں یا اپنی نارمل غذا پوری کھاتے ہیں تو انہیں مصنوعی دوائیں یا نام نہاد طاقت کی دوائیں سیرپ کا عادی نہ بنائیں۔ بچے کو بہت زیادہ چینی کی عادت نہ ڈالیں زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز رکھیں۔ ثانی، جام، مصنوعی جوس کی عادت نہ ڈالیں۔ گیہوں کا دلیہ نمکین یا میٹھا کھلائیں یا بڑا ہونے پر پراٹھا یا روٹی زیادہ کھلائیں۔ اس کی خوراک سادہ ہونی چاہیے۔ چاول یا آلو بہت زیادہ مقدار میں کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہیں۔ بچے کو کوئی چیز زبردستی نہ دیں اگر وہ کھانا نہ چاہے تو زور مت دیں لیکن نقصان دہ چیزوں سے ضرور اسے بچائیں۔



## بچہ کا دودھ چھڑانا

### (FEEDER RESTRICTION)

**تعارف (Introduction):** بچے کا فیڈر سے دودھ پینا نو ماہ سے ایک سال عمر تک چھڑا دینا سب سے اچھا عمل ہے۔ دودھ چھڑانے کا وقت بچے کی زندگی میں نہایت نازک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت تک بچے کو ماں کا دودھ یا اوپری دودھ صحیح ٹائم پر بڑے آرام سے ملتے رہنے کی عادت رہی ہے لیکن اب نہ صرف دودھ چھڑانے پر اس کو ایک نئی غذا کا عادی بننا پڑتا ہے بلکہ وہ ماں کی شفقت، پیار اور اپنائیت کسی بھی ایک قسم کی کمی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ماں بچے کو اپنا دودھ پلاتے وقت عموماً بہت پیار کرتی ہے۔ بچہ اس تبدیلی کو ہرگز پسند نہیں کرے گا یا کم از کم اسے احساس تو ہوگا جب تک اس کو اس کی عادت نہ ہو جائے۔ بہت سے بچے اس وقت تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر دودھ صحیح طریقے سے چھڑایا جائے تو عموماً یہ

تکالیف نہیں ہوتیں۔ پہلی بات یہ کہ دودھ چھڑانے سے پہلے بچے کو رفتہ رفتہ پیالی سے دودھ پینا سکھانا چاہیے۔ اگر بیٹھے سگترے کا عرق ہفتہ دو ہفتہ میں پیالی سے پہلے سے پلایا جا رہا ہو تو نئے ذائقے کی وجہ سے بہت سے بچے جلدی پیالی سے پینا سکھ جاتے ہیں۔ جب بچہ شوق سے خود بغیر گرائے پیالی سے دودھ پینے لگے تو اس وقت فیڈر سے دودھ پینا چھڑا دینا چاہیے۔

بعض مائیں اپنا دودھ چھڑاتے وقت بوتل کی عادت شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد پیالی سے پینا سکھاتی ہیں حالانکہ فوراً بعد اپنا دودھ چھڑاتے ہی پیالی سے پلانا شروع کر دینا چاہیے۔ فیڈر سے دودھ چھڑانے کا وقت نو ماہ کی عمر کا ہے۔ اس وقت سے تھوڑی سی روٹی، بسکٹ، توس اور ٹھوس چیزیں دینا شروع کر دیں۔ جب بچے کے دانت نکل رہے ہوں یا کوئی اور تکلیف ہوگئی ہو تو اس وقت اس کا دودھ نہیں چھڑانا چاہیے بلکہ بہت بہتر ہے کہ جب تک وہ مکمل ٹھیک نہ ہو جائے دودھ نہ چھڑایا جائے۔ دودھ چھڑانے میں جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ چھ سات دن میں محض اوپری دودھ پر ڈال دینا اچھا نہیں۔ کسی بھی عادت کا ایک دم چھڑانا ٹھیک نہیں۔ بچے کو دودھ چھڑانے میں کم از کم ایک ماہ لگانا چاہیے۔ رفتہ رفتہ بچے کو اس نئی غذا کی عادت ہو جائے گی۔ اس طرح ماں کو بھی آرام ہو جائے گا۔ اگر ماں کا دودھ ایک دم چھڑا دیا جائے اور تھوڑا بہت روزانہ نکالا جائے تو چھاتی میں گانٹھیں سی پڑ جاتی ہیں اور وہ پک جاتی ہیں جو بڑی تکلیف دیتی ہیں اور دیر میں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں ماں کو سیال چیزیں کم پینی چاہئیں۔ دودھ ہمیشہ تازہ استعمال کریں۔ کافی دیر کا رکھا ہوا دودھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کو ابال کر ٹھنڈا کر کے ناپ کر دیں۔ بلاناغہ بچے کے تمام برتنوں کو ابال لیا جائے تو بہتر ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مچھلی کا تیل بھی دودھ میں ملا کر دیں۔ آٹھ ماہ کی عمر سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا دیں تاکہ وہ اسے چبائے اور جڑوں کی ورزش ہو جائے لیکن خیال رکھیں کہ بڑے ٹکڑے نہ نکل لے۔ جب دودھ سے ٹھوس غذا پر لانے کا وقت آئے تو نئی چیز ایک وقت میں دیں مثلاً جو یا گیہوں کا دلیہ، دودھ اور پانی میں پکائی ہوئی فیرنی، روٹی، شوربہ، سبزیاں، کچے ٹماٹر اور پھل وغیرہ شروع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کے دودھ میں معمول کی مقدار کم کرتی رہیں لیکن جب بچہ تین بڑے چچے تک نئی ٹھوس غذا کھانے لگے اور ہضم کرنے لگے تو دودھ میں کمی کر دینی چاہیے۔ جب تک بچے کے کم از کم آٹھ دانت نہ نکلیں بچے کو ماں ہی کے دودھ پر رکھنا چاہیے اور اس کے بعد دودھ چھڑا دینا چاہیے۔ دوسرے سال کے شروع ہونے کے بعد بہت سے بچے چار دفعہ کھانے پر ہی صحت مندر ہتے ہیں لیکن موسم سرما میں انڈے، مکھن، دودھ وغیرہ کافی دینا چاہیے۔ اگر سگترے دیں تو سگترے زیادہ ترش نہ ہوں ورنہ کھانسی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دودھ کے چھڑانے کے بعد بچے کے کھانے کے اوقات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح اسے بھی اور ماں کو بھی آرام رہے گا۔ کھانا ایسا دیں کہ اسے زیادہ چبانے پڑے مثلاً گوشت، سبزی، ٹماٹر وغیرہ کے شوربے میں بھگو کر دیں یا دلیہ پکا کر اس میں دودھ اور میٹھا ملا کر یا شوربہ ملا کر نمکین کر دیں۔ بازاروں میں ڈبوں میں بند دلیہ بھی ملتا ہے جو بہت جلدی پک جاتا ہے۔ یہ دلیہ بچوں کے لئے خصوصاً مفید ہے۔ ایسی غذائیں اور ان کے علاوہ بسکٹ یا ڈبل روٹی کے ٹکڑے دیئے جائیں تاکہ جڑوں کی ورزش ہو اور دانت نکلنے میں آسانی ہو۔ گلاس سے دودھ پلاتے وقت ایک پیالی دودھ میں ایک چمچ چینی ڈالیں۔



## بچہ کی نیند

### (CHILD'S SLEEP)

**تعارف (Introduction):** بچے کی نشوونما کے لئے نیند بے حد ضروری ہے۔ جو بچے کم سوتے ہیں وہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ ایسے بچے ہر وقت ست رہتے ہیں یا روتے رہتے ہیں حالانکہ ان کی بھوک ٹھیک ہوتی ہے اور غذا بھی صحیح ہوتی ہے اور ایک مقررہ وقت پر دی جاتی ہے۔ انہیں قبض اور بدہضمی کی شکایت بھی نہیں ہوتی جو بچہ زیادہ سوتا ہے وہ زیادہ تندرست اور موٹا ہوتا ہے۔ نیند کی کمی کی کئی وجوہات ہیں مثلاً بستر آرام دہ نہیں یا اس کو غذا صحیح نہیں دی جا رہی ہے یا زیادہ غذا دی جاتی ہے یا کم غذا دی جاتی ہے یا اسے شروع سے یہ عادت ڈال دی گئی ہے کہ جہاں وہ سوتا ہو وہاں ذرا بھی شور وغل نہ ہو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ذرا شور وغل ہو اور بچے کی آنکھ کھل گئی۔ ایک بچے کی موجودگی میں تو یہ پابندی ہو سکتی ہے کہ شور نہ ہو حالانکہ ایک بچے کی گھر میں موجودگی کے یہ معنی نہیں کہ گھر میں سب احتیاط سے چلیں، منہ سے آواز نہ نکالیں یا کوئی شور والا کام نہ کر سکیں۔ اس کا خیال شروع ہی سے رکھنا چاہیے کہ بچے کو ایسی عادت ڈالی جائے کہ وہ معمولی شور وغل اور مطلق خاموشی میں یکساں سوتا رہے۔ اس عادت سے ماں اور بچے دونوں کو آرام ملے گا مثلاً ریل کا سفر ہے تب بھی آسانی سے سولے گا ورنہ نیند نہ آنے کی وجہ سے بچہ ماں کو تنگ کرے گا۔ ماں کے لئے بچے کو سنانے کے لئے ٹہلانی کی عادت بھی بُری ہے۔ اگر شروع ہی سے اسے یہ عادت پڑ گئی تو وہ دو تین سال کی عمر تک پریشان کرے گا۔ یہ عادت مشکل ہی سے جائیگی۔ اگر شروع ہی سے اسے یہ عادت ڈالیں کہ وقت پر بستر پر لیٹے لیٹے خود سو جایا کرے تو وہ خود اپنے وقت پر ہمیشہ سو جایا کریگا۔ پیدائش کے فوراً بعد سے نہ صرف سنانے کے لئے بلکہ ویسے ہی بچہ سے کھیلنے کیلئے جاگتے ہیں جہاں تک ہو سکے بالکل گود میں نہ لیا جائے۔ بغیر گود میں لئے اس سے پیار کی بات کریں اسے پیار کریں لیکن گود کی عادت نہ ڈالیں۔ دو تین سال کی عمر کے بچوں کے اوقات کھانا کھانے کے ایسے مقرر کریں کہ انہیں نیند کے وقت سے ایک یا دو گھنٹہ پہلے مل جائے تاکہ وہ ذرا چل پھر کر کھانا ہضم کر لیں اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کریں ورنہ قبض یا بدہضمی ہو جائے گی یا رات کو بچہ سوتے میں چونکنے لگے گا۔ رات کو سوتے وقت کا دودھ بعض بڑے بچوں کو ہضم ہوتا ہے اور بعض کو نہیں۔ رات کو دیر میں سونے یا بے چینی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کو بچہ وقت پر نہیں اٹھتا ہے۔ کبھی سات بجے کبھی آٹھ بجے اس کی وجہ سے صبح کے ناشتے کا وقت مقرر نہیں ہو سکتا۔ بچے کا وقت ایسا مقرر کریں کہ وہ رات سات بجے ہی سو جایا کرے اور صبح کو رات بھر پوری نیند کے وقت پر جاگے۔ تین سال کے بچے کو کبھی دن بھر میں تھوڑی دیر کے لئے ضرور سونا چاہیے۔ اگر بچہ آیا کے حوالے ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آیا اپنے آرام کی وجہ سے کہیں بچے کو آپ سے چھپا کر ایون تو نہیں دے رہی۔ اس طرح وہ بچے کے دماغ اور اعصاب کو خراب کر دے گی۔

اگر بچے کی نیند غیر معمولی ہو یا جاگنے کے بعد بھی فوراً پھر سو جائے یا بہت دیر تک سوتا رہے یا سوتے میں بے قاعدہ سانس لے یا آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جائیں چہرے کا رنگ پیلا پڑ جائے ہضم میں خلل ہو یا پاخانہ خشک آتا ہو یا بھوک کم ہو یا بچہ نڈھال ہوتا جائے تو ممکن ہے بچے کو ایون دی جا رہی ہے۔ ایون بچے کے دل و دماغ کیلئے مضر ہے اور اکثر سوکھے کا مرض پیدا کرتی ہے۔ اگر ایون کی عادت پڑ جائے تو اگر کسی وجہ سے نڈھال سکے تو بچے کو نیند نہیں آتی اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔

یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بچے کو سوتے سے جگایا جائے۔ دوا کھلانے کے لئے یا کسی اور بات کے لئے کچی نیند میں جاگا ہوا بچہ دیر تک روتا رہتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر دودھ کا وقت آ گیا ہے اور بچہ سو رہا ہے تو تھوڑی دیر ٹھہر جانا بہتر ہے۔ بعض مائیں یہ خیال کر لیتی ہیں کہ چونکہ بچے کے باپ دادا بھی کم سوتے ہیں یا دیر میں سوتے ہیں اس لئے یہ خاندانی بات ہے کہ بچہ بھی کم سوتا ہے حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ بچے کو ہمیشہ ایک پرسکون نیند سونا چاہیے ورنہ بچہ جلد بیمار ہو جائے گا یا کمزور ہو جائے گا۔



## بچہ کے پہلے دانت نکلنا

(DENTITION)

**تعارف (Introduction):** بچے کی عام صحت کی طرح اس کے دانتوں کی مضبوطی بھی ماں کی صحت ہی پر منحصر ہے۔ خصوصاً ایام حمل کی صحت پر۔ اگر ماں کی صحت دوران حمل ٹھیک رہی ہے تو یقیناً بچے کے دانت بھی اچھے ہوں گے اور آسانی سے نکل آئیں گے۔ عموماً ان بچوں کے دانت جلدی نکل آتے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں کیونکہ ان کے جبروں کی صحیح ورزش ہوتی رہتی ہے۔ اگر بوتل سے دودھ پلاتے وقت ماں بوتل کو باہر کھینچتی رہے جبکہ بچہ بوتل سے دودھ پی رہا ہو تو بھی بچے کے دانت اچھے اور آسانی سے نکلتے ہیں اور جبروں کی بھی ہلکی سی ورزش ہو جاتی ہے۔ بچوں کے دانت نکلنے کی تفصیل درج ذیل ہے۔

| بچے کی عمر           | دانتوں کی ترتیب                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 6-7 ماہ کی عمر میں   | نیچے کے، نیچے کے دانت                        |
| 8-9 ماہ کی عمر میں   | اوپر کے چار دانت                             |
| 10-11 ماہ کی عمر میں | اوپر نیچے کے چار کونپلیاں یا داڑھیں          |
| 14 ماہ کی عمر میں    | اوپر نیچے کی چار پیچھے کی کونپلیاں یا داڑھیں |
| 16 ماہ کی عمر میں    | اوپر نیچے کی چار کونپلیاں یا داڑھیں          |

نیچے کے دانت مسوڑھوں کے اندر پیٹ ہی میں پیدا ہو جاتے ہیں اور پیدائش کے بعد دانتوں کے کونے (جڑیں) باہر نکل آنے میں کوئی خاص دقت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض بچوں کو دانت نکلنے میں تھوڑی اور بعض کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔



## بچہ کی غذائی ضرورت

### (CHILD'S FOOD NEED)

**تعارف (Introduction):** چھوٹے بچے کو 100 سے 110 حرارے یا کلوریز فی کلوگرام وزن کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر بچے کا وزن پانچ کلوگرام ہے تو اسے 550 حرارے کی ضرورت ہوگی اور اگر بچے کا وزن دس کلوگرام ہے تو اسے 1100 حرارے کی ضرورت ہوگی۔ پیدائش سے لے کر چار سال کی عمر تک ایسی ہی خوراک کی ضرورت ہوگی لیکن بڑا ہونے پر یہ ضرورت کم ہوتی جائے گی۔

☆..... چار سے بارہ سال تک کی عمر کے بچے کو 80 حرارے فی کلوگرام (وزن کے حساب سے) ضرورت ہوتی ہے۔

☆..... بارہ سے چودہ سال تک کے بچوں کو 50 حرارے فی کلوگرام (وزن کے حساب سے) ضرورت ہوتی ہے۔

☆..... چودہ سال کی عمر سے اور آئندہ تک کے بچوں کو پچیس حرارے فی کلوگرام (وزن کے حساب سے) ضرورت ہوتی ہے۔

☆..... یعنی اگر چودہ سال کی عمر کے بعد بچے کا وزن پچاس کلوگرام ہے تو اسے 1250 کلوریز کی ضرورت ہوگی۔



## بچہ کی دیکھ بھال میں احتیاطیں

### (CHILD'S CARE)

**تعارف (Introduction):** نوزائیدہ بچے کو پہلے چند دن گھرے ہرے یا کالے رنگ کے پاخانے آتے ہیں۔ آپ اسے کوئی بیماری نہ سمجھیں یہ قدرتی ہیں۔ چند روز میں نارمل ہو جائیں گے۔ نوزائیدہ بچے کو کبھی کیسٹر آئل یا کوئی اور جلاب آورد واندیں۔ ماں کو چاہیے کہ کم از کم شروع کے نو ماہ بچے کو اپنا ہی دودھ پلائے۔ چاہے ایک مرتبہ صرف دو اونس دودھ ہی میسر ہوتا ہو۔ ممکن ہے بعد میں یہ مقدار زیادہ ہو جائے۔ ماں کو اپنی خوراک پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ماں کو دودھ زیادہ آئے۔ جہاں تک ہو سکے بوتل سے دودھ پلانے کی عادت نہ ڈالیں۔ بچے کو بار بار دودھ نہ پلائیں۔ وقت مقرر پر ہی دودھ دیں۔ چونکہ گھنٹے میں پانچ یا چھ بار دودھ پلانا کافی ہے۔ رات کے دس بجے سے صبح کے چھ بجے تک دودھ کی عادت نہ ڈالیں۔ رات کو دودھ نہ دیں۔ سونے سے پہلے دیں۔ دودھ پوری رات اطمینان سے ہضم ہونے دیں۔ ماں کا دودھ بچے کے لئے ایک بہترین غذا ہے۔ بچے کو صرف اس وجہ سے کہ ماں کا دودھ دیکھنے میں پتلا اور بغیر غذائیت کا لگتا ہے، اوپری دودھ شروع نہ کریں۔ ماں کا دودھ بہترین متوازن غذا ہے۔ بچے کو کبھی ایک دم فل کریم دودھ شروع نہ کریں بلکہ آہستہ آہستہ دودھ میں پانی کی مقدار کم کر کے عادت ڈالیں۔ بچے کو وقت پر اجابت کی عادت ڈالیں۔ ہر روز صبح دس بجے تک بچے کو ایک دفعہ اجابت ضرور کر لینی چاہیے۔ بچے کا وزن ہر ماہ چیک کیا کریں تاکہ اس کی پرورش کا اندازہ ہو سکے۔

بچے کے لئے سفر میں یا کسی اور موقع پر دودھ کو ہر وقت گرم کر کے نہ رکھا کریں کیونکہ گرم دودھ جو کہ تھرماس میں رکھا جاتا ہے اگر اس کا ٹیمپچر بالکل وہی رہے تو ٹھیک ہے ورنہ عموماً ٹھنڈا کر کے دینے سے صحیح نہیں رہتا۔ کبھی بازاری پیسٹ غذا، شربت یا پاؤڈر استعمال نہ کریں۔ کافی عرصہ سے پیک کیا ہوا دودھ بچے کے لئے مناسب نہیں ہوتا۔ بچے کو تازہ جوس اور غذا دیں۔ باسی چیز ہرگز کھانے یا پینے کو نہ دیں۔ کبھی بچے کو بہت زیادہ لپیٹ کر اوڑھ کر رکھنے کی عادت نہ ڈالیں اس طرح بچے کو اگر باہر لے جائیں گے تو بچہ کو ایک دم سردی لگ جاتی ہے۔ بچے کو مناسب کپڑوں میں تازہ ہوا اور کمرہ میں رکھیں۔ کبھی بھی بچے کے منہ کو نہ ڈھکیں۔ یہاں تک کہ بچہ کا منہ جالی سے بھی نہ ڈھکیں۔ بچے کو سلانے کے لئے کبھی گود میں لے کر نہ ٹھیلیں۔ اس طرح اُسے روزانہ ٹھیلانے کی عادت پڑ سکتی ہے۔ بچے کے رونے کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں ممکن ہے بچہ کو پیاس لگ رہی ہو۔ بچے کو رونے پر فوراً دودھ، جوس، بسکٹ نہ دیں سوائے اس کے کھانے کے وقت کے۔ بچے کے کمرے میں تیز لائٹ نہ رکھیں اس کی آنکھوں کو نقصان ہو گا۔ بچے کو اکثر نیم گرم پانی سے ٹھیلیں اور سارے بدن پر کسی بے ضرر تیل یا لوشن سے ماسح کر کے ہلکی پھلکی ورزش کروائیں۔ اس ضمن میں سرسوں یا زیتون کا تیل مفید رہتا ہے۔



## بچوں کے لئے احتیاطیں

### (PRECAUTIONS FOR CHILD)

**تعارف (Introduction):** نوزائیدہ بچے کی پرورش میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدائش کے دن سے دو سال تک کا عرصہ بچے کے لئے بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا اور اپنی تکلیف یا ضرورت بیان نہیں کر سکتا۔ ماں کو بچے کی ہر وقت دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ بچہ اس عرصے کے دوران اپنے آپ کو ماحول میں ہم آہنگ کرنے کے ادوار میں ہوتا ہے۔ اس دوران وہ عام شکایتوں کا شکار ہو سکتا ہے۔

ایک ماں کی حیثیت سے بچے کی ضرورت یا تکلیف کو حل کرنا آپ کا فرض ہے۔ ماں کو ایسے وقت میں کبھی غیر ضروری طور پر پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسی چھوٹی موٹی شکایات کے لئے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے۔ رات کو دو ایک بار اٹھ کر ضرور دیکھیں کہ آپ کا بچہ اچھی طرح سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ اگر منہ کھلا ہے تو اسے بند کر دیں۔ ماں کا دودھ پینے والے بچہ کو بدضمی کی شکایت عموماً کم ہوتی ہے۔ ممکن ہے کبھی تھوڑا سا دودھ اگل دے یا اگر اسے الٹی ہو جائے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ بچے کو چوہے یا آگ کے نزدیک بالکل نہ جانے دیں۔ کچن کو بند رکھیں اور غسل خانے میں بھی اکیلا نہ رہنے دیں۔ غسل سے پہلے سب چیزیں تیار کر کے رکھیں تاکہ بار بار نہ اٹھنا پڑے۔ بچہ غلطی سے گرم پانی کا ٹل نہ کھول لے۔

ہاتھ نہ جلا لے یا صابن سے پھسل نہ جائے۔ بچے کو کوڑے دان سے دور رکھیں ورنہ اس میں ہاتھ ڈال دے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گندی چیزیں منہ میں لے جائے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر پانچ سال کی عمر تک خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقریباً ہر وقت بچے کے ساتھ ایک بڑے آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ ہر وقت خیال رکھیں کہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے۔ مشین میں سلائی کا کام یا کپڑے دھونے کا کام اس وقت کریں جب بچہ سو رہا ہو۔ تین سے پانچ سال کی عمر میں بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اسے سلام کرنا، شکریہ ادا کرنا، خدا حافظ کہنا اور قرآن پڑھانا شروع کر دیں تاکہ وہ بنیادی طور پر ہی اچھی عادات سیکھے۔ بچے کے سامنے غصہ نہ کریں اگر بچہ غلطی کرے تو اسے سمجھا دیں۔ اگر گھریا خاندان میں کوئی حادثہ ہو جائے مثلاً کوئی میت ہو گئی ہے تو بچہ کو پہلے بتائیں تاکہ وہ ذہنی طور پر تبدیلی کے لئے تیار رہے اور پریشان نہ ہو۔ گھر میں مہمان داری ہو یا گھر میں کوئی بچہ ہونے والا ہو تو بچے کو بتادیں کہ آپ کا بھائی آنے والا ہے۔ امی ہسپتال جائیں گی وہاں سے ننھے کو ساتھ لائیں گی ورنہ بچہ ماں کی علیحدگی کو محسوس کرے گا۔ اسے آنے والے بچے کے بارے میں بتا کر ذہنی طور پر تیار کر دیں تاکہ وہ اسے پیار کرے اور اس سے حسد نہ کرے۔ چچک، خسرہ، کالی کھانسی کے بیماروں سے بچوں کو دور رکھیں۔ یہ بیماریاں انہیں لگ سکتی ہیں۔ بچے کو متعدد دی بیماریوں کی ویکسین وقت پر لگوائیں۔



## بچوں میں چھوت کی بیماریاں

(INFECTIOUS DISEASES IN CHILDREN)

| مرض         | بچہ کو بیماری لگنے اور ظاہر ہونے کا درمیانی عرصہ | بیماری کی مدت                            |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| چچک         | 14 سے 20 دن                                      | جب تک سارے دانے صاف ہو کر نہ گریں        |
| خناق        | 2 سے 6 دن                                        | کم از کم چار ہفتے                        |
| خسرہ        | 7 سے 21 دن                                       | نشان ظاہر ہونے کے دو ہفتے بعد تک         |
| جرمن خسرہ   | 14 سے 21 دن                                      | نشان ظاہر ہونے کے عموماً ایک ہفتہ بعد تک |
| کنپیز       | 12 سے 26 دن                                      | چند دنوں سے لے کر چار ہفتوں تک           |
| لال بخار    | 1 سے 16 دن                                       | دو سے چار ہفتے تک                        |
| کالی کھانسی | 5 سے 14 دن                                       | عموماً شروع ہونے کے پانچ ہفتے بعد تک     |



## مات اور بچوں کے لئے ٹیکے

### (VACCINATIONS FOR MOTHER & CHILD)

حاملہ کو دوران حمل کھالی کھانسی، پولیو، ٹی بی، خناق کے انجکشن لگوانے چاہئیں جبکہ T.T یعنی ٹینٹس ٹاکسائڈ کے دو انجکشن لگنے چاہئیں۔

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| بچے کو پیدائش کے بعد                             | B.C.G یعنی ٹپ دق سے بچاؤ کے ٹیکے۔ |
| بچے کو دو ماہ کی عمر میں                         | D.P.T اور پولیو ڈرائپس۔           |
| کالی کھانسی، خناق، تشنج اور پولیو سے بچاؤ کے لئے | D.P.T.II اور پولیو ڈرائپس II      |
| بچے کو تین اور چار ماہ کی عمر میں                | D.P.T.III اور پولیو ڈرائپس III    |
| بچے کو نو ماہ کی عمر میں                         | خسرہ سے بچاؤ کے لئے انجکشن۔       |

کسی بھی قریبی ہسپتال سے یا سرکاری ڈسپنسری سے مفت میں یہ ٹیکے، ڈرائپس اور انجکشن لگوائے جاسکتے ہیں۔



عثمانیہ نیاپتہ سلی میڈیشر

یونٹ: 20

## نومولود بچہ کی پیچیدگیاں

(COMPLICATIONS OF NEWBORN)

### (اسفکسیا نیونٹورم)

(ASPHYXIA NEONATORUM)

**تعارف (Introduction):** یوٹرس کے اندر بچہ سانس نہیں لیتا، لیکن اگر لیبر کے دوران آکسیجن کی سپلائی کم ہو اور یہ کمی جاری رہے تو بچے میں ڈسٹریس (Distress) کی علامات واضح ہو جاتی ہیں اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے اسفکسیا نیونٹورم نامی مرض لاحق ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آکسیجن کی کمی بہت شدید ہو یا زیادہ دیر تک رہے تو ایسی صورت میں بچہ مردہ پیدا ہو سکتا ہے یا پھر اسکی جلد موت واقع ہو جاتی ہے۔

**اسفکسیا نیونٹورم (Asphyxia Neonatorum):** اگر بچہ مکمل پیدائش کے بعد خود بخود سانس لینا شروع نہ کر سکے تو اسے اسفکسیا نیونٹورم (Asphyxia Neonatorum) کہتے ہیں۔

**اسفکسیا کی وجوہات (Causes Of Asphyxia):** اسفکسیا کی عام وجوہات درج ذیل ہیں:

**(الف)۔ ماں میں وجوہات (Maternal Causes):** اسفکسیا کی ماں میں ممکنہ وجوہات درج ذیل ہیں:

|                                 |                           |        |
|---------------------------------|---------------------------|--------|
| (Toxaemia Of Pregnancy)         | ٹاکسمیا آف پریگننسی۔      | ☆..... |
| (Severe Anaemia)                | خون کی شدید کمی۔          | ☆..... |
| (Cardiovascular Diseases)       | کارڈیو واسکولر ڈیزیزز۔    | ☆..... |
| (Abnormal Uterine Contractions) | یوٹرس کی غیر نارمل حرکات۔ | ☆..... |
| (Rh-Incompatibility)            | آر، ایچ این کمپٹی بلیٹی۔  | ☆..... |

(ب)۔ بچے میں وجوہات (Foetal Causes): بچے میں اسفلیا کی عام وجوہات درج ذیل ہیں؛

1۔ ڈیلیوری سے پہلے خون میں آکسیجن کی کمی درج ذیل وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے؛

|                                         |                                                     |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| (Respiratory Obstruction Due To Mucous) | تنفسی نالیوں کا مکونیم یا میوکس کی وجہ سے بند ہونا۔ | ☆..... |
| (Respiratory Center Damage)             | سانس کنٹرول کرنیوالے سینٹر کو نقصان پہنچنا۔         | ☆..... |
| (Prolapsed Cord)                        | کارڈ پروفلس۔                                        | ☆..... |
| (Placental Lesion)                      | پلے سینٹا کا زخمی ہو جانا۔                          | ☆..... |
| (Prolonged Labour)                      | لیبر کا طویل ہو جانا۔                               | ☆..... |

2۔ سانس کنٹرول کرنے والے سینٹر کا ادویات کے استعمال کی وجہ سے کام چھوڑ دینا۔ ان ادویات میں درج ذیل ہیں؛

|             |              |        |
|-------------|--------------|--------|
| (Morphine)  | مارفین۔      | ☆..... |
| (Pethidine) | پیتھیدی ڈین۔ | ☆..... |

یہ ادویات اس وقت عمل تنفس کے مرکز کو نقصان پہنچاتی ہیں جب انہیں ڈیلیوری کے دو گھنٹے کے اندر اندر دے دیا جائے اس عمل کو ٹھیک کرنے کے لئے ماں کو 10 ملی گرام نیلارفن (Nalorphine) یا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ایک ملی گرام نیلارفن دیا جاسکتا ہے۔

3۔ نظام دوران خون میں خرابی (Malformation Of Vascular System) بھی اسفلیا جیسے مرض کو جنم دے سکتی ہے۔ اس خرابی میں کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز (Congenital Heart Disease) سب سے زیادہ اہم ہے۔

4۔ دماغ کے اندر خون کا اخراج (Intracranial Hemorrhage) ہو جانے سے بھی نومولود میں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔

نومولود میں اسفکسیا کی علامات (Signs & Symptoms Of Asphyxia Neonatorum): اسکی علامات درج ذیل ہیں؛

| علامات و نشانات<br>(Sign & Symptoms) | ہلکا اسفکسیا<br>(Mild Asphyxia)                    | شدید اسفکسیا<br>(Severe Asphyxia)        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| چلد کا رنگ<br>(SKIN COLOUR)          | نیلگوں<br>(Cyanosis)                               | سفید یا خاکستری<br>(White or Grey)       |
| کارڈ کی نبضیں<br>(CORD PULSATIONS)   | طاقتور<br>(Strong)                                 | ہلکی اور کمزور<br>(Weak)                 |
| پٹھوں میں اکڑاؤ<br>(MUSCLES TONE)    | بہتر<br>(Good)                                     | کمزور<br>(Poor)                          |
| سانس کی رفتار<br>(RESPIRATION)       | وقفے وقفے سے سانس لینا<br>(Breathing at intervals) | سانس بالکل نہ آنا<br>(Breathing Abscent) |

بچے کی حالت کی بنا پر سانس میں دشواری یعنی اسفکسیا نیونیٹورم کو درج ذیل دو اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے؛

1۔ اسفکسیا لیویڈا (Asphyxia Livida): سانس لینے سے پہلے بچے کی چلد کی رنگت نیلی (Cyanosed) ہوتی ہے لیکن جب خون میں آکسیجن کی کمی (Hypoxia) طویل نہیں ہو پاتی تو بچے کی نبض کی رفتار 100 فی منٹ سے زیادہ رہتی ہے جبکہ اس وقت بچے کے پٹھوں کی ٹون (Muscles Tone) بھی بہتر حالت میں رہتی ہے۔ اس قسم کے اسفکسیا کو اسفکسیا لیویڈا (Asphyxia Livida) کہتے ہیں۔

2۔ اسفکسیا پیلیدا (Asphyxia Pallida): اگر خون میں آکسیجن کی کمی کا دورانیہ طویل ہوتا جائے یعنی ڈیلیوری سے پہلے یا ڈیلیوری کے بعد، تو نظام دوران خون بالکل رُک جاتا ہے۔ نبض کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے اور بچہ پیلا نظر آتا ہے۔ بچے کے سٹھے بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ان کی ٹون بالکل ختم ہو جاتی ہے اور بچہ بالکل سُد ہد گنوا بیٹھتا ہے۔ اس حالت کو اسفکسیا پیلیدا (Asphyxia Pallida) کہتے ہیں۔ اس دوران بچے کا ایپگار سکور (APGAR Score) بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ایپگار سکور 0 اور 10 کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بچے کا جتنا ایپگار سکور کم ہوگا اتنا ہی بچے کی زندگی کو خطرہ زیادہ ہوگا۔

| اپرگار سکور (APGAR Score) | حالت (Condition)                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 8 سے 10                   | بہترین (Excellent)                                  |
| 5 سے 7                    | سانس میں درمیانے درجے کی تنگی (Moderate Depression) |
| 5 سے کم                   | سانس میں شدید دشواری (Severe Asphyxia)              |



## سانس کی تنگی میں مبتلا بچہ کی فوری طبی امداد

### (RESUSCITATION OF NEWBORN IN ASPHYXIA)

**تعارف (Introduction):** بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اگر یہ محسوس ہو کہ بچے کو سانس میں تنگی پیش آرہی ہے اور بچہ اسفکسیا نیونیورم کا شکار ہے تو بطور ایڈی ہیلتھ وزیٹر آپ درج ذیل نکات پر فوری طور پر عمل پیرا ہوں:

- 1- فوری طور پر کسی ڈاکٹر کو مدد کیلئے کال کریں۔
- 2- نومولود بچے کو ممکنہ طور پر گرم رکھیں۔
- 3- بچے کو ایک ترجیحی میز (Inclined Table) پر لٹائیں۔ بچے کا سر ٹانگوں کے مقابلے میں قدرے نیچے ہوتا کہ سانس کی نالیوں سے لیکوئز امینائی (Liquor Amnii) نکل آئے اور وہ صاف ہو جائیں۔
- 4- ایک میوکس کیتھیٹر (Mucous Catheter) کی مدد سے بچے کے منہ اور گلے سے میکونیم، خون اور میوکس کو آہستہ آہستہ نکالیں جبکہ ہسپتال میں اس مقصد کیلئے مکینیکل سکر (Mechanical Sucker) موجود ہوتے ہیں۔
- 5- بچے کے نظام تنفس کو چالو کرنے کیلئے پیچھے سے آہستہ آہستہ تھپتھپائیں۔ نومولود کا نظام تنفس چالو کرنے کے لئے ادویات کا استعمال اتنا زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ماں کو ڈیلیوری کے تین گھنٹوں کے اندر مارفین یا پٹیٹھی ڈین دی گئی ہے تو پھر ان کا توڑ (Antidote) فوراً دیں۔ ان دونوں ادویات کا توڑ نیلارفین (Nalorphine) ہے۔ اس انجکشن کا 0.25 ملی گرام ڈسولڈ وائر میں ملا دیا جاتا ہے اور اس طرح یہ تیار کردہ انجکشن امبالائیکل وین (Umbilical Vein) میں لگا دیا جاتا ہے۔

6۔ آکسیجن کے استعمال کے لئے درج ذیل طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال میں لائیں؛

i۔ نزل کیتھیٹر کی مدد سے آکسیجن ایک لیٹرنی منٹ کے حساب سے دیں۔

ii۔ ایک نرم ربڑ فنل (Rubber Funnel) بچے کے ناک اور منہ پر لگا دیں اور اس کی مدد سے آکسیجن دو لیٹرنی منٹ کے حساب سے لگائیں۔

iii۔ 3 گینج کے دو کیتھیٹر (Catheters Gauge 3) منہ کے ذریعے نومولود کے معدے میں اتارے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک کیتھیٹر کو آکسیجن کے ساتھ لگا کر آکسیجن ایک لیٹرنی منٹ کی رفتار سے چلا دیتے ہیں۔ دوسرا کیتھیٹر آکسیجن کا راستہ مہیا کرتا ہے۔ اس کیتھیٹر کے باہر والے کنارے کو پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے پانی سے بلبل نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طریقے سے آکسیجن کا خون میں انجذاب بہت معمولی سا ہوتا ہے۔ اس لئے اس طریقے کی افادیت کا زیادہ پتہ نہیں ہے۔

iv۔ اسی طرح فیس ماسک (Face Mask) کے ذریعے بھی نومولود کو آکسیجن مہیا کی جاسکتی ہے۔

v۔ آکسیجن نہ ہو تو پھر منہ سے منہ (Mouth to Mouth Breathing) کے ذریعے بھی سانس چالو کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔

سانس کی تنگی دور ہونے کی علامات و نشانیوں (Signs & Symptoms Of Improvement In Asphyxia): جن بچوں میں بروقت علاج کی وجہ سے سانس کی تنگی دور ہونے لگتی ہے تو اسفکسیا کی علامات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہیں اور پھر یہ علامات بالکل دور ہو جاتی ہیں۔

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | نومولود کی جلد کی رنگت نیلی سے ہلکی گلابی ہو جاتی ہے۔                               |
| ☆..... | نومولود میں ہچکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کے درمیان وقفہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ |
| ☆..... | نومولود میں سانس لینے کا عمل ہموار، تیز اور گہرا ہو جاتا ہے۔                        |
| ☆..... | نومولود کے دل کے دھڑکنے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔                               |
| ☆..... | نومولود کے پٹھوں کی ٹون (Muscles Tone) بھی بڑھ جاتی ہیں۔                            |
| ☆..... | بچہ ہلکی سی چیخ نکالتا ہے جس سے آکسیجن پیپٹروں کے اندر جانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ |

سانس کی تنگی کی خطرناک علامات و نشانیوں (Dangerous Signs & Symptoms Of Asphyxia): جب علاج کے باوجود بچے میں بہتری نہ آ سکے تو اس میں خطرناک علامتیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان میں سے چند اہم علامات و نشانیوں درج ذیل ہیں:

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | جلد کی رنگت نیلی سے سفید یا خاکستری ہو جاتی ہے۔                                            |
| ☆..... | نومولود کے سانس لینے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔                                               |
| ☆..... | نومولود میں ہچکیاں کافی وقفے سے آنا شروع کر دیتی ہیں۔                                      |
| ☆..... | یہ وقفہ عموماً 30 سیکنڈ سے زیادہ کا ہوتا ہے۔                                               |
| ☆..... | نومولود کو سانس ہلکے ہلکے آتے ہیں۔                                                         |
| ☆..... | اگر 10 منٹ کے اندر بچے میں سانس بحال نہ ہو سکے تو یہ مہلک ہو سکتا ہے۔                      |
| ☆..... | ایسے بچے کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے۔                                                 |
| ☆..... | بچے میں ڈھیلا پن اور زیادہ ہو جاتا ہے اور پٹھوں کی ٹون (Muscle Tone) بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ |
| ☆..... | ان حالات میں سانس بالکل رک جاتی ہے اور بچہ فوت ہو جاتا ہے۔                                 |

اسفلیا کے مرض میں مبتلا بچے کیلئے ٹھیک ہونے کے بعد کی ہدایات (Post Care In Asphyxia Neonatorum): اسفلیا کے مرض (Asphyxia Neonatorum) میں مبتلا بچے کیلئے ٹھیک ہونے کے بعد درج ذیل ہدایات پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے:

|        |                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | 48 گھنٹے تک نومولود بچے کو لٹائے رکھیں اور اسے اٹھانے سے پرہیز کریں۔                                   |
| ☆..... | بچے میں سانس کی تنگی کے دورے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں اس لئے اس بچے پر پوری طرح نظر رکھیں۔              |
| ☆..... | کسی بھی خطرناک علامت کے ظاہر ہونے کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر کو کال کریں۔                           |
| ☆..... | بے بی کاٹ (Baby Cot) میں بچے کو سیدھا لٹائیں جس میں بچے کا سر ایک طرف کو کر کے رکھیں۔                  |
| ☆..... | ہر دو گھنٹے بعد بچے کی پوزیشن تبدیل کریں۔                                                              |
| ☆..... | اگر میوکس نکل رہی ہو تو بچے کا سر ٹانگوں کے مقابلے میں ذرا نیچے رکھیں۔                                 |
| ☆..... | میوکس کی تھیز کی مدد سے گاہے بگاہے نومولود کی سانس کی نالیوں کو صاف کرتے رہیں۔                         |
| ☆..... | اگر دورے دوبارہ شروع ہوں تو فوری طور پر آکسیجن تیار رکھیں تاکہ اسے فوری طور پر نومولود کو لگایا جاسکے۔ |



Icterus Neonatorum



Asphyxia Neonatorum



Ophthalmia Neonatorum



Umbilical Hernia

|        |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | نومولود کو اگر سانس لینے میں بے ترتیبی پیدا ہو جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔                               |
| ☆..... | اگر بچے کی چھاتی اندر کی جانب مڑنا (Indrawing Of Chestwall) شروع ہو جائے تو ڈاکٹر کو طلب کریں۔                        |
| ☆..... | اگر نومولود کو اسفکسیا کا دورہ پڑ جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔                                             |
| ☆..... | اگر بچے کی جلد کی رنگت پھر سے نیلی ہونا شروع ہو جائے تو یہ ایک خطرناک علامت ہے لہذا فوری طور پر ڈاکٹر کو طلب فرمائیں۔ |
| ☆..... | ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق اسٹنی بائیوٹکس دینا شروع کر دیں۔                                                              |
| ☆..... | 24 گھنٹے کے لئے بچے کو دودھ نہ دیں۔                                                                                   |
| ☆..... | بچے کی جزل فزیکل کنڈیشن پر خاص نظر رکھیں۔                                                                             |

اسفکسیا کے بعد نومولود پر مرتب ہونے والے اثرات (After Effects Of Asphyxia On Neonate): اسفکسیا کے نتیجے میں بچے کی بعد کی زندگی میں کئی طرح کی پیچیدگیاں رونما ہو سکتی ہیں اور یہ پیچیدگیاں اس وقت اور بڑھ جاتی ہیں جب اسفکسیا بہت زیادہ شدید ہو۔ دماغی اور اعصابی بیماریاں بچے کو آنے والی زندگی میں گھیر سکتی ہیں۔ اس میں مرگی، دماغی دورے اور ذہنی کمزوری وغیرہ جیسی علامات آ سکتی ہیں۔



## دورانِ پیدائش بچہ کو پہنچنے والی چوٹیں

### (BIRTH INJURIES)

تعارف (Introduction): بچے کی پیدائش کے دوران نومولود کو کئی اقسام کی چوٹوں اور انجریز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ درج ذیل ہیں:

1۔ لمبی ہڈیوں کے فریکچر (Fractures Of Long Bones): وہ ہڈیاں جن میں پیدائش کے دوران زیادہ فریکچر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:

کلیویکل (Clavicle)، ہیومرس (Humerus)، فیمر (Femur)

یہ فریکچر عام طور پر پیدائش کے لئے لگائے جانے والے مختلف قسم کے دباؤ اور کھچاؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر کلیویکل ہڈی کا فریکچر ہو تو بالکل پتہ نہیں چلتا اور دو ہفتوں بعد کیلس (Callus) بنتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کلیویکل ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ لمبی ہڈیوں کی فریکچر کی صورت میں بچے کی ٹانگوں میں مورور ٹیفلیکس غائب ہوتا ہے اور اس فریکچر کی تشخیص کے لئے ایکسرے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صحت مند بچوں میں کیلس (Callus) تیزی سے بنتا ہے اور سپلنٹ (Splint) کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

2۔ **مورور فلیکس (Moro Reflex):** اگر اچانک شور ہو یا ارتعاش پیدا ہو تو بچے کی ٹانگیں اور بازو پہلے سیدھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ آکر مل جاتے ہیں۔ بچے میں شور و ارتعاش کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہاتھ پیروں کی اس کنڈیشن کو مورور فلیکس کہا جاتا ہے۔

3۔ **بریکمیل پلیکس کو چوٹ لگنا (Damage To Brachial Plexus):** بچے کی پیدائش میں اگر نومولود بچے کی پوزیشن سر کے بل یعنی ورنیکس (Vertex) یا چوتڑوں کے بل یعنی بریچ (Breech) ہو اور پیدائش کے دوران اگر نومولود کی گردن ایک طرف بہت زیادہ ہی مڑ جائے جسے لیٹرل فلیکشن (Lateral Flexion) کہتے ہیں تو ایسی صورت میں بریکمیل پلیکس (Brachial Plexus) کو ٹراما ہو سکتا ہے۔

4۔ **اربز پالیسی (Erb's Palsy):** اس میں سروائیکل مہروں میں سے پانچویں اور چھٹے مہرے کے اعصاب C5 اور C6 کو سب سے زیادہ چوٹ پہنچتی ہے۔ اس میں بازوؤں کے ابڈکٹرز (Abductors) اور فلیکسر پٹھے (Flexors) متاثر ہو جاتے ہیں اور بچے کے بازو ایک مخصوص انداز لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس خاص انداز کو ویٹرنریپ کہتے ہیں۔

5۔ **کلپ کیزیر الائیس (Klumpke's Paralysis):** اس میں آٹھویں سروائیکل اور پہلے تھوریک مہرے سے نکلنے والے C8 اور T1 اعصاب سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں مگر یہ اتنا عام نہیں ہے اس میں ہاتھ کمزور ہو جاتا ہے اور اس میں رسٹ ڈراپ (Wrist Drop) ہوتا ہے جبکہ گریپ فلیکس (Grasp Reflex) غائب ہوتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر چوٹوں کا علاج نہیں کیا جاتا ہے۔ صرف فزیوتھراپی کی مدد سے سختی کو روکا جاسکتا ہے اور دیر سے ٹھیک ہونے کی بجائے مریض جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر چوٹ بہت سخت ہو تو ایسی صورت میں آرتھروپڈک سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے۔

6۔ **کھوپڑی کا ڈپریشن فریکچر (Depression Fracture Of Skull):** یہ عام طور پر مشکل قسم کی ڈیلیوری میں فورسپس بلیڈ کی نوک لگ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور عام طور پر اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بچے میں دماغی علامات آرہی ہوں یا جسم کے کسی حصے میں کمزوری نمایاں ہونے لگے تو پھر سرجری ضروری ہو جاتی ہے۔

7۔ **فیشیل پالیسی (Facial Palsy):** اس میں بچے کی ساتویں کرینل نرو، فیشیل نرو کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ نرو سٹائلوماسٹائڈ فورامین (Stylomastoid Foramen) سے باہر نکلتی ہے تو اس پر فورسپس کے دباؤ کی وجہ سے کمزوری سی واقع ہو جاتی ہے۔ چند ہی دنوں میں بچہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر چند دنوں میں بچہ ٹھیک نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں بچے کو اسپیشلسٹ کے پاس بھجوا دیں۔

8۔ **سٹرنوماسٹوئڈ ٹیومر (Sternomastoid Tumor):** پیدائش کے بعد پہلے ہفتے کے اندر سٹرنوماسٹوئڈ (Sternomastoid) مسل کے اندر ایک رسولی سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ عام طور پر چوٹ لگنا ہوتی ہے لیکن اس کی صحیح وجہ معلوم نہیں۔ اس میں ماں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ دن میں وقفے وقفے سے تین سے چار مرتبہ اس مسل کو آہستگی سے کھینچے، شروع میں اس مسل پر کھچاؤ پیدا کرنے سے بچے کو درد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کنڈیشن کے ٹھیک ہونے میں فزیوتھراپی کا اہم رول ہے۔

9۔ **سر کی ہلکی سطحی چوٹیں (Superficial Head Injuries):** فورسپس ڈیلیوری یا وکیوم ایکسٹریکشن جیسے طریقے ڈیلیوری کے دوران استعمال کرنے سے بچے کے سر پر معمولی زخم یا خراشیں آ سکتی ہیں۔ ان کے علاج کے لئے بیرونی علاج ہی کافی ہوتا ہے۔

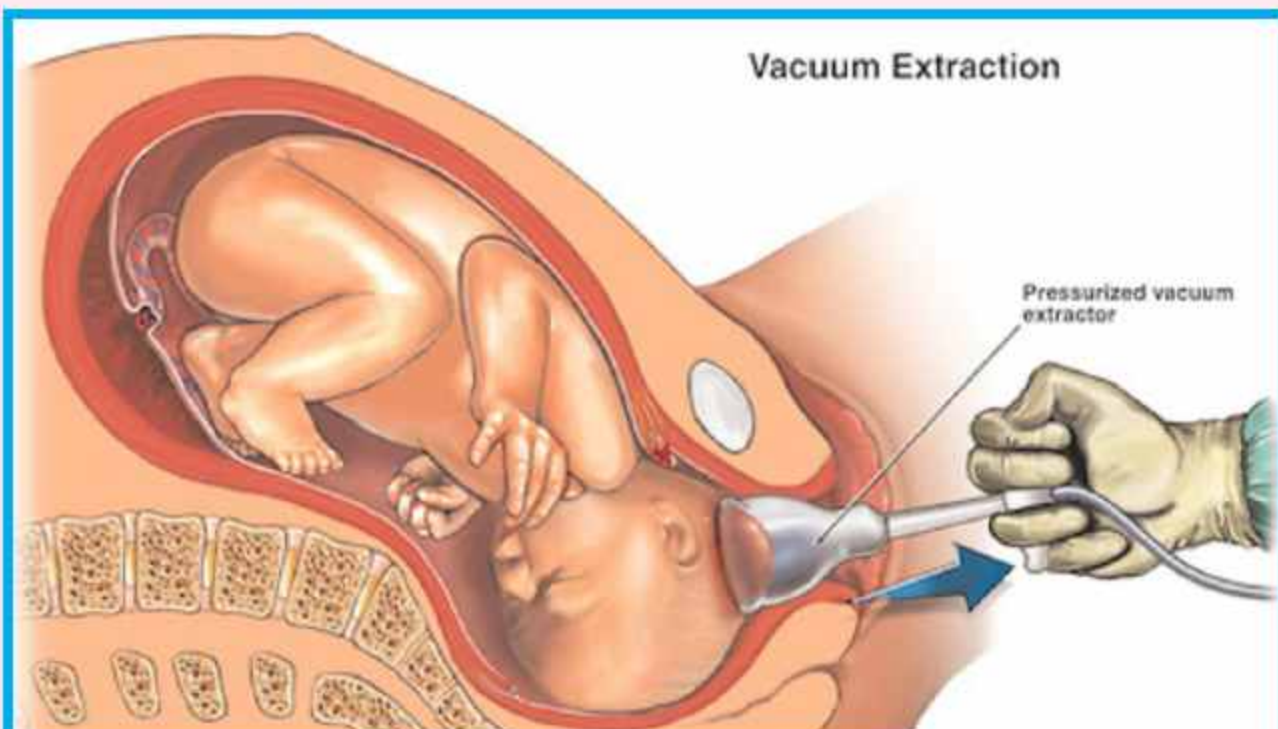
10۔ **کپٹ کسی ڈیفیم (Caput Succedaneum):** اسے متبادل سر (Substitute Head) بھی کہتے ہیں۔ اس میں دراصل لیبر کے دوران سرویکس پر زیادہ دباؤ آنے کی وجہ سے کھوپڑی کے اوپر موجود سب کیوٹینیس ٹشوز میں خون جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سر کے اوپر زیر جلد گومڑ سا بن جاتا ہے۔ پیدائش کے بعد چند گھنٹوں کے اندر یہ فلوئیڈ خود بخود جذب ہو جاتا ہے اور بچے کا سر بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔

11۔ **سب اپونیورالک ہیمریج (Subaponeurotic Haemorrhage):** اس میں بچے کا بہت زیادہ خون بہتا ہے اور پوری کھوپڑی پر جلد کے نیچے خون جمع ہو جاتا ہے جس سے بچے میں خون کی کمی اور ہائپو ولیمیا (Hypovolemia) جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔

12۔ **سیفل ہیماٹوما (Cephalhaematoma):** اس سے مراد پیری اوسٹیم (Periosteum) اور اسکل بون (Skull bone) کے درمیان خون کا جمع ہو جانا ہے۔ بچے میں سیفل ہیماٹوما عموماً چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ پیدائش کے چند گھنٹوں بعد نمودار ہوتا ہے۔ بچے میں سیفل ہیماٹوما کو نہ تو ڈرین (Drain) کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اسے ایسپائریت (Aspirate) کرنیکی ضرورت ہوتی ہے بلکہ چند ہفتوں کے اندر یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔

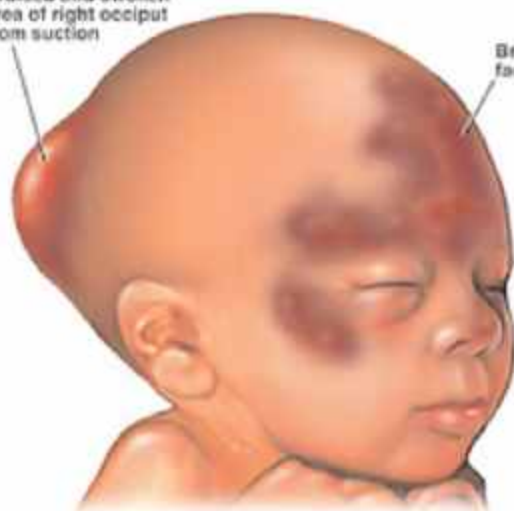


## Vacuum Extraction



Bruised and swollen area of right occiput from suction

Bruises on face



Bruises from birth

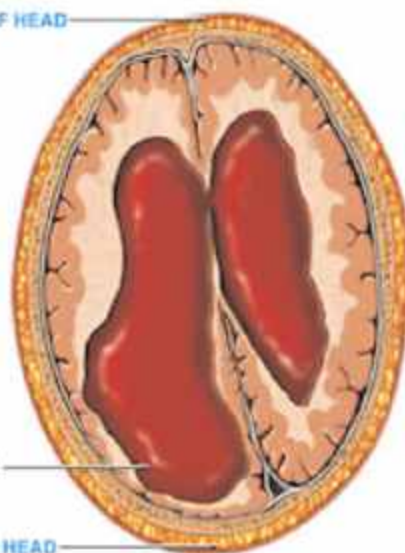
FRONT OF HEAD

L

R

Grade II intraventricular hemorrhage

BACK OF HEAD



Cut Section of Infant's Brain  
Subsequent condition

## Neonatal Birth Injuries

## وراثتی اور پیدائشی نقائص

### (CONGENITAL MALFORMATIONS)

**تعارف (Introduction):** بچوں میں پیدائش کے بعد وراثتی اور پیدائشی نقائص عام طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نقائص کی وجہ معلوم نہیں ہوتی لیکن عام طور پر ان نقائص میں درج ذیل چار میں سے ایک وجہ موجود ہوتی ہے:

|   |                         |                              |
|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | وراثتی جینیاتی خرابیاں۔ | (Hereditary Genetic Defects) |
| 2 | کروموسومز کی خرابیاں۔   | (Chromosomal Defects)        |
| 3 | خاندانی بیماریاں۔       | (Familial Diseases)          |
| 4 | حادثاتی نقائص۔          | (Incidental Defects)         |

جینیٹک کونسلنگ (Genetic Counseling) میں یہ تمام مسائل زیر بحث لائے جاسکتے ہیں اور جس جوڑے کی شادی ہونے والی ہے اسے صحیح مشورے دیئے جاسکتے ہیں اور انہیں یہ بتایا جاسکتا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی خطرناک بیماری آگے منتقل ہونے کا چانس تو نہیں؟ اس طرح کی کونسلنگ (Counseling) بعض اوقات حمل کے ابتدائی دنوں میں ضروری ہو جاتی ہے۔ پیدا ہونے والے بچے پر کچھ مخصوص ٹیسٹ کر کے یہ بتایا جاسکتا ہے کہ کوئی خطرناک مرض بچے میں منتقل تو نہیں ہو رہا۔ اس کیلئے جینیٹکس (Genetics) کے ماہر کی ضرورت پڑ سکتی ہے مگر ایک جنرل پریکٹیشنر کو بھی ان نقائص کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

**(1) وراثتی جینیاتی خرابیاں (Hereditary Genetic Defects):** جینز (Genes) انسانی سیل کے نیوکلئیس میں کروموسومز کے جوڑوں پر مخصوص جگہوں پر واقع ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جینز کے جوڑوں کو ایلیلز (Alleles) کہتے ہیں۔ اگر یہ ایلیلز ایک جیسے ہوں تو پیدا ہونے والے بچے کو ہوموزائیکس (Homozygous) کہتے ہیں۔

**a۔ آٹوسومل جینیٹک خرابیاں (Autosomal Genetic Defects):** اگر اس طرح کا صرف ایک جین (Gene) غیر نارمل ہو تو دوسرے کروموسوم پر موجود اپنے جیسے دوسرے نارمل جین کے اثر کو زائل کر دیتا ہے اور اس طرح اس انسان میں بیماری ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے انسان کو اس بیماری کے لئے ہٹرو زائیکس (Heterozygous) کہتے ہیں۔ اس شخص کی نسل میں پچاس فیصد بچوں میں یہ بیماری آگے منتقل ہونے کا چانس ہوتا ہے کیونکہ اس شخص کے ایک جیسے جینز کے جوڑے میں سے صرف ایک جین نارمل نہیں ہوتا مثلاً:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| (Achondroplasia)           | ☆..... اے کانڈروپلازیا۔        |
| (Osteogenesis Imperfecta)  | ☆..... آسٹیوجینیسس امپرفیکٹا۔  |
| (Congenital Spherocytosis) | ☆..... کن جینیٹل سفیروسائٹوسس۔ |
| (Sickle Cell Anaemia)      | ☆..... سکل سیل انیمیا۔         |
| (Huntington's Chorea)      | ☆..... ہنٹنگٹن کوریا۔          |

**b۔ آٹوسومل ریسیو ڈس آرڈرز (Autosomal Recessive Disorders):** اگر جینز کے جوڑوں میں سے ایک نارمل نہ ہو اور وہ نارمل جین کے مقابلے میں کمزور ہو تو پھر طاقتور جین کمزور جین پر قابو پالیتا ہے اور اس انسان میں وہ بیماری ظاہر نہیں ہوتی۔ اس صورت میں بیماری صرف اس وقت ہوگی جب دونوں جینز نارمل نہ ہوں۔ اگر باپ میں ایسا ایک جین غیر نارمل ہو اور ایک جین ماں میں غیر نارمل ہو اور آنے والے بچے میں دونوں جین غیر نارمل منتقل ہو جائیں تو پھر بچے میں بیماری ظاہر ہو جائے گی یعنی بیماری منتقل ہونے سے پہلے ماں اور باپ دونوں کو بیماری کے لئے ہیٹرو زائیکس ہونا پڑے گا۔ میٹابولزم کے پیدائشی نقائص زیادہ تر اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً:

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| (Phenylketonuria) | ☆..... فینائل کیٹون یوریا۔ |
| (Cystic Fibrosis) | ☆..... سیسٹک فائبروسس      |

**c۔ ایکس لینکڈ ریسیو ڈیزیز (Sex Linked Recessive Disease):** یہ ایک خاص حالت ہوتی ہے جس میں ریسیو جین یا جے کمزور جین کہہ سکتے ہیں وہ ایکس کروموسوم پر واقع ہوتا ہے۔ یہ کروموسوم زیادہ تر X کروموسوم ہوتا ہے۔ خاتون میں کروموسومز XX ہوتے ہیں جبکہ ایک X کروموسوم باپ کی طرف سے اور ایک ماں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لئے اگر ماں یا باپ میں سے کسی کا X کروموسوم غیر نارمل جین رکھتا ہے تو دوسرا جین اس کے اثر کو زائل کر دے گا اور آنے والے بچے میں بیماری ظاہر نہیں ہوگی جبکہ آنے والے نر بچے میں کروموسومز XY ہوتے ہیں۔ اس لئے اس میں ماں کی طرف سے X کروموسوم پر غیر نارمل جین موجود ہو تو اس کی مخالفت کرنے والا دوسرا X کروموسوم نہیں ہوتا۔ اس طرح اس بچے میں بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس فیصد مادہ بچوں میں ریسیو جین تو منتقل ہو جائے گا مگر ان میں بیماری ظاہر نہیں ہوگی جبکہ آنے والے نر بچوں میں سے پچاس فیصد میں بیماری موجود ہوگی۔

(2) کروموسومز کی خرابیاں (Chromosomal Defects): یہ خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اووسائٹ (Oocyte) یا سپرم (Sperm) پختہ ہونے لگتا ہے یعنی می او سس کے وقت کی خرابیاں بعض اوقات کروموسومز کو صحیح طرح سے الگ نہیں ہونے دیتیں جس کے نتیجے میں بعض جرم یلز میں کروموسومز کی تعداد نارمل نہیں رہتی اور خرابیاں پیدا ہونے والے بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کی خرابیوں میں سے سب سے عام ڈاؤن سائنڈروم (Down's Syndrome) ہے۔ اس بیماری میں پیدا ہونے والے بچے کا ایک کروموسوم زیادہ ہوتا ہے۔ اس کروموسوم کا نمبر 21 ہوتا ہے۔ اس لئے اس مرض کو ٹرائی سومی 21 (Trisomy-21) بھی کہتے ہیں۔ اس مرض کی تشخیص فینس کا ٹھولے کرکچر کے ذریعے کی جاتی ہے اور پھر اسکی کیریوٹائپنگ کی جاتی ہے۔ یہ نمونہ ایمنیو سیٹیس یا کوریونک ولس سیمپلنگ (Chorionic Villus Sampling) کی مدد سے لیا جاسکتا ہے مثلاً:

|        |                       |                          |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| ☆..... | ڈاؤن سائنڈروم۔        | (Down's Syndrome)        |
| ☆..... | ٹرائی سومی 18۔        | (Trisomy 18)             |
| ☆..... | ٹرائی سومی 13۔        | (Trisomy 13)             |
| ☆..... | ٹرنر سائنڈروم۔        | (Turner's Syndrome)      |
| ☆..... | کلائن فیلٹر سائنڈروم۔ | (Klinefelter's Syndrome) |

(3) خاندانی بیماریاں (Familial Diseases): اس گروپ میں وہ بیماریاں آتی ہیں جن میں کئی عوامل کا فرما ہوتے ہیں اور یہ خاندانوں میں چلتے ہیں۔ یہ بیماریاں ایک یا ایک سے زائد جینز میں خرابی کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور ایمریو یوٹائیس کے ماحول میں خرابی کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ پیدا ہونے والے بچوں میں کس مرض کا کتنا چانس ہے اس کا صحیح اور درست اندازہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔

(4) حادثاتی خرابیاں (Incidental Defects): یہ وہ خرابیاں ہوتی ہیں جو کہ انفرادی طور پر حمل کے دوران پیدا ہو سکتی ہیں۔ کئی کیسوں میں دوران حمل انفیکشنز اور ادویات کا استعمال ان بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ایسی صورت میں والدین کو یہ بتایا جاسکتا ہے کہ یہ مرض خاندانی نہیں ہے بلکہ حمل کے دوران پیچیدگی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو کہ اگلے حمل میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے نہیں ہوگا۔ اسی لئے ایک لیڈی ڈاکٹر اور ماہر امراض زچہ و بچہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیدائش کے وقت کونسی خرابیاں کتنی خطرناک ہیں اور وہ اس کا علاج بھی شروع کرا سکیں۔

**a۔ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس (Neural Tube Defects):** اس قسم کے نقائص کو اینٹی نیل وزٹ پر چیک کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایسی خواتین کے سیرم میں ہیومن کوریونک گونیڈوٹروفن (HCG) کی مقدار بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان نقائص کو الٹراساؤنڈ پر بھی تشخیص کیا جاسکتا ہے۔ ان نقائص کا گہرا تعلق فولک ایسڈ کی کمی سے ہوتا ہے۔ جن خواتین میں دوران حمل فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے ان میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے دوران حمل تمام خواتین کو فولک ایسڈ احتیاطاً دیا جاتا ہے۔

**b۔ سپائنا بایڈا (Spina Bifida):** اس قسم کے مرض میں ریڑھ کی ہڈی کے مہروں میں خرابی ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے مخصوص حصے ورٹیبرل آرچز (Vertebral Arches) آپس میں نہیں مل سکتے چونکہ اب مہروں میں پیچھے کی طرف سے فاصلہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے سائنل کالم کے پیچھے کی جانب سے دماغ کی جھلیاں (Meninges) اور حرام مغز (Spinal Cord) ریڑھ کی ہڈی سے باہر نکل آتے ہیں اور ایسا عام طور پر لمبوسیکل ریجن (Lumbo Sacral Region) میں ہوتا ہے۔

**c۔ مینگو سیل (Meningocele):** اس بیماری میں پایا میٹر (Pia Mater) اور اریکنا ایڈ میٹر (Arachnoid Mater) جو کہ دماغی جھلیاں ہیں، باہر نکل آتی ہیں اور اس کے اوپر صرف جلد موجود ہوتی ہے۔ اگر اس میں اعصابی نشوونما اثر نہ ہوئے ہوں تو نتائج بہتر نکل سکتے ہیں۔ بہر حال اس مرض میں آپریشن کر کے بچے کو ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔

**d۔ مائیلول (Myelocele):** اس بیماری میں سائنل کارڈ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے جبکہ سیک کے فنڈس میں جھلیاں اور نیورل اپی تھیلیم موجود ہوتی ہیں چونکہ اس کے اوپر جلد پوری طرح موجود نہیں ہوتی اس لئے اگر چوبیس گھنٹے کے اندر آپریشن کر کے اس سوراخ کو بند نہ کیا جائے تو پھر انفیکشن کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

**e۔ این ان سفیلی (ANENCEPHALY):** اس مرض میں بچے کی کھوپڑی (Cranium) اور سکیلپ (Scalp) پوری طرح سے نہیں بنتیں۔ اس میں بچے کا چہرہ اور کھوپڑی کی بنیاد (Base Of Skull) موجود ہوتی ہے۔ اس نقص کو دوران حمل ابتداء میں ہی تشخیص کیا جاسکتا ہے۔ اس حالت میں حاملہ خاتون کو تھیراپیونک ابارشن (Therapeutic Abortion) کا مشورہ جاتا ہے کیونکہ ایسا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر حمل چلتا رہے تو پھر ایسی صورت میں پولی ہائیڈریمنیاس (Polyhydramnios) کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ بچے میں اینٹی ڈائی یوریکک ہارمون (Antidiuretic Hormone) بالکل موجود نہیں ہوتا۔ اگر اس نقص کے ساتھ پولی ہائیڈریمنیاس (Polyhydramnios) نہ

ہو تو اور کئی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مثلاً اس حمل کا دورانیہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس بیماری میں پچوٹری گلینڈ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات لیبر کے دوران بچے کی پوزیشن منہ کے بل یعنی فیس پرے زینٹیشن (Face Presentation) ہوتی ہے اور اس دوران شولڈر ڈس ٹاشیا (Shoulder Dystocia) کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے۔



## ہائیڈروسیفلس (HYDROCEPHALUS)

**تعارف (Introduction):** ہائیڈروسیفلس نومولود بچوں میں پایا جانے والا ایک عام مرض ہے۔ اس مرض میں مبتلا بچے کا سر جسم کے لحاظ سے قدرے بڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں بچے کے دماغ کے وینٹریکلز (Ventricles Of Brain) میں سیربروسپائل فلوئیڈ کا دباؤ بڑھ جانے سے اس کا دماغ اور کھوپڑی پھول جاتے ہیں اور اسی وجہ سے بچے کا سر بڑا محسوس ہوتا ہے۔

**فزیوپیتھالوجی (Physiopathology):** دماغ میں ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جسے لیٹرل وینٹریکل (Lateral Ventricle) کہتے ہیں۔ اس میں مخصوص قسم کے آرٹیریل پلکسس (Arterial Plexuses) ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص فلوئیڈ پیدا کرتے ہیں جسے سیربروسپائل فلوئیڈ (Cerebrospinal Fluid) کہتے ہیں۔ یہ فلوئیڈ لیٹرل وینٹریکل سے گزر کر تھرڈ وینٹریکل (Third Ventricle) اور فورٹھ وینٹریکل (Fourth Ventricle) سے ہوتا ہوا سب اریکنائیڈ سپیس (Subarachnoid Space) میں چلا جاتا ہے اور پھر ڈیورا میٹر (Dura Mater) میں موجود اریکنائیڈ گرینولیشنز (Arachnoid Granulations) یا اریکنائیڈ ولائی (Arachnoid Villi) میں جذب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس سیربروسپائل فلوئیڈ (CSF) کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس فلوئیڈ کے دباؤ کی وجہ سے وینٹریکلز پھول جاتے ہیں اور جیسے جیسے یہ دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے بچے کے سر کی جسامت اور سائز بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ بچے کے سر کی جسامت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ سرجری کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔



## دل کے نقائص

### (CARDIAC LESIONS)

**تعارف (Introduction):** نومولود بچوں میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس (Neural Tube Defects) کے بعد پیدا ہونے والے نقائص میں سب سے زیادہ نقائص دل کے نقائص ہیں۔ نومولود میں دل کے ان نقائص کی وجہ عام طور پر معلوم نہیں ہوتی لیکن حمل کے ابتدائی دنوں میں ماحولیاتی عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں مثلاً:

|                             |        |                      |
|-----------------------------|--------|----------------------|
| (Rubella Infection)         | .....☆ | روبیلا انفیکشن۔      |
| (Heavy Alcohol Consumption) | .....☆ | شراب نوشی کی کثرت۔   |
| (Maternal Diabetes)         | .....☆ | ماں کو ذیابیطس ہونا۔ |

دل کی بیماریاں درج ذیل وراثتی نقائص میں عام ہوتی ہیں۔

|                     |        |                |
|---------------------|--------|----------------|
| (Trisomy-21)        | .....☆ | ٹرائی سومی 21۔ |
| (Trisomy-18)        | .....☆ | ٹرائی سومی 18۔ |
| (Trisomy-13)        | .....☆ | ٹرائی سومی 13۔ |
| (Turner's Syndrome) | .....☆ | ٹرنرز سنڈروم۔  |

موجودہ سالوں میں میڈیکل سائنس میں ترقی کی وجہ سے دل کے وراثتی نقائص کی تشخیص اور علاج میں کافی آسانی ہو گئی ہے۔ اینٹی ٹیل کیر کے دوران یوٹرس میں موجود بچے کی ایکو کارڈیو گرافی یا الٹراساؤنڈ کیا جاسکتا ہے۔ ڈاپلر الٹراساؤنڈ کی مدد سے بھی دل کے نقائص کی تشخیص بہت جلد اور آسانی سے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سرجری میں بھی انتہائی ترقی آ جانے کے باعث ان نقائص کا سرجیکل حل آسانی سے مہیا کیا جاسکتا ہے۔ دل کے وراثتی نقائص درج ذیل دو طرح کے ہوتے ہیں:

1۔ **سایانائک ہارٹ ڈیزیز (Cyanotic Heart Disease):** ان نقائص میں بچے کا رنگ نیلا یعنی سایا یا نوس ہوتا ہے:

|                                       |        |                                   |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| (Transposition Of The Great Arteries) | .....☆ | بڑی شریانوں کی جگہ تبدیل ہو جانا۔ |
| (Tetology Of Fallot)                  | .....☆ | ٹیٹالوجی آف فیلاٹ۔                |

2۔ اے سائناٹک ہارٹ ڈیزیز (Acyanotic Heart Disease): ان نقائص میں بچے کا رنگ نیلا یعنی سائانوسس نہیں ہوتا؛

|                                   |                                  |        |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| (Septal Defects)                  | سپٹل ڈیفیکٹس۔                    | ☆..... |
| (Patent Ductus Arteriosus)        | پینٹ ڈکٹس آرٹیر یوسس۔            | ☆..... |
| (Coarctation Of Aorta)            | کوآرکٹیشن آف ایارٹا۔             | ☆..... |
| (Pulmonary Aortic Stenosis)       | پلومونری ایارٹک سٹینوسس۔         | ☆..... |
| (Hypoplastic Left Heart Syndrome) | ہائپو پلاسٹک لیفٹ ہارٹ سائنڈروم۔ | ☆..... |

اگر درج ذیل علامتوں میں سے کوئی علامت نمودار ہو تو فوری طور پر بچوں کے سپیشلسٹ ڈاکٹر کو ریفر کریں۔

|                       |                             |        |
|-----------------------|-----------------------------|--------|
| (Shortness Of Breath) | سانس لینے میں دشواری ہو۔    | ☆..... |
| (Tachypnoea)          | تیزی سے سانس لینا۔          | ☆..... |
| (Cyanosis)            | جلد کی رنگت نیلی پڑ جانا۔   | ☆..... |
| (Shock)               | شاک کی علامتیں نمودار ہونا۔ | ☆..... |
| (Murmurs)             | دل سے غیر نارمل آوازیں آنا۔ | ☆..... |



## کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلیٹ

### (CLEFT LIP & CLEFT PALATE)

**تعارف (Introduction):** ہر 600 پیدائشوں میں سے ایک بچے کو یہ نقص موجود ہوتا ہے اور دس فیصد بچوں میں یہ نقص خاندانوں میں موجود ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہونٹ اور پیلیٹ یا تالودونوں اکٹھے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان نقائص میں بچے کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور تالو بھی دو حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے بچوں میں دودھ پلانا کافی مشکل کام ہوتا ہے اور دودھ پلانے کے لئے چیخ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات بچے میں نیزو گیسٹرک فیڈنگ (Nasogastric Feeding) کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ اس مرض میں بچے میں چوسنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ایسے بچے میں ہر دفعہ دودھ پلانے کے بعد تالو یا ہونٹ کے کلیفٹ کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر چار ماہ کی عمر میں بچے کے ہونٹ کی پلاسٹک سرجری ہو جائے تو اس سے بچہ کافی حد تک نارمل ہو جایا کرتا ہے جبکہ تالو کی درستگی کچھ عرصے بعد کی جاتی ہے۔





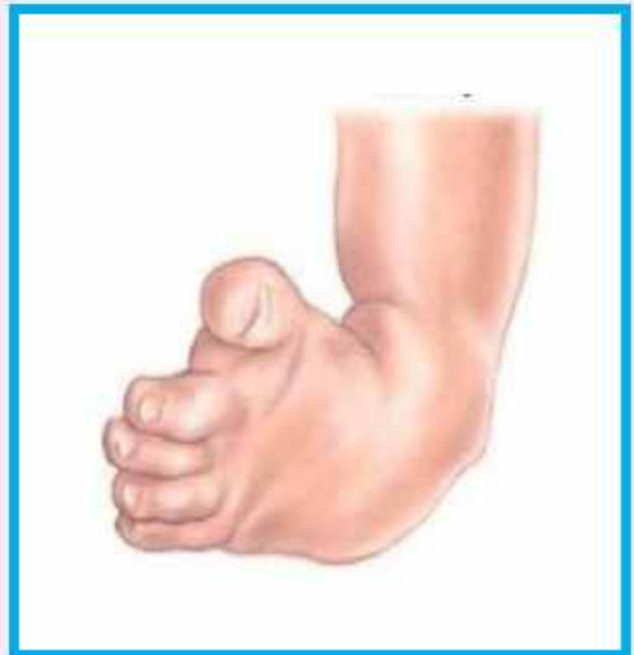
Asphyxia Neonatorum



First Aid In Asphyxial Neonate



Cleft Lip & Palate in baby



Club Foot In Baby

## نظام انہظام کے نقائص

(DEFECTS OF G.I.T)

ایسوفیجیل ایٹریزیا / ٹریکیو ایسوفیجیل فیلچولا (Oesophageal Atresia/Tracheo-Oesophageal Filstula):  
نظام انہظام کے ان نقائص میں خوراک کی نالی یا ایسوفیجس کا منہ T3-T4 کے لیول پر بند ہوتا ہے جبکہ ایسوفیجس سانس کی نالی ٹریکیا کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اینٹی نیٹل کئیر میں پولی ہائیڈرایمنیاس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اور وہ دودھ نگلتا ہے تو اس کا سانس بند ہونے لگتا ہے اور جلد کی رنگت نیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کے منہ سے جھاگ سی نکلتی رہتی ہے۔ اگر ایک سخت کیتھیٹر (Catheter) ایلویولر مارجن (Alveolar Margin) سے دس سے بارہ سینٹی میٹر دُرُک جائے تو یہ نقص ثابت ہو جاتا ہے۔

امپر فورم ایٹس (Imperforate Anus): بچے کے اینس اور ریکٹم میں کئی طرح کے نقائص پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایمرجنسی کے طور پر بچے کی کولاسٹومی (Colostomy) کروانا پڑتی ہے۔ اس نقص میں بچے کو فیلچولا (Fistula) بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بچے کا پاخانہ پیشاب کی نالی یا ویجائنا سے بھی خارج ہوتا نظر آتا ہے۔

پیٹ کی دیوار کے نقائص (Abdominal Wall Defects): اگر اینٹی نیٹل کئیر کے دوران ماں کے سیرم میں AFP لیول زیادہ ہوں تو پیٹ کی دیوار کے نقائص کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ الٹراساؤنڈ سکین اور روٹین ایناٹمی سکین میں ان نقائص کی تشخیص ہو جاتی ہے۔

ایگزومفیلالس (Exomphalos): اس نقص میں پیٹ کے اعضاء امبالائیکل کارڈ میں موجود ہوتے ہیں اور پیٹ کی دیواریں صحیح طرح سے نشوونما نہیں لے پاتیں۔ اس کے سیک کی جیلی کی طرح کی جھلی ہوتی ہے جو کہ امبالائیکل کارڈ کی تہہ ہوتی ہے اور کارڈ کی خون کی نالیاں سیک کے اوپر سے گزرتی ہیں۔ اس کے لئے پیڈیاٹرک سرجن سے مخصوص آپریشن کروانا پڑتا ہے۔

گیسٹروشیس (Gastroschisis): یہ بھی پیٹ کی دیواروں کا ایک نقص ہوتا ہے جو کہ فیٹل ڈیولپمنٹ کے دوران واقع ہوتا ہے۔ اس نقص میں نارمل امبالائیکل کارڈ کا دایاں حصہ بند نہیں ہو پاتا اور اس کے اوپر کوئی کوریگ نہیں ہوتی جس کے باعث الٹراساؤنڈ میں بچے کی بڑی آنتوں کا کچھ حصہ ایمینیاک کیوٹی میں نکلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا علاج بھی آپریشن کے ذریعے ہوتا ہے۔

**کلب فٹ (Club Foot):** اس قسم کے نقص میں پاؤں ایک مخصوص انداز میں مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس مرض کا علاج بچپن میں ہی شروع ہو جاتا ہے تاکہ ہڈیوں اور پٹھوں کی نشوونما پر برا اثر نہ پڑ جائے۔ ماں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ کس طرح اس نقص کو ہلکا ہلکا کھچاؤ ڈال کر ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔ اس نقص کے علاج کے لئے اب آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ لمبے عرصے تک سپلنٹ (Splint) استعمال کرنا پڑتا ہے۔

**اضافی انگلیاں (Accessory Digitus):** اس قسم کا نقص بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ اس میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے جسے با آسانی دور کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایک مکمل انگلی موجود ہو تو پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپریشن کر کے وہ انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔



## نومولود بچے کو لاحق ہونے والے انفیکشنز

(INFECTIONS OF THE NEW BORN)

**تعارف (Introduction):** ہسپتال میں انفیکشنز ایک بچے سے دوسرے بچے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں۔ ان انفیکشنز کے پھیلنے کے درج ذیل طریقے ہو سکتے ہیں:

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆..... | بچے کے لواحقین میں سے کسی کو نزلہ زکام لگا ہوا ہو یا کوئی انفیکشن لاحق ہو تو یہ انفیکشن اس متاثرہ انسان سے بچے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ |
| ☆..... | وہ لوگ جو بچے کو ملنے کیلئے باہر سے آرہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی انفیکشن بچے میں منتقل ہو سکتی ہے۔                                 |
| ☆..... | بچے کے زیر استعمال چیزیں مثلاً صابن، تولیہ، کمبل، بیڈ شیٹ وغیرہ سے بھی انفیکشن پھیل کر بچے کو متاثر کر سکتی ہے۔                      |
| ☆..... | نرسری میں زیادہ بچوں کو اکٹھا کرنے یا غیر تربیت یافتہ نرسوں کے باعث کر اس انفیکشن (Cross Infection) پھیل سکتی ہے۔                    |

**انفیکشنز کی روک تھام (PREVENTION OF INFECTIONS):** بچے میں انفیکشنز کی روک تھام کیلئے درج ذیل تدابیر اپنائیں:

**1۔ سب سے پہلے صفائی نہایت اہم ہے۔** فرش اچھی طرح صاف رکھا جائے۔ ہر بچے کے ڈسچارج ہونے کے بعد بے بی کاٹ (Baby Cot)، کمبل اور لینن (Linen) کو فیومی گیشن (Fumigation) یا آٹو کلیو (Autoclave) کے عمل سے گزار کر صاف کر لیا جائے۔ مناسب آلات اور کافی مقدار میں لینن ہونا چاہیے تاکہ صاف لینن کو آنے والے بچے کے لئے استعمال کیا جاسکے۔ بچے کو روزانہ ان کے کپڑے اتار کر چیک کریں اور اگر بچے میں کوئی انفیکشن موجود ہو تو اس بچے کو علیحدہ کر دیں تاکہ دوسرے بچے متاثر نہ ہو جائیں۔

- 2- کسی بھی بچے کو چھونے سے پہلے نرس کو پانچ منٹ تک ہاتھ صابن سے صاف کرنے چاہئیں اور جب ایک بچے سے دوسرے بچے کو چھونا ہو تو پھر دو منٹ تک ہاتھ دھونا چاہئیں۔ نرس کو ماسک پہننا چاہیے اور اپنے کپڑے روزانہ تبدیل کرنے چاہئیں۔
- 3- اگر بچے کو کوئی مصنوعی دودھ دیا جا رہا ہے تو فیڈر اور دودھ کو جراثیموں سے پاک رکھنے کیلئے حفاظتی تدابیر اپنائیں۔
- 4- بچے کے خراب ہو جانے والے نیپکین (Napkin) ڈھانپ کر رکھیں اور پھر اکثر انہیں تبدیل کرتے رہیں۔

☆..... امبالائیکل انفیکشن (Umbilical Infection): اگر امبالائیکل کارڈ کی انفیکشن ہو جائے تو اس میں کارڈ پر سوزش ہو جاتی ہے اور اس سے گند اور بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ کارڈ کے اوپر جراثیم زدہ پاؤڈر چھڑکنے سے بچے کو ٹیٹائیس بھی ہو سکتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

علاج: کارڈ کو بالکل صاف اور خشک رکھیں اور روزانہ سپرٹ سے صاف کریں۔ اگر اس میں انفیکشن نظر آئے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ انفیکشن والے حصے کو سپرٹ سے صاف کریں۔ اگر کارڈ سے پیپ آرہی ہو تو اسے کلچر اور سنسٹیوٹی (Culture & Sensitivity) کے لئے لیبارٹری بھجوا دیں۔ اگر انفیکشن شدید ہو تو ڈرینگ کر دیں اور روزانہ ڈرینگ تبدیل کریں۔ اینٹی بائیوٹک دیں اور تمام انفیکٹڈ بچوں کو علیحدہ کر دیں۔

☆..... جلدی انفیکشن (Skin Infections): پیمن فی گس نیونیورم (Pemphigus Neonatorum) ایک بہت ہی خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی انفیکشن ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ انفیکشن جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ انفیکشن زدہ جلد پہلے ہلکی گلابی ہو جاتی ہے اور پھر جلد پر چھوٹے چھوٹے نمودار ہو جاتے ہیں جن میں پانی کی طرح کا مواد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چھالے بعد میں ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں اور ان میں سے پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شدید انفیکشن بچے کی جان بھی لے سکتی ہے۔

علاج: ڈاکٹر کو فوری طور پر اطلاع دیں اور پیپ کلچر کے لئے بھجوا دیں۔ متاثرہ بچے کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے۔ انفیکشن والی جگہ کو صاف کیا جاتا ہے اور جینٹل وائلٹ (Gentian Violet) اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں نرسنگ سٹاف کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ انفیکشن ان کی وجہ سے دوسرے بچوں تک منتقل ہو سکتی ہے۔ انفیکٹڈ بچوں کو فوری طور پر علیحدہ کر دیں۔

☆..... آفٹھلما نیونیورم (Ophthalmia Neonatorum): اس مرض میں بچے کی آنکھیں انفیکشن کے باعث سرخ ہو جاتی ہیں اور ان میں سے گندامواد خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کی آنکھیں چپک جاتی ہیں اور پیوٹے سوجھ جاتے ہیں۔ شدید انفیکشن میں بچے کی آنکھیں بالکل بند ہو جاتی ہیں اور ان میں سے مسلسل مواد نکلتا رہتا ہے۔ بچے کو آنکھوں کا یہ انفیکشن عام طور پر نوری یا کے جراثیموں کے باعث ہوتا ہے۔